



● 许书亮 齐振熙 施荣鑫 编著

图解点穴疗法

● “图解民间传统独特疗法”丛书

福建科学技术出版社



“图解民间传统独特疗法”丛书

图解点穴疗法

许书亮 齐振熙 施荣鑫 编著

福建科学技术出版社

(闽)新登字 03 号

“图解民间传统独特疗法”丛书

图解点穴疗法

许书亮 齐振熙 施荣鑫 编著

*

福建科学技术出版社出版、发行

(福州市东水路 76 号)

各地新华书店经销

福建省科发电脑排版服务公司排版

三明日报社印刷厂印刷

开本 787×1092 毫米 1/32 6.5 印张 130 千字

1999 年 7 月第 1 版第 5 次印刷

印数:40 301—50 400

ISBN 7-5335-0982-X/R · 205

定价:7.70 元

书中如有印装质量问题,可直接向承印厂调换

施 序

点穴疗法乃以手法点按穴位而治疾病，其历史悠久矣。盖人体经络遍布，而循经有穴，经外亦有奇穴，皆气血所灌注之处，点按输通则气血流畅，百病虽沉顽亦可治愈。《素问·至真要大论》云手法之要曰：“摩之浴之，薄之劫之，开之发之，适事为故。”《医宗金鉴·正骨心法要旨》论手法更为深刻，其曰：“既知其病情，复善用夫手法，然后治之多效，诚以手本血肉之体，其宛转运用之妙，可以一己之卷舒，高下疾徐，轻重开合，能达病者之血气凝滞，皮肉肿痛，筋骨挛折，与情志之苦欲也。”可见手法治病在中医学中占有重要的地位。而点穴疗法则将手法治病的技术加以创新与发展，不仅更具特色，也发挥了新的功能。晋·葛洪《肘后救卒方》中已有受伤致命穴位之论述，至明清时期运用日盛。如明嘉靖异远真人《跌损妙方》提出“血头行走穴道”之说，并总结为 65 穴，使点穴疗法理论化，更具有规律性。清代江考卿、赵廷海诸家均有发明。此时民间亦广为流传，与武术、气功结合，不仅治病，亦用于养生康复等多方面。但其播散多秘行于流派门人之间，嫡传而不外泄，以致每闻其名而难得真髓精义，久之多有失传。闽南地区乃我国少林技击家集聚之域，无论医家或民间皆有点穴疗法应用之经验。许书亮教授有意于继承发扬这一宝贵遗产，多年来根据

陈老中医之秘本悉心研究，又博采广罗，凡廿春秋，所著《图解点穴疗法》，内容丰富，别具一格，为近年医林书市所罕见，实为振兴我国中医骨伤科事业之一大贡献。许君于书稿编就后示余，拜读之收益殊多，余有感于编著者虔诚奉献民众健康之举，欣然命笔谨叙一二，以志敬意。

施 杞

1993 年春于上海中医药大学

前 序

点穴疗法是广泛流传于我国民间的一种简便而有效的治病方法。我年青时,就曾听说我的故乡永泰有些拳师会点穴,当时我因阅历无多,不甚相信,只认为那不过是类似侠义小说作者笔下夸张之谈而已。后来随着社会实践日增,对点穴疗法也就逐渐由疑转信。如今则悔及当初没有学到这门技术而感到遗憾!其实,点穴疗法不仅流传于民间,而且早已载入祖国医籍之中,如明代曹士珩的《保生秘要》就有这方面的经验介绍,却未见后人有进一步研究。

我院骨伤系主任许书亮教授,在 20 多年前阅读一位归国老华侨所献之点穴疗法秘本,后经潜心整理研究,并通过临床实践验证,积累了经验,掌握了方法,摸索了规律。在此基础上,许君又研究了历代医籍有关资料,广泛收集民间经验,结合自己的长期临证实践体会,编著了《图解点穴疗法》。书稿甫成,我近水楼台得以先读,读后深感作者厥功不浅!本书不仅有发掘继承,而且有整理提高;不仅有经验总结,而且有机理探讨。使点穴疗法这一古老的民间经验,焕发新的生命力,有如出土明珠大放光彩。由此我推想,民间还有许许多多独特的治病方法,效果很好,但说不出道理,因而不被人们所重视以至失传。事实上不少民间单方草药秘方和某些简易疗法,有的

乍听好像“无稽之谈”，及至应用研究，却是有稽可信。《图解点穴疗法》的发掘、整理、提高与出版问世，对中医界同仁是很有启发的。

俞 长 荣

1993 年元月写于福建中医学院

前 言

传统点穴疗法,来自民间,源于实践,是我国历代劳动人民长期同疾病作斗争的经验总结,是祖国医学的宝贵遗产之一。

60年代末,归侨陈松柏医师将其父珍藏的一本点穴疗法秘本,献给龙溪地区卫生局,但内容只有穴名、经络线及其定位、施治病种和点穴手法的简要记述。1985年经编著者补充、整理成讲义,1986年后作为国外进修生及骨伤专业本科生之试用教材,深受欢迎。

为进一步继承和发扬祖国医学这一宝贵遗产,二十年来,编著者根据小册子的记载,通过不断临床验证,见其效果颇佳,遂在原秘本的基础上,参考了历代点穴疗法的文献资料,广泛收集了散在民间的有关治疗经验,并结合自己的长期临床实践体会,整理编著成《图解点穴疗法》一书。

本书分上、下二篇:上篇概论,总述传统点穴疗法的特点、作用机理、适应症、禁忌症、取穴方法和疗程,具体手法、经络线与穴位,以及各经穴位定位、主治及手法。下篇各论,介绍各病的定义、病因病机、临床表现、取穴和手法操作。此书在编写过程中,承蒙中华中医骨伤科学学会主任、上海中医药大学校长施杞教授,福建中医学院前任院长俞长荣教授赐序,福建中医

学院院长杜建教授大力支持。在此谨表衷心的感谢！

因水平有限，遗误之处在所难免，希同道及广大读者不吝指正。

许书亮

1994 年 12 月于福建中医学院

目 录

上 篇 总 论

一、点穴疗法概说	(1)
(一) 点穴疗法的起源与发展	(1)
(二) 点穴疗法的特点	(3)
(三) 点穴疗法的作用机理	(4)
(四) 点穴疗法的适应症和禁忌症	(9)
二、点穴疗法常用穴位及取穴法	(10)
(一) 经络线与经络点	(10)
(二) 各经穴位定位、解剖、主治及手法	(21)
三、点穴疗法基本手法及操作	(61)
(一) 基本手法	(62)
(二) 辅助手法	(65)
(三) 指力的运用	(68)
(四) 点穴治疗的准备工作和常用体位	(69)
(五) 取穴方法、疗程及注意事项	(71)

下 篇 各 论

一、咳嗽	(75)
二、哮喘	(76)

三、心悸	(78)
四、胃痛	(80)
五、胁痛	(82)
六、腹痛	(84)
七、泄泻	(85)
八、便秘	(87)
九、癃闭	(89)
十、阳痿	(91)
十一、头痛	(93)
十二、牙痛	(94)
十三、眩晕	(95)
十四、耳鸣、耳聋	(97)
十五、失眠	(98)
十六、郁证	(99)
十七、癫证	(101)
十八、痫证	(102)
十九、厥证	(104)
二十、痉证	(105)
二十一、中风后遗症	(107)
二十二、痿证	(109)
二十三、疝气	(111)
二十四、痛经	(113)
二十五、乳痛	(114)
二十六、缺乳	(115)
二十七、疔证	(117)
二十八、小儿呕吐	(118)

二十九、厌食	(120)
三十、小儿尿频	(121)
三十一、小儿遗尿	(121)
三十二、夜啼	(123)
三十三、颈部扭挫伤	(124)
三十四、落枕	(127)
三十五、颈椎病	(127)
三十六、肩部扭挫伤	(130)
三十七、肩关节周围炎	(131)
三十八、肘部扭挫伤	(134)
三十九、骨化性肌炎（创伤性肘关节炎）	(135)
四十、肱骨外上髁炎	(136)
四十一、肱骨内上髁炎	(138)
四十二、腕部扭挫伤	(138)
四十三、桡骨茎突腱鞘炎	(139)
四十四、腕管综合征	(140)
四十五、髋部扭挫伤	(141)
四十六、股内收肌损伤	(142)
四十七、股四头肌扭挫伤	(144)
四十八、腓绳肌拉伤	(146)
四十九、膝关节侧副韧带损伤	(147)
五十、髌骨软化症	(148)
五十一、膝关节创伤性滑膜炎	(149)
五十二、腓肠肌损伤	(151)
五十三、踝关节扭伤	(153)
五十四、跖管综合征	(155)

五十五、跟痛症	(156)
五十六、颞颌关节功能紊乱症	(157)
五十七、胸部挫伤	(158)
五十八、肋软骨炎	(160)
五十九、背肌筋膜炎	(160)
六十、岔气	(162)
六十一、急性腰扭伤	(163)
六十二、腰部劳损	(165)
六十三、腰椎后关节紊乱症	(166)
六十四、第三腰椎横突综合征	(166)
六十五、腰椎间盘突出症	(168)
六十六、梨状肌损伤综合征	(170)
六十七、骶髂关节扭伤	(172)
六十八、骶尾关节扭挫伤	(173)
六十九、类风湿性关节炎	(174)
七十、先天性斜颈	(176)
七十一、大脑损伤后遗症	(178)
七十二、小儿瘫后遗症	(179)
七十三、多发性神经炎	(181)
七十四、臂丛神经损伤	(184)
七十五、桡神经损伤	(185)
七十六、正中神经损伤	(187)
七十七、尺神经损伤	(188)
七十八、坐骨神经损伤	(190)
七十九、颜面神经麻痹	(191)
八十、三叉神经痛	(192)

上 篇 总 论

一、点穴疗法概说

（一）点穴疗法的起源与发展

点穴疗法是我国医学遗产的一部分，也是一门研究防治人体疾病的科学。它与祖国医学的其他学科一样，历史悠久，具有丰富的经验，同样对中华民族的繁衍昌盛有着较大的影响。

科学的发生和发展从开始便是由劳动生产所决定的，点穴疗法的起源及形成也与劳动人民长期的劳动生活、生产实践紧密相连。我们的祖先在与疾病的斗争中，开始用砭石或顺手拨摩或用手指按压揉动人体某些损伤、疾病疼痛部位，以求达到治病的目的，继而逐渐发展为穴位，这便是点穴疗法的起源和最初形式。嗣后，随着社会发展与科学的进步，尤其是伴随着医学、武术及气功的兴起与发展，逐渐积累经验，并且经过历代医家不断实践的检验和总结，逐步发展成为一种独特的治病疗伤的有效方法。

关于点穴疗法的理论与穴位考证，前人早已有过精辟的论述，并散见于历代的医学书籍中。如《素问·刺禁论》有：

“七节之旁，中有小心”，《素问·举痛论》则有：“按之则气血散，故按之痛止”的记载。这也是后人解释点按“后心穴”可以止痛的理论依据之一。晋代葛洪在《肘后救卒方》中载有受伤致命的穴位，说明了穴位的重要性以及与人体的关系。由于医学与武术的兴起及发展，迨至明、清，点穴疗法，尤其是民间“点穴疗法”与少林寺派之“跌打点穴治伤”的学术观点已经形成，传统点穴疗法也较全面地发展，不少伤科论著均有这方面的记载，作为这个时期的代表著作，如明嘉靖年间，异远真人在《跌损妙方》中以经络学说为主要理论依据，提出“血头行走穴道”论，并载有六十五穴，为后世医家，尤其是少林寺派之点穴疗伤提供了理论依据和经验总结。清·道光年间，江考卿著《江氏伤科方书》，在异远真人六十五穴的基础上发展为一百零八穴，其中大穴三十六，小穴七十二；清·咸丰年间，赵廷海在《救伤秘旨》中载有三十六大穴图说，并在书中论及穴道与经脉脏腑间的相关联系。此外，陈氏抄本《点穴秘要》中则载有十二经气血流注时辰歌等。

由于点穴疗法在其发展过程中与武术、气功的发展有着密切的联系，并受其影响，故气功、武术界又将其统属于我国武功之列，其中有点穴、打穴、拿穴、踢穴……之分，后又以点穴统而名之；在我国传统武术中它既作为一种攻击对方的手段，又作为一种疗伤治病的方法，且秘而不传，正如《救伤秘旨·黄序》中所说：“这种疗法自古为技击家所秘，世传盖少。”故其经验长期流传于民间，甚至一些宝贵的经验也因此而佚失。随着西方医学的传入，点穴疗法又一度被视为不科学的歪门邪术，横遭排斥与非难，既不为人所知，也得

不到发展，几乎濒于奄奄一息之境地。建国以来，在党的中医政策指导下，祖国医学中的点穴疗法日益受到重视，经过不断的发掘、整理和总结，得以不断提高，并趋完善。尤其是近年来，通过对经络学说、气功疗法的深入研究，新兴的气象医学、地理医学、长寿医学、免疫学以及有关生理、生化、应用解剖学等方面的科学实验，证实了点穴疗法中经络穴位、气血流注等理论的科学性及其应用价值，从而赋予这一传统的治疗方法以崭新的内容，同时也进一步开拓了其治疗的前景。

（二）点穴疗法的特点

点穴疗法可以说是从中国武术演变而来的一种医疗方法，它是将武术点穴作为进攻或防御的强刺激手法改变为人体所能接受的治疗手法。医者根据不同病种和病情，在患者体表适当的穴位或经络线上，用手指进行点、震、冲、按、推、刮、转、揉等不同手法的刺激，通过经络的作用，使体内的气血畅通，促使已经发生功能障碍的肢体或器官恢复正常功能，从而达到治愈疾病的目的。点穴疗法与传统的针灸、气功、推拿、按摩等疗法的经络、取穴以及手法有所不同，其共有 84 个穴位，按 6 条经络线分布于全身的各部位。点穴疗法的优点在于不仅可以治疗多种疾病，使患者既免受针药之苦，且简便易行，奏效迅速，而对某些疾病的疗效，则为针药所不及，因此，深受人们的欢迎。其特点归纳如下：

1. 适应症广，疗效显著 点穴疗法除了对骨伤科疾患，如骨折、脱位之后遗症，常见的伤筋以及一般的伤科内伤疾患，有较显著的疗效外，对于某些内科、妇科、儿科以及神经系统的疾患，如正确运用点穴治疗，也可获得较好的效果。

2. 经济简便, 好学易懂 点穴疗法操作简便, 容易掌握, 便于学习。只要辨证明确, 选穴得当, 手法适宜, 操作熟练, 就能在临证治疗中收到预期的效果。同时, 不需药品和特殊的设备, 不论在任何场所, 均可随时施术治疗, 因此, 便于普及和推广。

3. 施治安全, 易于接受 点穴疗法是一种安全而且见效较快的治疗方法, 临证中只要注意一些特殊穴位的手法操作, 施术认真细致, 一般是不会发生不良反应的, 因而男女老幼均能接受治疗。

(三) 点穴疗法的作用机理

点穴疗法是祖国医学的一个重要组成部分, 是以祖国医学的经络学说、脏腑学说以及气血学说作为理论基础的。因此, 点穴治疗作用是有其理论依据的。

1. 点穴与经络的关系 经络系统是祖国医学认识人体、治疗疾病的独特理论。《灵枢·海论》篇说: “……经脉者, 内属于脏腑, 外络于肢节。”《素问·调经论》载有: “五脏之道皆出于经隧, 以行气血。”《灵枢·本藏》亦说: “经脉者, 所以行气血而营阴阳, 濡筋骨利关节者也。”说明了经络是运行营卫气血的通路, 它内联脏腑, 外络肢节, 网络全身, 沟通表里上下, 使人身成为一个完整的统一体。人体通过经络的经气运行, 一方面传输气血津液, 一方面相互协调平衡, 以维持正常的生理功能。故经络畅通, 则气血调和, 营卫御, 脏腑协调, 肢体矫健。反之, 若经络阻塞, 则气滞血瘀, 营枯卫弱, 脏腑失调, 躯体羸弱。正如《灵枢·经别》所说: “夫十二经脉者, 人之所以生, 病之所以成, 人之所以治, 病之所以起……。”经络是营卫气血在人体运行的通路, 而经穴

则是营卫气血运行通路中显示的交会点，亦称经络点，其包含于经络系统之中。点穴疗法虽然重点是在穴位上施行手法，但实际上是根据经络在人体内分布和循行的关系来进行的。临床上了解经络体系、认识疾病所在，是点穴疗法中辨证施治的依据。当人体某一部位的筋、骨、肌肉、血脉以及脏腑发生病变、功能失调时，通过在与其相关联的经络线和穴位上，恰当地运用点、按、推、刮、揉等点穴手法，使“力”与“气”的作用沿着相关的经络路线渗透到患者体内，以激发经气，使气至病所产生感应，而调节内在的不平衡达到协调一致。现代医学研究认为，经气实际上是一种信息载体，在经脉中形成信息流，并通过经和络与全身组织结构沟通信息。点穴疗法正是依据经气的运行规律及其信息流的表现而进行诊断和穴位的调整来治病的。因此，点穴疗法又称为信息疗法。

2. 点穴对脏腑的影响 人体是以五脏为中心，以气、血、精、津液为物质基础，通过经络使脏与脏、脏与腑、腑与腑密切联系，外连五官九窍、四肢百骸，构成一个有机的整体。脏腑相合，配以五行，起着相互依存、相互生克、相互制约、相互维持其生理平衡的作用，同时影响着气、血、筋、脉、骨、髓等各个方面的正常生理关系。人体不论哪一部分发生病变，均与脏腑的生克、制约有关。根据祖国医学“有诸内，必形于诸外”的理论，五脏六腑发生病变，可以通过躯体的外部反映出来。如《素问·藏气法时论》说：“肝病者，两胁下痛引少腹”；“心病者，胸中痛，胁支满，胁下痛，膺背肩胛间痛，两臂内痛，虚则胸腹大，胁下与腰相引而痛”；“脾病者，身重，善肌肉痿，足不收行，善瘕脚下痛”；“肺病者，喘咳逆气，肩背痛，汗出，尻阴股膝髀腠胻足背痛”；“肾病者，腹

大胫肿；喘咳身重，寝汗出，憎风。”五脏如此，六腑亦然。如《灵枢·胀论篇》说：“胃胀者，腹满，胃脘痛，……”；“大肠胀者，肠鸣而痛濯濯，……”；“小肠胀者，少腹膨胀，引腰而痛”；“膀胱胀者，少腹满而气癃”；“三焦胀者，气满于皮肤中，轻轻然而不坚”；“胆胀者，胁下痛胀”。由此可见，一旦脏腑有病，必然于躯体外部的不同部位有着不同程度的证候表现。因此，点穴疗法施于体表，运用具体而恰当，消除这些证候，实际上也就对脏腑起到调整和治疗的作用。另一方面，以经络学说的理论分析，点穴对脏腑的影响是通过经络、气血而起作用的。经络遍布全身，内通五脏六腑，外连四肢百骸，按照经络分布的关系，以经络统属脏腑，可见脏腑与经穴有着相当密切的关系。因而，在人的体表施行点穴手法后所起的刺激作用通过气血、经络影响到内脏及其它部位，直接地调节着五脏六腑之间的有余或不足，使之相互间的生克制化恢复平衡状态，从而达到治疗的目的，使人体这一有机的整体组织继续维持其正常的生理功能。此外，通过近代生理学的研究，人们认识到人体的各个脏器都有其特定的生物信息（各脏器的固有频率及生物电等），当脏器发生病变时，有关的生物信息就会发生变化，而脏器生物信息的改变可影响整个系统乃至全身的机能平衡。通过各种刺激或各种能量传递的形式，作用于体表的特定部位，产生一定的生物信息，通过信息传递系统输入到有关脏器，对失常的生物信息加以调整，从而起到对病变脏器的调整作用。这是点穴疗法的现代科学理论依据之一。因此，点穴疗法可以说是建筑在人体生物电、生物力学、生物内能以及组织器官的生理、生化、解剖学理论基础上的—种古老而又崭新的治疗方

法。

3. 点穴对气入血的作用 气血是构成人体的基本物质，是正常生命活动的基础，人的生命活动是气血运动变化的结果。点穴之所以能够治病，其中主要的因素之一，就是能够调整气血的关系，对气血的循行有调节和促进作用。

人体中最基本的气是元气，《内经》说：“人之有生，全赖此气”，这是维持人体生命活动最为基本的力量。它的生成有赖于肾中精气、水谷精气和自然清气的相互结合，其生理功能的发挥，则有赖于气机的调畅。血是由脾胃运化的水谷精气化生而成，所谓“中焦受气取汁，变化而赤，是谓血。”血与营气共行脉中，为脏腑组织器官提供丰富的营养。气血运行于全身，周流不息，外而充养皮肉筋骨，内而灌溉五脏六腑，可谓“一身之支柱”。

气为血之帅，血为气之母，气血相辅相成，互相依附，循行周身，犹如日月丽空。人体生机蓬勃，精神振而百邪远。倘若气血被阻，失真调畅，则如日月被蚀，光明顿失，而成暝晦之象，人将因此而致病。人身之气血固然如此重要，那么临证中调节气血的生理功能势必为治疗之关键。《点穴术·点穴与气血篇》指出：“……若能开其门户，使气血复其流行，则经脉既舒，其病自除。……治法当从其穴之前导之，或在对应之穴启之，使所闭之穴感受震激，渐渐开放，则所阻滞之气血亦得缓缓通过其穴，以复其流行矣。”由此说明采用适当的手法进行穴位点穴，可以起到疏通经络、行气活血的作用。点穴疗法对气血的调节作用，亦是通过经络系统来完成的。气血环流周身，按经络循行于一定的径路，而经穴则是气血在人身循行的必经之点，点穴就是在穴位上以手法的直

接作用来改变气血循行状态，即通过手法使气血的系统内能增大，加速气血的循行，从而起行气活血的作用，解除因气滞血瘀引起的各种病证。此外，临床实践中还经常见到，人体一旦发生病变，则与病变有关的经脉区内的经穴会出现一定的反应和变化，如麻木、酸胀、疼痛、硬结等，这些正是气血失调、运行不畅所体现出的病理征象。通过点穴手法的治疗，可以消除经穴及其周围的这些现象，从而反证了点穴对气血所起的调节作用。通过现代医学的实验观察，按压某些部位（多在血管循行部位），可使血管中的血流暂时隔绝，根据血液动力学原理，在按压处的近侧端，由于心脏的压力和血管壁的弹性作用，局部的压力急骤增高；当急速放松压迫时，则血流向远端骤然流去，利用这短暂的血流冲击力，可起到活血祛瘀、改善肢体循环的作用。点穴疗法中的点推法、点击法及碎点法等正是利用这一原理进行治疗的。

综上所述，点穴疗法对人体的作用是多方面的，它既有疏通经络，行气活血的作用，又有调整脏腑功能、平衡阴阳、扶正祛邪的效果。这些作用的发挥，一方面取决于人体的机能状态，另一方面则在于所取的穴位和选用的手法，二者是相辅相成，互相影响的。其作用机理，主要是以祖国医学的经络、脏腑以及气血学说等为理论依据，通过手法与经络穴位相互结合，调节气血的循行，作用和影响于脏腑，调整人体内在的不平衡状态，达到维持生理功能协调一致，消除症状，使机体得以康复。从现代医学研究的角度来认识，其主要是通过调节神经系统的功能，改变有关的系统内能以及信息调整等，反射性地改善病变部位的血液循环和一系列的新陈代谢，促进病变部位组织细胞的修复与再生能力，从而达

到治愈疾病的目的。

（四）点穴疗法的适应症和禁忌症

点穴疗法广泛适用于骨伤科疾患和部分内科、妇科、儿科、神经科疾患以及其他病证。由于病情千变万化，故医者在临证时应慎重考虑点穴疗法的适应症或禁忌症，以提高治疗效果，避免造成失治或误治。

1. 适应症

（1）**上肢骨与关节疾病：**部分上肢骨折与关节脱位之后遗症、肩周炎、肱二头肌腱鞘炎、肩腱袖病、肱骨外上髁炎、肘部外伤性尺神经炎、前臂缺血性瘢痕挛缩、腕关节扭挫伤、狭窄性腱鞘炎、腕管综合症以及掌指关节和指间关节韧带损伤等。

（2）**下肢骨与关节疾病：**梨状肌损伤综合征、股内收肌损伤、膝关节内外侧副韧带损伤、膝关节损伤性滑膜炎、腓肠肌痉挛、踝关节扭挫伤、马蹄内翻足畸形（包括先天性及神经系统疾病后遗症在内）以及跖痛症、跟痛症等。

（3）**躯干与脊柱疾病：**颈椎病、落枕、肌源性斜颈、胸腰椎关节紊乱症、第三腰椎横突综合征、腰椎间盘突出症、腰骶及骶髂关节损伤、急性腰肌扭伤、慢性腰骶部劳损以及胸壁挫伤、胸肋进伤等症。

（4）**神经系统疾病：**大脑损伤后遗症、大脑外伤及手术后遗症、外伤性不完全截瘫、脊髓灰质炎、脑炎后遗症、偏瘫、多发性神经炎、面神经麻痹、三叉神经痛、臂丛神经不完全麻痹、正中神经、尺神经与桡神经不完全损伤、坐骨神经痛以及股神经和腓总神经不完全损伤等。

（5）**其他病证：**头痛、眩晕、耳鸣、耳聋、神经性呕吐、

发热、牙痛、呃逆、咳嗽、哮喘、感冒、急性咽喉炎、胃痛、胸胁痛、小儿消化不良、急性胃肠炎、便秘、遗尿病、尿失禁、遗精、阳痿、前列腺炎、痛经、闭经、带下病、疝气、疮疡、瘰癧、瘰癧病、癲狂、癲痫、眼睑下垂、近视、麻痹性斜视等。

2. 禁忌症

(1) 急性病：外科常见急腹症、炎症急性期、热性病及各种传染病等。

(2) 严重的心脏病、高血压、恶性肿瘤等症。

(3) 出血性疾病：血友病、血小板减少性紫癜、过敏性紫癜等。

(4) 严重的皮肤病。

此外，妇女经期、怀孕期亦得慎用。

以上所述适应症与禁忌症，在临床上可视病者情况而酌情掌握。

二、点穴疗法常用穴位及取穴法

(一) 经络线与经络点

1. 经络线 经络线在临床实践中有一定的指导意义，它与奇经八脉相似，但与十二正经不同，既不直属脏腑，又无表里配合关系，而是“别行其道”。它们纵横交错地循行分布于十二经之间，其主要作用体现于两个方面：其一，沟通了十二经脉之间的联系。它将部位相近、功能相似的经脉联系起来，达到统摄有关经脉气血、协调阴阳的作用。其二，对十二经气血同样有蓄积和渗灌的调节作用。这6条经络分别

为：颅经、哲经、脾胃经、肾经、龙经、经外线（图1、2）。每一条经络线均有一定的循行路线，经络线的循行分布与该经穴位主治有内在的联系。故了解经络线的发源及循行分布，就能更好地了解穴位主治范围，同时也有助于了解及掌握肘、膝关节以下穴位的主治作用。

（1）经络线与经络点的关系：这六条经络线均发源于后心穴，因此，后心穴是全身的总穴，它有管辖全身经络线和经络点的作用。而各个经络线上的经络点又有互相管属的关系。《灵枢·小针解》说：“节之交，三百六十五会者，经脉之渗灌诸节者也。”说明经络线与经络点是密切相连的。人体的穴位均分别归属于各经络，而经络又隶属于一定脏腑，故经络点、经络、脏腑间的相互联系成为不可分割的关系。各条经络线均有其主要的经络点，如：颅经的主穴——椎点；哲经的主穴——抬肩穴；脾胃经的主穴——前心穴；肾经的主穴——腰点；龙经的主穴——血筋穴；经外线的主穴——乳面点。

各经的主穴有统管该经络点的作用，同时可以治疗该经范围的疾病以及邻近区域的某些病症。点穴治病时，应取各经的主要经络点作为主穴，并以其所管属的经络点作为配穴，这样才会提高疗效。

（2）各经络线的主治：各经络线的循行分布不同，而且纵横交错于十四经脉，因此各经络线除了主治该经的疾病外，同时还有治疗邻近经络线区域的病证。

①颅经：主治落枕、颈椎病、颈部扭挫伤、脑震荡后遗症、三叉神经痛、牙痛、哮喘、眩晕、咳嗽等证。

②哲经：主治肩部及上肢扭挫伤、肩周炎、上肢骨折及

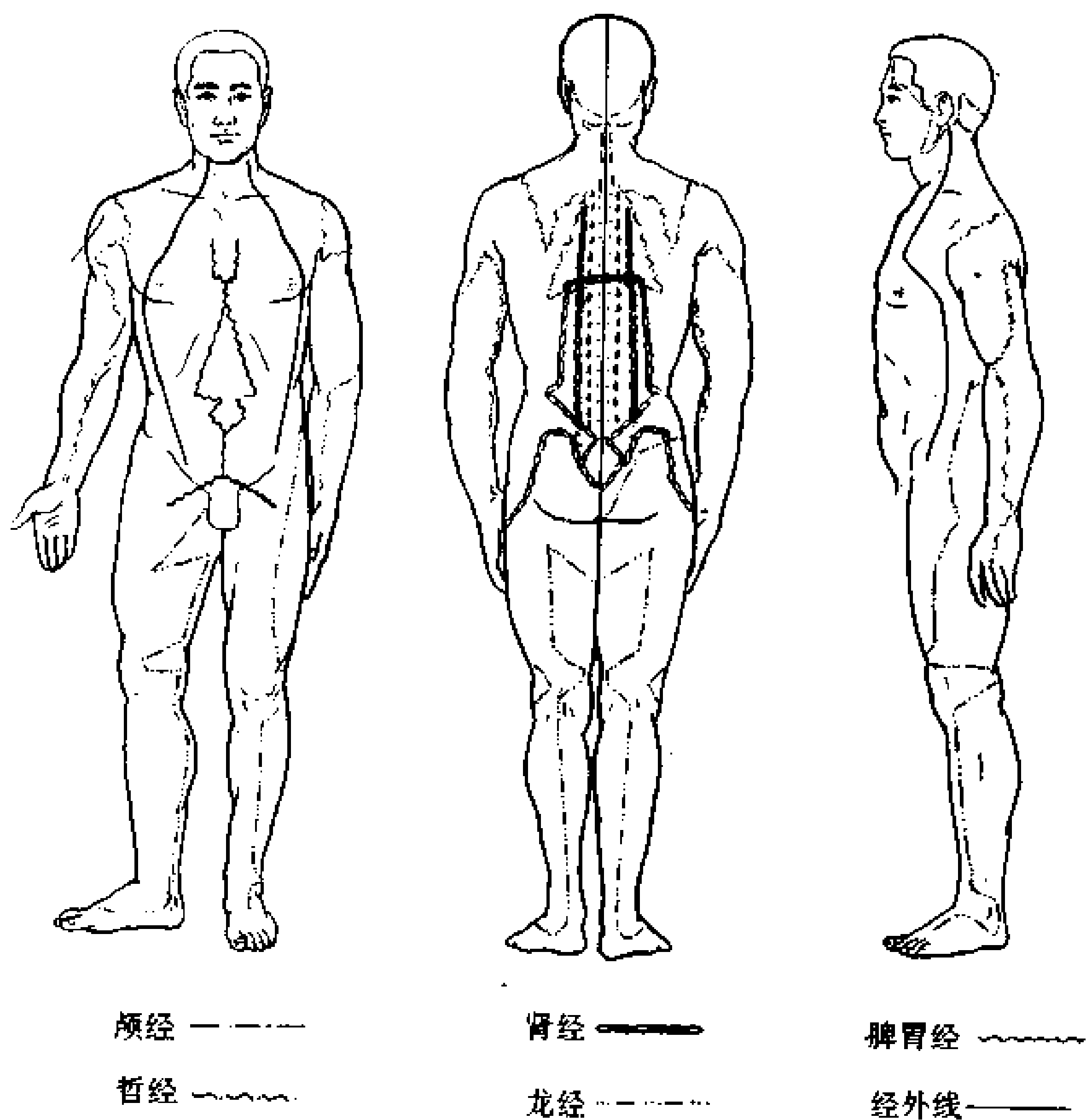


图 1 经络线循行示意图

脱位后遗症、上肢周围神经损伤、牙痛、头痛、心悸等证。

③脾胃经：主治胸腹部挫伤、肋间神经痛、疝气、胃肠

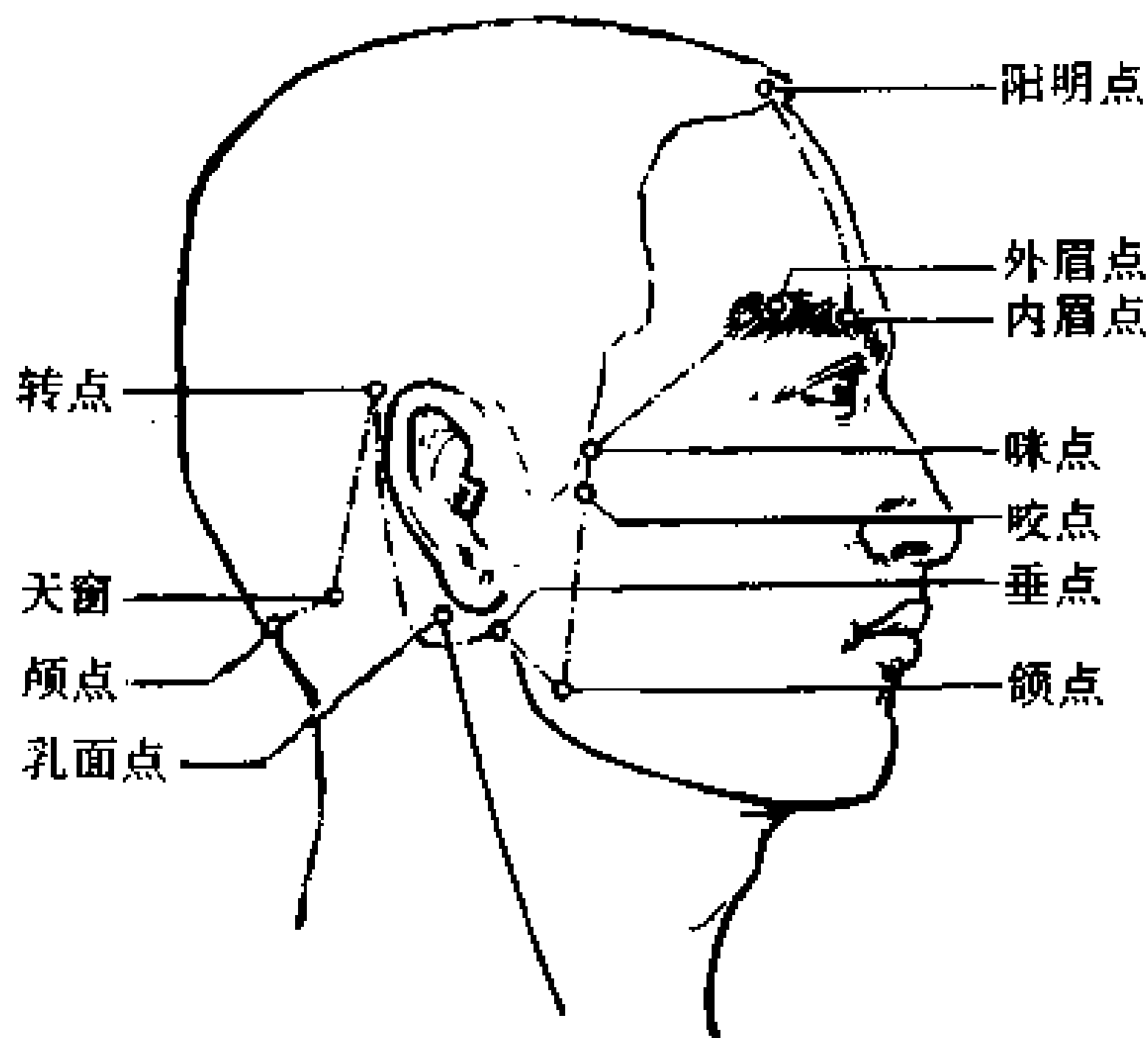


图 2-1 头面部经绪线及穴位分布示意图

道疾病以及泌尿系统疾患等。

④肾经：主治急性腰部扭伤、腰背部挫伤、慢性腰肌劳损、腰椎间盘突出症、梨状肌损伤综合征、臀上皮神经损伤、小儿麻痹后遗症、便秘等证。

⑤龙经：主治下肢周围神经损伤、下肢骨折及脱位后遗症、髋髂关节炎、髋髂关节扭挫伤、腰椎间盘突出症、小儿麻痹后遗症、风湿痹痛、急慢性阑尾炎等证。

⑥经外线：主治颞颌关节系乱症、颜面神经麻痹、胸胁部挫伤、肋间神经痛、腹痛、疝气等证。

2. 经络点 经络点即穴位，一般有清点与暗点之分：清点又称为“小穴”或“不致命穴”，分布于全身，是点穴治病

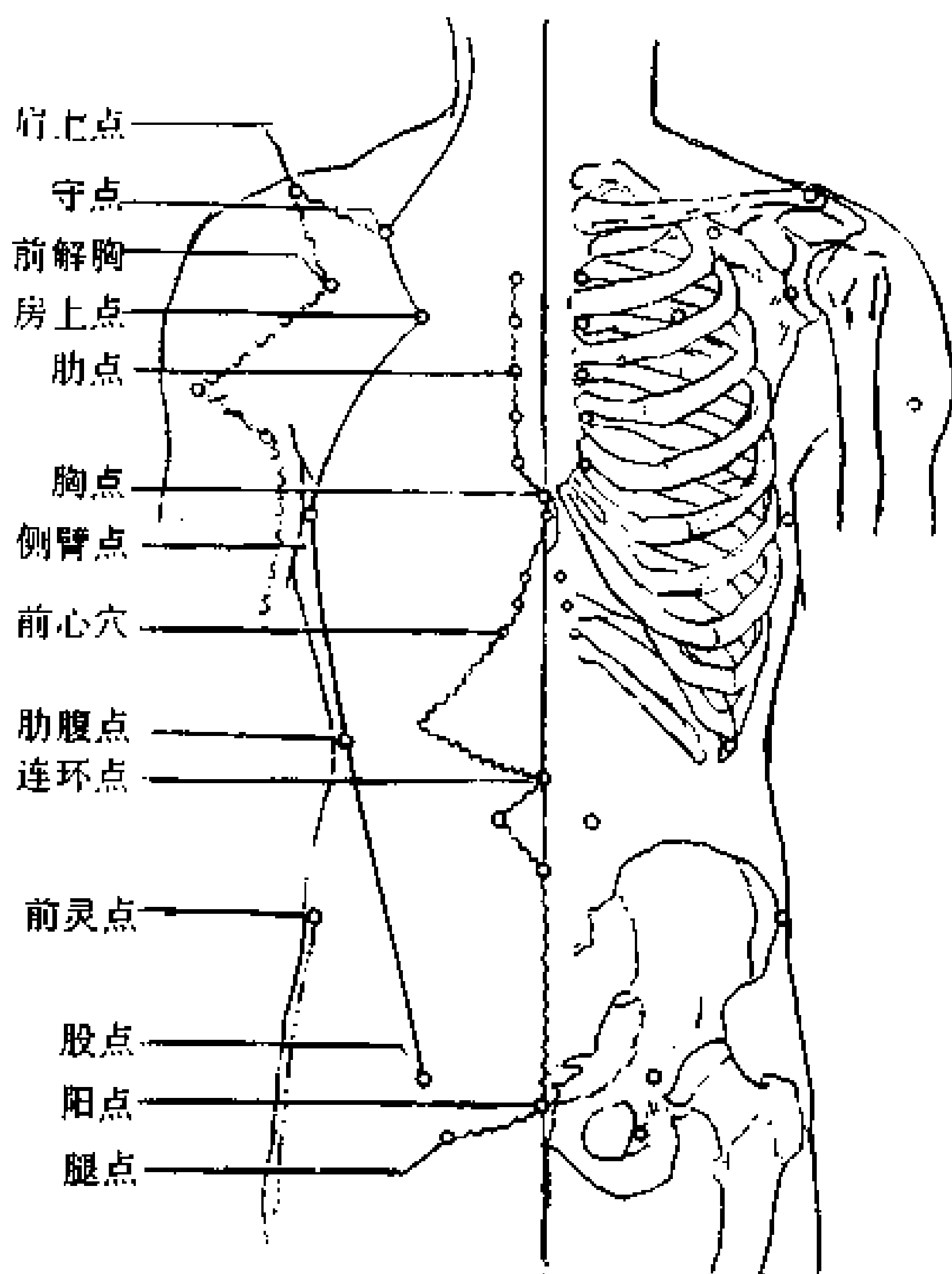


图 2-2 胸膈肋腹部经络线及穴位分布示意图

的主要穴位；暗点又称为“大穴”、“绝穴”、“死穴”，清代伤科名医江考卿所云的“三十六大穴”就属于暗点。

穴位是人体脏腑经络之气输注于体表的点穴施术的主要

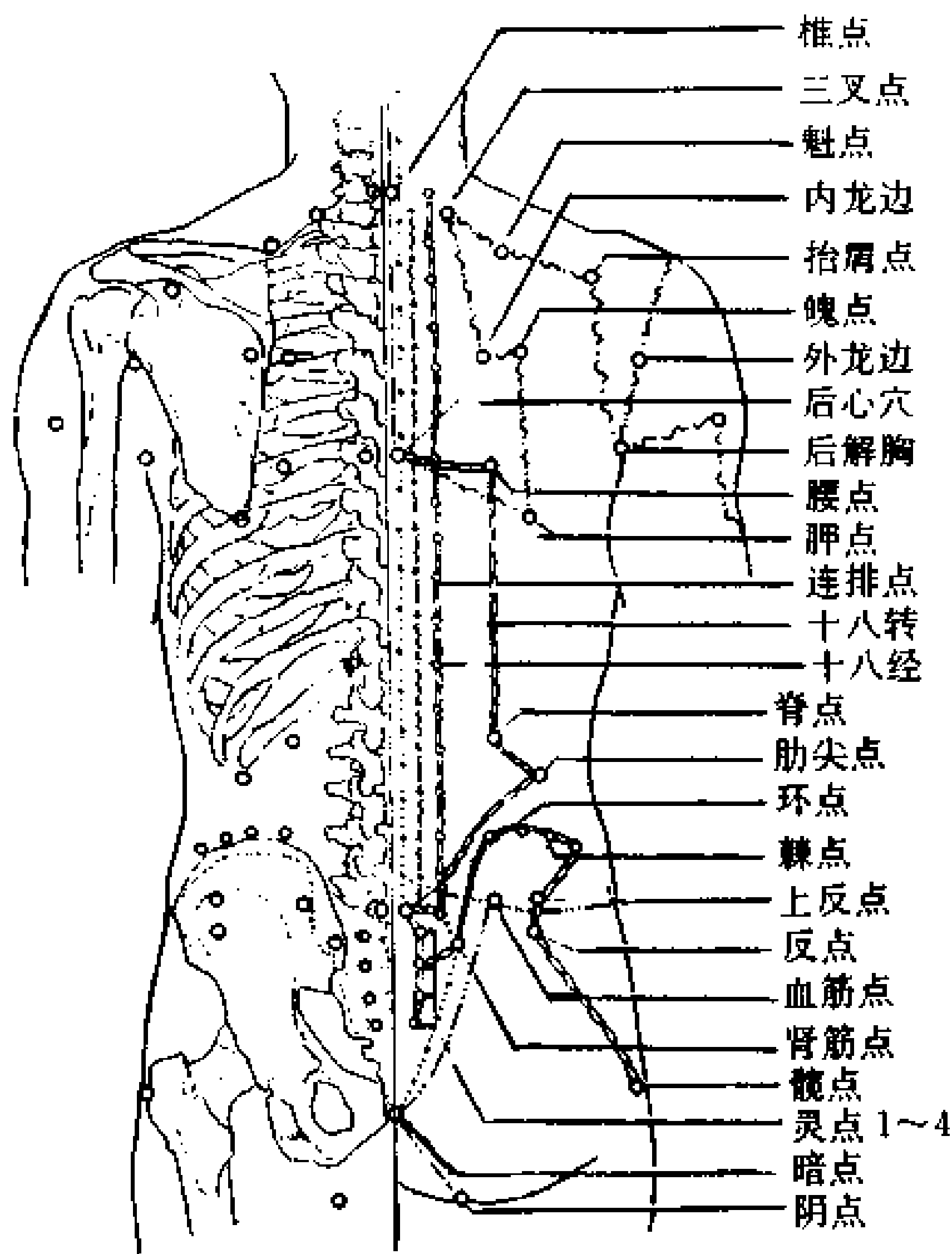


图 2-3 肩背腰尻部经络线及穴位分布示意图

部位。临床上要正确运用点穴治病，就必须掌握好穴位的定位、手法、主治等基本知识。

经络点是我国人民在长期与疾病作斗争的过程中陆续发

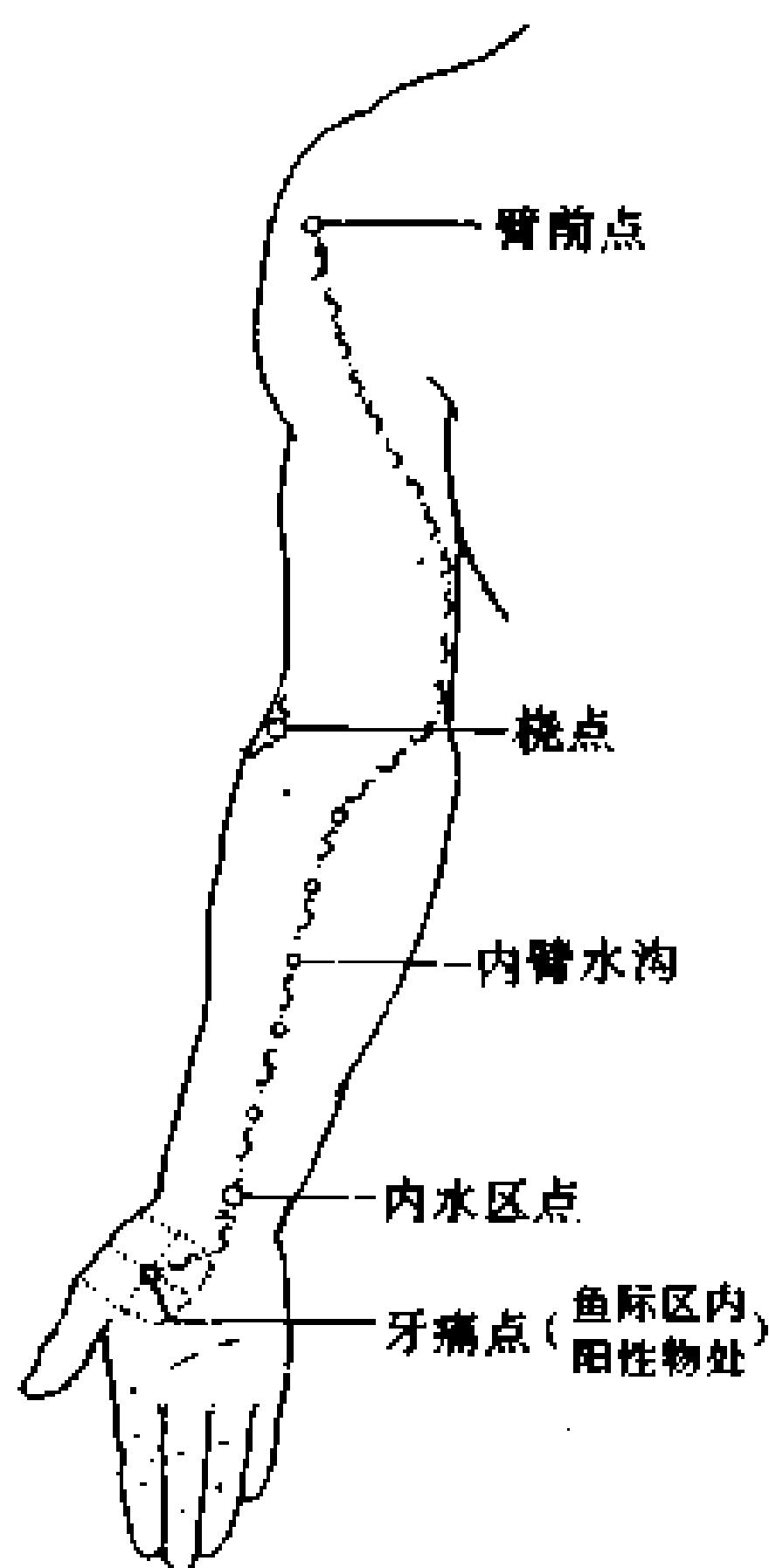


图 2-4 上肢前侧部经络线及穴位分布示意图

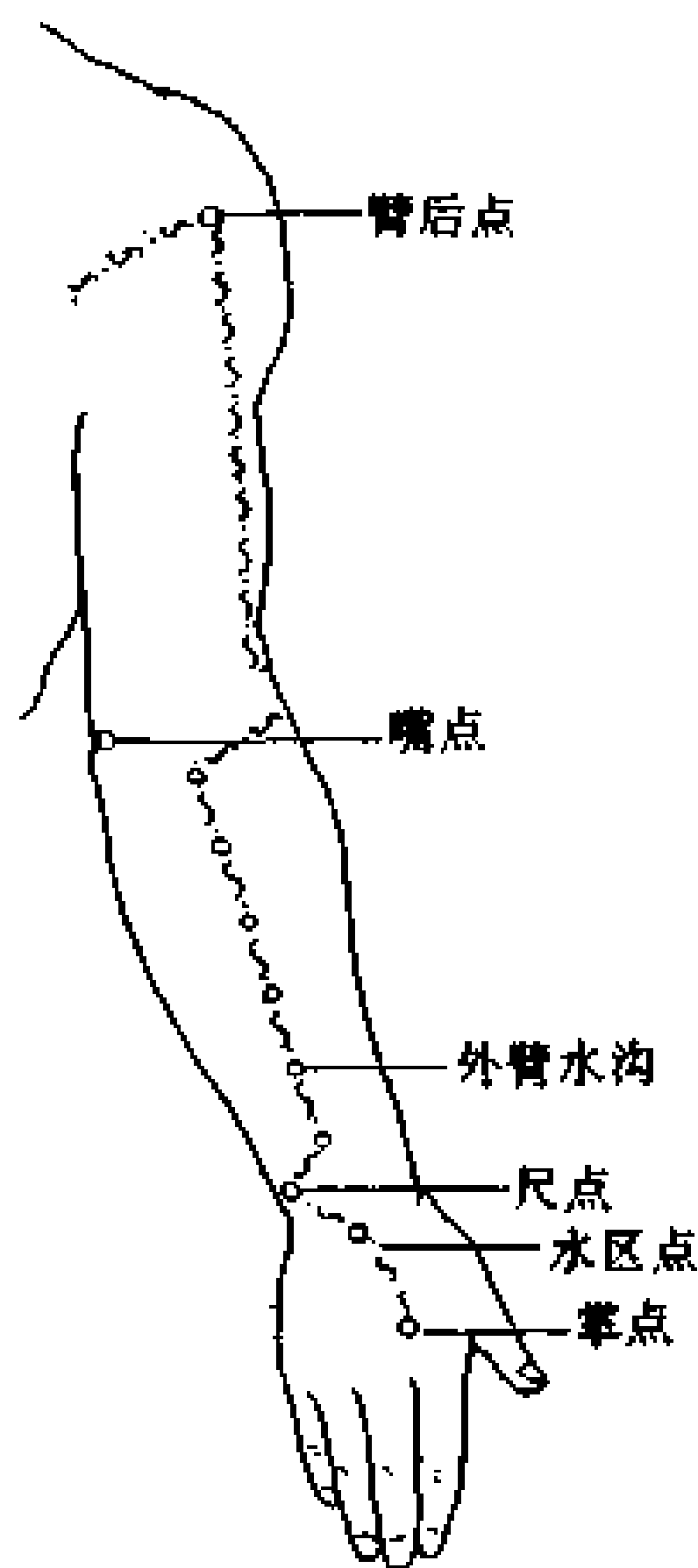


图 2-5 上肢后侧部经络线及穴位分布示意图

现并逐渐积累起来的。它与针灸学的奇穴一样，既有一定的穴位名称，又有明确的位置，但未列入正经系统的穴位，属于“经外奇穴”范畴。这些穴位对某些疾病具有特殊的治疗作用，同时与经络线系统有一定的联系。

(1) 经络点的命名：经络点的命名是古人以其部位及作用为基础，结合医学理论及某种事物，运用取类比象的方法而制定的。它的命名不仅有其医学上的意义，同时也包含着

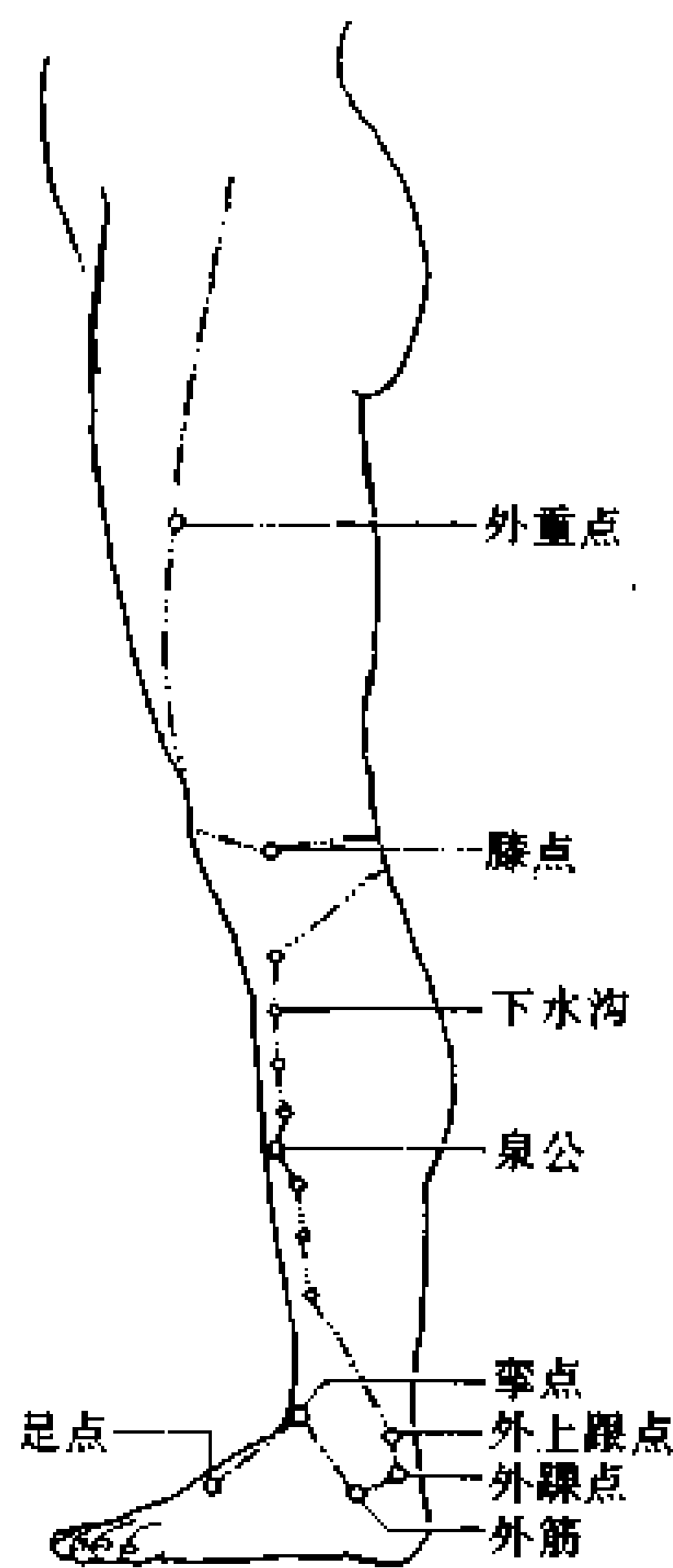


图 2-6 下肢外侧部经
络线及穴位分布示意图

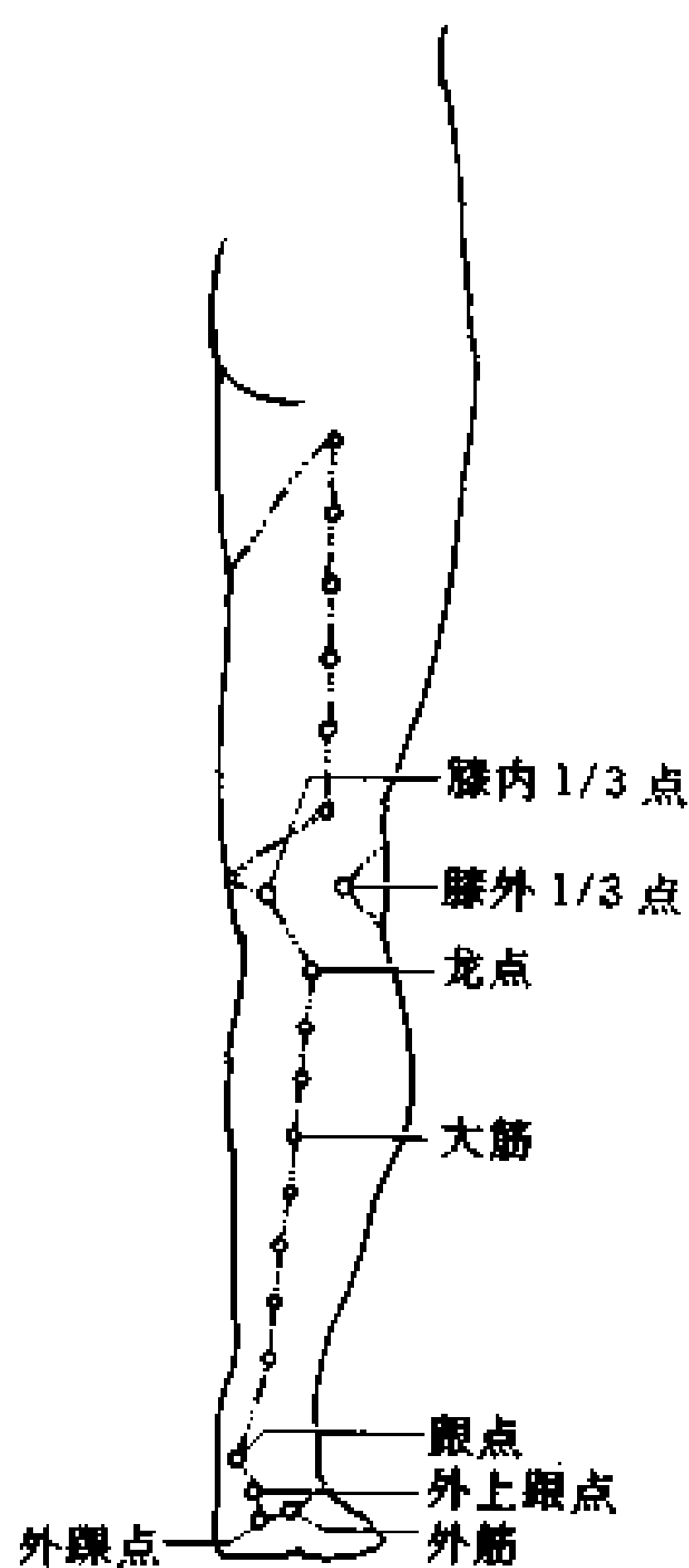


图 2-7 下肢后侧部经
络线及穴位分布示意图

古代灿烂文化的一部分，正如《千金翼方》所说：“凡诸孔穴，名不徒设，皆有深意”，它是点穴治病名词术语的重要组成部分。因此，了解经络点命名的意义，对于学习、熟悉经络点的部位及治疗作用有很大的帮助。兹将穴位名称择要分类说明如下：

①依据所在部位命名：部分经络点是根据穴位所在部位

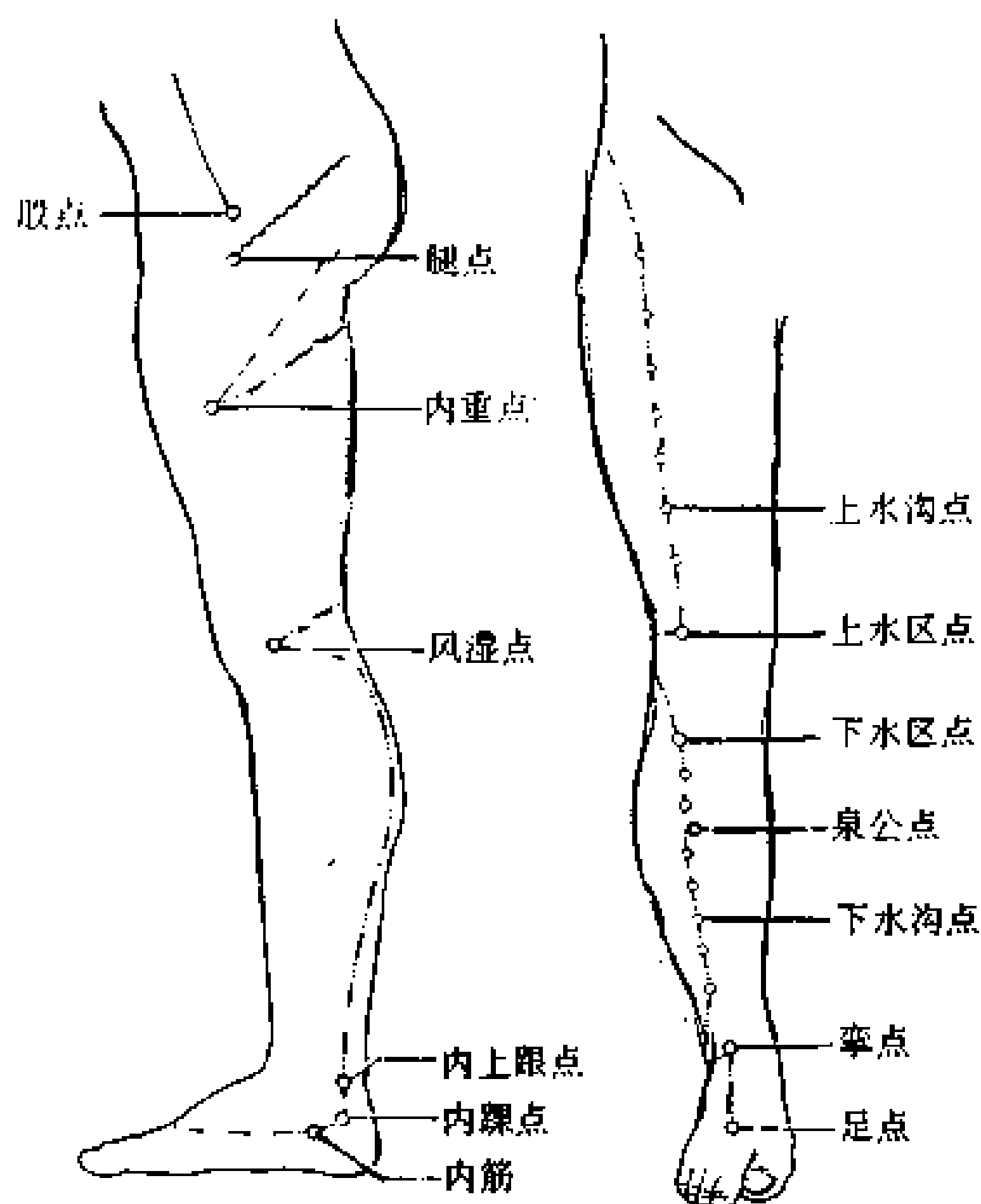


图 2-8 下肢内侧部经
络线及穴位分布示意图

图 2-9 下肢前侧部经
络线及穴位分布示意图

解剖名称或相关部位的特点而命名的，如尺骨茎突内上缘的尺点、肱骨内髁与鹰嘴之间的嘴点、锁骨中下的守点、第七颈椎旁的椎点等。

②结合中医学理论命名：部分经络点是根据其部位或治疗作用，结合经络、阴阳、脏腑、气血等中医学理论来命名的，如前额发际中点上的阳明点、坐骨结节内侧缘的阴点、耻

骨联合中点的阳点、第七胸椎旁的后心穴、剑突下肋缘的前心穴、肩胛岗内下缘的魄点、后髂嵴下的血筋穴等。

③根据治疗作用命名：部分经络点是根据其对某种病证的特殊治疗作用而命名的，如治疗风湿性关节炎的风湿点、治疗膝关节积液及肿胀的上水区点与下水区点，以及治疗腰部疾患的腰点等。

④以动物名称命名：部分经络点的命名与动物有关，如委中穴直下四横指处的龙点、肩胛骨外侧缘的外龙边及内侧缘的内龙边等。

⑤利用地理天体命名：有的经络点是利用地理名称及天体名称如“泉”、“沟”、“天”来命名的，像胫骨中点外侧缘的泉公穴、大腿前中线及后中线的上水沟、小腿前胫腓骨间的下水沟、头枕部两侧的天窗穴等。

⑥借建筑物来命名：部分的经络点借用建筑物有关的名称如“窗”、“房”来命名，像枕骨粗隆与耳垂连线中点的天窗穴、第三肋间与锁骨线中交点的房上穴等。

⑦利用点穴手法及穴位排列命名：如乳突后上方的转点，脐部四旁的连环点，胸、腰椎旁的连排点等。

(2) 经络点的临床治疗作用：经络点是点穴施术的主要部位。经络点之所以有治疗作用，主要是它有通讯、传递活动等功能，正如《子午流注传真》所说：“经气的运输，俞穴的开合，就是在不断地进行着通讯传递活动。……经络线上的穴位既是接受器，又是发送器……经过穴位的加工、编码，信号就能扩大，再经过经络传达所联络的脏腑器官。”经络点的治疗作用主要有四个方面：

①近治作用：是所有经络点主治作用所具有的共同特点。

这些经络点均能治疗该穴所在部位及邻近组织、器官的伤痛疾病，例如头枕部下缘的颅点、两侧的天窗穴均能治疗头痛，肩胛岗下抬肩穴及内侧缘的魄点均能治疗肩胛部疾患，剑突下的前心穴、脐旁的连环点可以治疗某些胃肠疾病。

②远治作用：这是六条经络线穴位主治作用的基本规律。在六条经络线穴位中，有两条经络线的穴位在四肢肘、膝关节以下，它不仅能治疗穴位局部的疾病，同时还可以治疗本经循行所及的远隔部位的组织、脏腑器官的病证。甚至可以治疗某些全身性疾病，例如龙点不仅可以治疗下肢的某些疾患，同时还可以治疗早期颈椎病及高血压；掌点不仅治疗掌部疾患，同时还可以治疗腰部急性扭伤；后心穴有治疗全身疼痛的作用。

③特殊作用：通过临床实践证明，点按某些穴位，对机体的不同状态，可以起到双相的良好调整作用，例如大便秘结时，点按连环点可以通便；而泄泻时，点按连环点又有止泻之功能。六条经络线的主治作用归纳起来就是：本经穴位主治本经病，邻近经穴能互相配合治疗局部病。各经穴位的主治有其特殊性，同时又有其共同性，例如颅经主治颈、头部疾病、脾胃经与经外线二经同样可以治疗胃肠疾病。

④穴位的互相对抗与协同作用：临床实践证明，穴位与穴位之间有互相对抗及协同的现象。所谓对抗，系指某些穴位在施术时不能同时点按，否则便会失去其功效，但可以先后施术点按。这些对抗穴位是前心穴抗后心穴，血筋穴抗反点，魄点抗魁点，内龙边抗外龙边。所谓协同，则是指某些穴位与某穴位在施术时，同时施行手法，可以提高疗效。这些穴位是血筋穴协同肋尖穴、脊点、龙点。

（二）各经穴位定位、解剖、主治及手法

1. 颅经

（1）循行分布：起于后心穴，上行抵颈椎旁，合于枕骨下缘，分支上行至乳突顶，循耳后抵下颌，入颞骨，循眉棱骨，止于前额发际上。本经分布在头、背、颈部，共有 12 个穴位（图 3）。

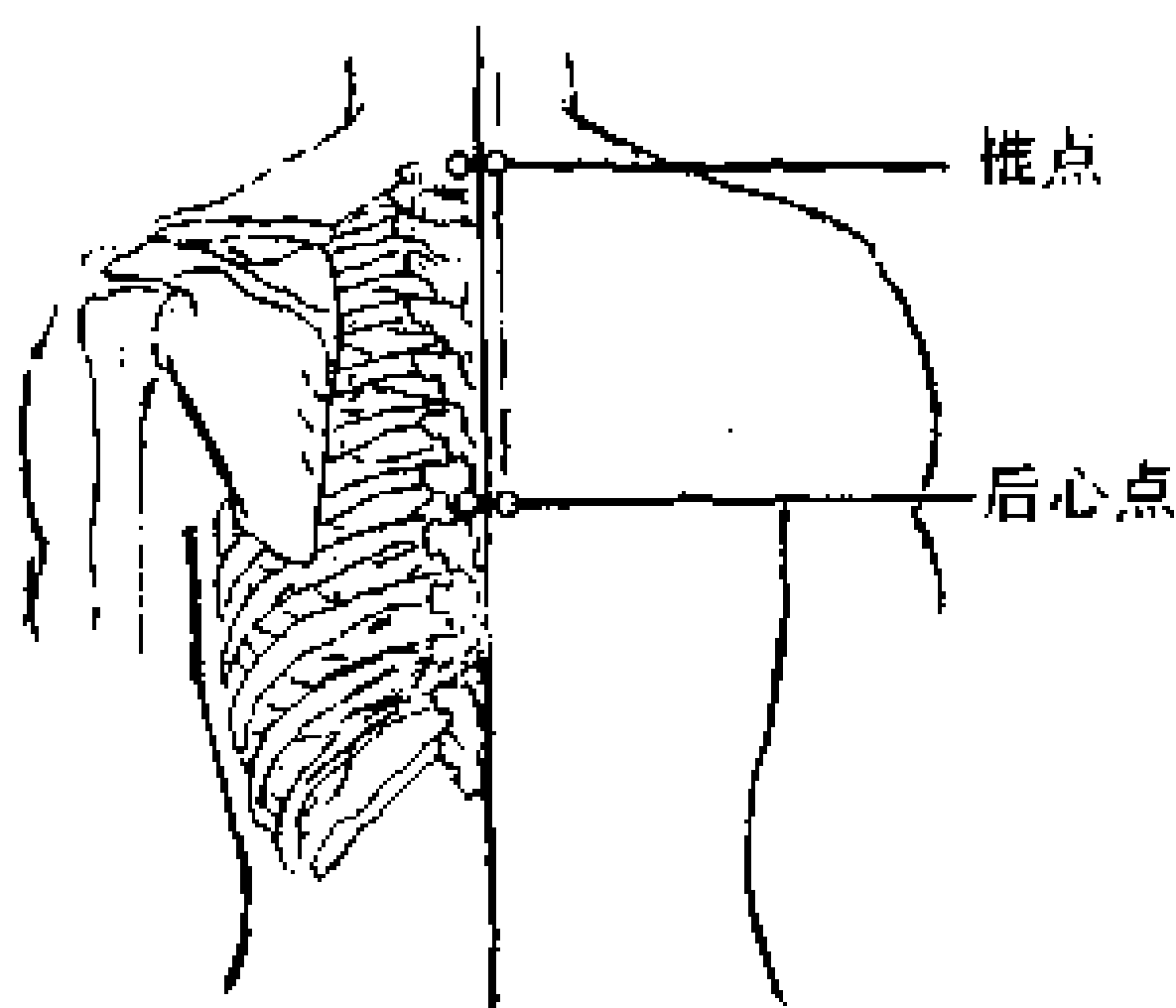


图 3-1

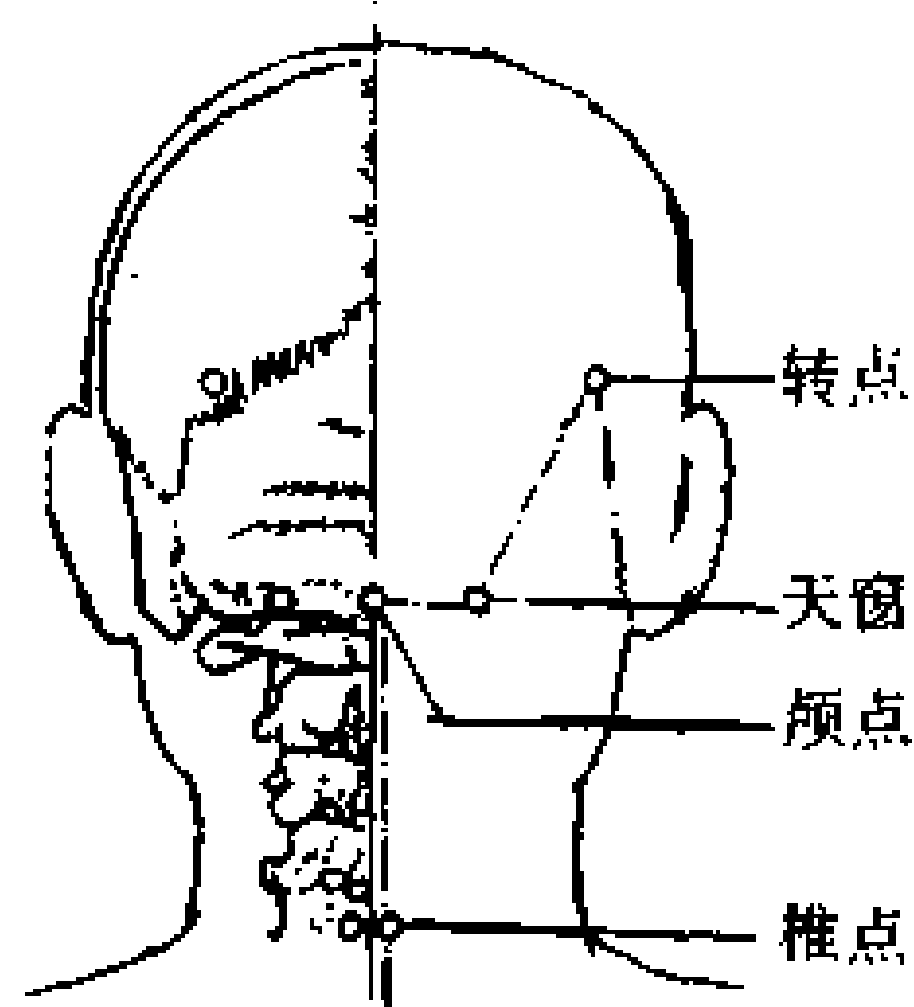


图 3-2

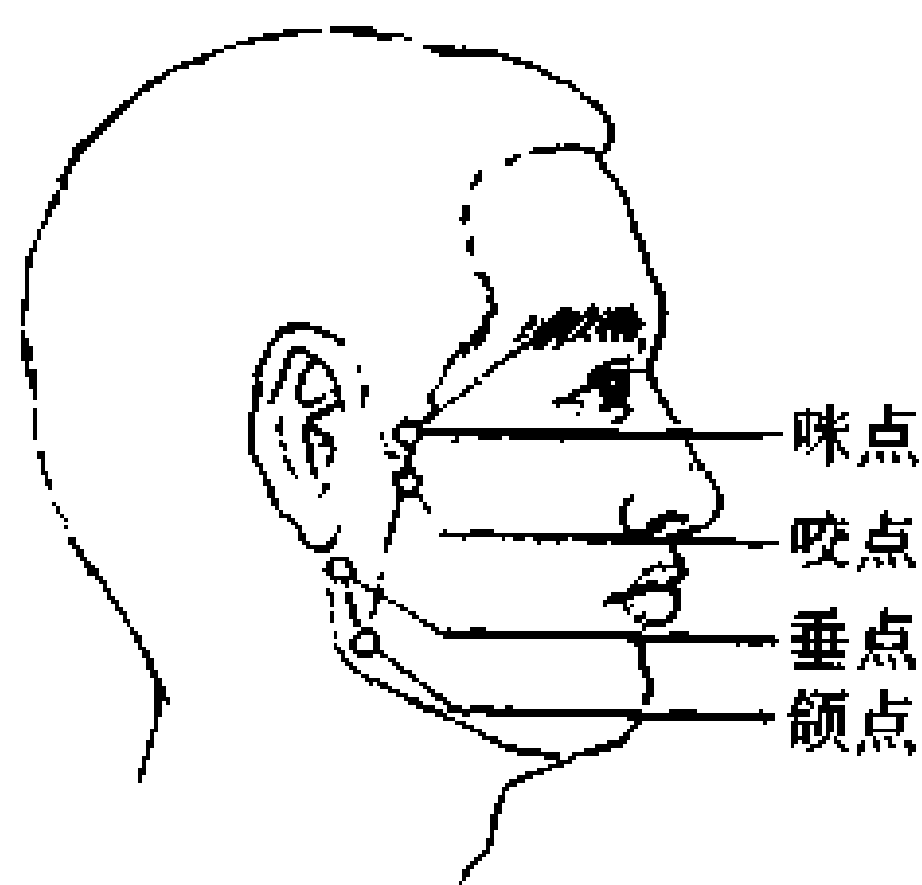


图 3-3

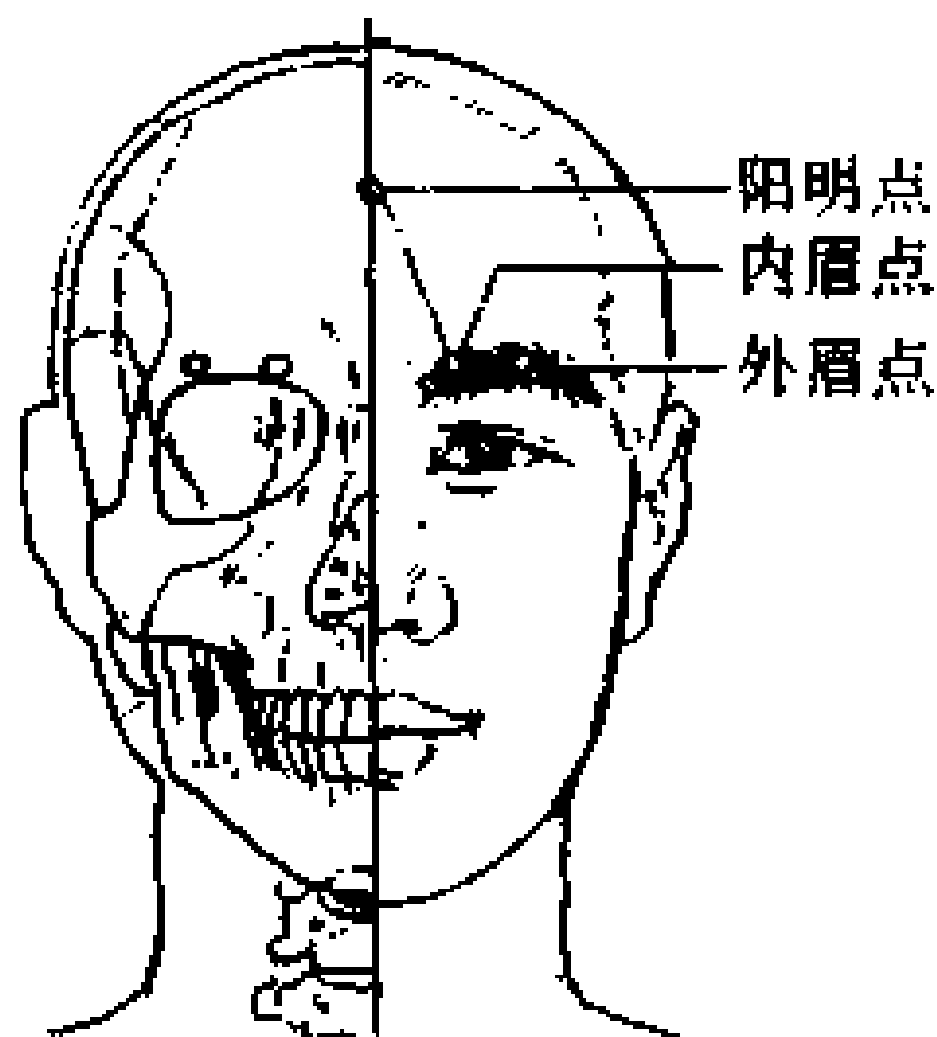


图 3-4

图 3 颅经循行及穴位分布示意图

(2) 主要病候：痛症，哮喘，咳嗽，癫痫，头痛，肩周炎，颈椎病，热病，眩晕，脑震荡后遗症，耳鸣，耳聋，齿痛，口眼喎斜，颜面神经麻痹等病证。

(3) 主治概要：本经经络点主治头、目、耳、肺、神志病以及经络线循行部位的其他病证。

(4) 本经穴位：

①后心穴：

〔定位〕第七胸椎棘突旁开 0.5 厘米，男取左，女取右。

〔解剖〕在斜方肌下缘，有背阔肌、最长肌，布有第七肋间动、静脉后支；第七、第八胸神经后支的皮支，深层为第七胸神经后支外侧支。

〔主治〕全身各种疼痛，气喘，呃逆，咳嗽，吐血，潮热，呕吐，盗汗，背部挫伤，胃脘痛。

〔手法〕用碎点法或往外侧点推法、点刮法。禁向脊椎方向点推或点刮。

〔附注〕此穴为全身总穴，也是各经络线的发源点。一般在午时及申时不可点按此穴。如果点按过重或手法操作错误而致晕厥时，不必惊恐，只要点刮前心穴即可解之。施术时如感肩臂部麻痹感，此为正常现象，此时手法应轻而慢。

②椎点

〔定位〕第七颈椎两侧缘（相当于定喘穴）。

〔解剖〕有腰背筋膜，棘上韧带及棘间韧带；有棘突间静脉丛；布有第八颈神经后支。

〔主治〕落枕，颈椎病，颈部扭挫伤，上肢神经损伤，肩周炎，肩胛炎，上肢风湿痛、头痛项强，咳嗽，热病，疟疾，哮喘，癫痫。

〔手法〕往外侧用点推法或点刮法。

〔附注〕禁向脊椎方向点推或点刮，本穴为颅经主穴。

③ 颅点

〔定位〕枕骨粗隆下缘。

〔解剖〕有枕动脉分支及棘突间静脉丛；布有第三枕神经与枕大神经之分支。

〔主治〕脑震荡，颅内组织损伤后遗症，头痛，项强，眩晕，中风，癫狂，咽喉肿痛，失音，颈椎综合征等。

〔手法〕往上点刮或用点揉法。

〔附注〕慢性病施术时，手法要轻。

④ 天窗穴

〔定位〕在耳垂与枕骨粗隆联线中点。

〔解剖〕在胸锁乳突肌和斜方肌终止部、枕外隆突起始部的凹陷处，深层为头夹肌；有枕动、静脉分支；布有枕小神经分支。

〔主治〕落枕，颈部扭挫伤，头痛项强，眩晕，耳鸣，中风，癫痫，热病，疟疾，目赤肿痛，鼻渊，鼻衄，脑震荡及颅内组织损伤后遗症。

〔手法〕稍向下方点推或用点刮法。

〔附注〕痛甚时可结合点揉法。

⑤ 转点

〔定位〕乳突后上方凹陷处。

〔解剖〕在枕肌中；有枕动、静脉分支；布有枕大神经分支。

〔主治〕眼部疾患，头痛，癫狂及癫痫，颈项强痛，目眩，近视，偏头痛，脑震荡后遗症。

〔手法〕点转法，并朝顺时针方向旋转 90°。

〔附注〕穴位准确时，乳突部有酸胀感或眼球有胀感。

⑥垂点

〔定位〕耳垂下缘与面延接处。

〔解剖〕有耳后动、静脉，颈外浅静脉；布有耳大神经，深层为面神经干从茎乳突穿出处。

〔主治〕下颌关节疾患，颜面神经麻痹，三叉神经痛，偏头痛，耳鸣，耳聋，口眼喎斜，牙关紧闭，齿痛，颊肿，瘰癧。

〔手法〕稍往前、下方点按或用点刮法。

〔附注〕手法宜轻。

⑦颌点

〔定位〕下颌角上缘凹陷处（颊车穴后上方）。

〔解剖〕在咬肌中，皮下有腮腺；有咬肌动、静脉分支；布有面神经分支。

〔主治〕下颌关节疾患，面颌部挫伤，三叉神经痛，口舌生疮，口、下齿痛。

〔手法〕往上点按或用点震法。

〔附注〕下颌关节脱位复位前，先用重手法点按此穴，使咬肌松弛，然后行手法复位。

⑧咬点

〔定位〕颧骨弓下缘（下关穴上方）。

〔解剖〕颧骨弓下缘，皮下有腮腺，为咬肌起始部；有面横动、静脉，最深层为上颌动、静脉；正当面神经颧眶支及耳颞神经分支，最深层为下颌神经。

〔主治〕同侧下颌关节疾患，三叉神经痛，颜面神经麻痹，

牙痛，耳鸣，耳聋，口眼喎斜。

〔手法〕垂直点按或用点震法。

〔附注〕此穴对上牙痛较有效。

⑨咪点

〔定位〕颧骨弓上缘，咬点的正上方。

〔解剖〕在颞肌中；有颧眶动、静脉；布有面神经的颧眶支及三叉神经小分支。

〔主治〕下颌关节疾患，牙痛，颜面神经麻痹，三叉神经痛，偏头痛，耳鸣，耳聋，口眼喎斜。

〔手法〕垂直点按或用点震法。

〔附注〕咪点对治疗三叉神经痛及上齿痛较有效。

⑩外眉点

〔定位〕眉弓的中外 1/3 交界处。

〔解剖〕在轮匝肌中；有额动、静脉外侧支；布有眶上神经、面神经的分支。

〔主治〕前额痛，眉棱骨痛，眼睑瞤动，眼睑下垂，目赤肿痛，目翳。

〔手法〕往上点按，或用点震法。

〔附注〕点按时可用左手食、中指分别按压在穴位的上下，然后再用右手食指指尖点按。

⑪内眉点

〔定位〕眉弓中内 1/3 交界处。

〔解剖〕有额肌及皱眉肌；当额动、静脉处；布有额神经内侧支。

〔主治〕头痛，前额痛，眼睑下垂，口眼喎斜，目视不明，流泪，目赤肿痛，眼睑瞤动，眉棱骨痛。

〔手法〕往上点按，或用点震法。

〔附注〕施术时手法宜轻。

②阳明点

〔定位〕前额发际中点上 0.5 厘米左右（于神庭穴稍上方）。

〔解剖〕在左右额肌交界处；有额动、静脉分支；布有额神经分支。

〔主治〕头痛，眩晕，癫痫，失眠，鼻渊，脑震荡后遗症。

〔手法〕用点按法或点震法，手法宜轻。

〔附注〕本穴常配合颅点治疗头痛。

2. 督经

（1）循行分布：起于后心穴，旁行至肩胛下角，循肩胛缘内缘抵内角，从肩胛岗下经肩胛外侧缘至腋后线上，上行至肩锁关节。分支：内侧支经腋前线入腋窝，循上臂内三角肌至鹰嘴，沿前臂两骨之间至内腕横纹中，抵鱼际肌入掌心；外侧支循上臂外三角肌抵肘前，沿前臂外侧两骨之间抵腕横纹中，止于掌背。本经分布在肩胛部及上肢，共有 20 个穴位（图 4）。

（2）主要病候：肩周炎，咳嗽，气喘，肺病，颈椎病，肩胛炎，挫伤，风湿痹痛，胸痛，胁痛，肩及上肢骨折、脱位后遗症等。

（3）主治概要：本经经络点主治肩、肩胛、颈、胸、胁、骨伤科和神经损伤某些疾病，以及经络线循行部位的其他病症。

（4）本经穴位：

①胛点

〔定位〕肩胛骨下角下缘。

〔解剖〕有背阔肌、髂肋肌；有第八肋间动、静脉背侧支；布有第七、八胸神经后支。

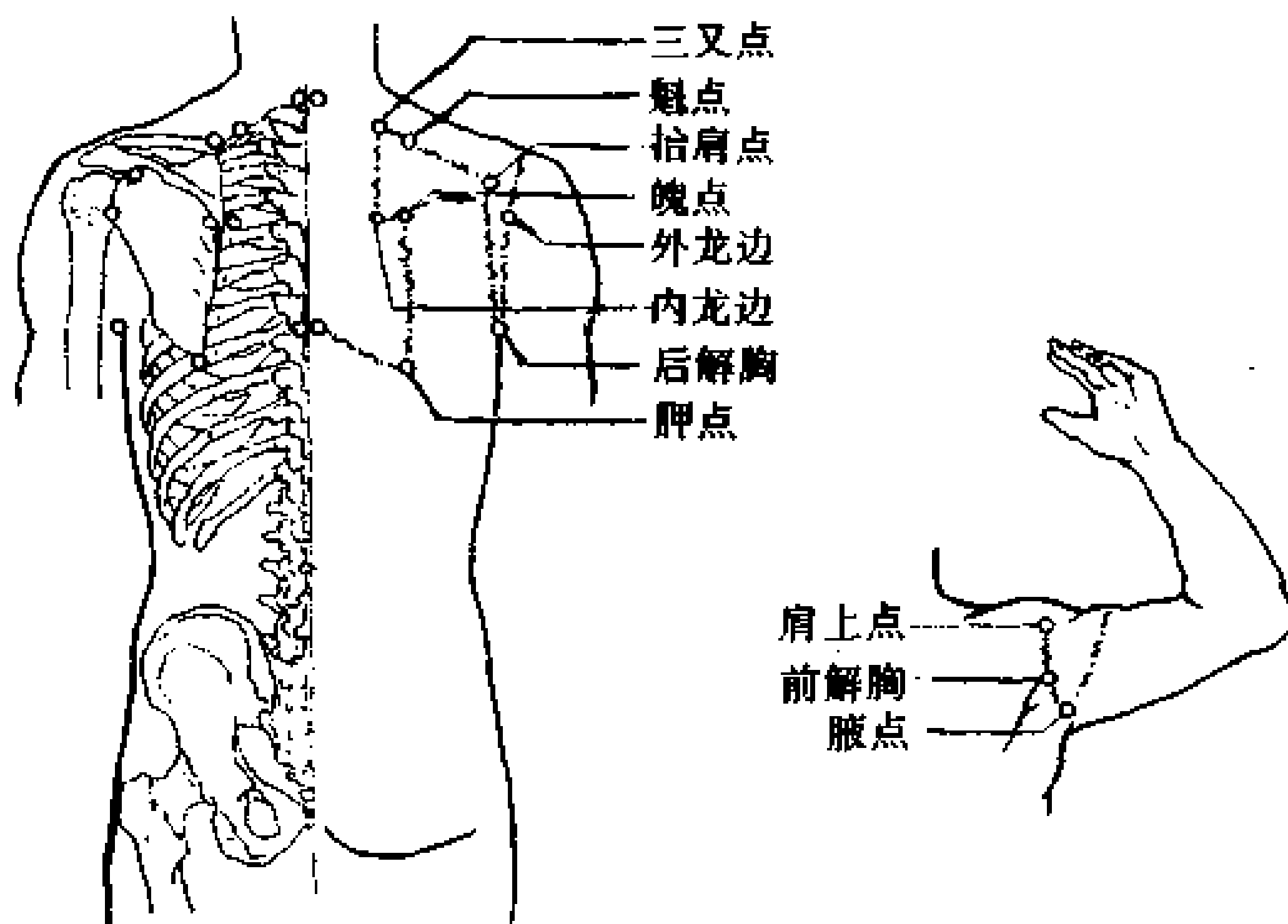


图 4-1

〔主治〕肩胛区域疾患，胸胁痛，背痛，呕吐，泄泻，肩胛及背部挫伤，腰背肌劳损。

〔手法〕向下方点刮或用点按法。

〔附注〕右侧穴位可以治疗胆囊炎。

②内龙边

〔定位〕肩胛骨内侧缘中上 1/3 交界处。

〔解剖〕在肩胛骨脊柱缘，有斜方肌、菱形肌，深层为髂肋肌；有肋间动、静脉背侧支及颈横动脉降支；布有第三、四

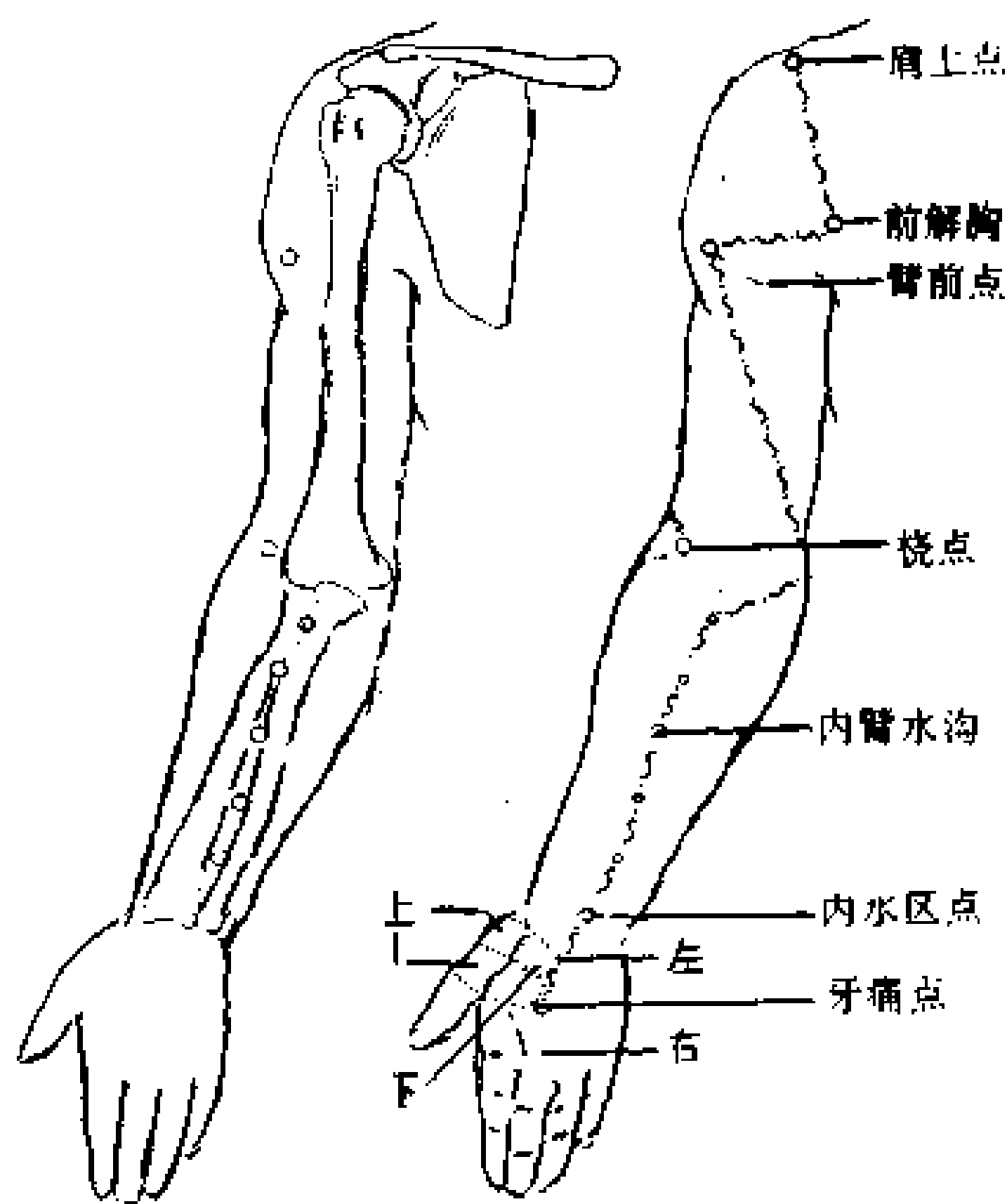


图 4-2

胸神经后支。

〔主治〕肩背部疾患，气喘，咳嗽，背部挫伤，肩周炎，肩胛炎。

〔手法〕往内侧点刮或点按，禁向肩胛骨点刮或点推。

〔附注〕此穴与外龙边对抗，不能同时点按，但可以先后施术。

③魄点

〔定位〕肩胛岗内下缘，与内龙边相邻。

〔解剖〕在岗下窝中央岗下肌中；有旋肩胛动、静脉肌支；布有肩胛上神经。

〔主治〕肩胛部疾患，肩胛炎，肩周炎，肩背部挫伤，气喘。

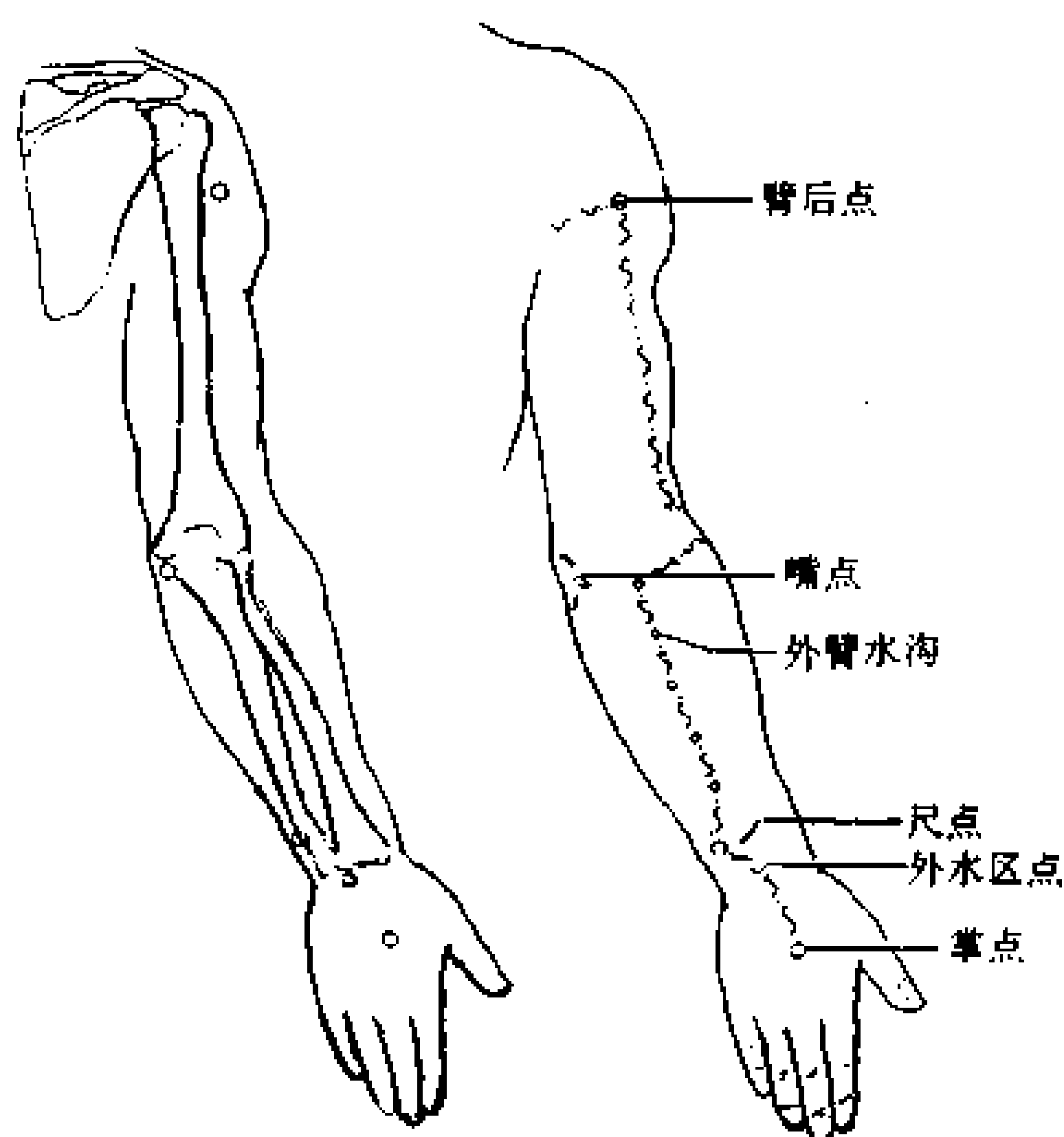


图 4-3

图 4 胆经循行及穴位分布示意图

〔手法〕用点刮法或往疾区域点推。

〔附注〕此穴与魁点对抗，不能同时点按，但可先后施术。

④三叉点

〔定位〕第七颈椎与肩胛骨内上角连线中点。

〔解剖〕有斜方肌、头夹肌分布，深层为肩胛提肌；有颈横动、静脉；布有第一胸神经后支内侧皮支，肩胛背神经和副神经。

〔主治〕落枕，颈椎病，颈痛项强，颈背部挫伤，肩周炎，肺癆。

〔手法〕用点按法，或往疾病区域用点推法。

〔附注〕治疗颈部扭伤时，在此穴上下用提拔法，称之为“三叉筋提拔法”。

⑤ 魁点

〔定位〕肩胛岗内上角。

〔解剖〕在肩胛骨内侧角边缘，表层为斜方肌，深层为肩胛提肌和菱形肌；有颈横动、静脉；布有第一胸神经后支内侧皮支，肩胛背神经和副神经。

〔主治〕肩周炎，颈痛项强，颈椎病，落枕，肩胛炎，肩胛部挫伤。

〔手法〕点按法或点刮法（朝肩部点刮）。

〔附注〕此穴与魄点为对抗穴，不能同时点按，但可先后施术。本穴对肩周炎有特效。

⑥ 抬肩穴

〔定位〕肩胛岗下缘，肩上穴直下方。

〔解剖〕在岗下窝中央岗下肌中；有旋胛动、静脉肌支；布有肩胛上神经。

〔主治〕上肢麻痹，上肢周围神经损伤，风湿痹痛，肩部挫伤，肩周炎，肩胛炎。

〔手法〕点按法或向上点推。

〔附注〕此穴为哲经的主穴。

⑦ 外龙边

〔定位〕肩胛骨外侧缘中上1/3交界处。

〔解剖〕在肩关节后下方，肩胛骨外侧缘，下层是大圆肌；有旋肩胛动、静脉；有腋神经分支最深部上方的桡神经。

〔主治〕肩胛外侧疾患，肩胛外侧部挫伤，肩周炎，肩部风湿痛，上臂酸痛。

〔手法〕用点按法或点刮法、点推法。

〔附注〕此穴与内龙边对抗，不能同时点按，但可先后施术。

⑧后解胸

〔定位〕外龙边穴稍上方，约腋后线上方3厘米处。

〔解剖〕在肩胛骨关节窝后方三角肌中，深层为岗下肌；有旋肱后动、静脉；布有腋神经，深层为肩胛上神经。

〔主治〕胸闷，胸痛，肩周炎，肩部风湿痹痛等。

〔手法〕往外上方点推或用点刮法。

〔附注〕此穴与前解胸穴对抗，不能同时点按，但可先后施术。

⑨肩上穴

〔定位〕肩锁关节上方凹陷处。

〔解剖〕在斜方肌与岗上肌中；深层有肩胛上动、静脉；布有锁骨上神经分支、副神经分支，深层有肩胛上神经。

〔主治〕肩周炎，肩部风湿痹痛，肩臂挛痛不遂，瘰癧，肩部挫伤，肩部骨折、脱位后遗症。

〔手法〕往颈部方向用点推法或点按法、点刮法。

〔附注〕治疗颈椎病常用此穴配椎点。

⑩前解胸

〔定位〕由腋前皱纹呈45°角向内上方3厘米左右处。

〔解剖〕当胸大肌、胸小肌处，内侧深层为第一肋间内、外肌，上外侧有腋动、静脉，胸肩峰动、静脉；布有锁骨上神经中间支，胸前神经分布及第一肋间神经外侧皮支。

〔主治〕胸痛，胸闷，肩周炎，肩背痛，咳嗽，气喘，肩部骨折、脱位后遗症。

〔手法〕往外上方用点推法或点刮法。

〔附注〕此穴与后解胸对抗，不能同时点按，但可以先后施术。

⑪腋点

〔定位〕腋窝中点稍后方（不能举臂取穴）。

〔解剖〕在胸大肌的外下缘，深层为喙肱肌，外侧为腋动脉；布有尺神经、正中神经、前臂内侧皮神经及臂内侧皮神经。

〔主治〕肩部挫伤、肩部骨折、脱位后遗症，肩周炎，肋肋疼痛，咽干烦渴。

〔手法〕往后上方用点刮法，手法宜轻。

〔附注〕穴位准确时，有麻痺或触电感。

⑫臂前点

〔定位〕三角肌前侧缘中点。

〔解剖〕在肱骨桡侧、三角肌中端、肱三头肌外侧头的中缘；有旋肱后动脉的分支及肱深动脉，布有前臂背侧皮神经，深层有桡神经本干。

〔主治〕上臂挫伤，上肢神经损伤，上臂骨折后遗症，筋伤，肩臂痛，颈项拘挛，瘰癧，目疾。

〔手法〕朝臂后点按或用点刮法、冲击法。

〔附注〕此穴与臂后点对抗，不能同时点按，但可先后施术。

⑬嘴点

〔定位〕尺骨鹰嘴与内上髁之间凹陷处稍上方。

〔解剖〕尺神经沟中，为尺侧腕屈肌的起始部；有尺侧上、下副动脉和副静脉以及返动、静脉；布有内侧皮神经、尺神

经本干。

〔主治〕前臂神经损伤、肿痛，癰疽，风湿痹痛，肘部骨折、脱位后遗症，肱骨内上髁炎。

〔手法〕往前方用点刮法或点按法。

〔附注〕穴位准确时，前臂内下侧有麻痹、触电感，此时应用轻手法。

⑭臂水沟

〔定位〕前臂前面与后面正中部位（即尺、桡骨之间从肘关节起至腕横纹止，前后共两条）。

〔解剖〕掌侧有指浅屈肌，深部为指深屈肌；有前臂正中动、静脉，深层为前臂掌侧骨间动、静脉；布有臂内侧皮神经，下为正中神经，深层有前臂掌侧骨间神经。背侧远端指总伸肌和拇长伸肌之间，深层有前臂骨间背侧动脉和前臂骨间掌侧动、静脉；布有前臂背侧皮神经和骨间背侧神经。中上侧指总伸肌和尺侧腕伸肌之间，有前臂骨间背侧动、静脉；布有前臂背侧皮神经，深层有骨间背侧神经和骨间掌侧神经。

〔主治〕前臂挫伤、肿胀，心悸，心痛，胸闷，失眠，眩晕，热病，疟疾，胃痛，癰疽，咳血，呕血，偏头痛，偏瘫，齿痛，耳聋，咽喉肿痛，暴暗，便秘，胁肋痛，耳鸣。

〔附注〕臂水沟穴分布夹在前臂尺桡骨前后之间，手法宜重。

⑮水区点

〔定位〕前臂腕横纹正中，前后各一穴。

〔解剖〕掌侧在掌长肌腱和桡侧腕屈肌腱之间，有拇长屈肌腱和指深屈肌腱；有腕掌侧动、静脉网；当正中神经本干，前臂内侧皮神经。背侧在尺骨和腕骨的关节部、指总伸肌腱

与小指固有伸肌腱之间；下有腕背静脉网，腕背动脉；布有来自尺神经手背支及前臂背侧皮神经末支。

〔主治〕前臂挫伤、肿胀，腕关节扭伤，腕部骨折后遗症，目赤肿痛，耳聋，消渴，疟疾，咽喉肿痛，心痛，心悸，胃痛，胸胁痛，呕吐，癫狂，疮疡。

〔手法〕用点按法或点震法。

〔附注〕背侧水区点不易得气，故在施手法时，手法要重。此穴也可以治疗垂腕症。

⑩牙痛点

〔定位〕在手掌大鱼际肌内侧缘划一条弧线，另从大拇指掌横纹中点作一条垂直线至腕横纹，再从此线中点作一垂直线交叉成 90° 角，把大鱼际肌划分成四个区域：大鱼际肌外侧代表上齿，内侧代表下齿，牙痛时，可在相应的区域内寻找阳性物，一般呈浅红色或紫红色的反应点。男取左手，女取右手。

〔解剖〕有拇短展肌和拇指对掌肌；血管当拇指静脉回流支；布有前臂外侧皮神经和桡神经浅支混合支。

〔主治〕牙痛。亦可治疗发热、咳嗽、咳血、失音、咽喉肿痛。

〔手法〕用小尖物或火柴根代指尖，用点按法或冲击法。

〔附注〕急性牙齿疼痛时，先用酒精棉球消毒穴位后，再用三棱针刺出血。

⑪掌点

〔定位〕第二、三、四掌骨间中点。

〔解剖〕掌侧第二、三、四掌骨间，下为掌筋膜，第二蚓状肌及指浅、深屈肌腱，深层为拇收肌横头起端，有骨间肌；

有指掌侧总动脉；布有正中神经。背侧有骨间肌；手背静脉网及掌背动脉；布有来自尺神经的掌背神经。

〔主治〕垂腕症，颈、腰、掌部扭挫伤及臂风湿痹痛，头痛，耳鸣，耳聋，目赤，热病，咽喉肿痛，心痛，呕吐，癫狂，癰疽，口疮。

〔手法〕掌侧用冲击法或点震法；背侧顺骨间往上方向用点刮法。

〔附注〕此穴分掌、背两侧共4个穴位：背侧第二、三掌骨间之穴，对急性腰部扭挫伤有特效。

⑮尺点

〔定位〕尺骨茎突内上缘（养老穴稍上方）。

〔解剖〕在尺骨背面、尺骨茎突上方、尺侧腕伸肌腱和小指固有伸肌腱之间；布有前臂骨间背侧动、静脉的末支，腕静脉网；有前臂背侧皮神经和尺神经。

〔主治〕垂腕症，腕、掌部扭挫伤，肩、背、肘、臂酸痛，目视不明。

〔手法〕往桡侧用点推法或点刮法。

〔附注〕此穴治疗尺桡骨下端骨折、脱位后遗症有一定疗效。配合转点治疗目视不明效果亦佳。

⑯桡点

〔定位〕曲池穴外上方0.5厘米左右。

〔解剖〕桡侧腕长伸肌起始部，肱桡肌的桡侧；有桡返动脉的分支；布有前臂背侧皮神经，内侧深层有桡神经本干。

〔主治〕手臂肿痛，前臂肌肉萎缩，肘部骨折、脱位后遗症，肘关节风湿痹痛，腹痛，吐泻，热病，目赤痛，齿痛，咽喉肿痛，高血压，癫狂，瘰癧。

〔手法〕用点按法或点刮法。

〔附注〕取穴时宜半屈曲。此穴对治疗桡神经损伤有效。

⑳臂后点

〔定位〕三角肌后缘中点。

〔解剖〕在肱骨上端背面、肱三头肌中；有中侧副动、静脉；布有臂背侧皮神经、桡神经肌支，深层为桡神经。

〔主治〕肩、肘、上臂及肘关节后侧疾病，风湿，扭、挫伤，上臂骨折、脱位后遗症，瘰癧。

〔手法〕朝前方用点按法或用冲击法。

〔附注〕此穴与臂前点对抗，不能同时点按，但可先后施术。

3. 脾胃经

（1）循行分布：起于后心穴，前支出剑突下，沿胸骨柄两侧缘上行；其别支从上肋缘直下，绕脐抵耻骨联合，止于腹股沟中下。后支挟棘突旁上行；止于第七颈椎棘突旁，其别者沿棘突旁下行，止于第五腰椎棘突旁。本经分布在胸、腹部，共有7个穴位（图5）。

（2）主要病候：胸痛，咳嗽，心悸，气喘，噎膈，胃痛，呕吐，泄泻，头痛，热病，月经不调，阳痿，遗精，带下，筋伤，胸胁脘腹部挫伤等证。

（3）主治概要：本经经络点主治胸、腹、头、颈、前阴的局部病证及经络线循行部位的其他病证，大部分经络点可治挫伤，少数经络点可治肋间神经痛。

（4）本经穴位：

①胸点

〔定位〕膻中穴下一横指左右，或两乳头连线中点下一横

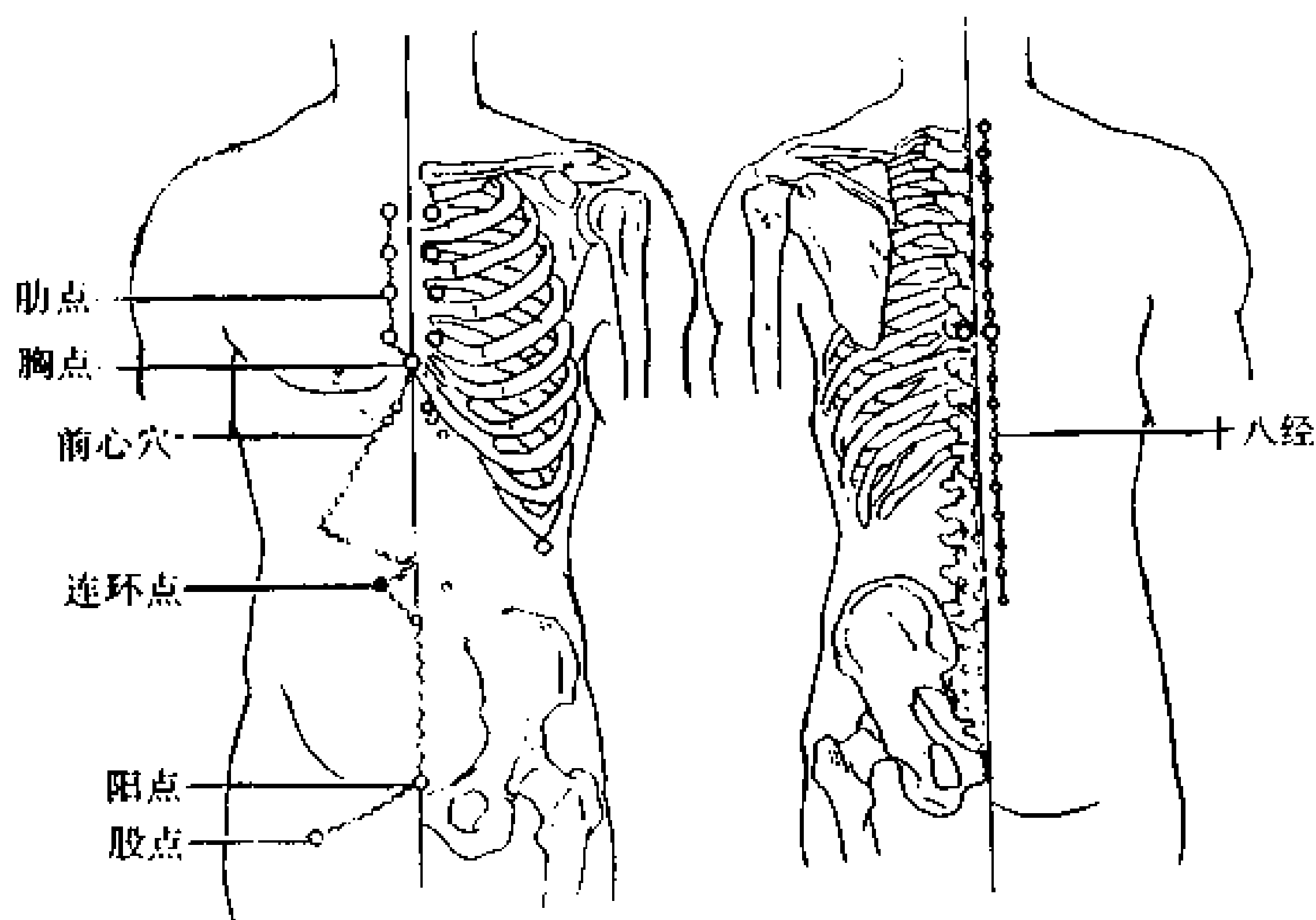


图5 脾胃经循行及穴位分布示意图

指。

〔解剖〕在胸骨体上，有胸廓内动、静脉的前穿支；布有第四、五肋间神经前支的内侧皮支。

〔主治〕胸痛，肋间神经痛，心悸，咳嗽，气喘，噎膈，乳少等。

〔手法〕用点按法或点震法。

〔附注〕此穴在施手法时，手法宜轻。可治疗胸部挫伤、岔气。

②肋点

〔定位〕靠胸骨柄旁诸肋间隙。

〔解剖〕在胸大肌中，有肋间外韧带，肋间内肌；有第1～5肋间动、静脉；布有第1～5肋间神经皮支，深层为第1～5肋间神经。

〔主治〕胸痛，肋间神经痛，咳嗽，气喘，胸胁胀满，呕吐，乳痛，胸部挫伤。

〔手法〕用碎点法或点按法。

〔附注〕此穴每侧共5个穴位。对胸部挫伤、内伤有一定疗效。

③前心穴

〔定位〕剑突下两旁约三横指左右，肋弓下缘。

〔解剖〕在腹直肌内缘；有腹壁上动、静脉分支；布有第6～7肋间神经前支的内侧皮支。

〔主治〕胸痛，上腹部挫伤，胃痛，腹胀，呕吐，泄泻，中暑。

〔手法〕沿肋弓下往外下方点刮，禁止往上点刮或点推。

〔附注〕此穴为脾胃经的主穴，有解除后心穴引起的晕厥。此穴配合后心穴治疗胃痛有特效。

④连环点

〔定位〕绕脐上下左右各二横指处，共4个穴位。

〔解剖〕上有腹壁下动、静脉；布有第八、九肋间神经前支内侧皮支（内部为小肠）。下在腹白线上；有腹壁浅动、静脉分支及腹壁下动、静脉分支；布有第十一肋间神经前支的内侧皮支（内部为小肠）。左右当腹直肌及其鞘处；有第九肋间动、静脉分支及腹壁下动、静脉分支；布有第十肋间神经分支（内部为小肠）。

〔主治〕腹胀肠鸣，绕脐痛，便秘，泄泻，月经不调，症

瘕，痢疾，水肿，小便不通，疝气，带下，崩漏，腹部内伤。

〔手法〕点按法或碎点法，朝顺时针方向旋转。

〔附注〕此穴也可用点转法，但手法不宜过重。

⑤阳点

〔定位〕耻骨联合中点（曲骨穴下方）。

〔解剖〕两侧有锥体肌；有腹壁下动脉及闭孔动脉的分支；布有髂腹下神经的分支。

〔主治〕会阴部疼痛，尿潴留，小儿夜尿症，遗精，阳痿，带下，月经不调。

〔手法〕用点按法或点震法、点揉法。

〔附注〕此穴也可治疗疝气。

⑥股点

〔定位〕腹股沟中点下方约10厘米左右。

〔解剖〕有长收肌，其下为短收肌；有股内侧动脉浅支，布有闭孔神经的浅支和深支。

〔主治〕大腿内上侧挫伤，髌关节脱位后遗症，髌部伤筋，小腹痛，小便不通，睾丸肿痛，阴挺，嗜卧。

〔手法〕用点按法或冲击法。

〔附注〕此穴也可辅助治疗血栓闭塞性脉管炎。

⑦十八经

〔定位〕第七颈椎至第五腰椎棘突旁，在痛点（腰背部）水平上两个椎体间隙旁取穴。

〔解剖〕有腰背筋膜、棘上韧带及棘间韧带；有棘突间静脉丛。布有第八颈神经后支；第一至第十一肋间动脉背侧支和棘突间静脉丛以及各肋间神经后支内侧支；有腰动脉后支，棘突间静脉丛；布有腰神经后支内侧支。

〔主治〕 脊柱两侧疼痛，腰骶痛。

〔手法〕 用点推法或点刮法、点震法。

〔附注〕 此穴分布于第七颈椎至第五腰椎之间，共有 18 个椎体，故称十八经，它以痛点为穴位。

4. 肾经

(1) 循行分布：起于后心穴，沿胸椎侧下行至十二胸椎，旁行抵游离肋下缘，循背至腰骶，经骶髂沿后髂嵴上缘环行，直下止于股骨大粗隆后侧。本经分布在背、腰、骶、臀部及大腿上部，共有 11 个穴位（图 6）。

(2) 主要病候：头痛，胸背痛，腰肌劳损，腰部扭挫伤，热病，癫狂，癫痫，肺癆，胃脘痛，心痛，阳痿，带下，月经不调，水肿，遗尿，耳鸣，气喘，脊背强痛。

(3) 主治概要：本经经络点主治背、腰、胸、腹的局部病证及妇科、伤科某些病证，少数经络点可治疗神志病。

(4) 本经穴位：

①连排点

〔定位〕 第七颈椎至第五腰椎棘突两侧旁开约两横指。

〔解剖〕 上有斜方肌、菱形肌、上后锯肌，最深层为最长肌、背阔肌；有肋间动、静脉后支；有胸神经后支的皮支，深层为胸神经后支外侧支；有腰背筋膜；最长肌和髂肋肌之间，有腰动、静脉后支；布有腰神经后支的外侧支，深层为腰丛。

〔主治〕 腰肌痉挛，小儿麻痹后遗症，咳嗽，发热，项强，头痛，胸背痛，气喘，盗汗，潮热，吐血，心痛，胸闷，呕吐，失眠，腹痛，寒热，梦遗，健忘，黄疸，胁痛，癫狂，痫，惊悸，胃脘痛，肺癆，遗尿，阳痿，带下，月经不调，水肿，耳鸣，耳聋，痛经，痔漏，便秘，泄泻，腰肌劳损，风湿痹

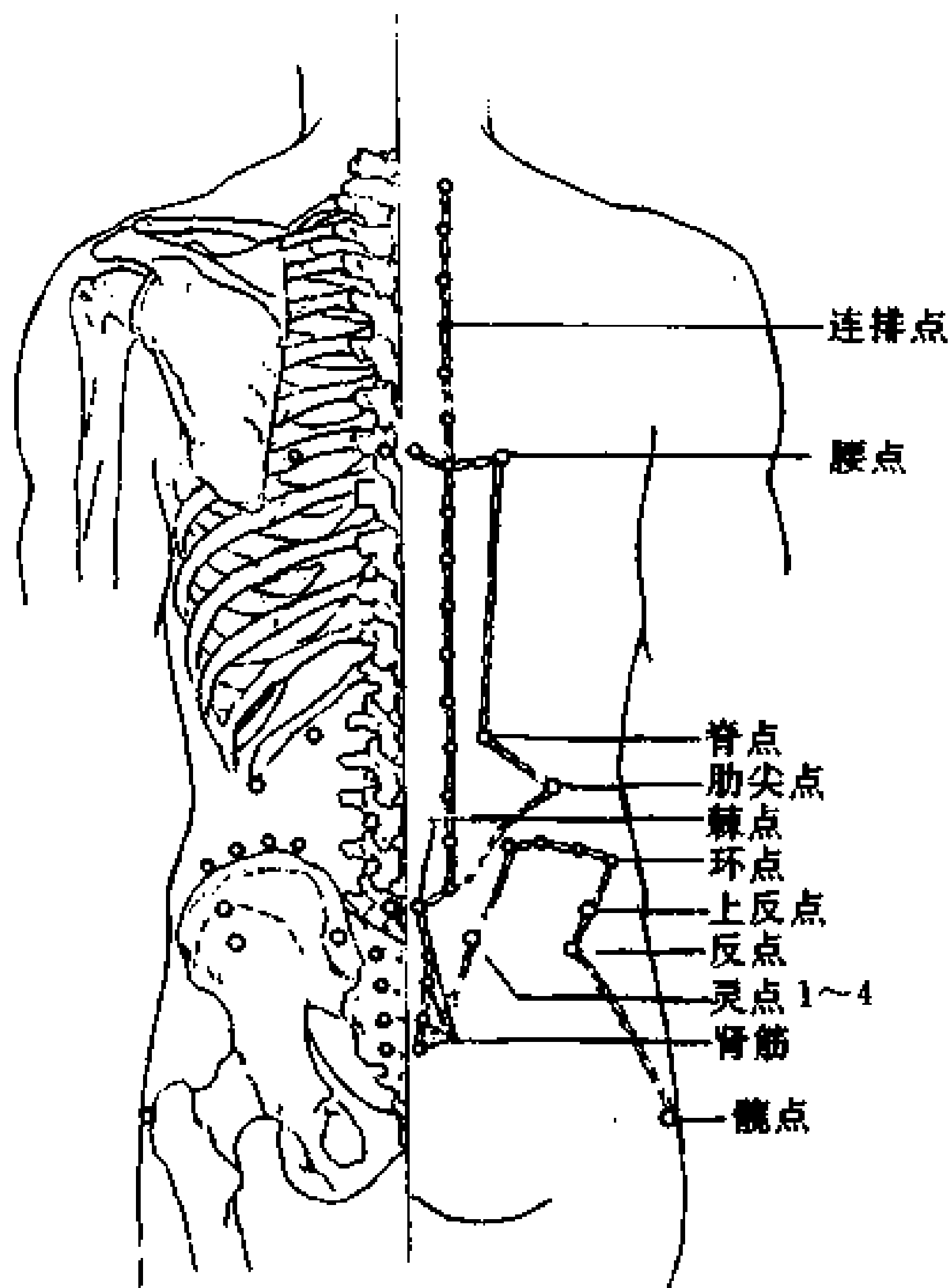


图6 肾经循行及穴位分布示意图

痛。

〔手法〕用碎点法或点揉法、点震法，可结合捏脊法。

〔附注〕此穴对急性腰部扭伤有特效。施手法时以食、中两指分开同时在脊椎的两侧点按。

②腰点

〔定位〕肩胛骨内侧缘中下 1/3 交点，取健侧穴。

〔解剖〕在背阔肌、髂肋肌；有第七肋间动、静脉背侧支；布有第六胸神经后支。

〔主治〕急性腰部扭伤，腰肌劳损，肩胛下角炎，胸闷，暖气，呕吐，脊背强痛。

〔手法〕往内下方向用点刮法或点推法。如左侧腰部扭伤取右侧（健侧）点按。此穴为肾经主穴。

〔附注〕如果扭伤在腰骶部，两侧穴位均要点按。

③脊点

〔定位〕第十二肋骨下缘与第一腰椎水平交界处。

〔解剖〕有背阔肌、髂肋肌；有肋下动、静脉背侧支；布有第十二、十三胸神经后支。

〔主治〕急性腰部扭、挫伤，胃脘痛，腹胀，小儿食积，水肿，脊背痛。

〔手法〕用点震法或点按法。

〔附注〕此穴可治疗急性胆囊炎（右侧穴）。

④肋尖点

〔定位〕第十二肋骨末端下缘（京门穴下后方）。

〔解剖〕有腹外斜肌、腹内斜肌及腹横肌；有第一肋间动、静脉；布有第十一肋间神经。

〔主治〕腰肌痉挛，小便不利，水肿，腰痛，胁痛，腹胀，泄泻。

〔手法〕用点按法或点揉法。

〔附注〕右侧穴对急性胆囊炎、胆道蛔虫有一定疗效。

⑤棘点

〔定位〕第五腰椎棘突下。

〔解剖〕有腰背筋膜、棘上韧带及棘间韧带；有腰动脉后

支，棘突间静脉丛；布有腰神经后侧支。

〔主治〕急性腰部扭、挫伤，腰骶痛，下肢痿痹，阳痿，遗精，月经不调。

〔手法〕用点刮法或点推法。

〔附注〕往脊椎上方点推或点刮可治疗骶椎疾患，往下方则可治疗腰椎疾患。

⑥灵点（灵1、灵2、灵3、灵4）

〔定位〕各骶骨孔外上方0.5厘米左右，第一骶骨孔外侧为灵1，其余依次类推（八穴外上方）。

〔解剖〕灵1：在骶棘肌起始部及臀大肌起始部，当骶外侧动、静脉后支处，布有第一骶神经后支。灵2：在臀大肌起始部，当骶外侧动、静脉后支处；在第二骶神经后支通过处稍外上方。灵3：在臀大肌起始部，当骶外侧动、静脉后支处；在第三骶神经后支通过处稍外上方。灵4：在臀大肌起始部；有臀下动、静脉分支；当第四骶神经支通过处稍上方。

〔主治〕灵1治腰痛，大小便不利，遗精，阳痿，妇女月经不调，带下，阴挺。灵2、灵3治腰骶关节痛，疝气，腰痛，遗精，下肢痿痹，便秘，泄泻，小便不利，妇女月经不调，带下，痛经。灵4治骶尾部酸痛，尾骨骨折、脱位后遗症，腹痛，小便不利，腰痛，便秘。

〔手法〕往内上方用点按法或点刮法。

〔附注〕灵点又称为“八灵穴”。

⑦肾筋

〔定位〕骶髂关节稍外上方。

〔解剖〕在骶棘肌起始部和臀大肌起始部之间；有骶外侧动、静脉后支；布有臀中皮神经分支。

〔主治〕急性腰部扭、挫伤，坐骨神经痛，小便不利，遗尿，腰脊强痛，泄泻，便秘。

〔手法〕向内上方用点刮法或点推法、冲击法。

〔附注〕此穴常配合腰点、连排点治疗急性腰部扭伤，疗效甚佳。

⑧环点

〔定位〕后髂嵴上缘。

〔解剖〕有背筋膜、最长肌和髂肋肌；有第四腰动、静脉后支；布有第三、五腰神经皮支、后支。

〔主治〕腰痛，梨状肌综合征，臀上皮神经损伤，下肢麻痹，便秘，泄泻，腹胀，遗尿，小便频数或小便不利。

〔手法〕沿后髂嵴上缘由内向外用碎点法。

〔附注〕此穴在后髂嵴上一般有5个穴位。

⑨反点

〔定位〕血筋穴偏外方凹陷处（相当于跃进穴外上方）。

〔解剖〕有臀大肌、臀中肌及臀小肌；正当臀上动、静脉；布有臀上皮神经，深层为臀上神经。

〔主治〕腰部扭、挫伤，髋部扭伤，腰脊强痛，便秘，癃闭，肠鸣，腹胀。

〔手法〕往外上方用点推法或点刮法。

〔附注〕此穴禁往内下方向点推或点刮。

⑩上反点

〔定位〕反点的稍上方（约半横指）。

〔解剖〕同反点。

〔主治〕腰、髋酸痛。余同反点。

〔手法〕往外上方用点推法或点刮法。

〔附注〕此穴对臀上皮神经损伤有疗效。

⑪髌点

〔定位〕股骨大粗隆后缘。

〔解剖〕在浅层为阔筋膜张肌，深部为股外侧肌；有旋髂浅动、静脉升支及旋股外侧动、静脉分支；布有股外侧皮神经。

〔主治〕股骨上段骨折，髌关节脱位后遗症，髌关节筋伤，下肢痿痹，疝气。

〔手法〕碎点法或点按法，手法宜重。

〔附注〕此穴可治疗坐骨神经痛。

5. 龙经

（1）循行分布：起于后心穴，分支挟胸脊柱上行至第七颈椎旁，下行沿胸腰椎抵后髂嵴，其别支抵尾骨尖上，沿下入坐骨结节处，循大腿后侧至胸部，直下抵后跟上，沿内踝下，止于足背；另别支经髂前上嵴，循大腿前抵膝，沿胫骨外缘直下，抵外踝下，入踝前凹陷中，会合于足背中。本经分布在背、腰、臀部及下肢，共有 28 个穴位（图 7）。

（2）主要病候：胸背痛，心痛，胃脘痛，腹痛，风湿痹痛，胁痛，咳嗽，气喘，发热，吐血，失眠，健忘，阳痿，遗精，耳鸣，癫痫，月经不调，带下，腰、背、臀、腿部挫伤等证。

（3）主治概要：本经经络点主治背、腰、胸、腹、臀的局部病证及某些妇科、伤科疾病，少数经络点可治神志病。

（4）本经穴位：

①十八转

〔定位〕第七颈椎至第五腰椎棘突两旁 1.5 厘米左右。

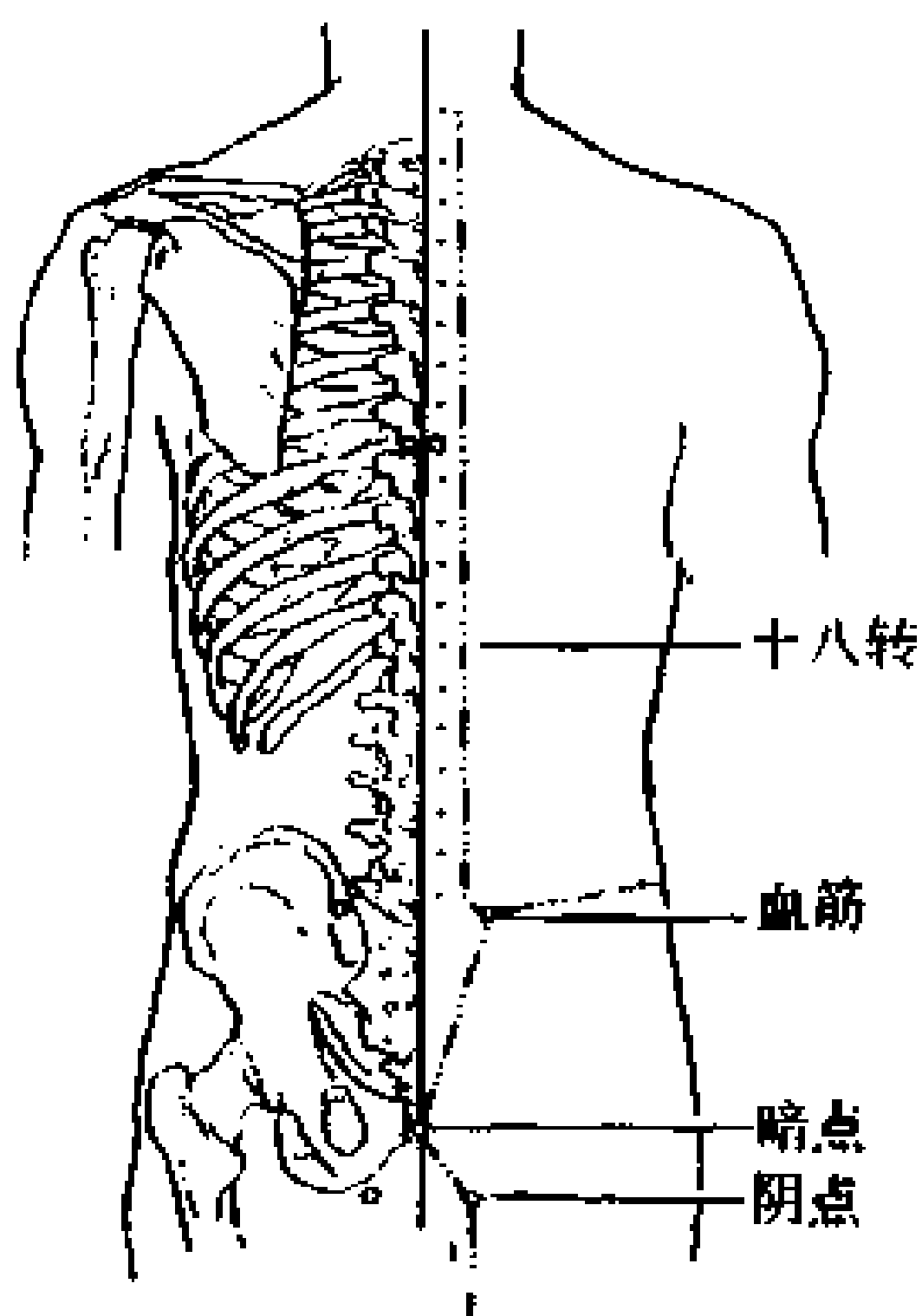


图 7-1

〔解剖〕胸段有斜方肌、菱形肌、上后锯肌，深层为最长肌；有肋间动、静脉后支；布有胸神经后支的皮支，深层为胸神经后支外侧支；腰段有腰背筋膜，在最长肌和肋肌之间，有腰动、静脉后支；布有腰神经后支的外侧支，深层为腰丛。

〔主治〕腰肌劳损，腰部扭伤、挫伤，胸腰椎骨折后遗症，腰椎间盘突出症，风湿痹痛，咳嗽，发热，项强，胸背痛，气喘，吐血，潮热，盗汗，胸闷，心痛，胃痛，呕吐，惊悸，失眠，健忘，癰疽，腹痛，寒热，黄疸，胁痛，目赤，遗精，阳痿，月经不调，带下，遗尿，水肿，耳鸣，耳聋，腹胀，泄泻，便秘，痢疾，尿血，痔疾，疝气，腰骶痛。

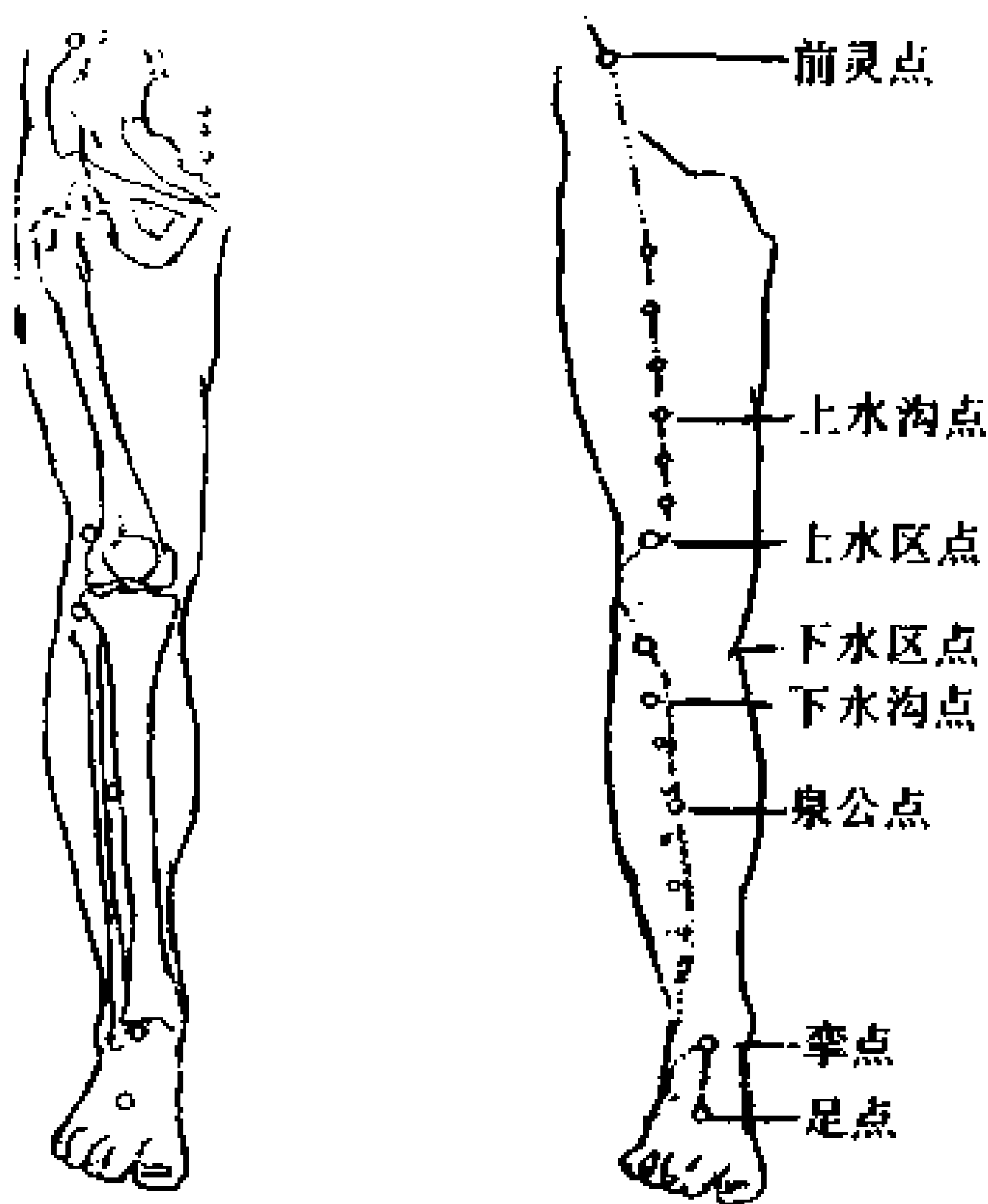


图 7-2

〔手法〕 两手指分别同时在脊柱两旁朝上下相反方向来回反复用点推法或碎点法。

〔附注〕 临床实践，此穴对小儿麻痹后遗症有效。

②血筋点

〔定位〕 后髂嵴下 3 厘米稍内方（跃进穴内上方）。

〔解剖〕 有臀大肌、臀中肌及臀小肌；正当臀上动、静脉，布有臀上皮神经，深层为臀上神经。

〔主治〕 坐骨神经痛，梨状肌综合征，臀上皮神经损伤，臀部挫伤，腰脊强痛，癃闭，便秘，腹胀，肠鸣。

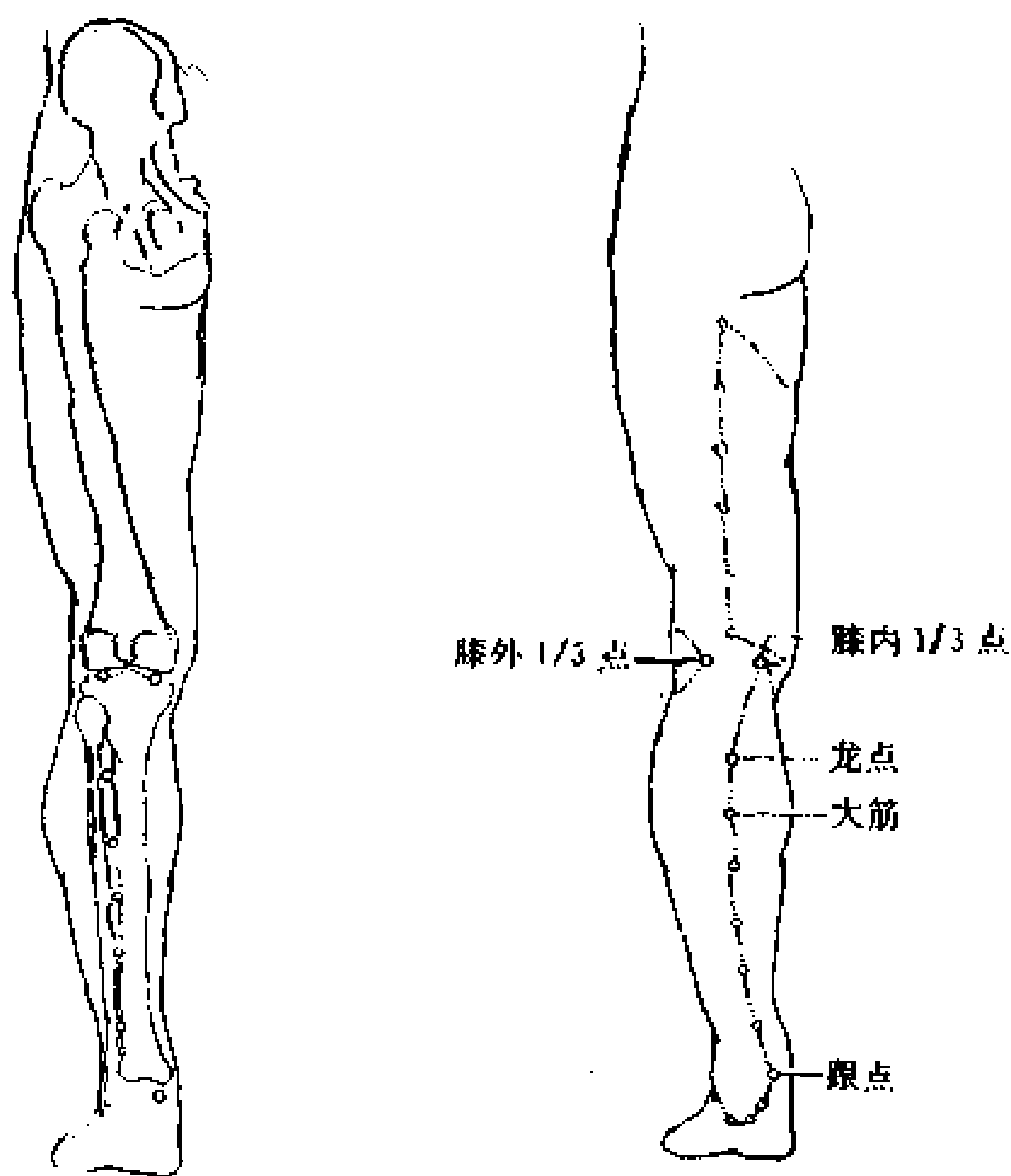


图 7-3

〔手法〕用点按法或往下方向用点推法，禁往上方点推或点刮。如因手法失误而出现胸闷头晕等不良反应时，即在原穴上用点推法向下方向迅速点推几下，症状即解。

〔附注〕此穴为龙经的主穴。穴位准确时有触电感。

③暗点

〔定位〕尾骨尖上缘（长强穴上方）。

〔解剖〕有肛门动、静脉分支，有棘突间静脉丛的延续部；

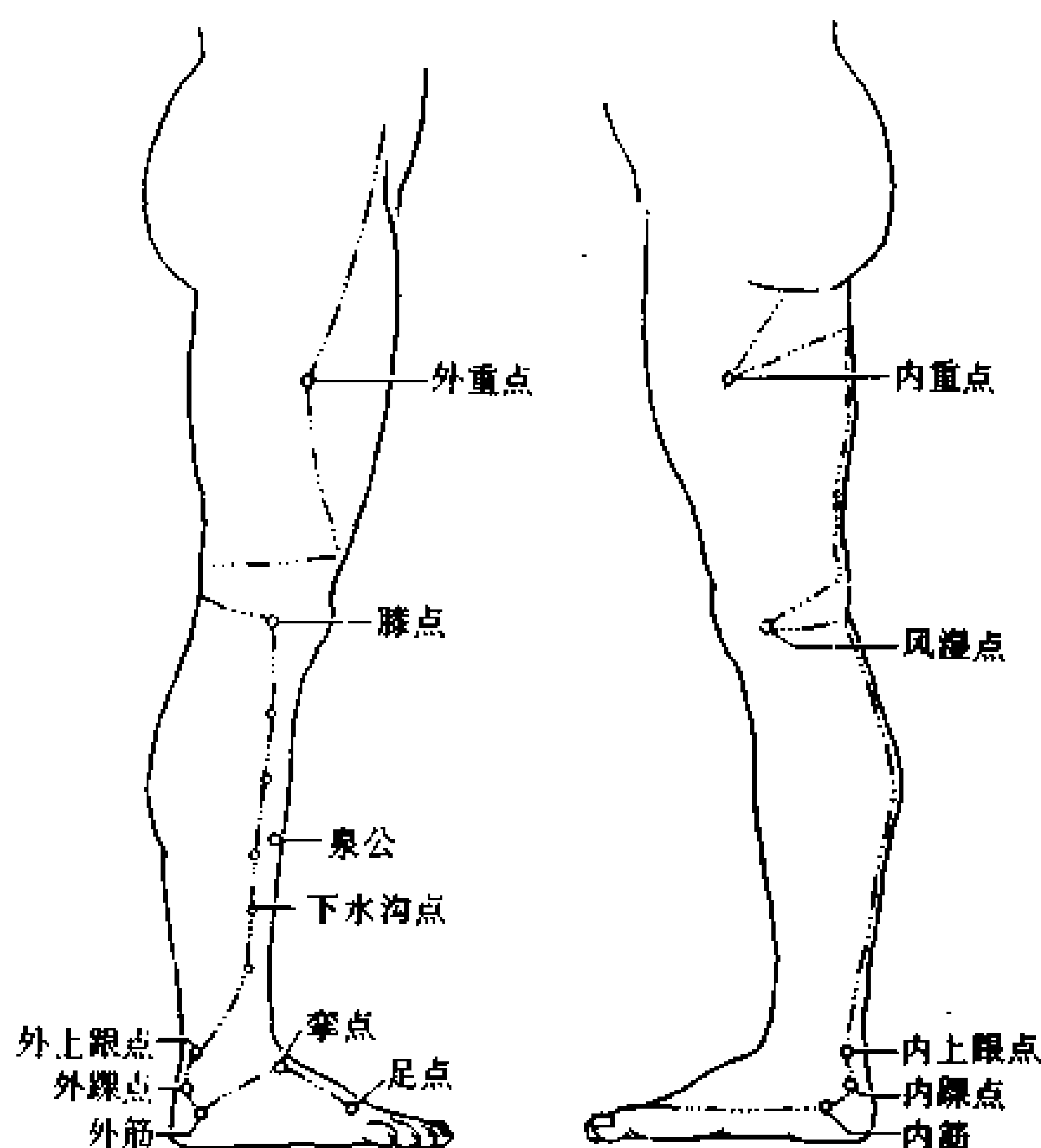


图 7-4

图 7 龙经循行及穴位分布示意图

布有尾神经后支及肛门神经。

〔主治〕 骶尾部骨折、脱位后遗症，骶尾部挫伤，便秘，泄泻，便血，痔疾，脱肛，癫狂，癫痫。

〔手法〕 往上方用点刮法或点震法、点冲法。

〔附注〕 此穴施术时手法宜重。

④阴点

〔定位〕 坐骨结节内侧缘。

〔解剖〕在耻骨结节下方，有长收肌，其下为短收肌；有股内侧动脉浅支，布有闭孔神经的浅支和深支。

〔主治〕内收肌劳损，髋关节伤筋，髋关节脱位后遗症，小腹痛，小便不通，阴挺，睾丸肿痛，嗜卧，瘰癧。

〔手法〕往外上方用点按法或点刮法。

〔附注〕临床实践对疝气治疗有效。

⑤上水沟（后侧）

〔定位〕大腿后侧中线。

〔解剖〕后侧在臀大肌下缘处；有坐骨神经伴行动静脉；有股后皮神经，深层为坐骨神经；中段有半腱肌与股二头肌，深层为大收肌；外侧为股深动、静脉第三穿支；布有股后皮神经，深层正当坐骨神经。下段有股二头肌腱，有膝上外动、静脉；布有股后皮神经，正当腓总神经处。

〔主治〕腰、骶、臀、股部疼痛，下肢肿胀，下肢痿痹，便秘，股部疼痛、麻木，腿足挛痛。

〔手法〕从下往上方用碎点法。

〔附注〕此穴从膈横纹中点上一寸起，每隔一横指为一穴，至臀横纹中央下一横指止。

⑥内重点

〔定位〕前灵点与风湿点连线的中点。

〔解剖〕在缝匠肌内侧缘，深层为大收肌；有大隐静脉，深层之外方股动、静脉；布有股前皮神经，深部有隐神经。

〔主治〕缝匠肌损伤，腹股沟肿痛，遗尿，小便不利，大腿内侧挫伤，膝关节风湿肿痛，膝关节扭伤。

〔手法〕用点按法或点冲法。手法宜重。

〔附注〕此穴可治疗股骨干骨折后遗症。

⑦风湿点

〔定位〕膝关节内侧间隙处（内膝眼内侧旁开2厘米）。

〔解剖〕在胫骨内前侧上缘和腓肠肌之间，比目鱼肌起点上方；前方有隐静脉，膝最上动脉，最深层有胫后动、静脉；布有小腿内侧皮神经本干，最深层有胫神经。

〔主治〕膝关节风湿肿痛及膝部扭挫伤，膝内侧半月板损伤，膝关节积液、水肿，小便不利或失禁，黄疸，腹胀，泄泻。

〔手法〕点按法或点刮法。

〔附注〕穴位准确时局部有酸胀感。

⑧膝内1/3点

〔定位〕腘横纹中内1/3交界处（阴谷穴内下方）。

〔解剖〕有腘筋膜，皮下有股腘静脉，深层内侧为腘静脉，最深层为腘动脉；有股后皮神经，正当胫神经处内侧。

〔主治〕膝关节风湿、积液、扭挫伤，内侧半月板损伤后遗症，下肢痿痹，腰痛，吐泻，丹毒，小便不利。

〔手法〕用点按法或点震法。

〔附注〕取穴时，患者取侧卧位，膝半屈曲。

⑨龙点

〔定位〕腘横纹中点直下四横指处。

〔解剖〕在腓肠肌两肌之间；有小隐静脉，深层为胫后动、静脉；布有腓肠内侧皮神经，深层为胫神经。

〔主治〕颈椎病早期，下肢痿痹，腰腿拘急疼痛，腰脊强痛，腓肠肌痉挛，踝关节扭伤。

〔手法〕用点按法或点冲法。

〔附注〕此穴为龙经的主穴。治疗早期颈椎病时，可用上

述手法，也可用揉捏法。嘱患者俯卧位，双腿、足用力伸直，然后术者用拇、食、中、无名指在穴位处连续揉捏约1分钟后略停片刻，如此反复5~6次。

⑩大筋

〔定位〕自龙点下一横指起沿腓肠肌中线往下至跟腱上方的一条区域。

〔解剖〕其上段有腓肠肌、小隐静脉，深层为胫后动、静脉；布有腓肠肌内侧皮神经，深层为胫神经；中段有腓肠肌及比目鱼肌；布有腓肠外侧皮神经；下段有跟腱，深层为拇长屈肌；有小隐静脉，深层为腓动脉末支；布有腓肠神经。

〔主治〕腓肠肌及比目鱼肌损伤，下肢痿痹，腰腿拘急疼痛，头痛，目眩，痔疾，腰骶疼痛，内翻型踝关节扭伤。

〔手法〕用碎点法或结合点冲法。

〔附注〕此穴由龙点下一横指起，每隔一横指为一穴。施术时由上而下。

⑪跟点

〔定位〕跟骨结节后上方。

〔解剖〕在腓骨的后部、跟腱中前缘，深层有拇长屈肌；有小隐静脉，深层为腓动脉末支；布有腓肠神经。

〔主治〕踝关节扭挫伤、肿痛，下肢痿痹，腰骶疼痛，跟骨骨折后遗症，踝关节脱位后遗症。

〔手法〕往下方用点刮法，手法宜重。

〔附注〕此穴敏感性较差，故宜用重手法，或用拇、食指揉捏穴位。可治疗头痛。

⑫内踝点

〔定位〕内踝尖端上2厘米与跟腱水平线后1/3点（太溪

穴的后上方)。

〔解剖〕前方有胫后动、静脉；布有小腿内侧皮神经、当胫神经通过处。

〔主治〕跖跗关节扭伤，内踝骨折后遗症，月经不调，阳痿，遗精，消渴，咳血，气喘，咽喉肿痛，便秘，小便频数。

〔手法〕往后下方用点刮或点推法。

〔附注〕此穴敏感性较强，故宜用轻手法。治疗跖跗关节扭伤时，手法宜改向足背方向点刮。

⑬内上跟点

〔定位〕内踝下缘与跟腱水平线后 1/3 凹陷处。

〔解剖〕在跟腱附着部的内前缘，有胫后动脉的跟内侧支；布有小腿内侧皮神经，当胫神经的跟骨内侧神经通过处。

〔主治〕咳血，气喘，遗尿，便秘，癃闭，痴呆，足跟痛，跖跗关节扭、挫伤，踝关节扭伤。

〔手法〕往后方用点刮法。

〔附注〕此穴敏感性较强，手法不宜过重。穴位准确时，踝内侧有酸胀感。

⑭内筋

〔定位〕内踝下后缘（照海穴后方）。

〔解剖〕在内踝下方，拇趾外展肌止点；后下方为胫后动、静脉，布有小腿内侧皮神经，深部为胫神经本干。

〔主治〕小便频数，月经不调，带下，阴挺，癃闭，便秘，失眠，癫痫，踝关节骨折、脱位后遗症，跖跗关节扭伤。

〔手法〕向内后下方用点刮法，禁向踝关节内点按。

〔附注〕此穴极敏感，手法宜轻。穴位准确时有麻、酸、胀感。

⑮足点

〔定位〕足背第二、三跖骨间中点（在陷谷穴上方）。

〔解剖〕在第二、三跖骨间隙间，有骨间肌；有足背静脉网，深层有第二跖背动脉；布有腓浅神经足背支。

〔主治〕足背肿痛，踝关节扭挫伤，足部骨折后遗症，脉管炎，目赤肿痛，面浮身肿，肠鸣腹痛，热病。

〔手法〕往上方或下方用点刮法。

〔附注〕治疗踝关节扭伤或踝部骨折后遗症时，手法应向上方点刮。

⑯前灵点

〔定位〕髂前上棘内侧缘。

〔解剖〕在髂前上棘前内方，有腹内、外斜肌，腹横肌；有旋髂浅、深动脉和静脉；布有髂腹下神经。

〔主治〕腹痛，便秘，疝气，阴挺，带下，下肢痿痹，髂髂关节扭伤、脱位后遗症，大腿挫伤肿痛。

〔手法〕往外下方用点刮法或点推法。

〔附注〕此穴常与阴点配合治疗股骨头缺血性坏死。

⑰上水沟

〔定位〕大腿前中线。

〔解剖〕上段有缝匠肌和阔筋膜张肌；深层有旋股外侧动、静脉分支；布有股外侧皮神经；中段有股直肌；有旋股外侧动、静脉分支；布有股前皮神经，股外侧皮神经；下段有股直肌和股外侧肌；有旋股外侧动脉降支；布有股前皮神经，股外侧皮神经。

〔主治〕下肢痿痹，腹痛，腰痛膝冷，疝气，脚气，胃痛，血尿，乳痛，膝关节风湿痹痛，大腿挫伤，股骨干骨折后遗

症。

〔手法〕 从下往上方用碎点法。

〔附注〕 此穴从髌骨上缘中点一横指上，每隔一横指一个穴，至腹股沟中点下四横指止。

⑮外重点

〔定位〕 前灵点与膝点连线的中点（风市穴稍上前方）。

〔解剖〕 在阔筋膜张肌下，股外侧肌中；有旋股外侧动、静脉肌支；布有股外侧皮神经；股神经肌支。

〔主治〕 下肢痿痹，遍身瘙痒，脚气，大腿侧挫伤，膝关节风湿痹痛，膝关节积液。

〔手法〕 用点按法或点冲法。

〔附注〕 此穴取法可用患者手臂垂直，中指尖下为风市穴，食指下即是本穴。

⑯上水区点

〔定位〕 髌骨上缘稍外方凹陷处。

〔解剖〕 有股直肌和股外侧肌，有旋股外侧动脉降支；布有股前皮神经，股外侧皮神经。

〔主治〕 膝关节风湿痹痛，膝关节积液，髌骨骨折、脱位后遗症，下肢不遂，外侧半月板损伤，血尿，胃痛。

〔手法〕 点按法，或往上方用点刮、点推法。

〔附注〕 此穴配合风湿点治疗膝关节风湿痹痛效果较好。

⑰膝点

〔定位〕 膝关节外侧间隙处，腓骨小头上缘（犊鼻穴外侧旁开2厘米）。

〔解剖〕 在髌韧带外缘；有膝关节动、静脉网；布有腓肠外侧皮神经及腓总神经关节支。

〔主治〕 下肢麻痹、屈伸不利，脚气，外侧半月板损伤，膝关节风湿痹痛，膝关节积液，膝关节韧带损伤。

〔手法〕 用点按法或点刮法。

〔附注〕 此穴敏感性较差，故手法宜重，“得气”后手法转轻。

②1 膝外 1/3 点

〔定位〕 在脛横纹中外 1/3 交界处（委阳穴的稍外侧）。

〔解剖〕 在股二头肌腱内侧；有膝上外侧动、静脉；布有股后皮神经，正当腓总神经处。

〔主治〕 下肢麻木，股部疼痛，便秘，外侧半月板损伤，膝关节风湿痹痛，股骨下端骨折后遗症。

〔手法〕 点按法或朝外侧用点刮法。

〔附注〕 取穴时膝关节呈半屈曲位。

②2 下水区点

〔定位〕 胫骨结节稍外下方凹陷处。

〔解剖〕 在髌骨韧带外缘下，有膝关节动、静脉网；布有腓肠侧外皮神经及腓总神经关节支。

〔主治〕 下肢麻痹，风湿肿痛，屈伸不利，脚气，膝痛，膝关节积液，膝部扭挫伤。

〔手法〕 用点按法或用点冲法、点震法。

〔附注〕 此穴敏感性较差，手法宜重。

②3 下水沟

〔定位〕 小腿前面、胫腓骨间隙的一条线。

〔解剖〕 上段有胫前肌，趾长伸肌之间；有胫前动、静脉；为腓肠外侧皮神经及隐神经的皮支分布处，深层为腓神经；中、下段为胫前肌与趾长伸肌之间，深层为拇长伸肌；有胫

前动、静脉；布有腓浅神经分支，深层为腓深神经。

〔主治〕下肢麻痹，虚劳羸瘦，胃痛，呕吐，腹胀，泄泻，肠痈，水肿，癫狂，便秘，转筋，跗肿，腰脊痛引睾丸，乳痈，小腿挫伤，胫腓骨骨折后遗症。

〔手法〕由下往上方用碎点法或点冲法。

〔附注〕此穴从足三里穴下起，每隔一指为一穴，至犊点上三横指止。

②④泉公

〔定位〕胫骨中点的外侧缘（在条口穴稍下方）。

〔解剖〕在胫前肌中；有胫前动、静脉；布有腓骨外侧皮神经及隐神经的皮支，深层当腓深神经。

〔主治〕下肢痿痹，胫腓骨干骨折后后遗症，小腿挫伤，腕腹疼痛，转筋，跗肿。

〔手法〕用点冲法或点按法。

〔附注〕施术时如穴位不敏感，可用重手法往胫骨缘方向点刮。

②⑤外踝点

〔定位〕外踝与跟腱水平线后 1/3 点（昆仑穴后上方）。

〔解剖〕有腓骨短肌；有小隐静脉及外踝后动、静脉；布有腓肠神经。

〔主治〕踝关节内翻扭伤，踝部骨折后后遗症，腰骶疼痛，足跟疼痛，头痛，项强，目眩，难产，癫痫，鼻蛆。

〔手法〕往后下方用点刮法。

〔附注〕孕妇禁用此穴。

②⑥外上跟点

〔定位〕外踝下缘与跟腱水平线后 1/3 凹陷处（昆仑穴后

下方)。

〔解剖〕有腓动、静脉的跟骨外侧支；布有腓肠神经跟骨外侧支。

〔主治〕足跟痛，踝关节扭伤，踝部骨折后遗症，下肢痿痹，癫痫，跖跗关节扭伤。

〔手法〕往后下方用点刮法或点推法。

〔附注〕穴位准确时，局部有酸胀感，手法不宜过重。

②⑦外筋

〔定位〕外踝后下缘跟腱（申脉穴的后方）。

〔解剖〕在腓骨长短肌腱上缘；有外踝动脉网及小隐静脉；布有腓肠神经的足背外侧皮神经分支。

〔主治〕踝关节扭伤，腰腿酸痛，目赤痛，失眠，头痛，眩晕，癫狂，癫痫，跖骨骨折后遗症。

〔手法〕向后下方用点刮法或点推法。禁向前上方点按。

〔附注〕此穴敏感性很强，手法宜轻。穴位准确时，局部有酸、麻、胀感。

②⑧挛点

〔定位〕踝关节前方正中凹陷处稍外方。

〔解剖〕在拇长伸肌腱与趾长伸肌腱之间；有胫前动、静脉；浅部当腓浅神经，深层当腓深神经。

〔主治〕下肢痿痹，便秘，头痛，眩晕，癫狂，腹胀，踝关节扭、挫伤。

〔手法〕往外方或往前下方用点刮法。

〔附注〕治疗踝关节扭伤时，手法宜用点按法。

6. 经外线

(1) 循行分布：起于后心穴，循背颈侧上行抵乳突前，下

行颈外侧至锁骨下中点，经胸膺至腋前下第六肋间，抵肋下缘直下止于腹股沟中点。本经主要分布在胸、腹及头部，共有 6 个穴位（图 8）。

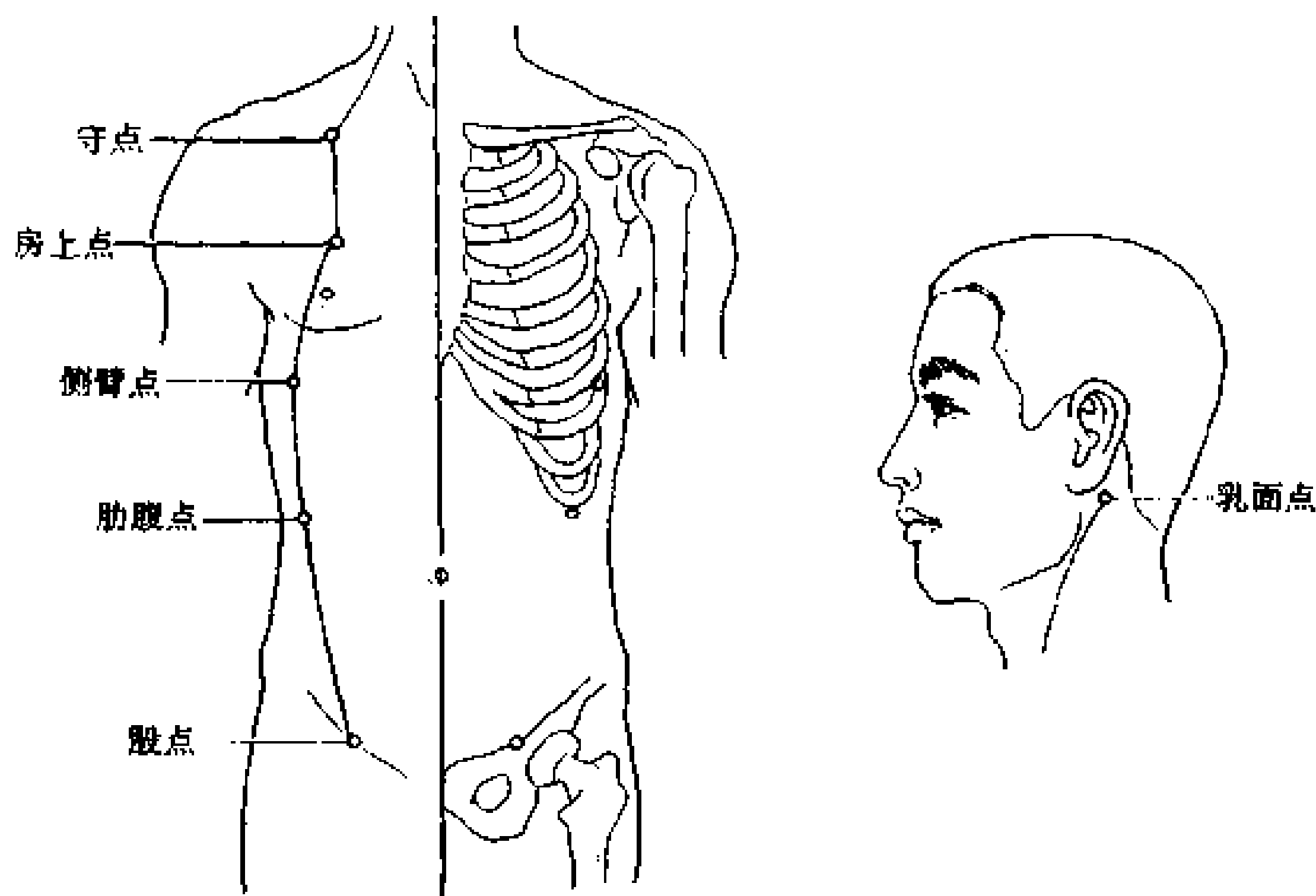


图 8 经外线循行及穴位分布示意图

(2) 主要病候：耳鸣，口眼喎斜，颜面神经麻痹，胸痛，气喘，呃逆，胁痛，腹痛，上肢风湿痛，上肢挫伤，疝气等。

(3) 主治概要：本经经络点主治头、胸、胁、腹、前阴、伤科某些疾病以及经络线循行部位的其他病症。

(4) 本经穴位：

①乳面点

〔定位〕乳突前方凹陷处（翳风穴稍上方）。

〔解剖〕有耳后动、静脉，颈外浅静脉；布有耳大神经，深层有面神经干从茎乳突穿出处。

〔主治〕 耳鸣，耳聋，口眼喎斜，颊肿，齿痛，下颌关节弹响症，乳突麻痹，颜面神经麻痹，牙关紧闭，瘰癧。

〔手法〕 往后下方用点刮或点按法，手法不宜过重。

〔附注〕 此穴可治疗三叉神经痛。

②守点

〔定位〕 锁骨中点下缘（气户穴外上方）。

〔解剖〕 在锁骨中下方、胸大肌起始部，深层上方为锁骨下肌；有胸肩峰动、静脉分支，外上方为锁骨下静脉；为锁骨上神经、胸前神经分支分布处。

〔主治〕 胸部内伤，胸痛，胸胁支满，咳嗽，气喘，呃逆。

〔手法〕 往下方用点刮或点按法。

〔附注〕 禁向上方点推，手法不宜过重。

③房上点

〔定位〕 第三肋间与锁骨中线交点（膺窗穴外方）。

〔解剖〕 第三肋间隙，有胸大肌，深层为肋间内、外肌；有胸外侧动、静脉；布有胸前神经分支。

〔主治〕 咳嗽，气喘，乳痈早期，胸胁胀痛，胸部挫伤。

〔手法〕 用点按法或用点震法。

〔附注〕 气血胸及乳痈中晚期禁止点按此穴。

④侧臂点

〔定位〕 第六肋间与腋前线交点。

〔解剖〕 有前锯肌和肋间内、外肌；有胸腹壁静脉；胸外侧动、静脉及第六肋间动、静脉；布有第六肋间神经外侧皮支，胸长神经分支。

〔主治〕 胸胁挫伤，胸满，胁痛，上肢痹痛。

〔手法〕 用点按法或点震法、点揉法。

〔附注〕此穴治疗胸胁部内伤效果较好，手法不宜过重。

⑤肋腹点

〔定位〕肋缘与锁骨中线交点（章门穴内上缘）。

〔解剖〕腹内、外斜肌及腹横肌中；有第十肋间动脉末支；布有第十、十一肋间神经（右侧当肝脏下缘，左侧为脾脏下缘）。

〔主治〕季肋部挫伤，胁痛，痞块，腹胀，泄泻。

〔手法〕用点按法或点揉法，手法宜轻。

〔附注〕此穴对胁部内伤之伤气型有较好的疗效。

⑥股点

〔定位〕腹股沟中点稍内方（急脉穴稍外下方）。

〔解剖〕有阴部外动、静脉的分支及腹壁下动、静脉的耻骨支，外方有股静脉；布有髂腹股沟神经，深层为闭孔神经的分支。

〔主治〕下肢痹痛，内收肌劳损，髋关节伤筋，股骨头缺血性坏死，小腹痛，阴挺，疝气。

〔手法〕用点按法或点揉法，手法宜轻。

〔附注〕此穴可作股骨头缺血性坏死的辅助治疗。

三、点穴疗法基本手法及操作

传统点穴疗法除了取穴准确外，手法的选择是否得当，操作的方向是否正确；指力的运用是否适宜，这些因素将直接影响到治疗的效果。在运用手法时，须根据病人体质的强弱、胖瘦，病情的轻重缓急，机体的反应和穴位的不同等情况，采用不同的手法。在指力的运用上要达到一定的刺激量，才能

取效。如某种疾患取相应的穴位点按尚难达到效果时，可加大指力，当达到其有效的刺激量时，常可取得立竿见影的效果。遇到产生酸痛感的穴位，采取适当的指力点按，不但不会增加病人的痛苦，而且可取得良性反应，提高疗效。如果点按某些穴位时，病人感到酸痛难忍，则应改用揉按或其它手法，以免增加痛苦，而产生反作用。有些穴位，如后心穴，不能往脊柱方向点推；前心不能往心窝部点推；背筋穴不能往肩胛内推；内筋穴与外筋穴不能向踝关节内推等。因此，手法的选择与操作以及指力的运用是点穴疗法的关键，值得充分重视。

（一）基本手法

1. 点冲法 以食指或中指为主，微屈掌指关节与指间关节。指尖垂直对准并点压在穴位上，然后迅速用力地朝穴位内冲击，而指尖始终不得离开皮肤（图9）。此法速度快，力量较大，是一种强刺激手法，多作为重点手法用。这是属于泻法的一种。

2. 点按法 以食指或中指的指尖垂直点压穴位，并由轻到重地行小幅度移位的掀压动作，直达组织深处（图10）。此法是点穴疗法中常用的手法之一，亦是一种较强的刺激手法，具有镇静、止痛、解痉作用。

3. 点揉法 用指端点压穴位，同时作圆圈形的揉动（图11）。所谓“揉”是按着摩的动作，含有按与摩两者之意。因而，揉的指端面应陷入穴位处皮肤之下，这样揉动可以避免指端离开皮肤（如果指端与皮肤成切线的揉，那么指端便与皮肤成为摩擦状态，这样就形成了按摩疗法中的摩法，须加以注意）。点揉法有轻、重两种手法，临床应用极为广泛，一

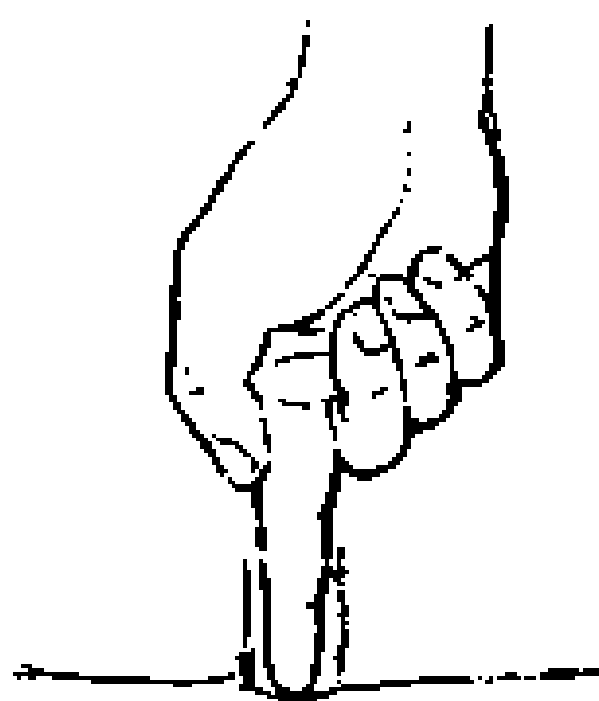


图 9 点冲法

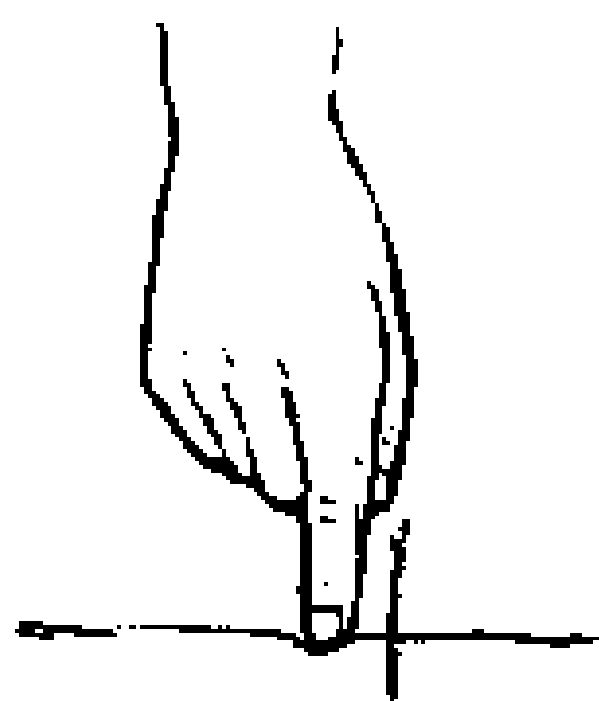


图 10 点按法

般的疾病都可选用，属于补法的一种手法。

4. 点推法 用食指或中指的指端与皮肤成 45° 角点压在穴位上，然后顺经络线走行方向，作上下往返的运推活动（图 12）。此法属中等刺激手法，常用于较为敏感的穴位，如颅点、桡点、前心穴、前解胸、后解胸等穴位。因此，用力要和缓，不宜用猛力运推。

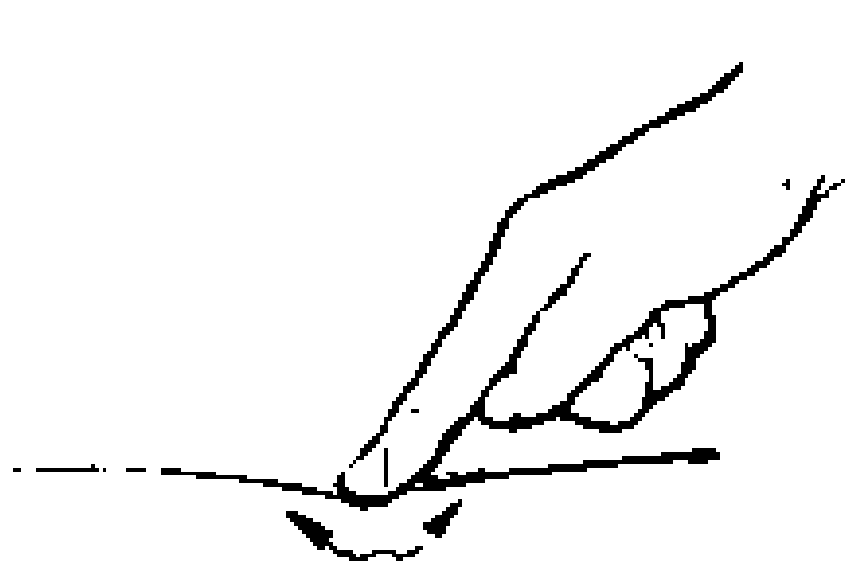


图 11 点揉法

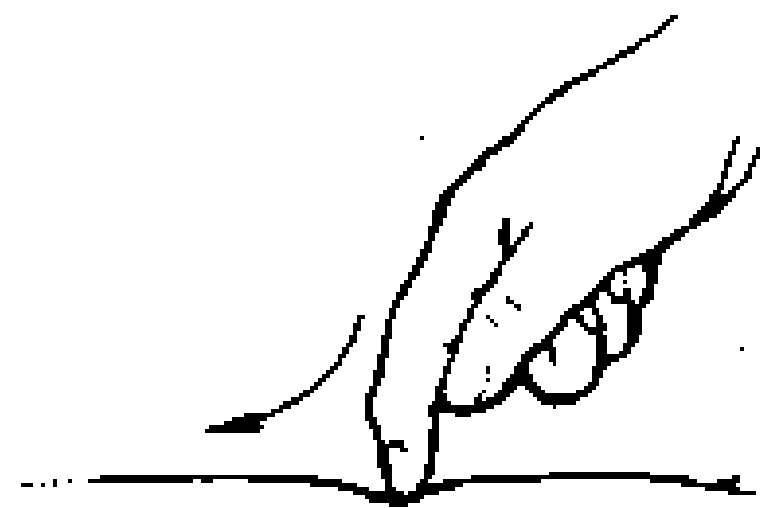


图 12 点推法

5. 点刮法 用食指或中指指尖的掌侧点压在穴位上，并

顺行经络线的方向，做刮的动作（图 13）。此法较点推法轻而快，一般节律为 3~4 次/秒，主要运用腕部的力量，用力较轻，属于轻刺激手法。

6. 点转法 用指尖垂直点压在穴位上，施行点按的同时，朝着一定的方向作旋转动作（图 14）。此法有顺时针方向与逆时针方向旋转两种，旋转的幅度应小于 90° ，频率和缓，用力适中。常用于某些特殊穴位，如连环点、转点等。

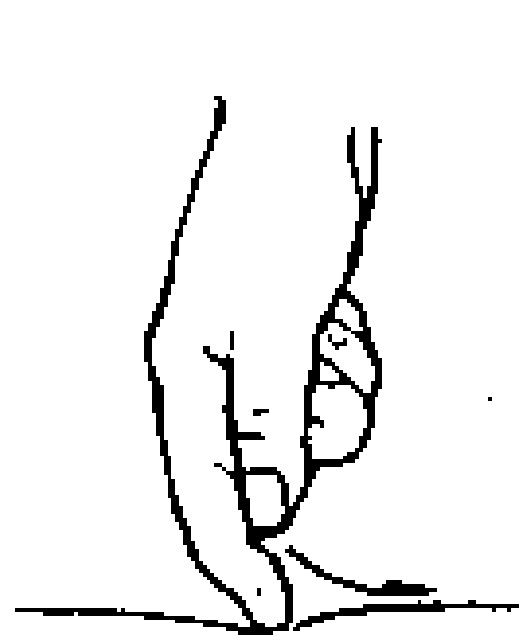


图 13 点刮法

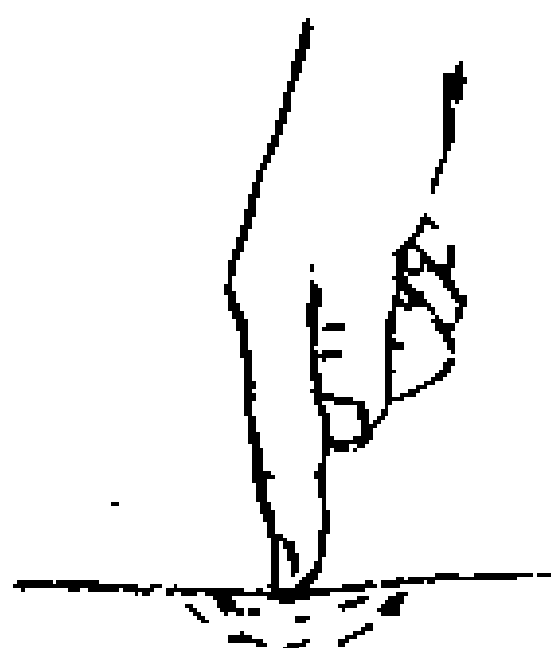


图 14 点转法

7. 点震法 以食指为主，微屈掌指关节与指间关节，中指按于食指背面，拇指腹抵于食指末节指间关节，环、小指握紧。先将食指的指尖点在穴位上，略停，而后利用掌指关节和腕关节的力量，作频率较快的摇动震颤（图 15）。此法具有解痉与镇痛的作用。

8. 碎点法 用食指或中指的指尖垂直点压在穴位上，并顺着经络线的循行径路，施行有节奏的连续点按手法（图 16）。此法力度较点按法轻，即力轻而富有弹性，是一种较弱的刺激手法。

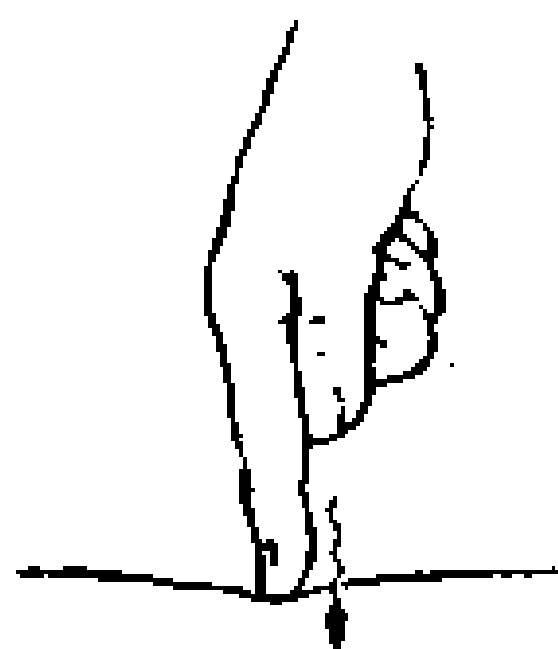


图 15 点震法

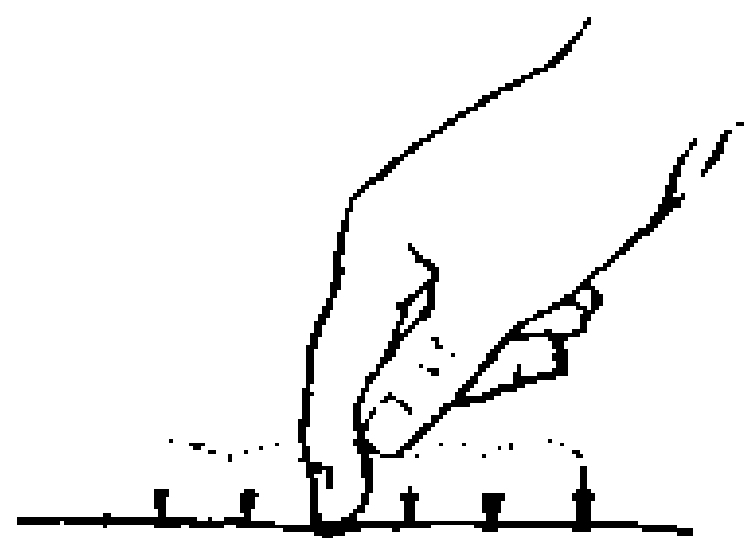


图 16 碎点法

(二) 辅助手法

传统点穴疗法中的辅助手法，是为了帮助和弥补上述几种基本手法不足的一种局部性手法，在点穴治疗中亦占有重要的地位。常用的辅助手法有以下几种：

1. 颈筋提拔法 用拇指与食指捏住颈部斜方肌的上缘，向上提拔，然后迅速放开（图 17）。节律和缓，用力适中，可松解肌肉的痉挛。此法常作为落枕及肩胛部疾患的辅助治疗。

2. 三叉筋提拔法 拇指与食指捏住第七颈椎棘突与肩胛骨内角之间的肌群，作向上提拔的动作，而后迅速放开（图 18）。节律与力度同上法。此法亦常用于落枕、颈椎病及肩胛部疾患的辅助治疗。

3. 背筋提拔法 用拇、食二指捏住胸椎棘突两侧的斜方肌，作迅速提拔与放开的动作（图 19）。此法较颈筋提拔法与三叉筋提拔法用力轻。治疗时若不易提拔，可先行三叉筋提拔法，就能顺利地提拔背筋。提拔后如有疼痛胀麻的感觉，是属于正常反应，1~2 天后便可自行消失。背筋提拔法可用于

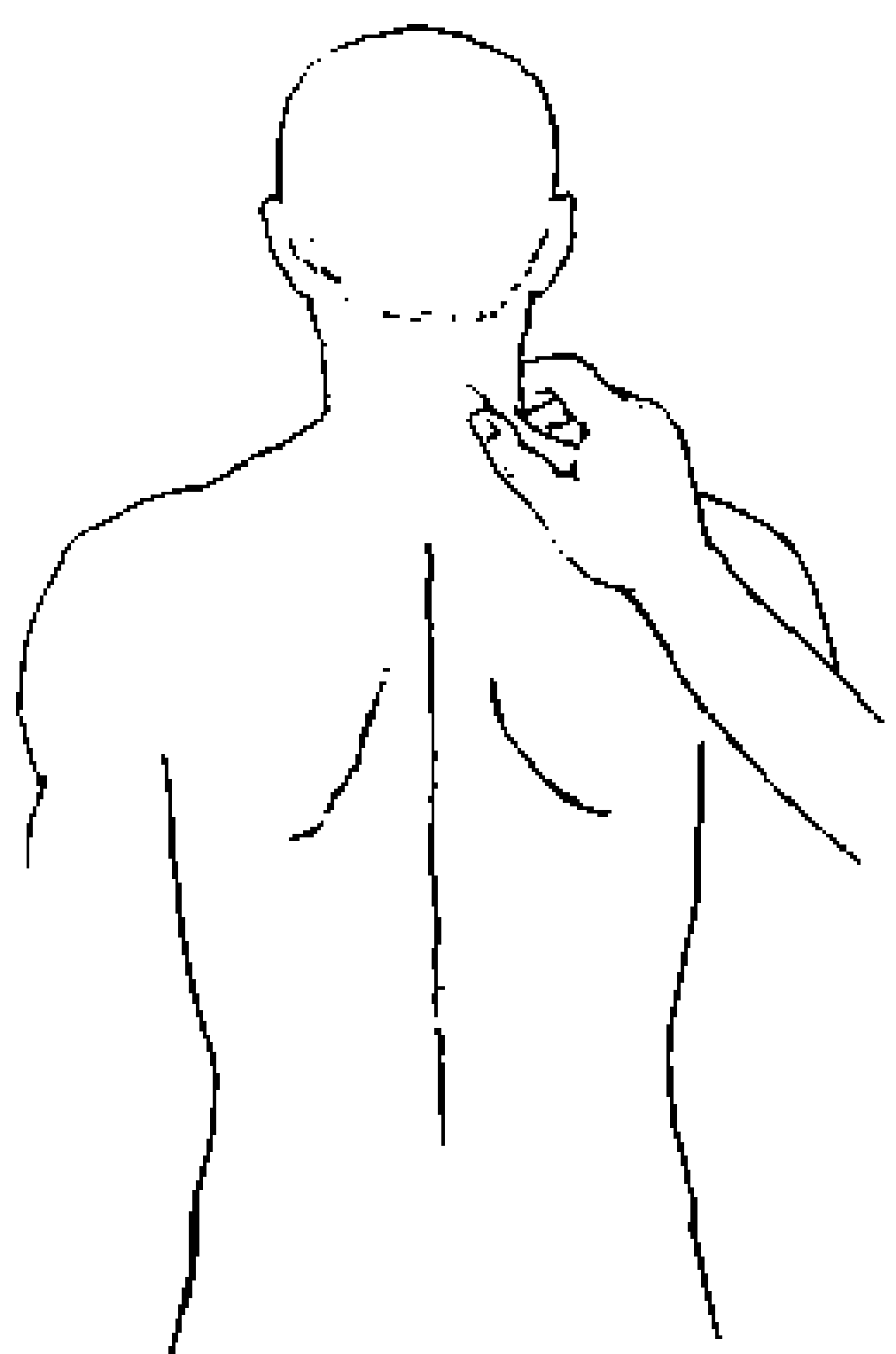


图 17 颈筋提拔法

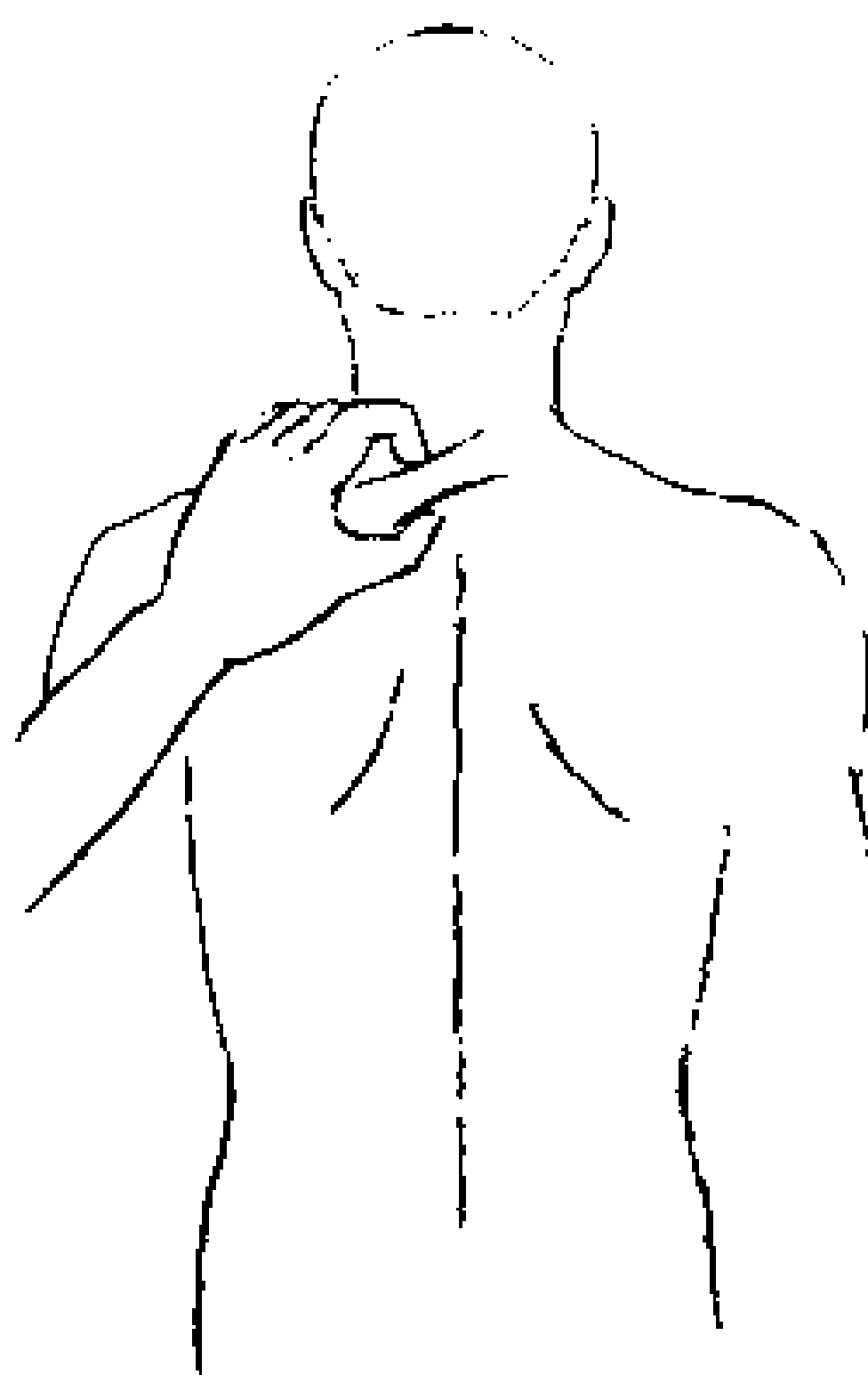


图 18 三叉筋提拔法

治疗肩胛背部的疾患。

4. 捏脊法 患者取俯伏坐位或俯卧位。术者以拇、食二指捏起脊椎棘突上肌肉，沿脊柱自下而上加以捻转（图 20）。每次施术的范围，按病情的需要而定。此法常用于脊柱疾患、腰背部疼痛、腹痛以及大便不畅等病症的辅助治疗。

5. 腹部揉刮法 用双手食指和中指指尖的掌侧作波浪形的点刮手法。从前心穴开始，沿着两侧肋弓下缘至腋前线，又从腋前线刮向脐部，而后再从剑突下开始，向脐部点刮（图 21）。此法可用于治疗腹痛、恶心、呕吐、食欲不振或上腹部挫伤等。

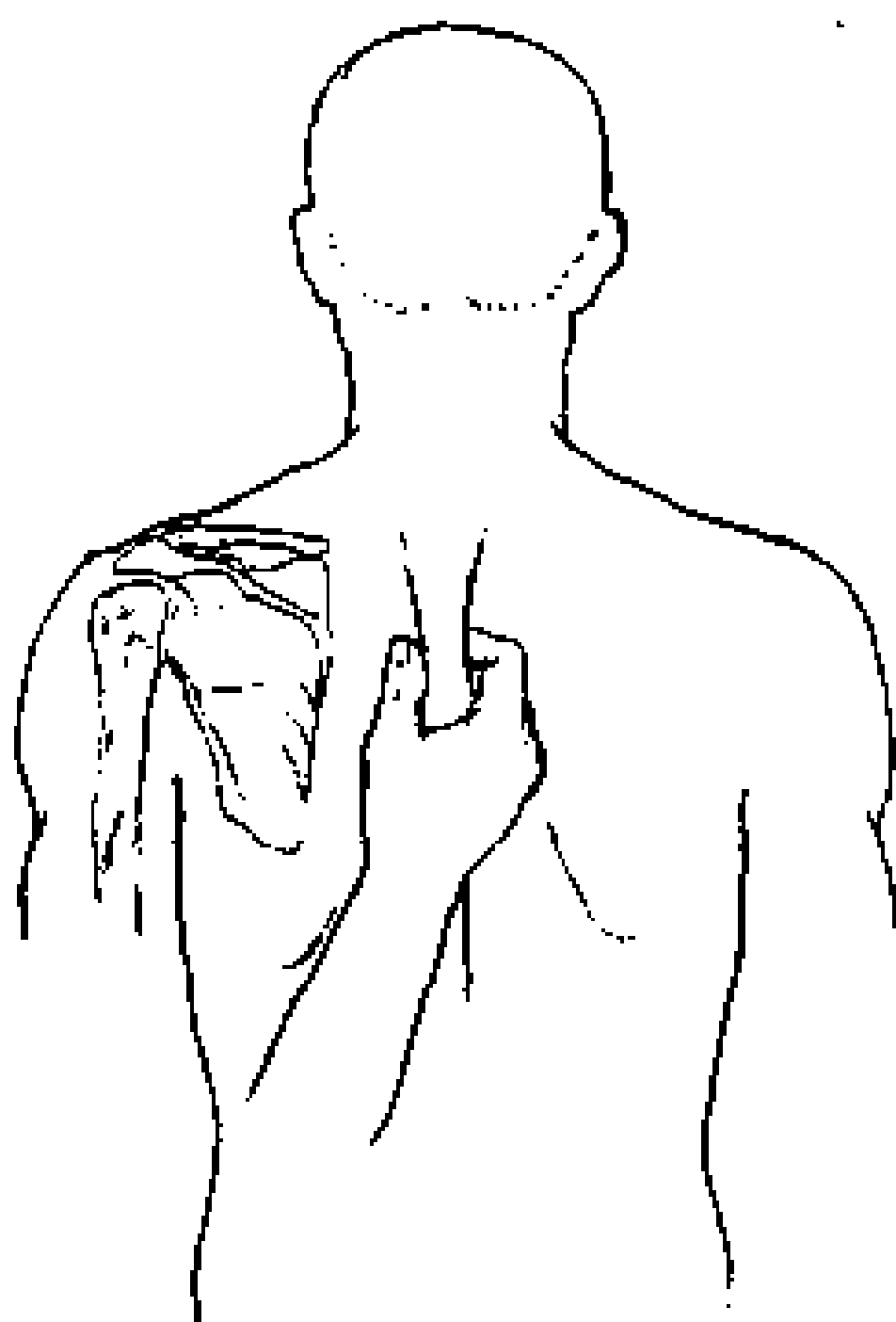


图 19 背筋提拔法

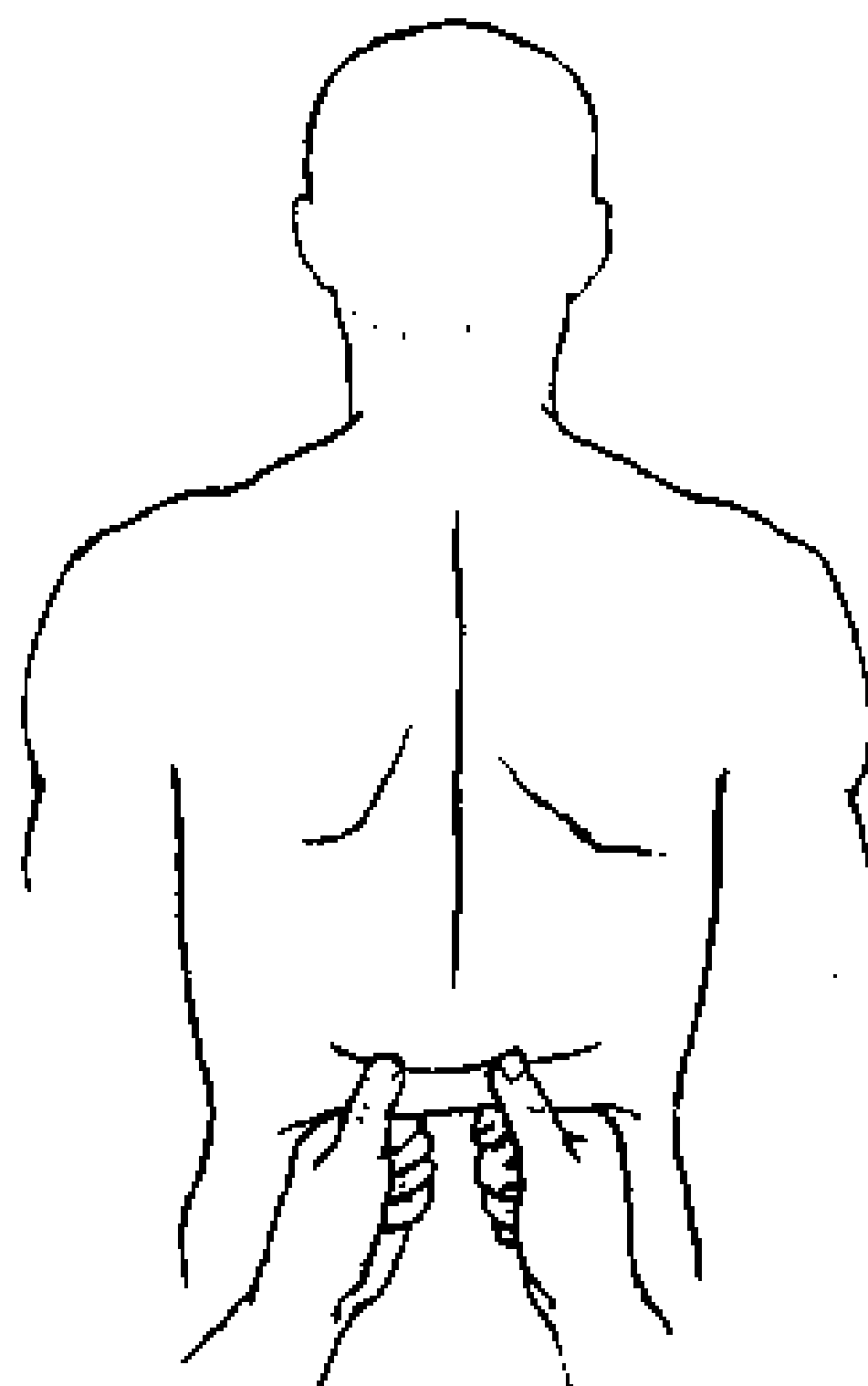


图 20 捏脊法

6. 按压法 患者取俯卧位，双手抱住床端，一助手用力牵拉患者两侧下肢。在牵拉的同时，术者将两手的拇指相互重叠，按压脊椎的患侧，并朝脊柱的方向推按（图 22）。此法可用于腰椎间盘突出症及棘韧带损伤等的辅助治疗。

7. 髌骨旋转法 患者双下肢自然放松伸直，术者用拇指的指腹按压在髌骨的一侧边缘，同时，反复作连续往返的旋转动作（图 23）。此法具有疏通经络、消肿止痛的作用，常用于治疗风湿性关节炎或膝部扭挫伤所致的膝关节酸困肿痛。

8. 骶尾骨反转法 患者取俯卧位，术者用双手食指指尖分别在骶尾骨的两侧边缘，朝相反的方向行点刮手法，反

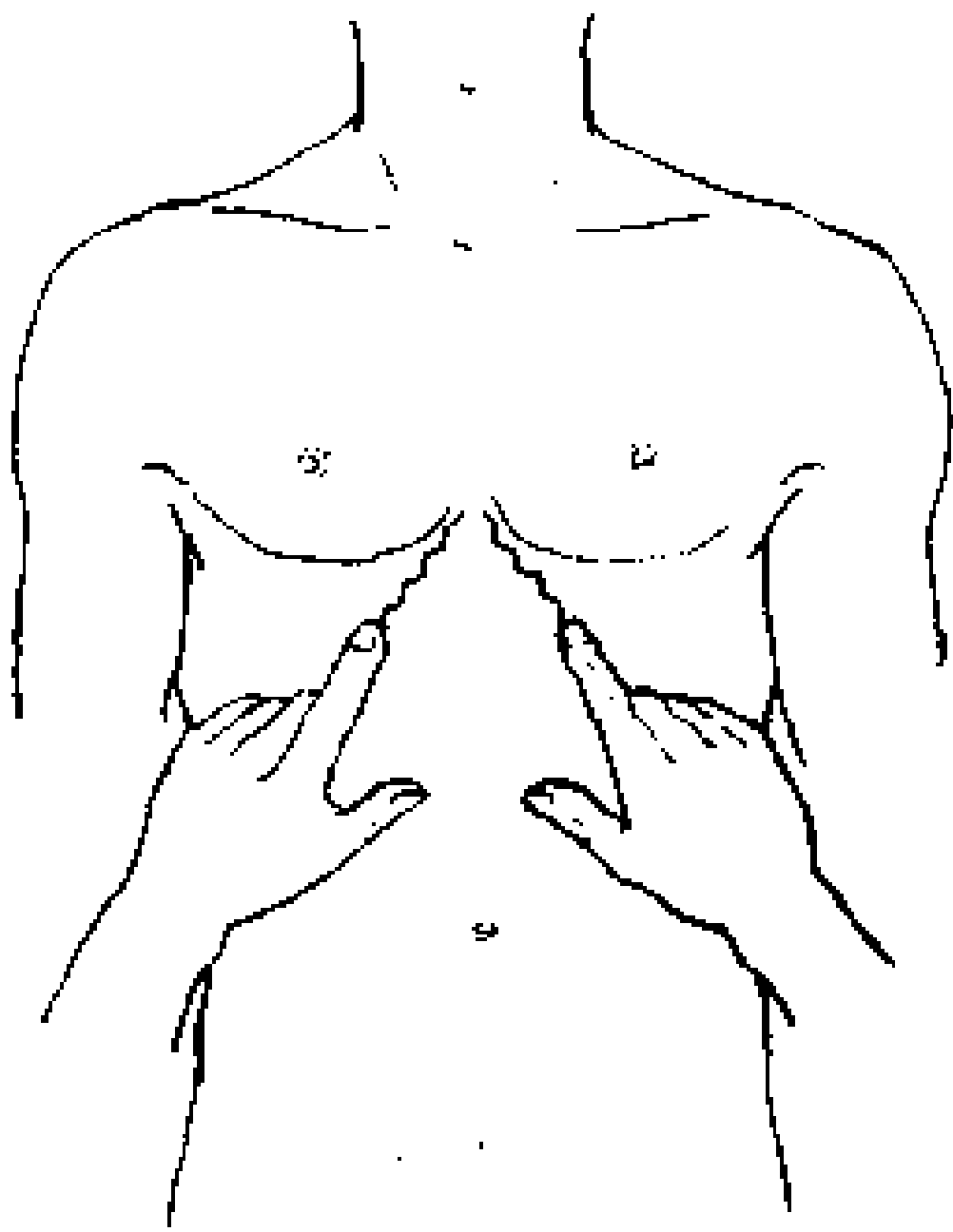


图 21 腹部揉刮法

复交换进行(图 24)。此法主要用于治疗骶尾关节扭挫伤以及尾骨挫伤等疾患。

(三) 指力的运用

在施行点穴治疗时，必须根据患者的病情、体质与部位等不同情况，分别运用轻重不同的手法进行操作，方能提高治疗的效果。

点穴疗法中，指力的运用可按照用力的强弱不同分为轻点手法、中点手法和重点手法三种。

1. 轻点手法 以腕关节活动为中心，主要是用腕部的力量，肘关节与肩关节起协调配合的作用。其力轻而富有弹性，是一种较弱的刺激手法，偏于补的作用。轻点手法，一般适用于下列情况：

- (1) 小儿、妇女、老年以及体弱和虚证患者。
- (2) 头面部及肩胛部等处的穴位。
- (3) 疾患区域或痛点所在。
- (4) 在治疗过程中感觉有效后。
- (5) 对穴位的反应敏感者。

2. 中点手法 以肘关节为活动中心，主要是用前臂的力量，腕关节固定或半固定，肩关节予以协调配合。其力介于强弱之间，是一种中等刺激手法，属于平补平泻法。适用于虚证、实证或虚实夹杂证。亦可根据病情需要酌情掌握，灵

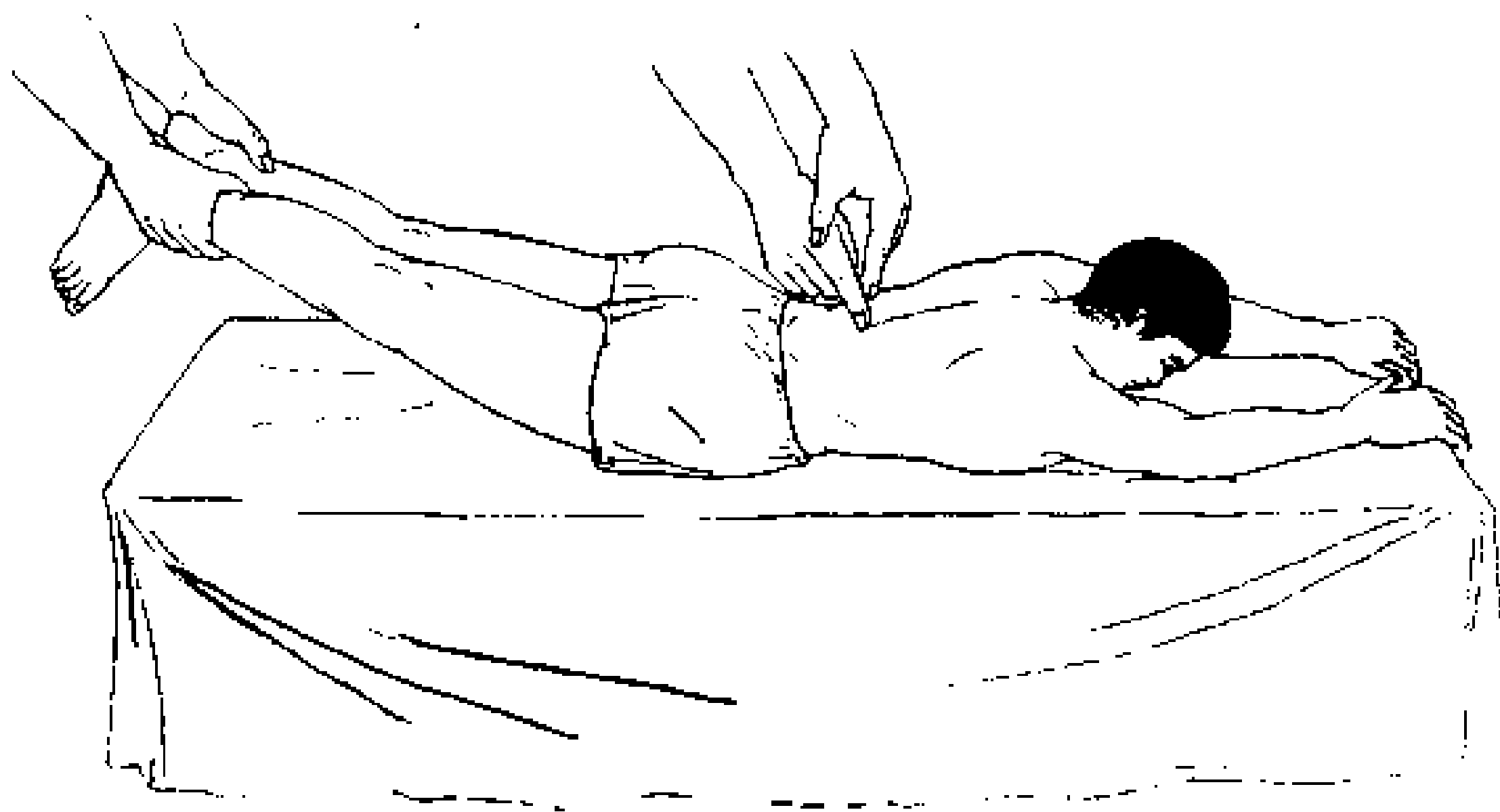


图 22 按压法

活运用。

3. 重点手法 以肩关节为活动中心，主要是用上臂的力量，腕关节固定，肘关节予以协调配合，是一种强刺激手法，偏于泻的作用。重点手法常用于下列情况：

- (1) 青壮年、体质强壮及肥胖的患者。
- (2) 软组织较丰厚的部位。
- (3) 初次接受点穴治疗者。
- (4) 一般的急性病亦可酌情采用重点手法。

(四) 点穴治疗的准备工作和常用体位

1. 准备工作 点穴治疗开始之前，必须仔细询问病史，进行认真的体格检查，必要的化验及特殊检查，作出较为准确的诊断和较为详细的病历记录。对慢性病应向患者及其家属说明治疗工作的艰巨性、长期性以及疗效预后等各项事宜，

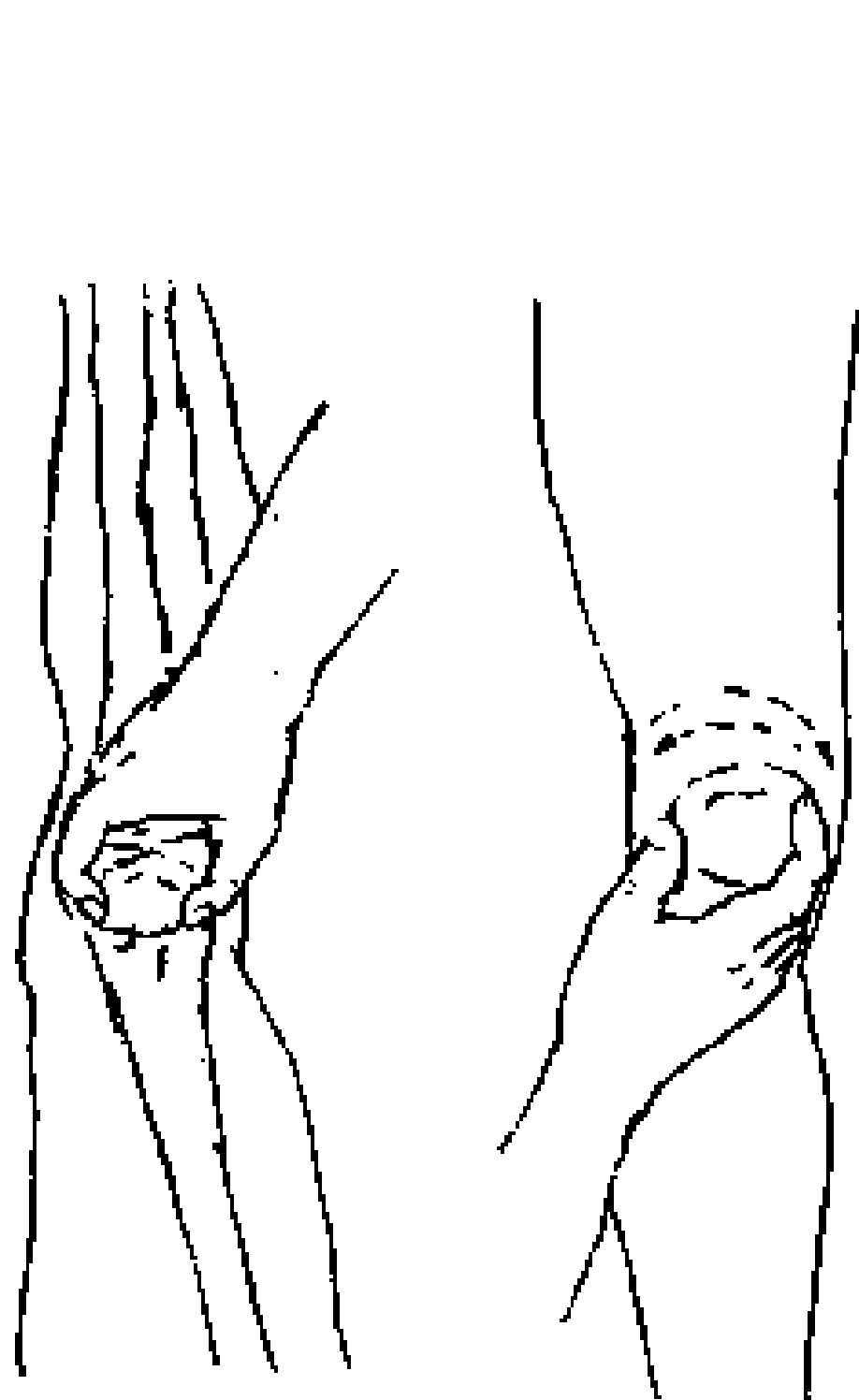


图 23 髋骨旋转法

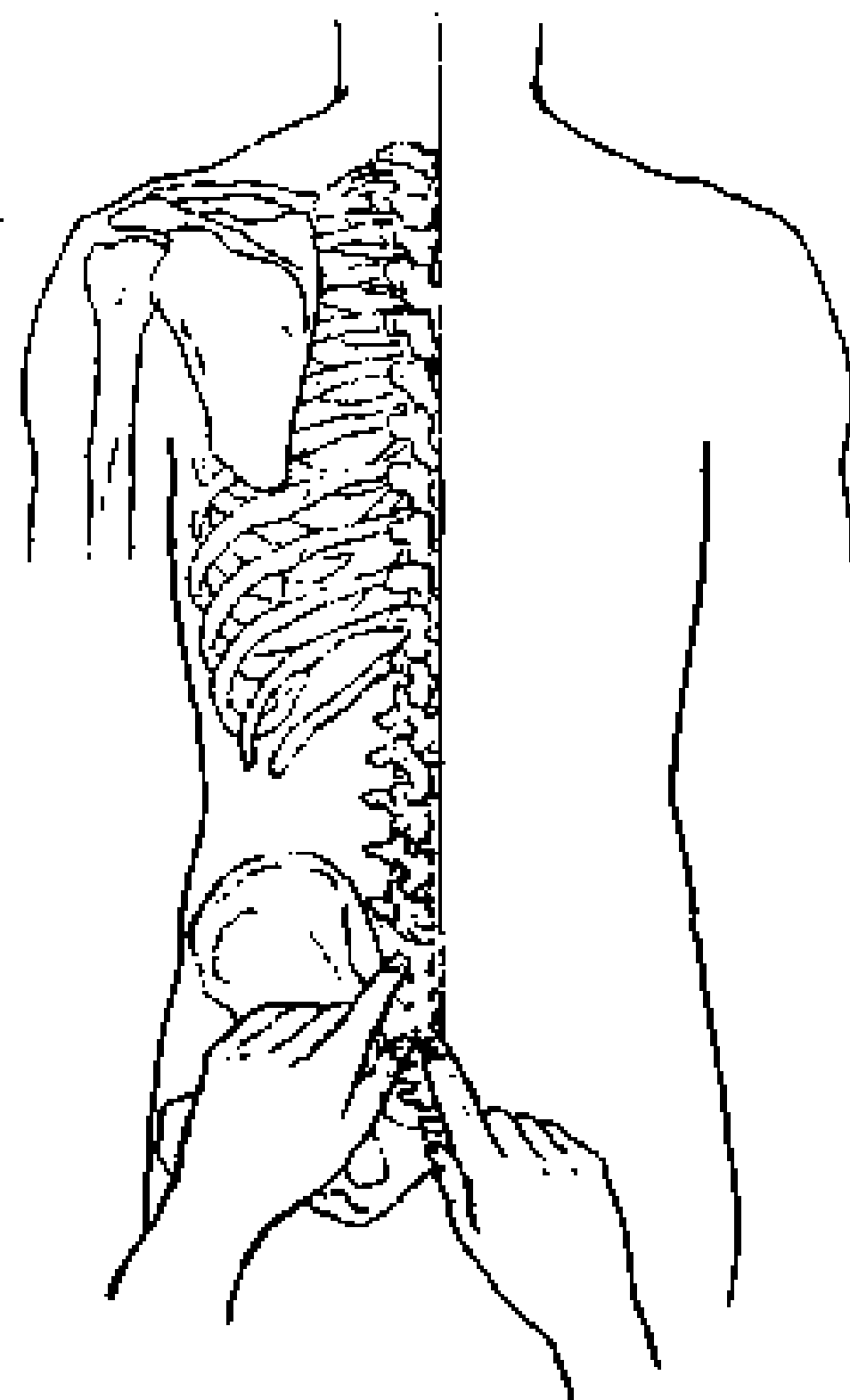


图 24 骶尾骨反转法

争取患者对点穴疗法的理解，取得合作，以配合治疗。既要树立向疾病作斗争、战胜疾病的信心，也要免除求胜心切、产生急欲求成的急躁心情，而影响治疗工作。

点穴疗法虽然是凭双手治疗，但事先也需做好适当的准备工作。诊室要求宽敞、通风好，诊查台不宜过高，诊室内配备卷尺、测角规、叩诊锤、血压表、听诊器、音叉、耳镜、眼底镜等必要设备，以供检查病人之用。

医务人员要经常修剪指甲，但不宜过短；以免损伤指腹、甲沟，必要时贴胶布保护手指末端。

2. 常用体位 为了使病人舒适并便于取穴，根据所选的

穴位，指导病人采取适当的体位。如体位不当，勉强支撑，不仅会造成病人过度疲劳，影响疗效，也会影响医生取穴的准确性。因此，体位的选择应以病人的体质强弱、病情的轻重为依据，以术者便于操作治疗为原则。点穴治疗常采用的体位有以下几种：

(1) 仰靠坐位：适用于头面部、颈前部以及部分上肢穴位。

(2) 俯伏坐位：适用于头项部、腰背部以及部分上肢穴位。

(3) 侧卧位：适用于人体侧面的穴位。

(4) 仰卧位：适用于头面部、胸腹部以及下肢前面的穴位。

(5) 俯卧位：适用于头项部、腰背部以及下肢后面的穴位。

除上述常用的体位之外，有些穴位需要采取特殊的体位，如内重点、风湿点等穴位，将在该穴取穴法中介绍。

(五) 取穴方法、疗程及注意事项

1. 取穴方法 临床上常用的取穴方法有以下几种：

(1) 骨度分寸取穴法：是将人体不同的部位规定出一定的长度和宽度，折合成若干等分，每一等分作为一寸。这种方法不论成人、儿童或高矮胖瘦均可适用，比较准确。

(2) 指寸法：是以病人手指的宽度为标准来测量取穴的方法。如果病人的身材与医生相仿，也可用医生的手指宽度来测量。常用的指寸法有：

①中指同身寸：中指近节和第二节横纹头之间的距离为一寸。

②拇指同身寸：拇指第一节的宽度为一寸。

③一夫法：食、中、无名、小指并拢时，四个手指第二节点的宽度为一夫（即三寸）。

这种方法比较简单，但没有骨度法准确。

（3）解剖标志取穴法：本法是以人体表面各种解剖标志作为取穴的依据。如：

头部——以五官、眉发为标志；

背部——以脊椎棘突、肩胛骨（两肩胛岗最高点相当于第三胸椎棘突，两肩胛下角相当于第七胸椎棘突）、肋骨（肋弓下缘相当于第二腰椎）、髂嵴（两髂嵴相当于第四腰椎）为标志；

胸腹部——以乳头、脐窝、胸骨、耻骨等为标志。

四肢——以关节、骨髁为标志等。

另外，病有缓急、证分虚实，临证治疗须审时度势，辨证施治。根据不同的病情，按“循经取穴”或“邻近取穴”的原则，选择相应而适当的穴位。同时，选穴应针对病情，取其主要经络线上的穴位为主穴，并以其所管属的经络线上的穴位为配穴，然后施以一定的手法，才能达到治愈疾病的目的。因此，还应结合下面几个特点，以指导取穴。

①在病变部位或周围取穴，如头痛取阳明点等。

②按穴位作用取穴，如落枕取天窗等。

③在远离病变部位处取穴，如牙痛取牙痛点。

④除腰点外，一般都在同侧取穴。

2. 疗程 点穴疗法的疗程不宜作硬性规定，而是要根据具体情况，如病程的长短、病情的轻重、急性或慢性以及病人对点穴疗法的耐受程度等，综合考虑疗程的长短，决定治

疗的总时间。一般来说，急性期每日1~2次，3~5日为一个疗程；慢性期每日1次，7~10日为一个疗程，必要时可连续治疗。有些病人治疗到一定程度时，进展缓慢，可以停止一段时间，然后再继续治疗。

3. 注意事项 点穴疗法虽为一种安全而简便的治疗方法，极少发生不良的副作用，但是，某些穴位在施术时，若手法不当，则有可能引起一些不良的反应。故临证时要注意以下几个方面：

(1) 运用点穴疗法时，必须以现代医学知识和中医基础理论相结合进行辨证施治。即根据患者临床表现的具体病症，运用四诊，将诊察所得到的各种病情与体征，加以综合、分析、归纳，寻求病变的所在部位和病情的转化趋势以及标本缓急等，作出明确的诊断，然后确定治疗原则，拟定治疗方案，真正做到取穴有据，施术有方，才能充分发挥点穴疗法的治病作用，收到预期效果。

(2) 施术时，由轻到重，由缓到急，循序渐进，最后再以轻手法缓解。对小儿久病体虚、过饥、过饱、初诊病人、妇女经期等尤应如此。如患者极度疲劳、醉酒时，暂不予以点穴治疗，对畸形的矫正，不宜操之过急，以免造成损伤。

(3) 施术过程中，除应选择恰当的穴位外，注意手法的轻重适宜，亦是相当重要的。重病轻治固属无效，而轻病重治亦非所宜。某些穴位在点按时，如果手法太重，甚至有可能发生晕厥，故宜加注意。

(4) 根据子午流注和气血运行的原理，中午及傍晚时分，不宜取“后心穴”，否则容易发生晕厥、虚脱或加重病情。治疗时若因点按“后心穴”而发生不良反应，可点按“前心

穴”以解之。倘若出现胸闷或同侧手臂、颜面部麻木，局部发麻、酸痛等现象，则说明已经取得疗效，此时不可继续点按，以免导致晕厥。

(5) 在点穴治疗后，患者往往感到施术部位有酸、麻、热、胀、抽动以及皮肤红润，甚至皮下瘀血、全身出汗、发烧等，此属正常反应，毋须处理，很快便可自行恢复，皮下瘀血一般于2~3天后也会慢慢地自行消失。个别患者在点穴后可能出现局部症状加剧现象，此属暂时性的，亦是正常反应，可继续进行点穴治疗，一般3~5天后，加重之症状消失，病情亦随之好转。对此应于治疗前预告患者，以免产生不必要的顾虑而影响治疗。

下 篇 各 论

一、咳嗽

咳嗽是肺系疾患的主要症状。倘若其他脏腑有病累及于

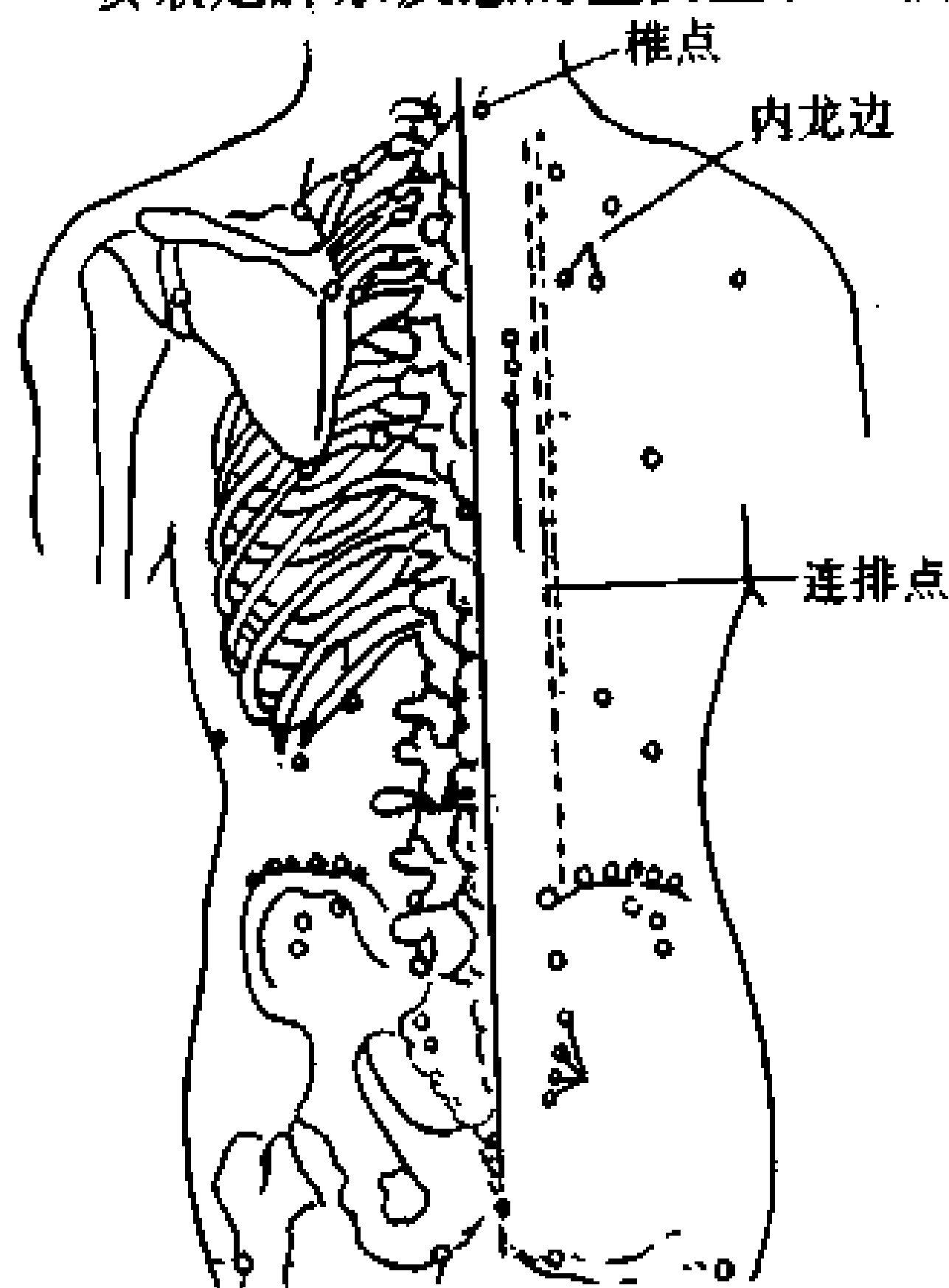


图 25-1

肺时，亦可发生咳嗽。咳嗽发生的原因有外感和内伤两大类。外感咳嗽由于感受外邪引起；内伤咳嗽由于脏腑失调所致。肺为娇脏，职司清肃，不易耐受邪浊之干扰，受邪后最易出现肺气壅实，或痰浊阻塞，肺失清肃，肺气不利，引发咳嗽。

外感引起的咳嗽多兼有表证。风寒咳嗽痰稀色白，咽痒声重；风热咳嗽痰稠色黄，咽痛

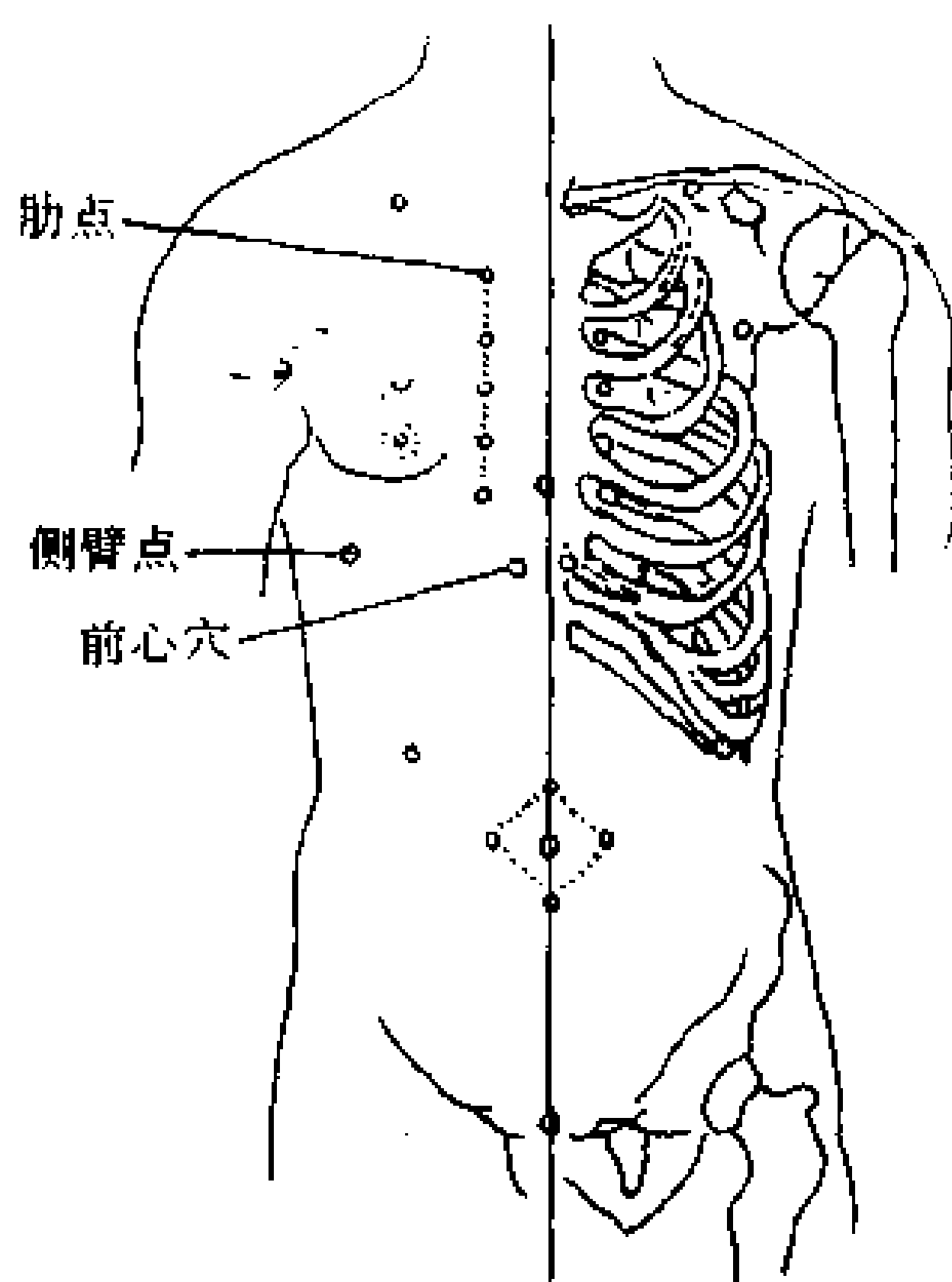


图 25-2

图 25 咳嗽取穴图

口渴。外感燥热与内伤阴虚咳嗽均可见干咳无痰或少痰，或痰中带血，口燥咽干；但燥热咳嗽多发于秋季，而阴虚咳嗽多伴潮热盗汗。痰湿咳嗽痰多且痰出咳停。肝火犯肺之咳嗽，则表现为气逆呛咳，或见咳血。

【取穴】（图 25）

（1）主穴：肋点（双侧穴）、前心、椎点。

（2）配穴：内龙边（双侧穴）、连排点、侧臂点（双侧穴）。

【手法操作】

先点主穴，每穴施术半分钟，反复 2~3 次，后点配穴。如有呕吐，可加腹部揉刮法。对小儿施术时，手法宜轻。冬季气候寒冷，不宜将小儿衣服脱光，以防受凉。

二、哮喘

喘，以呼吸气促、甚至张口抬肩为特征。哮，以阵发性喉间有哮鸣声为主症。其发生主要有外邪侵袭、痰浊内盛和肺肾虚弱等几个方面的原因。

喘分虚实，实喘气长有余，胸满声粗，病势急骤，以呼出为快；虚喘则气短不续，气怯声低，病势徐缓，动则喘甚，以深吸为快。哮分冷热，冷哮喘息频作，痰白清稀；热哮喘促气粗，痰黄粘稠。哮必兼喘，而喘非必兼哮。

【取穴】（图 26）

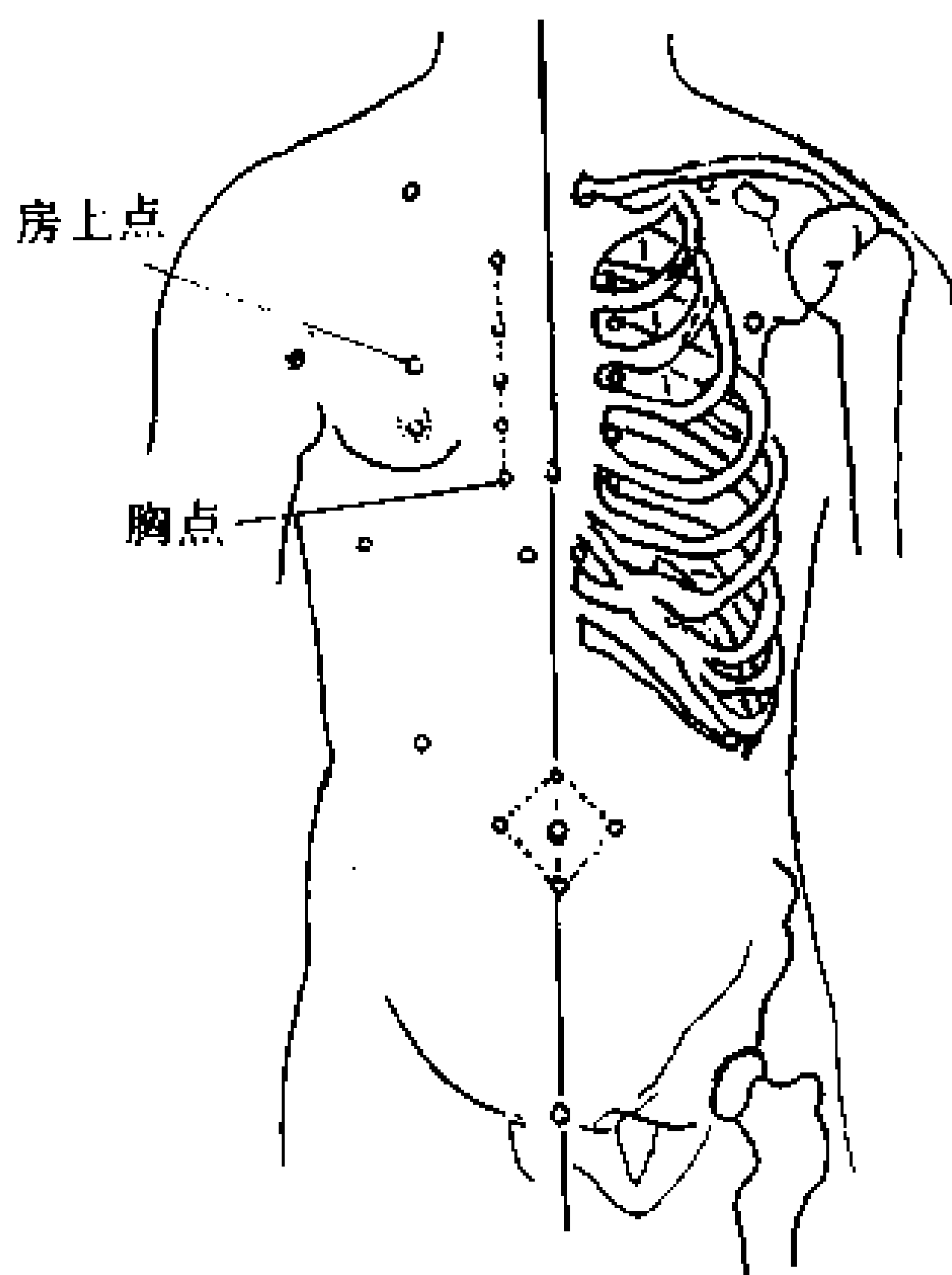


图 26-1

- (1) 主穴：椎点（双侧穴）、连排点。
- (2) 配穴：胸点、房上点（双侧穴）。

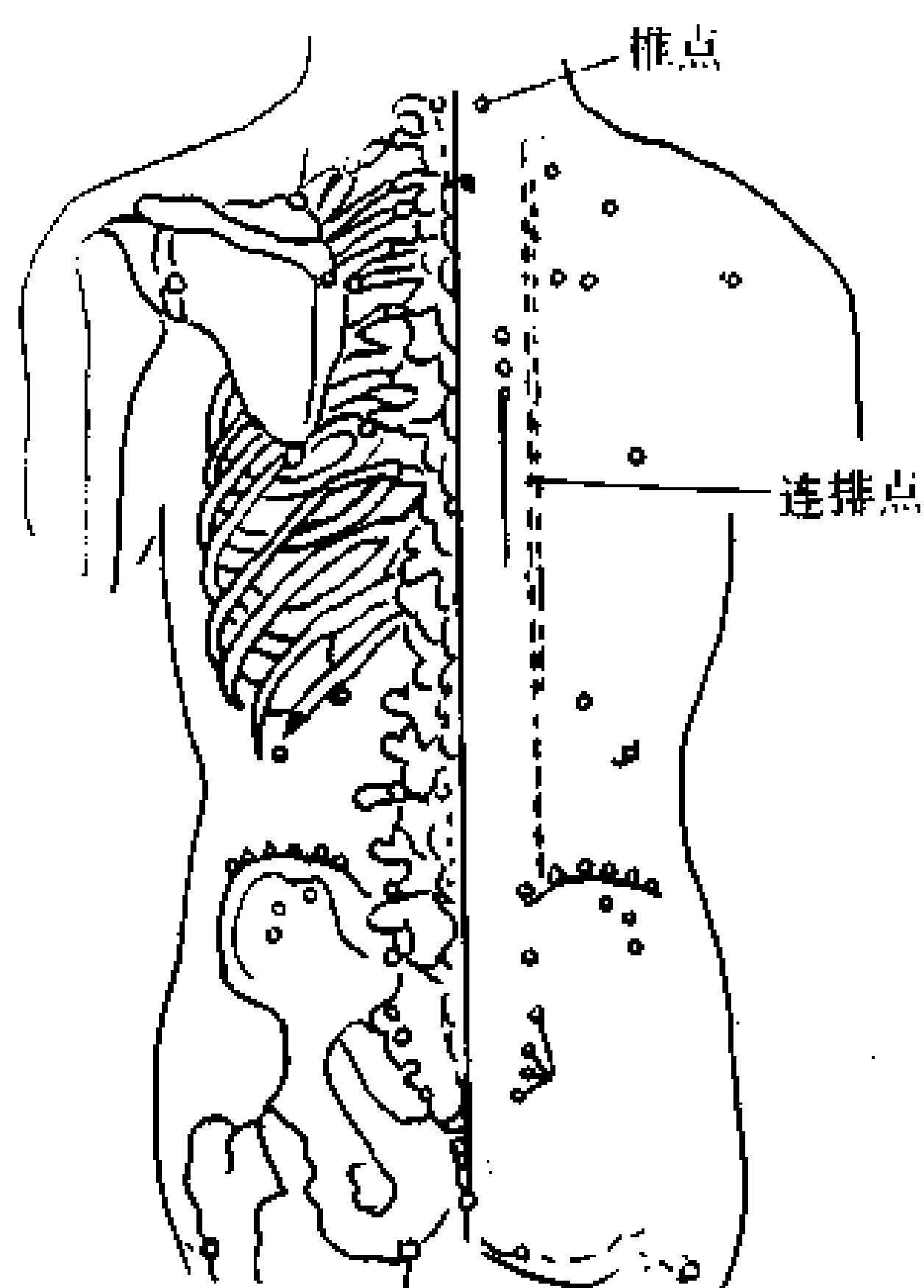


图 26-2

图 26 哮喘取穴图

【手法操作】

先点主穴椎点，后点连排点，每穴施术约 1 分钟，然后再点配穴。急性发作每天可施术 2 次。实证手法较重，虚证手法宜轻，最好运用点揉法。

三、心悸

心悸是指心中动悸不安的一种自觉症状。多为心脾不足、

心神失养，或为阳虚水泛、水气凌心，以及惊扰伤神、瘀血阻络而致。

心血不足者，心悸而烦，面色无华；心气不足者，心中空虚，惕惕而动，自汗气短，形寒怕冷；阳虚水逆者，心下悸而喘满，形寒肢冷，胸脘痞满；惊扰伤神者，惊悸烦乱，坐卧不安，善惊易恐；瘀血阻络者，悸惕心痛，时作时止。

【取穴】（图 27）

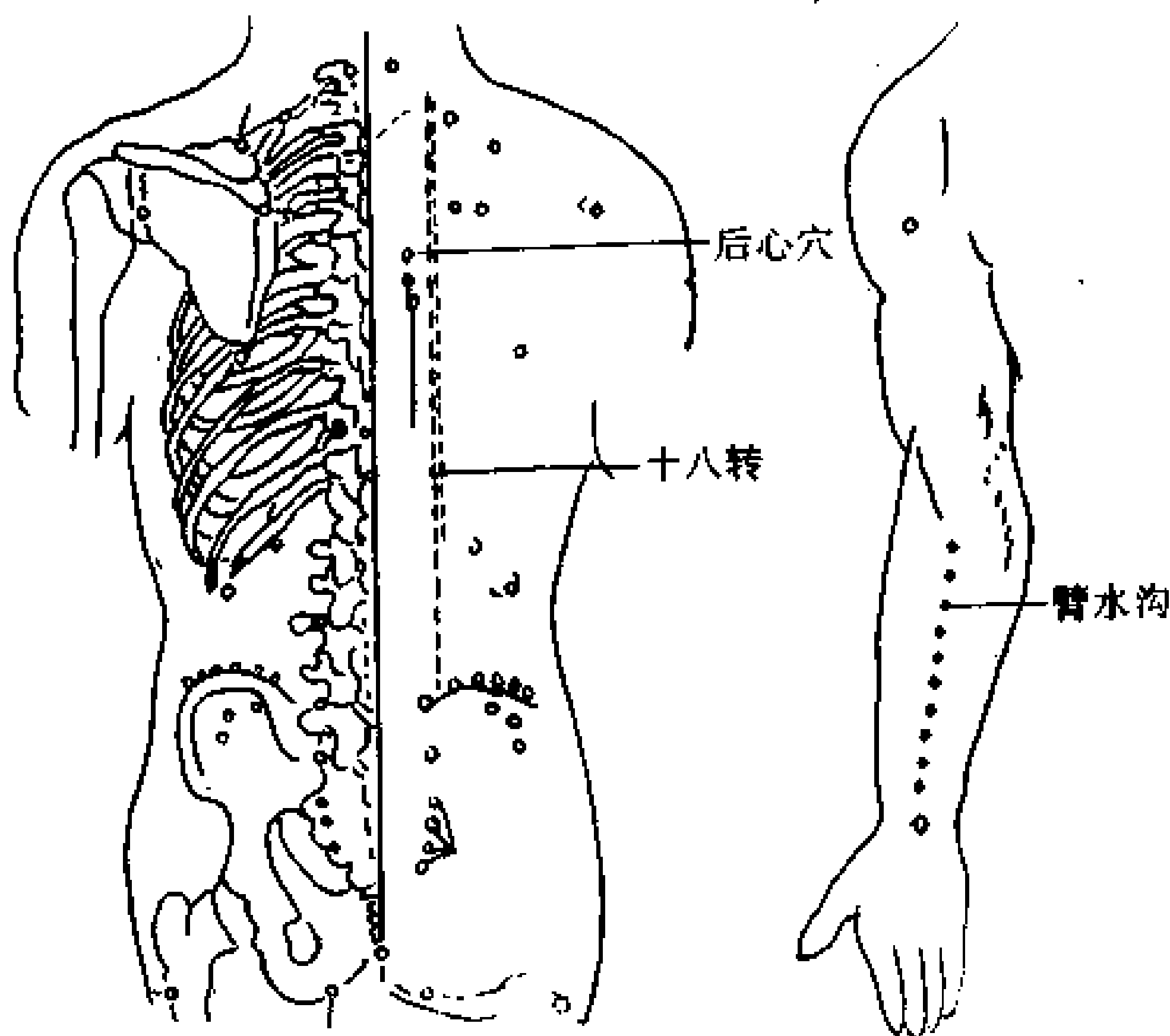


图 27-1

图 27-2

图 27 心悸取穴图

(1) 主穴：后心穴（男取左穴、女取右穴）、臂水沟点（取前侧穴）。

(2) 配穴：十八转。

【手法操作】

先点主穴，后点配穴，手法宜轻，每穴施术约1~2分钟，患者应俯卧床上为宜。

四、胃痛

胃痛又称胃脘痛，是以上腹部发生疼痛为主证。多因肝气犯胃、胃失和降，气机不畅、血瘀络阻，邪热犯胃、食滞中焦，脾胃虚寒、运化失职，或胃阴不足，或虫扰胃腑所致。

气滞胃痛，则胀痛攻胁，按之较舒；血瘀胃痛，则刺痛不移，食后较甚；食滞胃痛，则痛发突然，拒按厌食；胃热胃痛，则痛时拒按；虚寒胃痛，则痛作绵绵，喜温喜按；阴虚胃痛，则胃中灼热，空腹痛重；虫扰胃痛，则剧痛攻逆，时

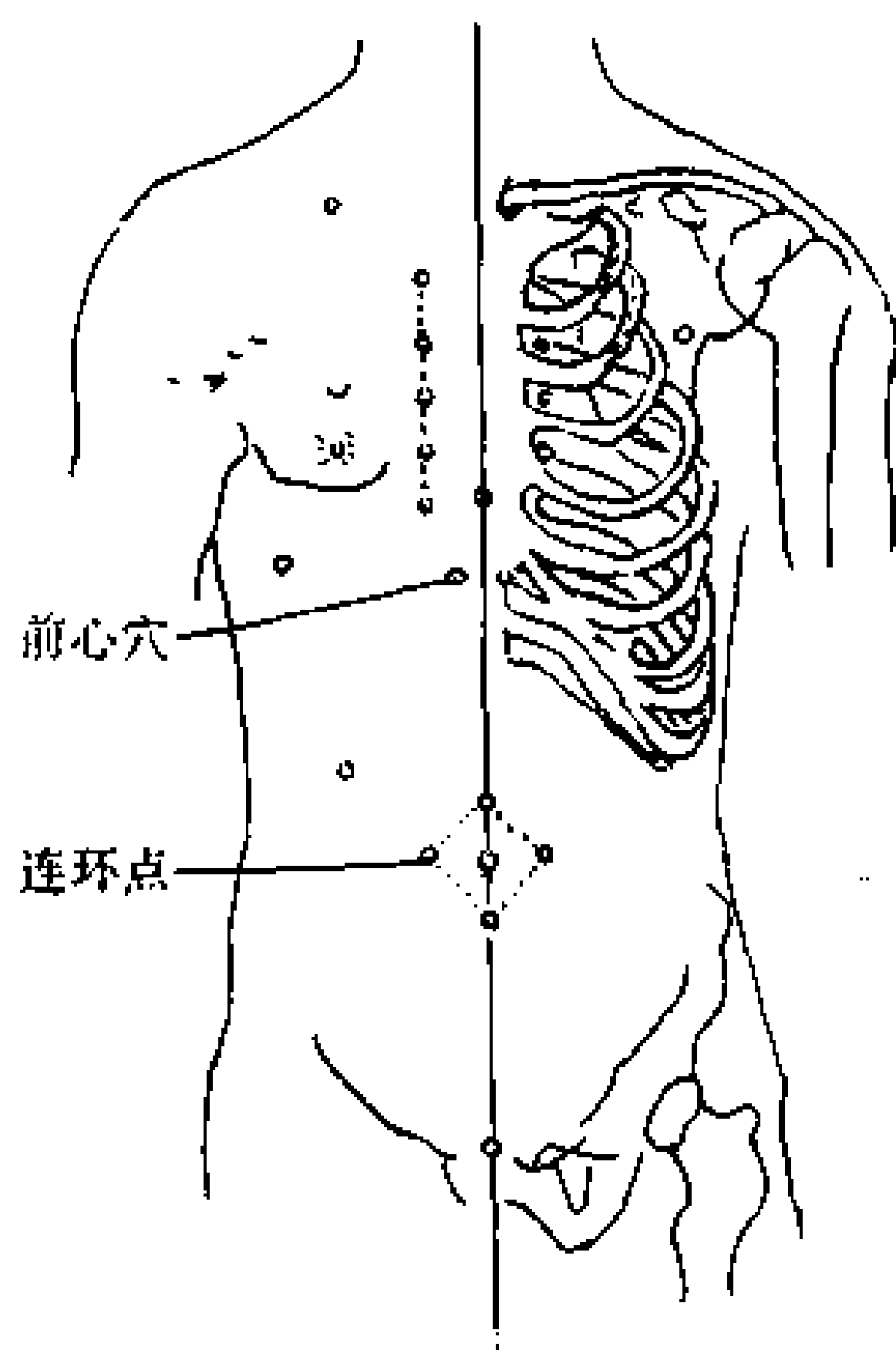


图 28-1

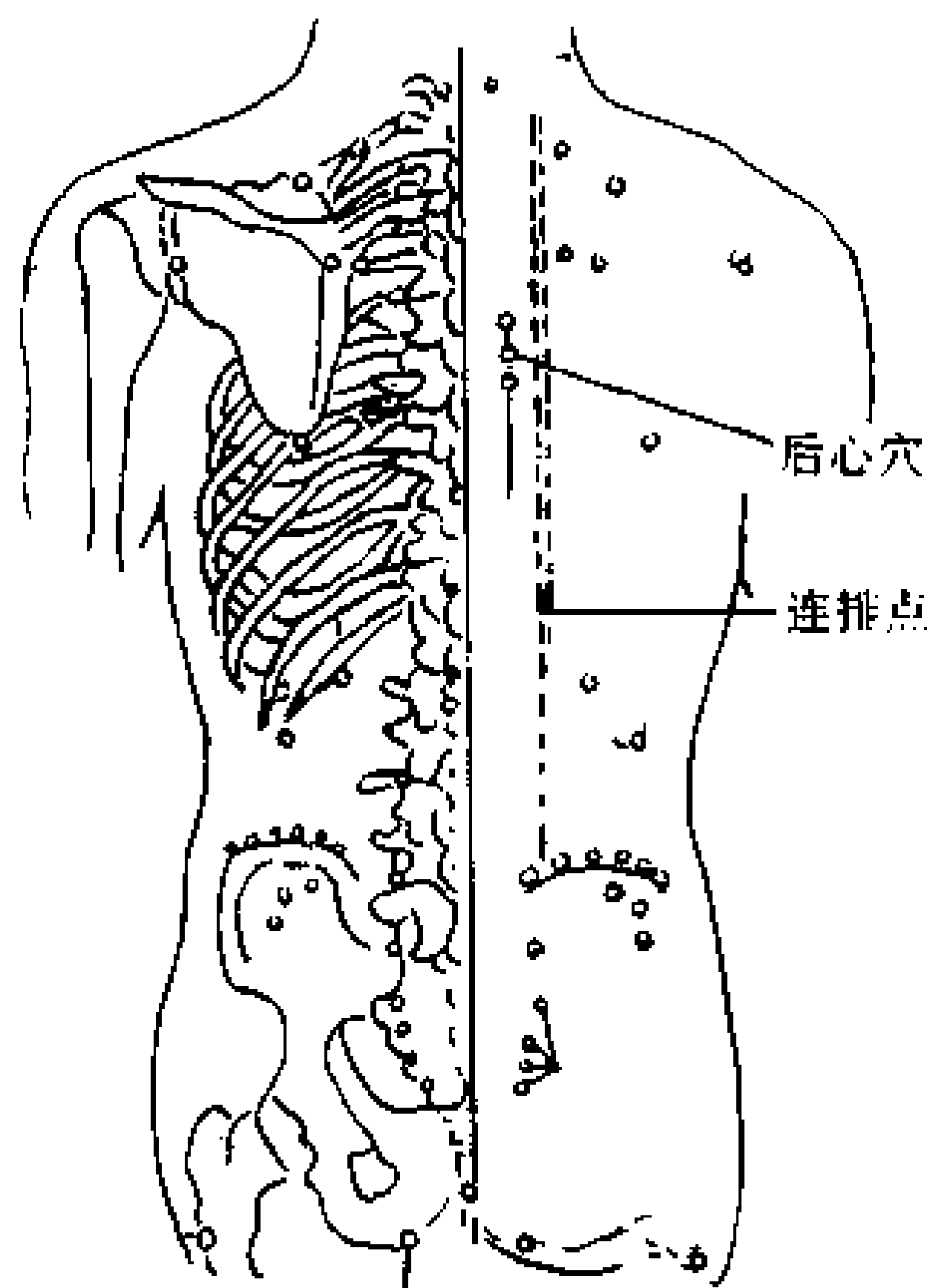


图 28-2

图 28 胃痛取穴图

作时止。

【取穴】（图 28）

- （1）主穴：后心穴（男取左穴、女取右穴）、前心穴。
- （2）配穴：连环点。

【手法操作】

胃痛时，在后心穴处可扪及条索状物，用点按点散它，疼痛即止。如未撤，可加点前心穴，然后点连排点；如因食积，可加点连环点。

五、胁痛

胁痛是指自觉胁肋一侧或两侧疼痛为主的病证。引起胁痛的原因，以肝胆湿热，肝郁化火，肝郁气滞，肝血瘀阻，肝肾阴虚，血不养肝，以及肝郁脾虚为多见。

湿热型，胁痛阵发，剧烈拒按；肝火型，胁痛剧烈，气怒加重；气滞型，则胀痛走窜，时作时休；血瘀型，胁痛如刺，固定不移；肝肾阴虚者，则隐痛绵绵，痛喜揉按；肝郁脾虚者，则胁肋胀痛，胸腹满闷。

【取穴】（图 29）

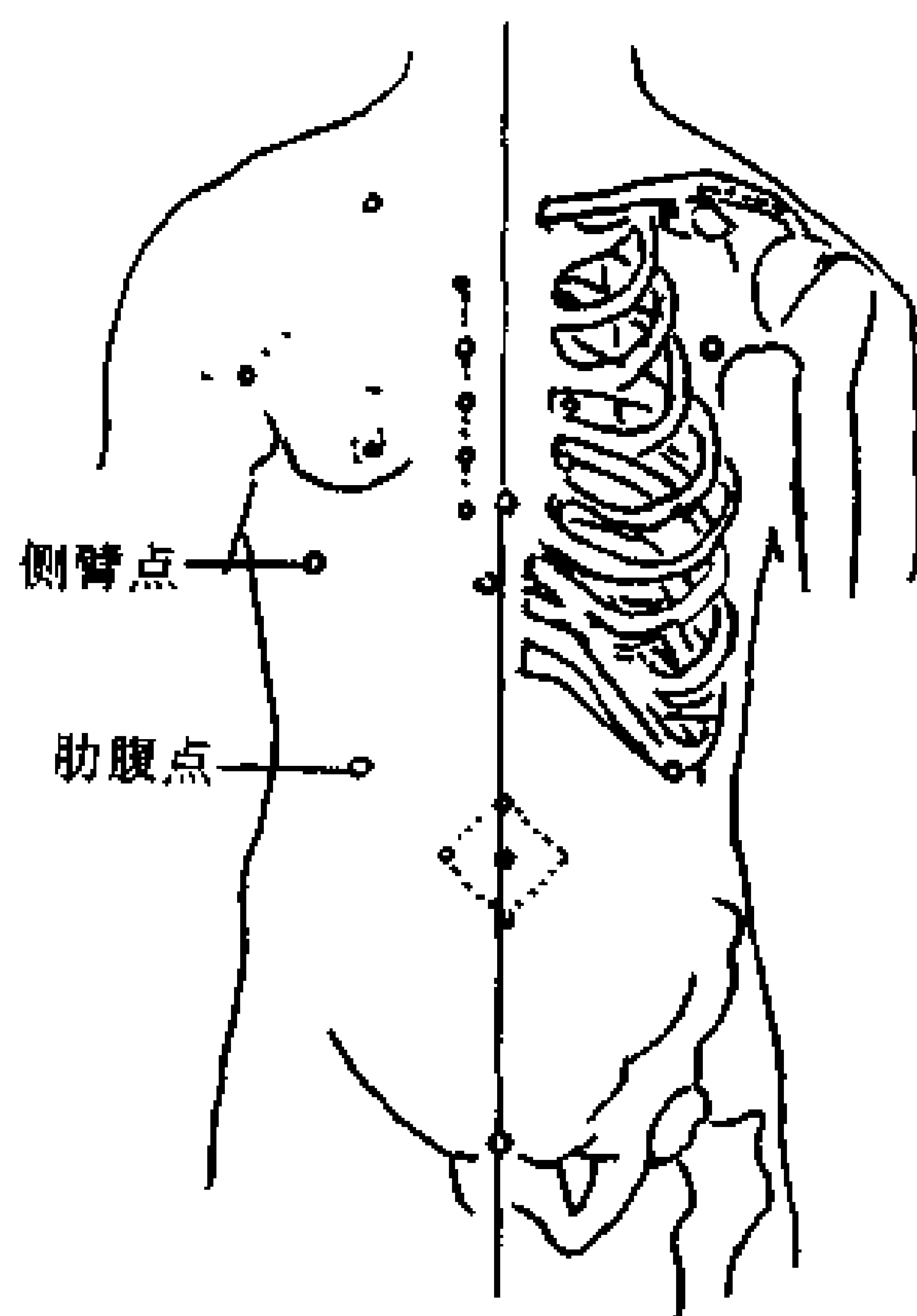


图 29-1

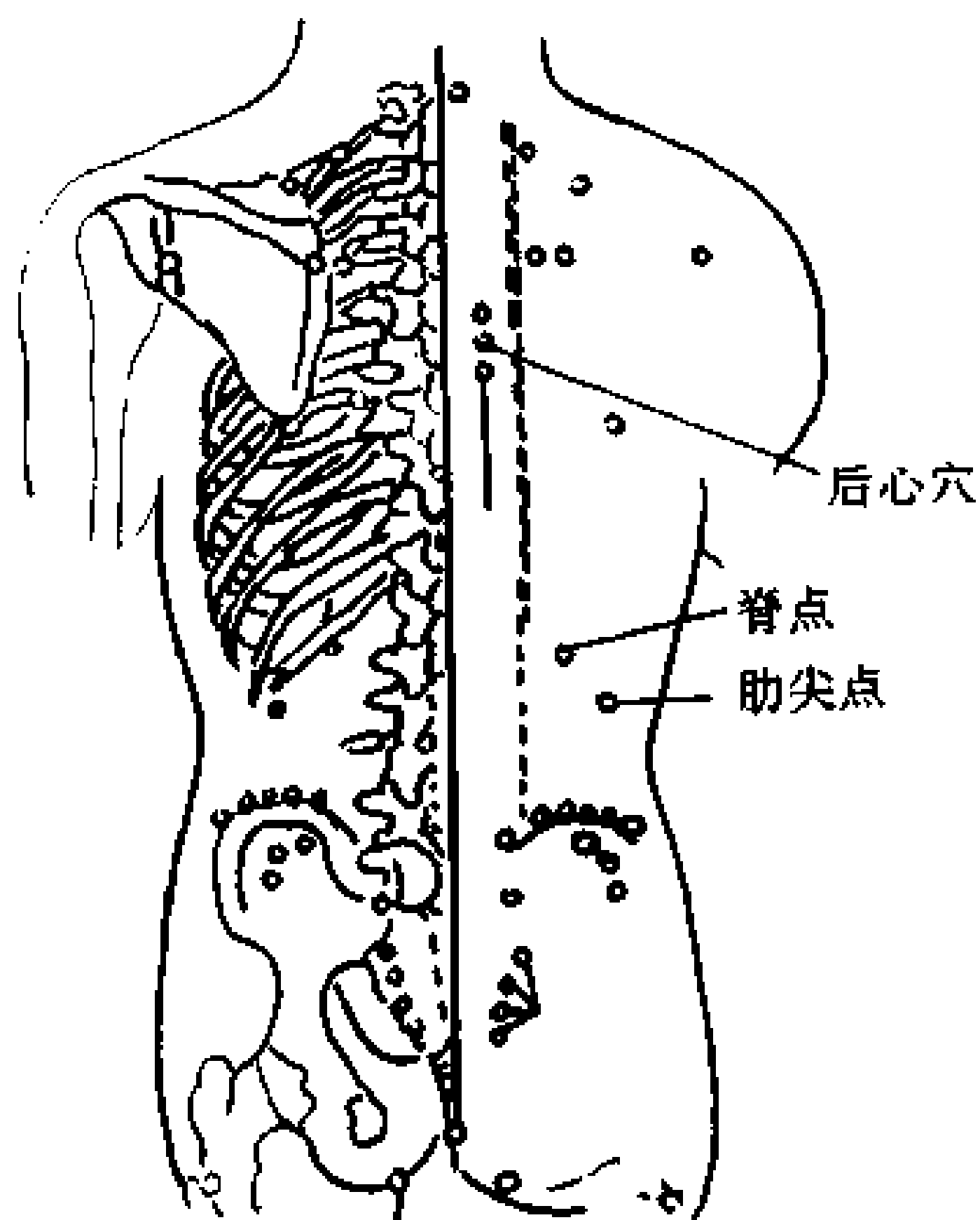


图 29-2

图 29 胁痛取穴图

(1) 主穴：后心穴（男取左穴、女取右穴）、侧臂点（取患侧穴）。

(2) 配穴：肋腹点、肋尖点、脊点（均取患侧穴）。

【手法操作】

先点主穴 1 分钟后，再点配穴。如疼痛牵及同侧腰背部，则加取健侧腰点穴，点按 1 分钟。

六、腹痛

腹痛是指以腹部疼痛为主的病证，可伴发于多种疾患。引起腹痛的原因较多，外感风、寒、暑、湿、热邪，或内伤饮食、气滞、血瘀、虫积，或脾胃虚寒等等，均可引起腹痛。

腹痛之证，分寒热虚实。一般而论，热证、实证腹痛拒按；寒证、虚证腹痛喜按；虫积脘腹攻痛，时发时止；食滞脘腹痞硬，胀满拒按；气滞腹部胀痛，痛无定处；血瘀腹部刺痛，固定不移。

【取穴】（图 30）

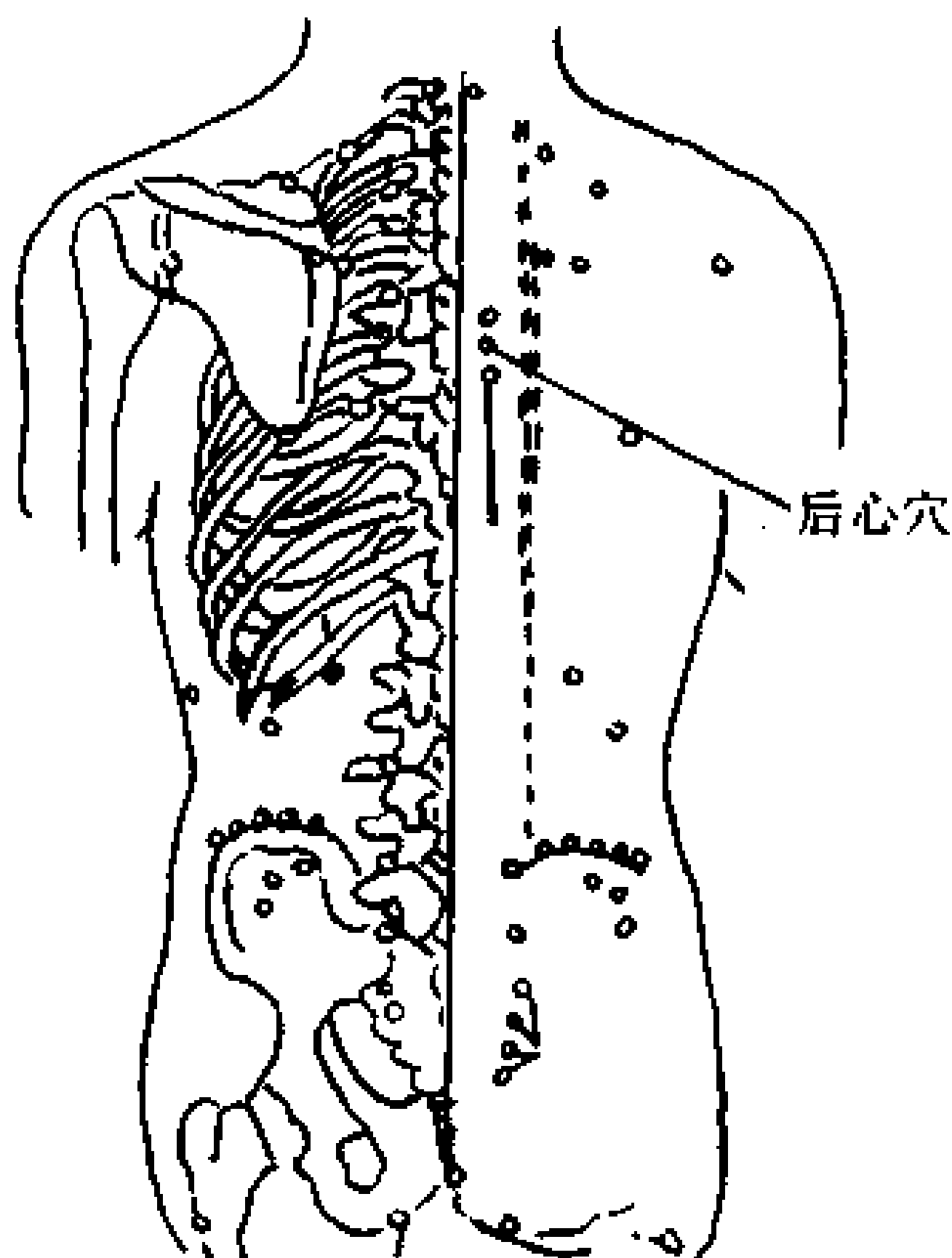


图 30-1

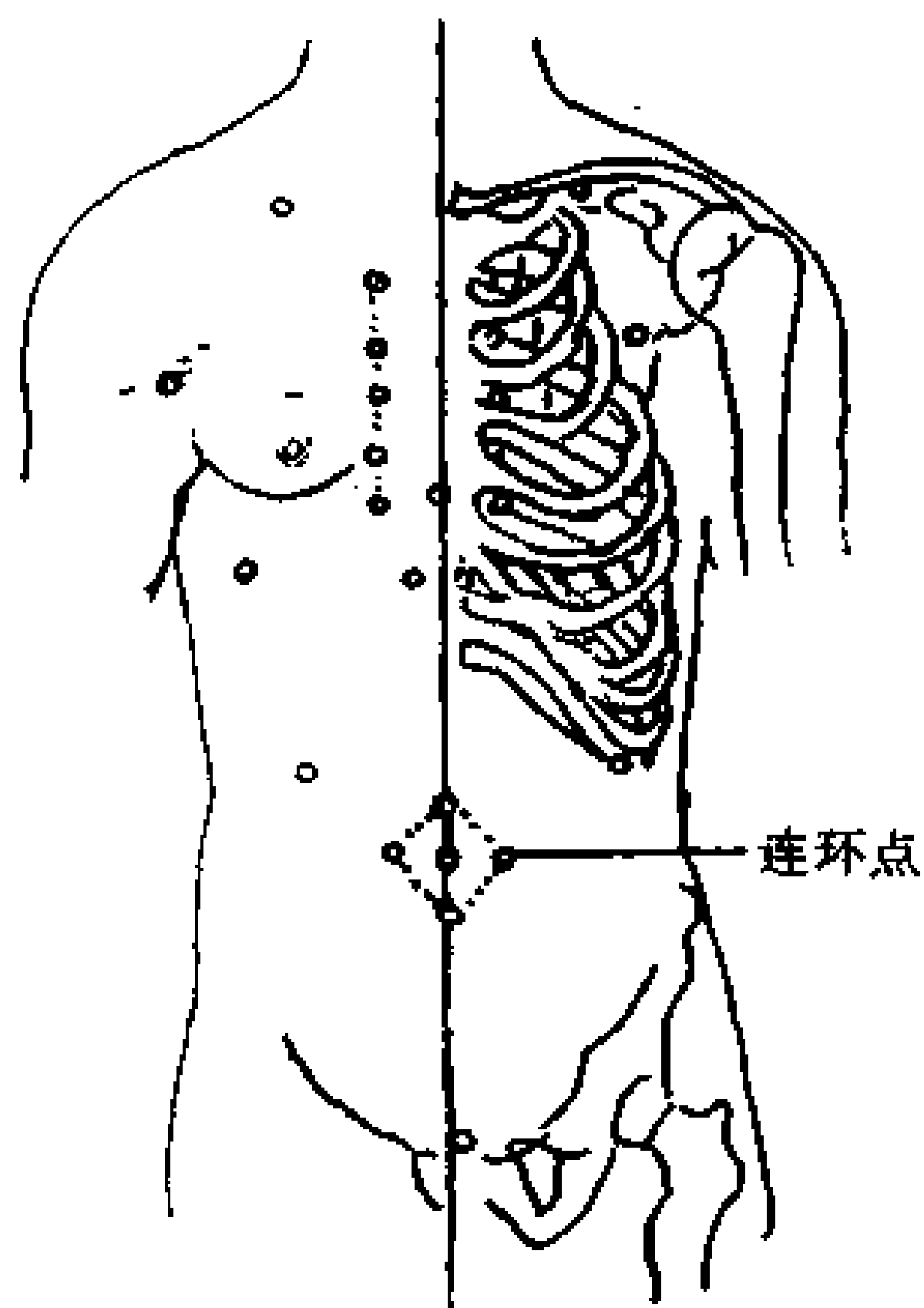


图 30-2

图 30 腹痛取穴图

- (1) 主穴：后心穴（男取左穴、女取右穴）。
- (2) 配穴：连环点。

【手法操作】

先用重手法点按主穴 1~2 分钟，再点按配穴。先行腹部揉刮法 3~4 次，如症状未愈再加点连环穴。

七、泄泻

泄泻是指大便稀薄，次数增多。泄者，如水之泄，势犹舒缓；泻者，暴注直下，势较急迫，一般统称为泄泻。主要

与湿胜及脾胃功能失调有关。水谷清浊不分，混杂而下，并走大肠，以致泄泻。

寒湿者便稀腥秽；湿热者暴注下迫，肛门灼热；湿困中焦，则大便稀薄，小便不利；食滞者暖腐拒食，便粘酸臭；肝郁脾虚，则腹痛即泄，泄后痛减；脾虚湿蕴，则脘闷食少，大便稀薄；脾肾虚寒者，黎明腹痛即泻，便急泻后即安。

【取穴】（图 31）

（1）主穴：暗点、肾筋（双侧穴）。

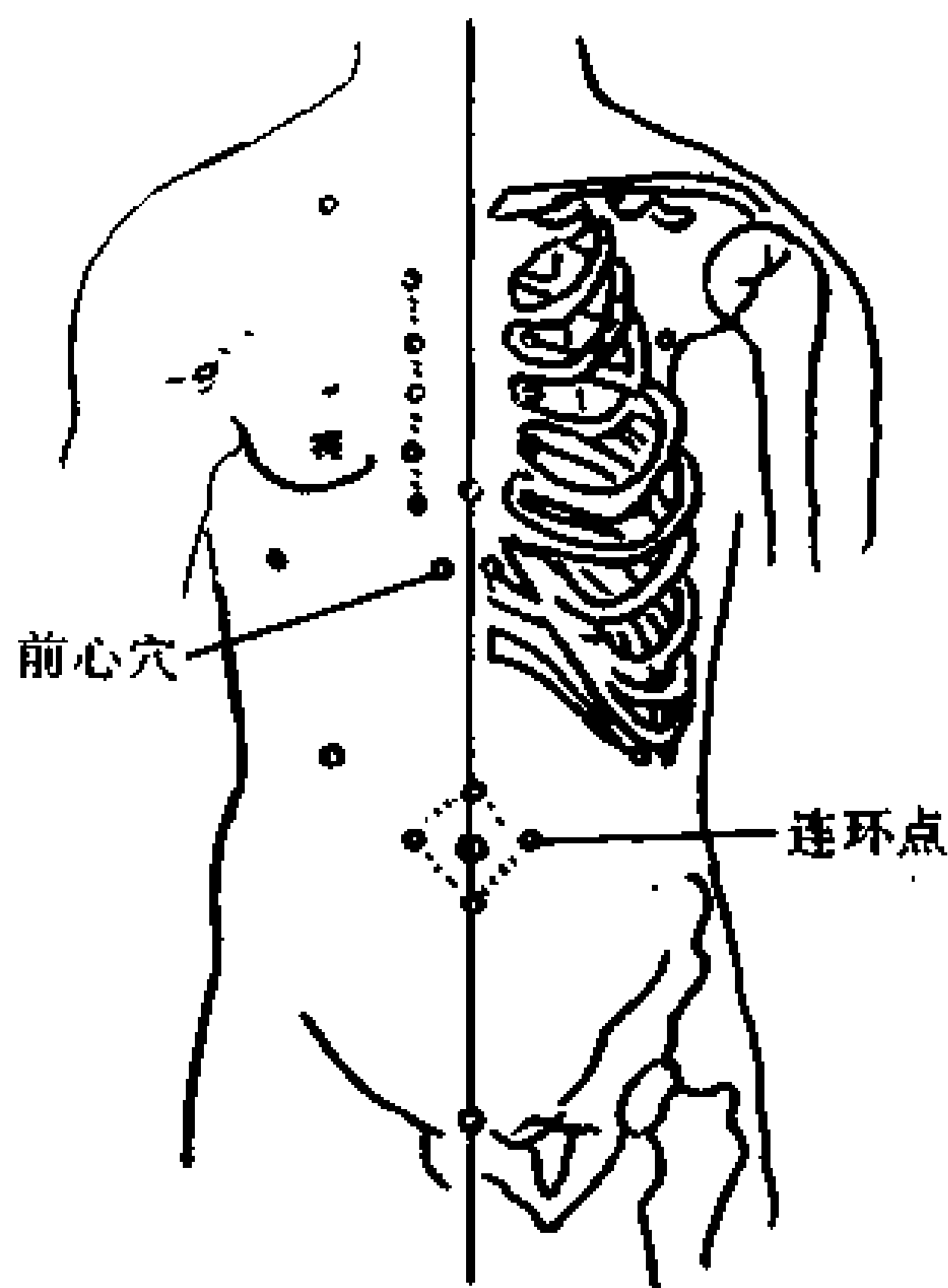


图 31-1

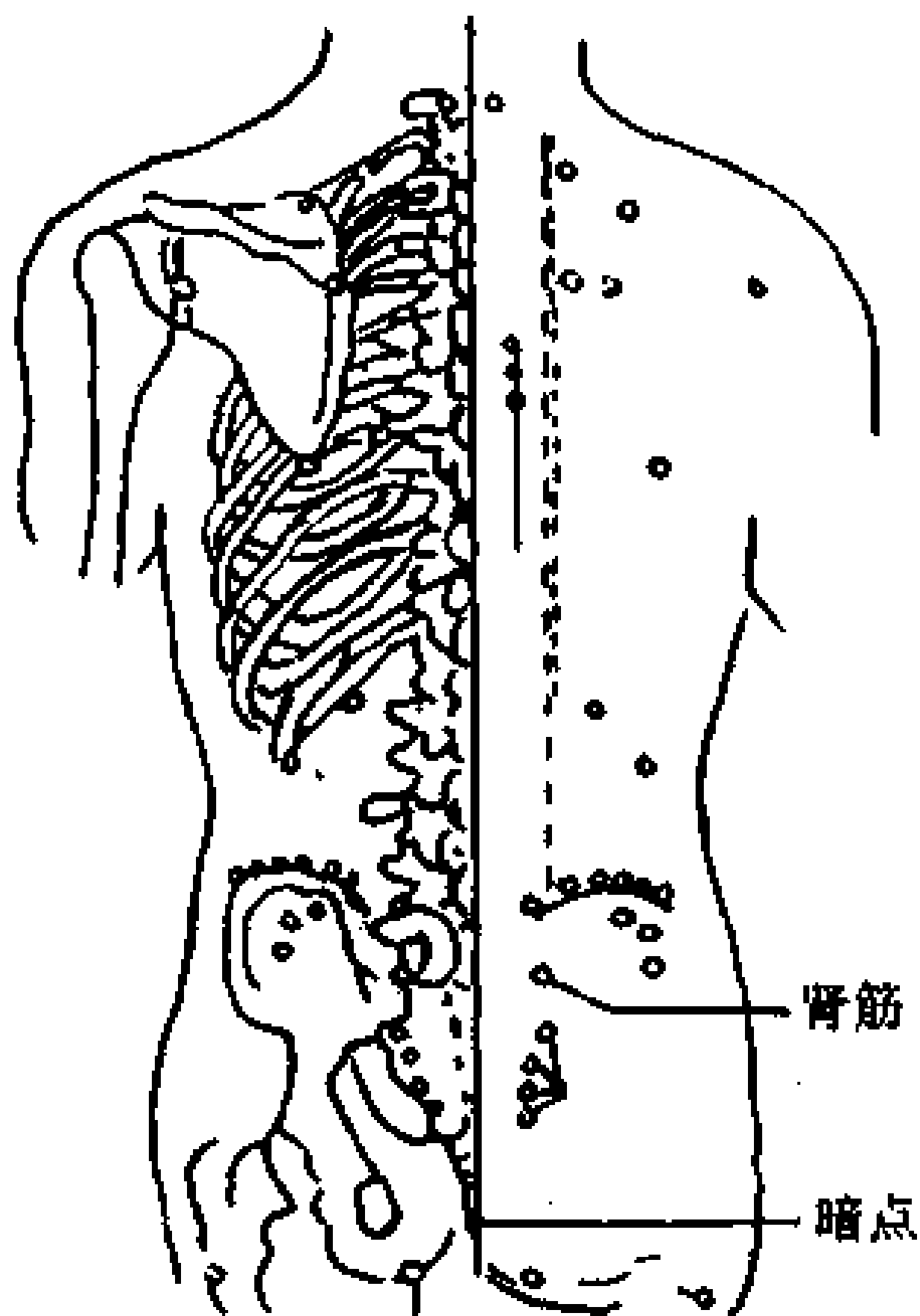


图 31-2

图 31. 泄泻取穴图

(2) 配穴：连环点、前心穴。

【手法操作】

先用重手法点按主穴 1 分钟，后点配穴。并用骶骨反转法反复 5~6 次。如兼有腹痛，可先点按后心穴以止之。

八、便秘

大便经常秘结不通，排便时间延长，或有便意而排便困难者，称为便秘。一般为燥热伤津、肠道滞涩，气机郁滞、传

导受阻，阴寒固结、阳气不运，气虚血少、传导无力所致。

便秘临诊，当分清虚实寒热。热秘者，大便干燥，硬结如球；气秘者，腹胀欲便，排便不畅；冷秘者，腹中攻痛，大便艰涩；虚秘者，又分气虚、血虚与阴虚：气虚者，便干不硬，无力排便，便后疲乏；血虚者，大便干燥，努挣难下；阴虚者，大便干燥，便意缺乏。

【取穴】（图 32）

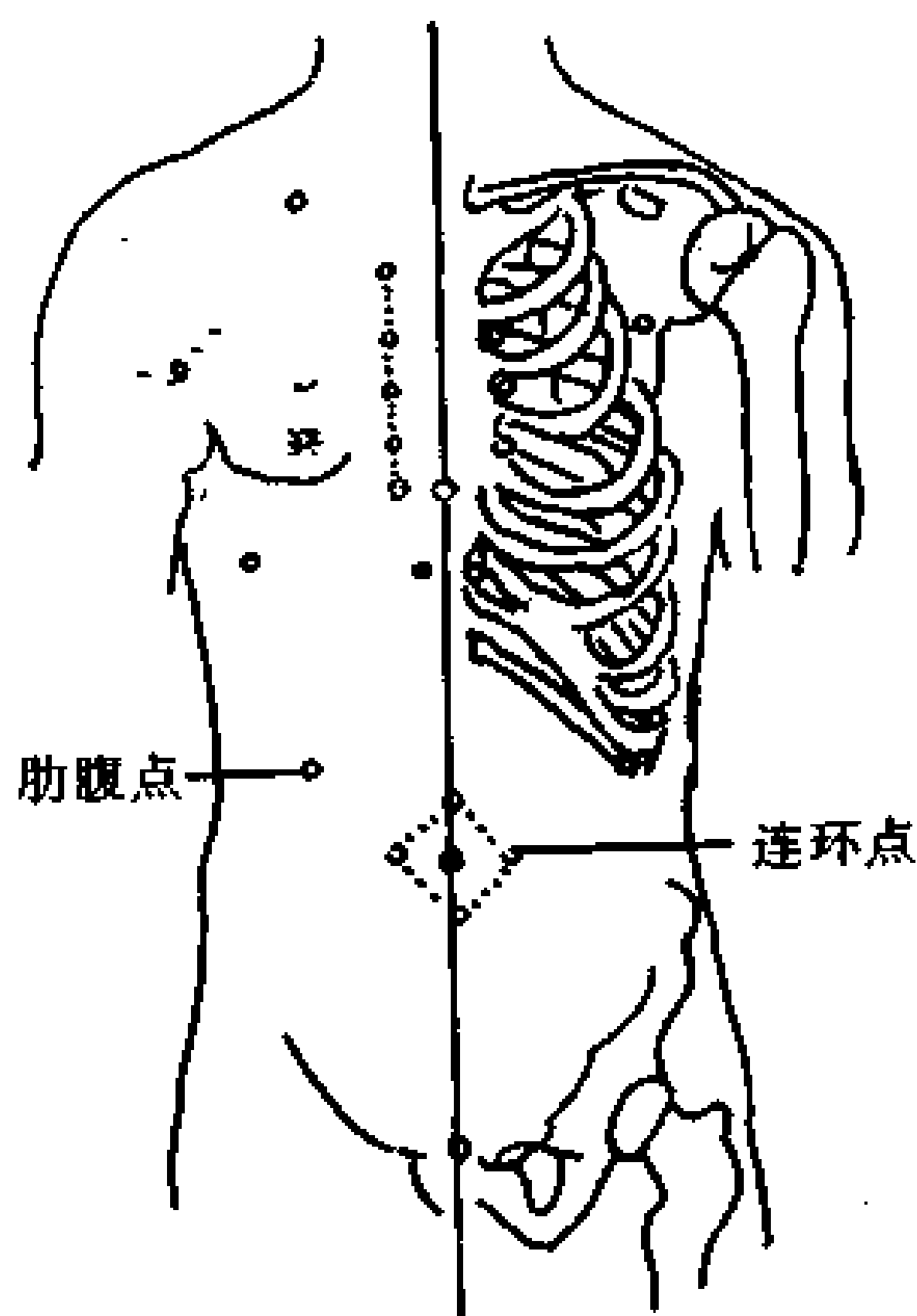


图 32-1

- (1) 主穴：连排点、暗点。
- (2) 配穴：连环点、肋腹点。

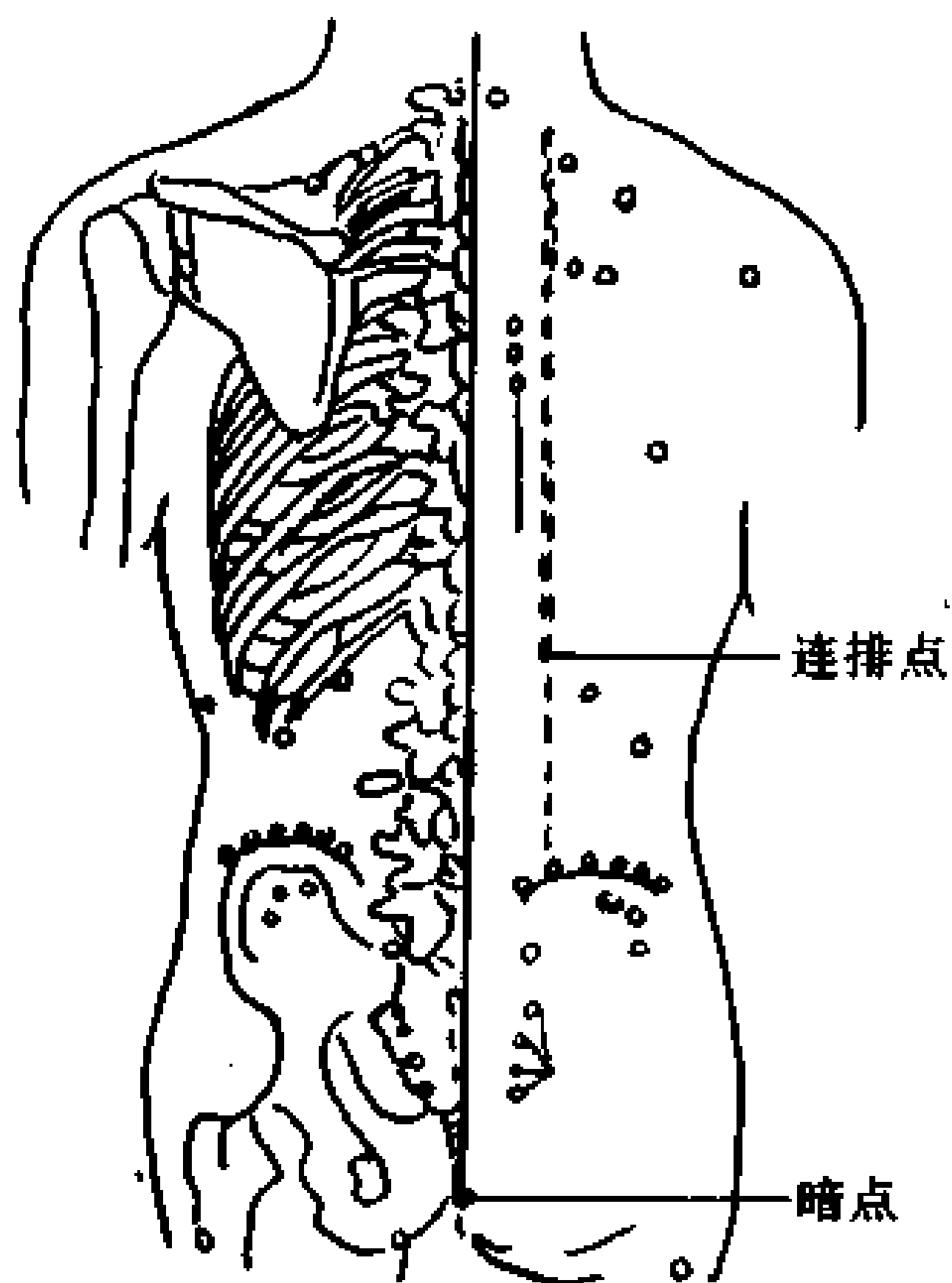


图 32-2

图 32 便秘取穴图

【手法操作】

先点主穴，后点配穴，并用捏脊法，手法不宜重。捏脊法重点在腰部，一般要捏 5~6 遍。

九、癃闭

癃闭是以排尿困难，甚则小便闭塞不通为主症的疾患。小便不利，点滴而短少，病势较缓者，称为“癃”；小便不通，欲解不得解，病势较急者，称为“闭”；一般统称为癃闭。发

生癃闭的原因，主要与膀胱气化不利有关。尿路闭阻，或三焦气化失常，均可引起癃闭。

湿热内蕴，则小便频数，灼热不畅，茎中刺痛；肺热壅盛，则小便点滴难下；肝郁气滞，则小便通而不爽，甚或小便不通，胁腹胀满；尿道阻塞，则小便滴沥，阻塞不通；肾气不充，则小便滴沥，排尿无力。

【取穴】（图 33）

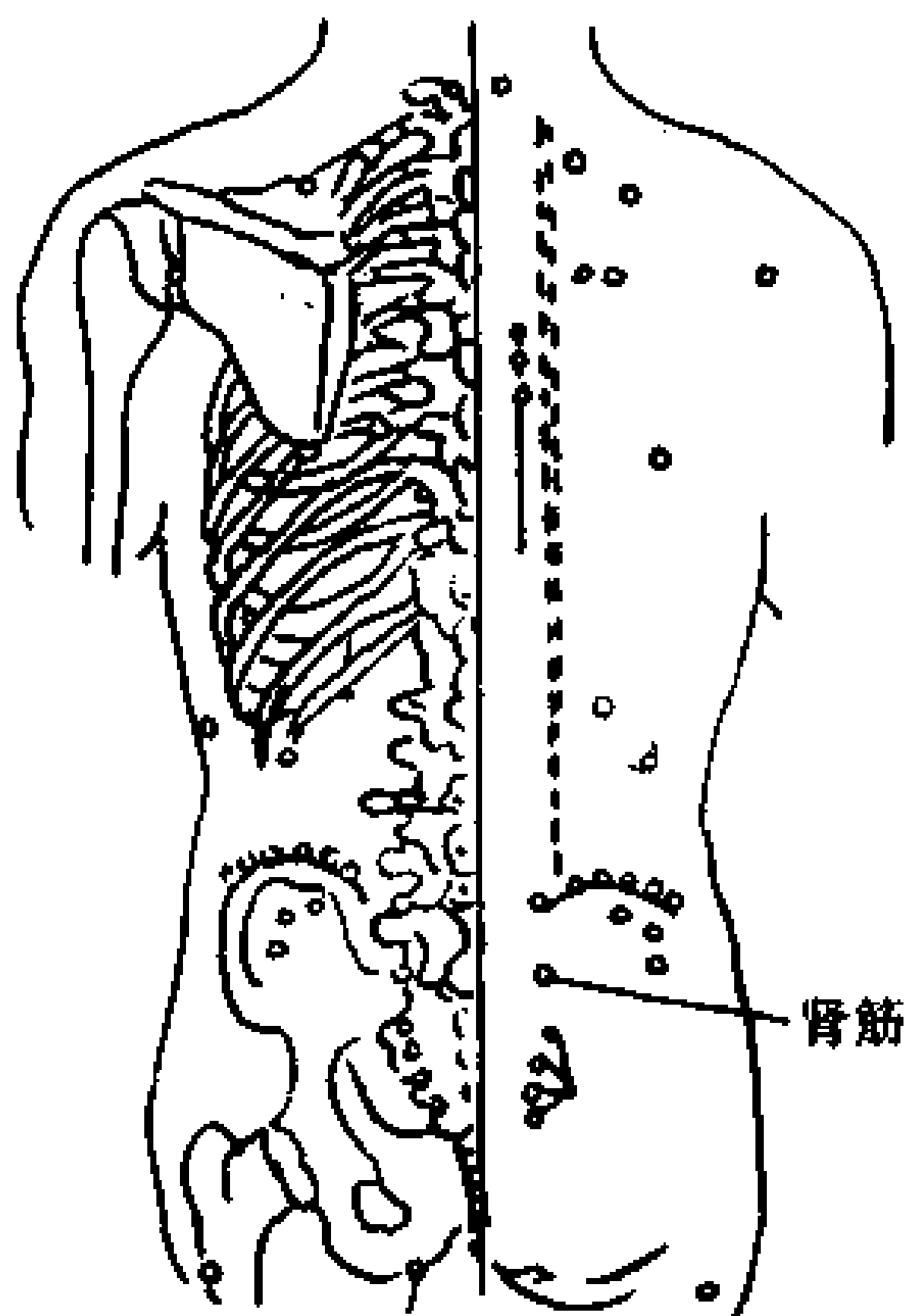


图 33-1

- (1) 主穴：阳点、连环点。
- (2) 配穴：肾筋、前心穴。

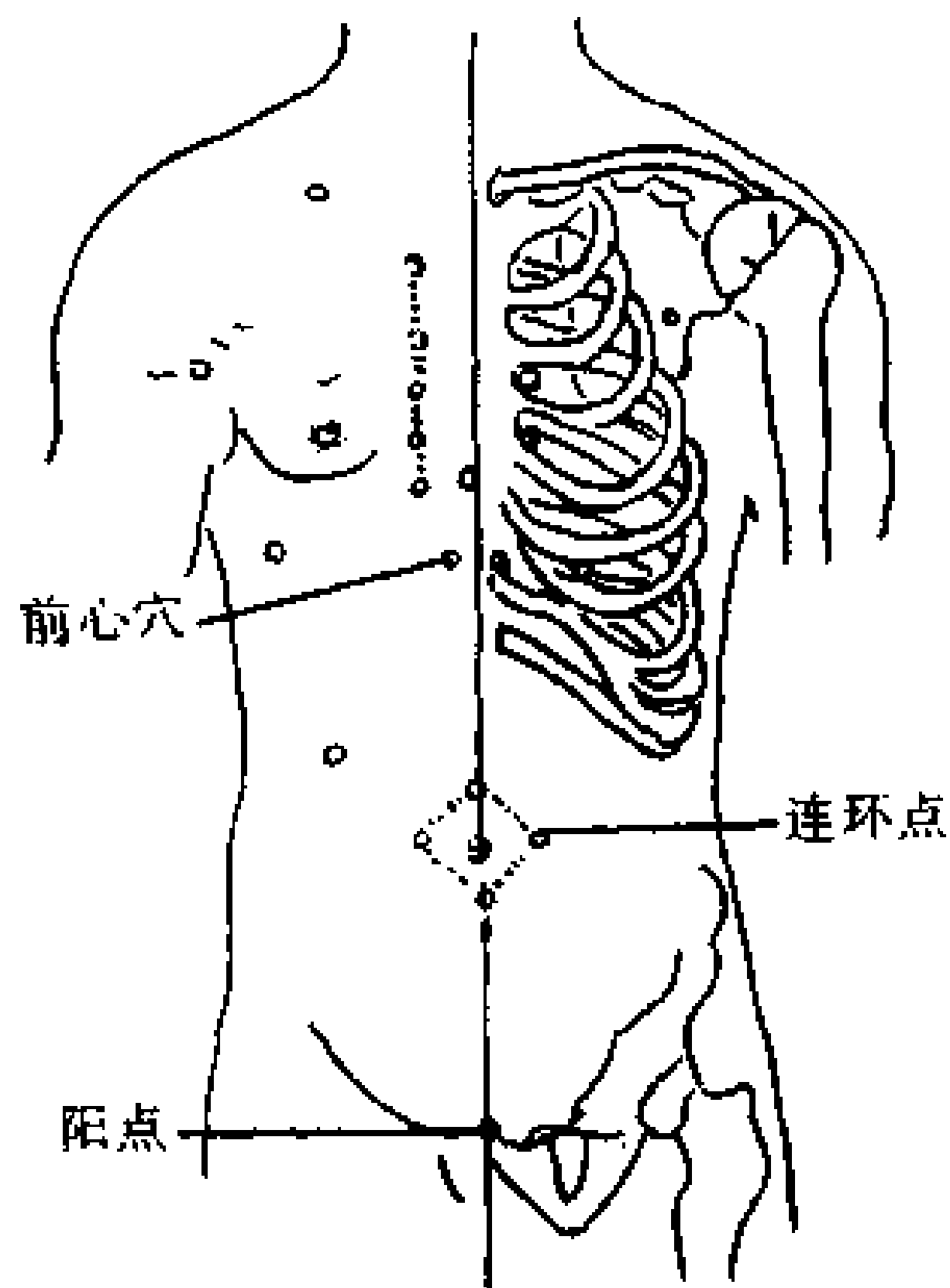


图 33-2

图 33 癰闭取穴图

【手法操作】

先点阳点及连环点 1~2 分钟，如效果不佳再取配穴。虚证者手法宜轻，实证者手法宜重。

十、阳痿

阳事不举，或举而不坚，称之为“阳痿”。多因湿热下注、宗筋弛纵，肾阴不足、相火妄动，中气虚亏、宗筋失养，肾阳衰微、兴阳无力所致。

湿热下注者，辜丸坠胀，阳痿不举；阴虚火旺者，性欲冲动，触而即泄；中气不足者，举而不坚；肾阳衰微者，痿而不起。

【取穴】（图 34）

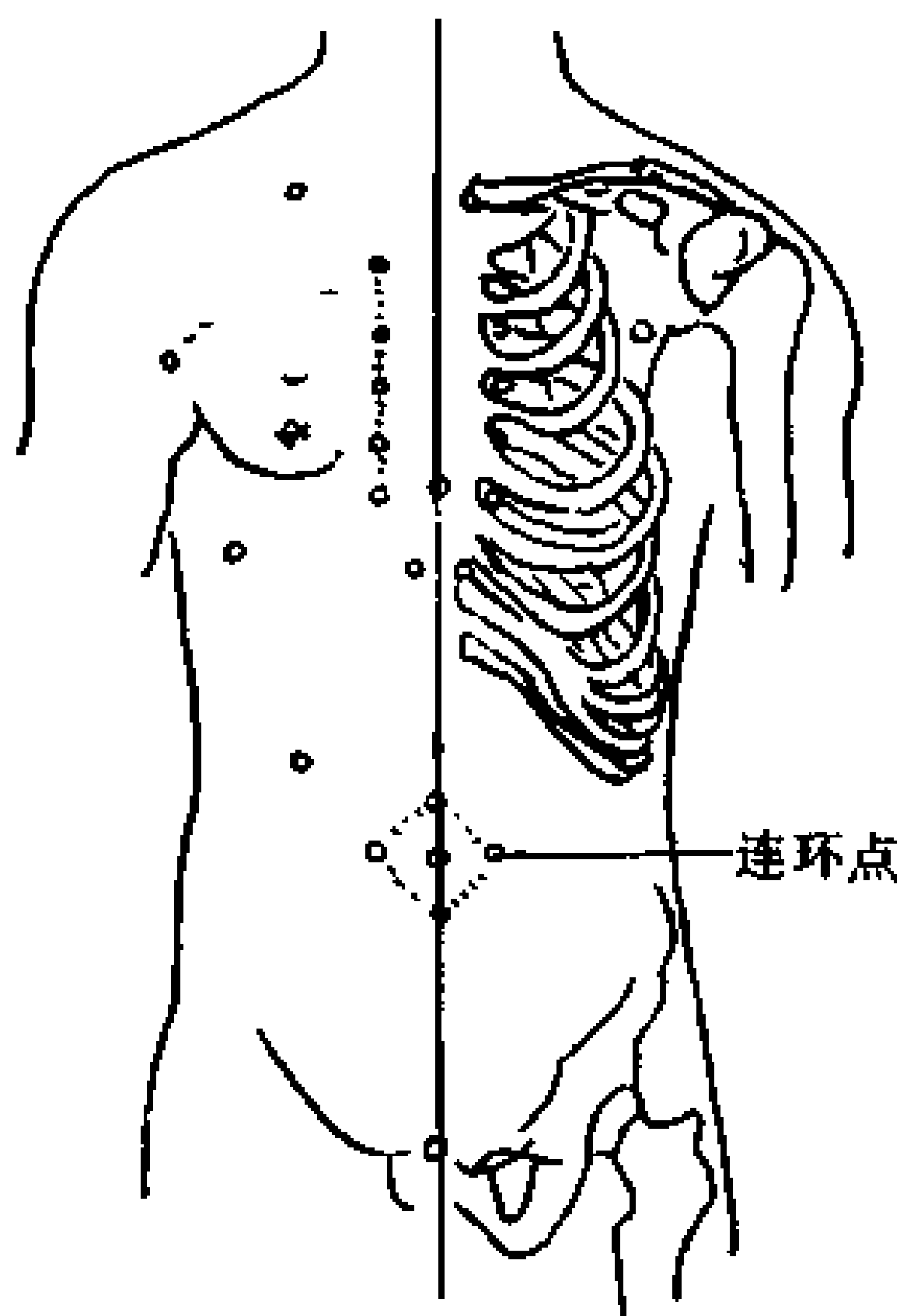


图 34-1

(1) 主穴：棘点、肾筋。

(2) 配穴：连排点、十八转、阳点。

【手法操作】

先点主穴，后点配穴，每天施术 1 次，7 天为一疗程。

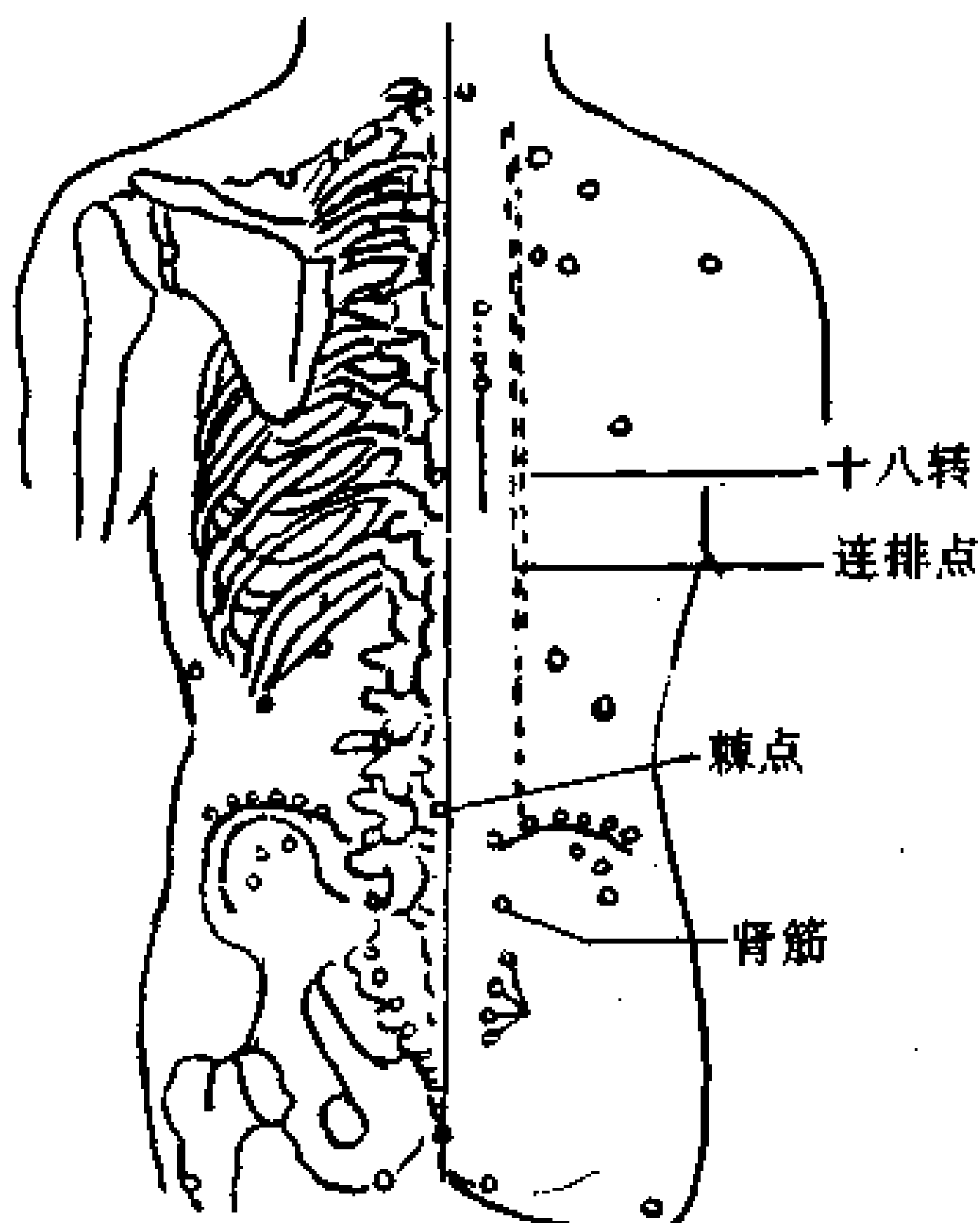


图 34-2

图 34 阳痿取穴图

十一、头痛

头痛是常见的自觉症状，可见于多种急、慢性疾病。一般分为外感与内伤两大类。头为诸阳之会，又为髓海所在，五脏六腑之气血皆上会于此，故外感时邪或脏腑内伤，均可发生头痛。

外感风寒，则头痛项强；外感风热，则头目胀痛；外感风湿，则头痛如裹，肢体困重；肝阳头痛，则偏侧痛重，胀

痛攻逆；痰浊头痛，则头痛昏蒙；瘀血头痛，则痛如针刺，固定不移。

【取穴】（图 35）

（1）主穴：椎点、天窗、颅点。

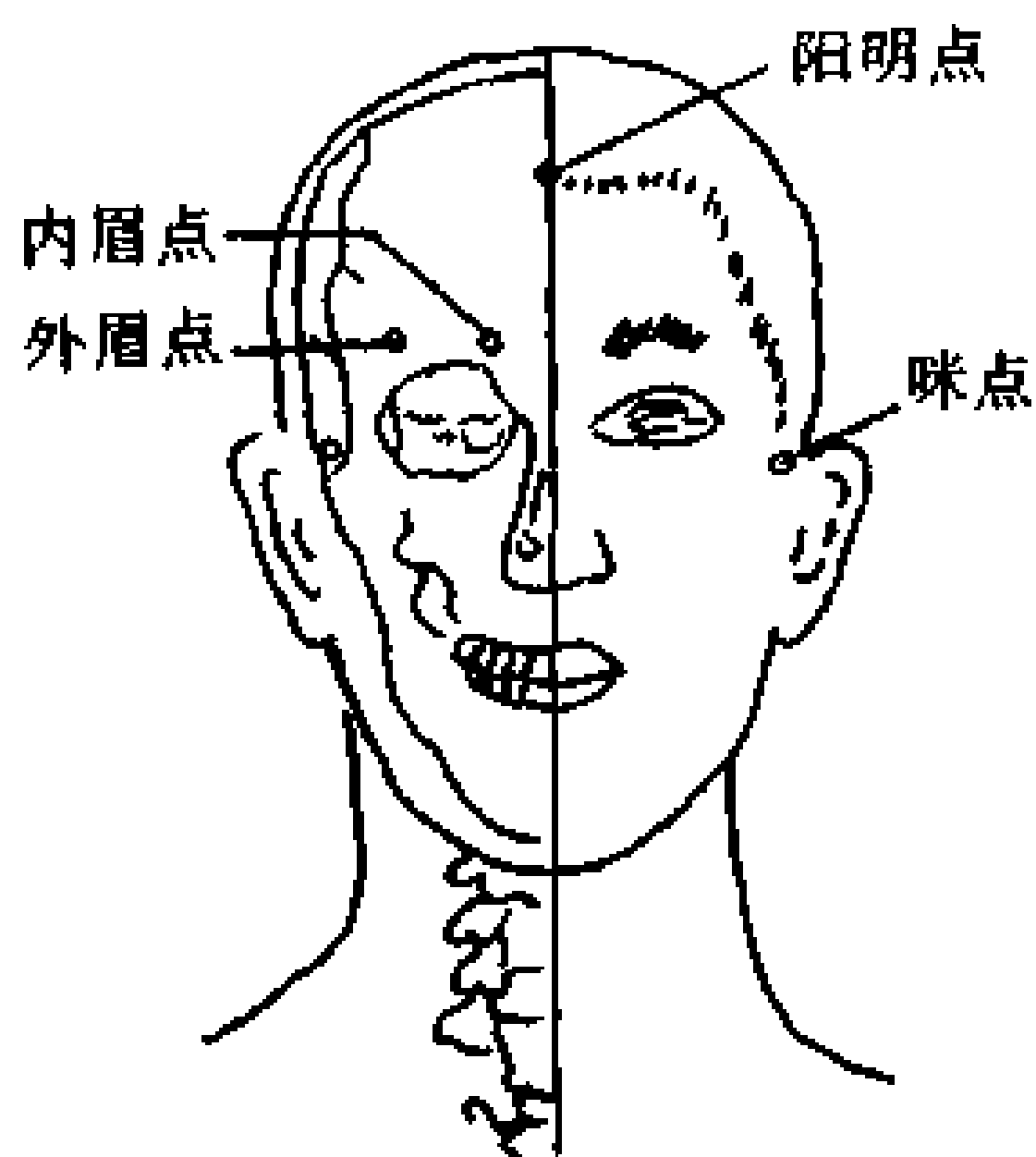


图 35-1

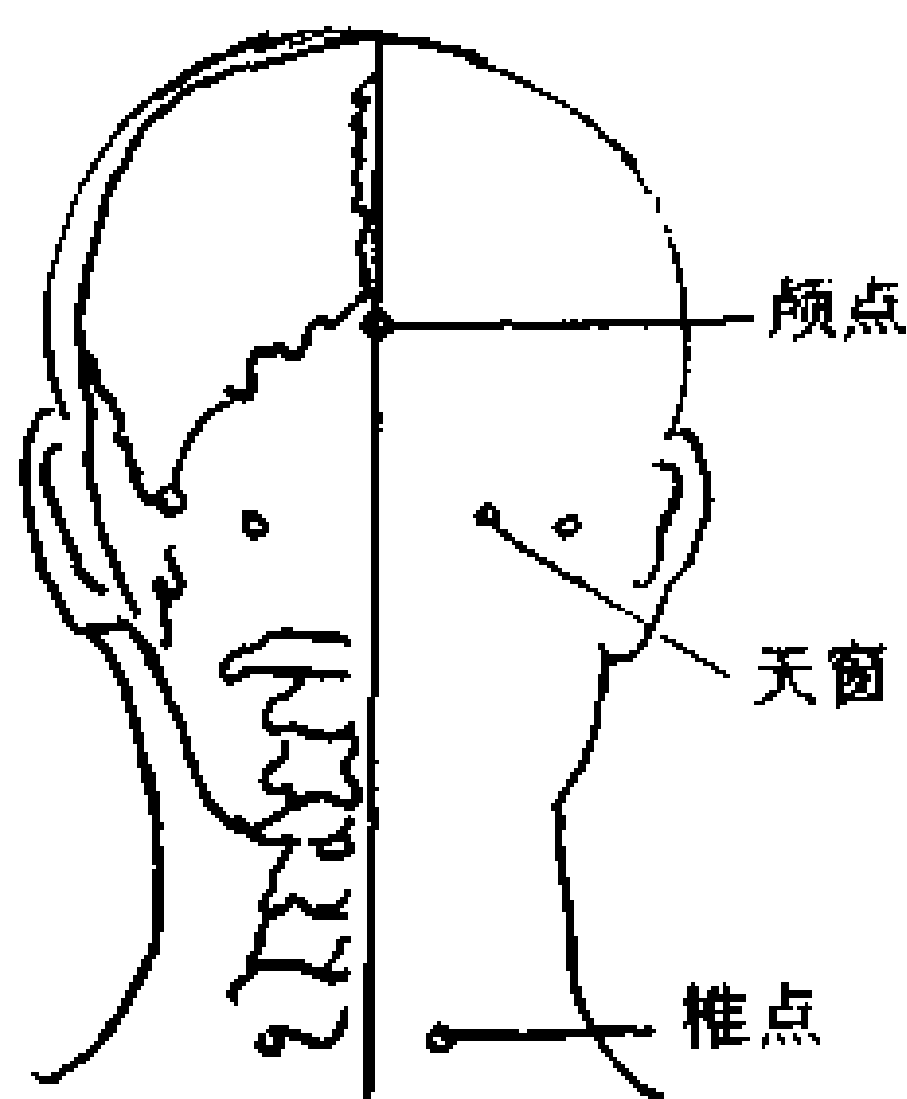


图 35-2

图 35 头痛取穴图

（2）配穴：阳明点，咪点，内外、眉点。

【手法操作】

先点主穴。如前额痛加阳明点，内、外眉点；偏头痛加咪点。手法均不宜过重。疼痛剧烈者可先点后心穴。

十二、牙痛

牙痛亦属常见的自觉症状。由于胃热，或大肠有热，加以外界风寒的刺激而引起。此外，尚有肾虚牙痛，或蛀牙疼

痛（龋齿）等。

以一侧臼齿疼痛为多数，或牙龈肿痛。如蛀牙疼痛，牙齿部有黑点或烂伤。肾虚牙痛，则牙龈不肿，而疼痛感觉在齿根部。

【取穴】（图 36）

（1）主穴：牙痛点、颌点。

（2）配穴：咬点。

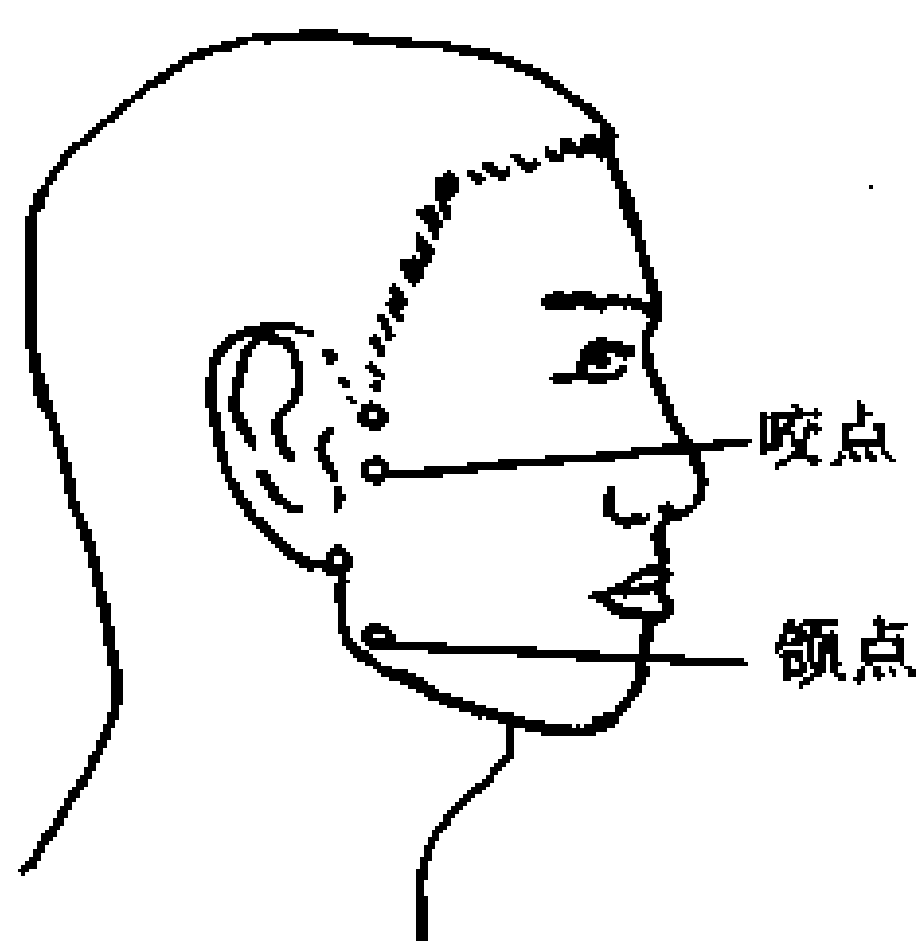


图 36-1



图 36-2

图 36 牙痛取穴图

【手法操作】

如因风火所致之牙痛，可在牙痛点处找小红点，用酒精消毒后，再用三棱针刺出血。如因虚火上炎，肾虚火不归源，可口服 10 毫升左右的白酒（60 度左右）。

十三、眩晕

“眩”为眼花，“晕”即头晕，故眩晕为二者的统称，是指头晕眼花，旋转不定，甚至仆倒，多伴恶心、呕吐、耳鸣、

汗出等证。眩晕发生的原因，主要有肝阳上亢、痰浊中阻、肾精不足以及气血亏虚等几个方面，且可彼此影响，互相转化。

肝阳上亢者，眩晕耳鸣，攻逆暴发；痰浊中阻者，头重目眩，不欲活动；肾精不足者，眩晕耳鸣，动则益甚；气血亏虚者，头晕目眩，遇劳加重。

【取穴】（图 37）

- （1）主穴：阳明点、椎点。
- （2）配穴：天窗，内、外眉点。

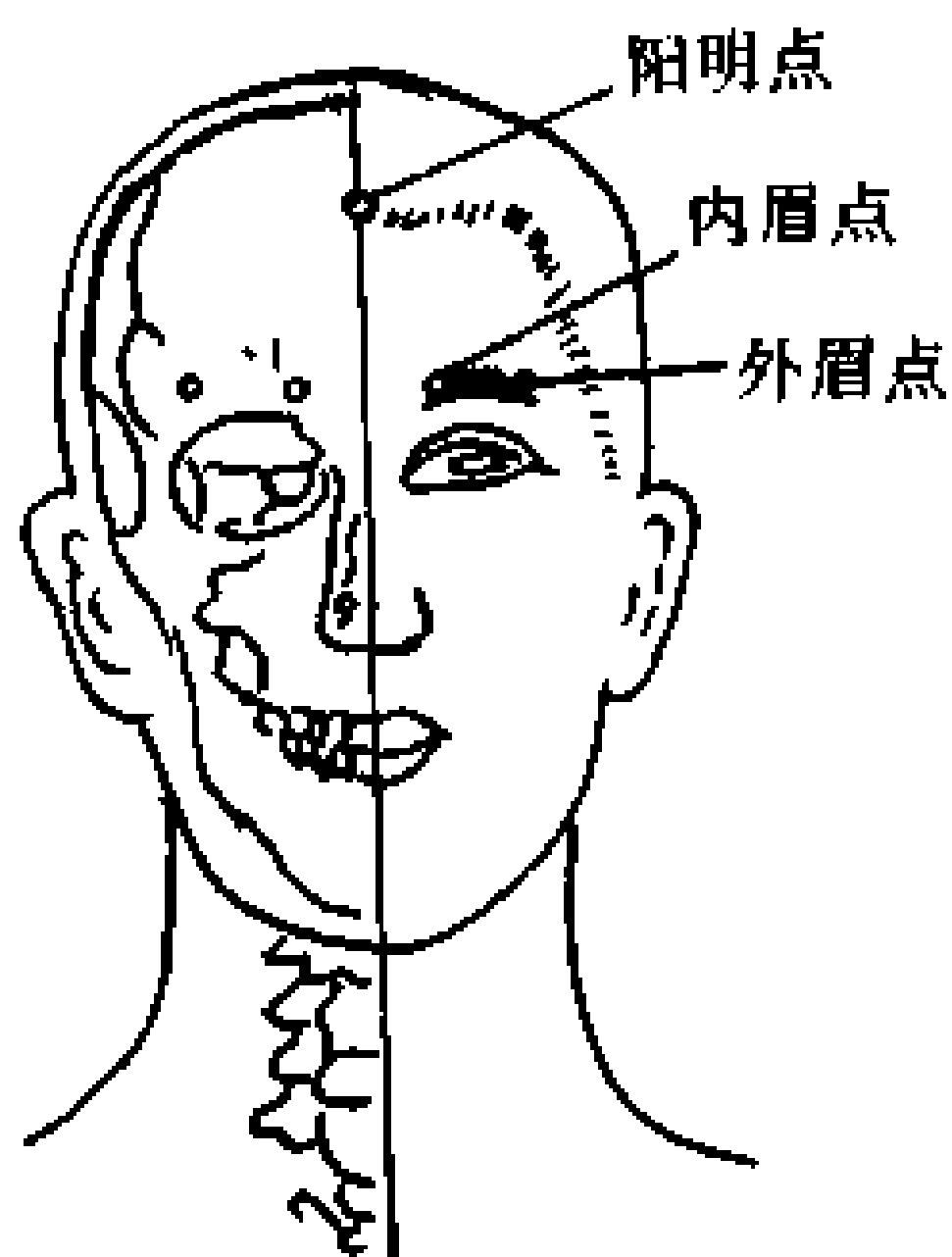


图 37-1

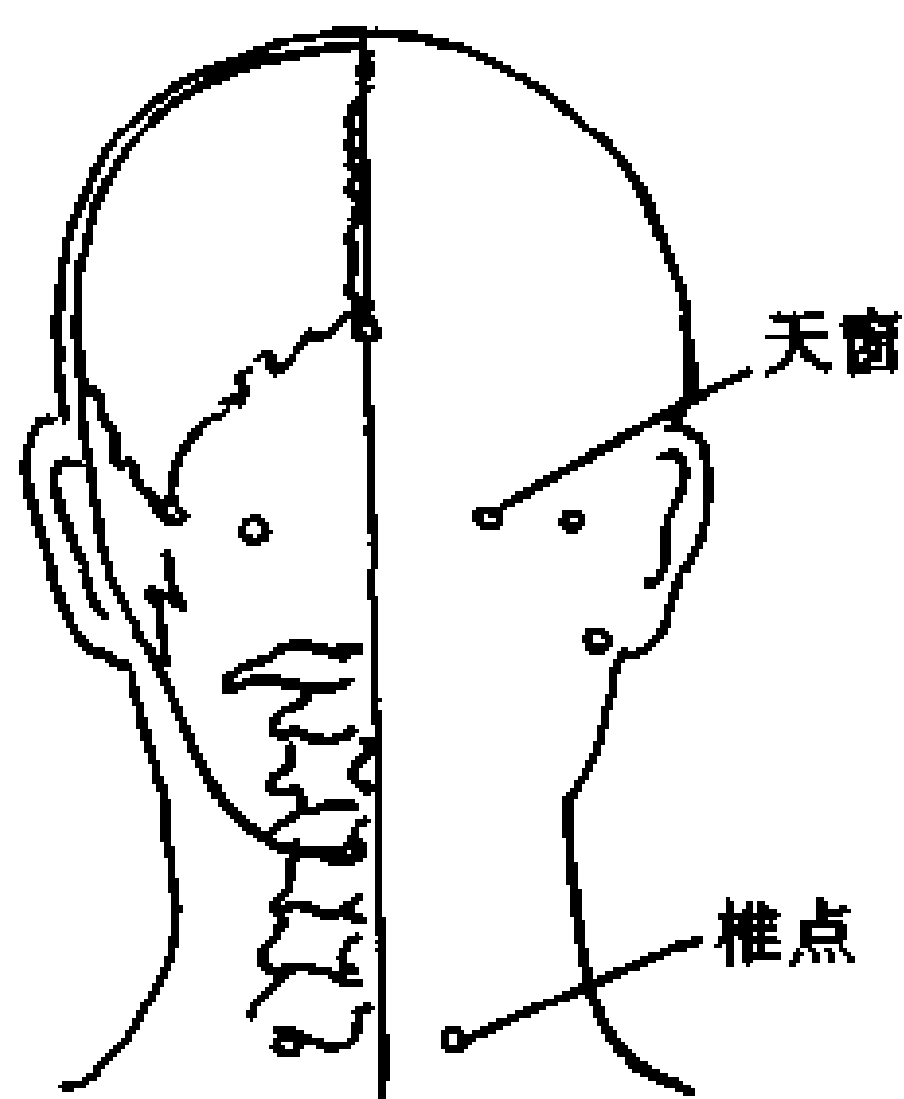


图 37-2

图 37 眩晕取穴图

【手法操作】

反复点按主穴后再点配穴，手法宜轻，点后加揉按穴位。

十四、耳鸣、耳聋

耳鸣、耳聋均为听觉异常的病象。耳鸣是自觉耳内如蝉鸣或如潮声隆隆，妨碍听力；耳聋是指不同程度的听力减退，又称重听。临床分为实证、虚证两大类。实证多因风热上扰，肝胆火盛，或痰火郁结所致；虚证多因肾精不足，髓海空虚而致。

实证耳鸣发病较急，鸣声如潮，按之加重；虚证耳鸣发病缓慢，鸣声如蝉，按之则减。

【取穴】（图 38）

- （1）主穴：乳面点、垂点（均取双侧穴）。
- （2）配穴：天窗、咬点。

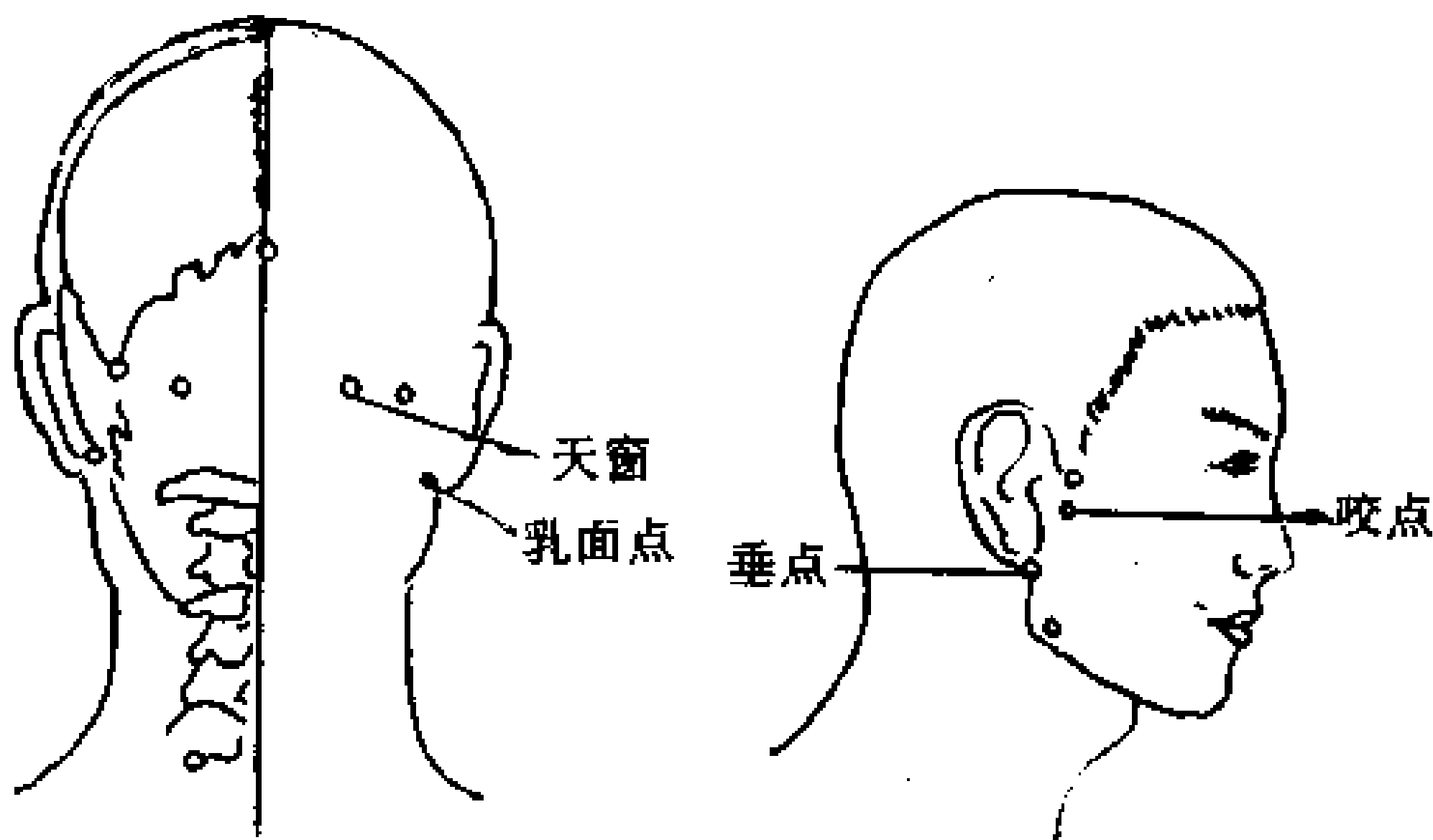


图 38-1

图 38-2

图 38 耳鸣、耳聋取穴图

【手法操作】

手法不宜过重。如系实证加点侧臂点（双侧）；虚证则应配合口服补肾药治疗。

十五、失眠

失眠是指经常不能获得正常的睡眠而言。轻者入眠艰难，或睡眠不稳，时寐时醒；严重者可彻夜不眠。本病多因思虑伤脾，或血虚不能养心、心肾不交，或痰热上扰，以致卧不得安。

心脾两虚则多梦易醒，心悸健忘；阴亏火旺则见心烦失眠，头晕耳鸣；痰热内扰者，失眠心烦，胸闷头重。

【取穴】（图 39）

（1）主穴：内、外眉点。

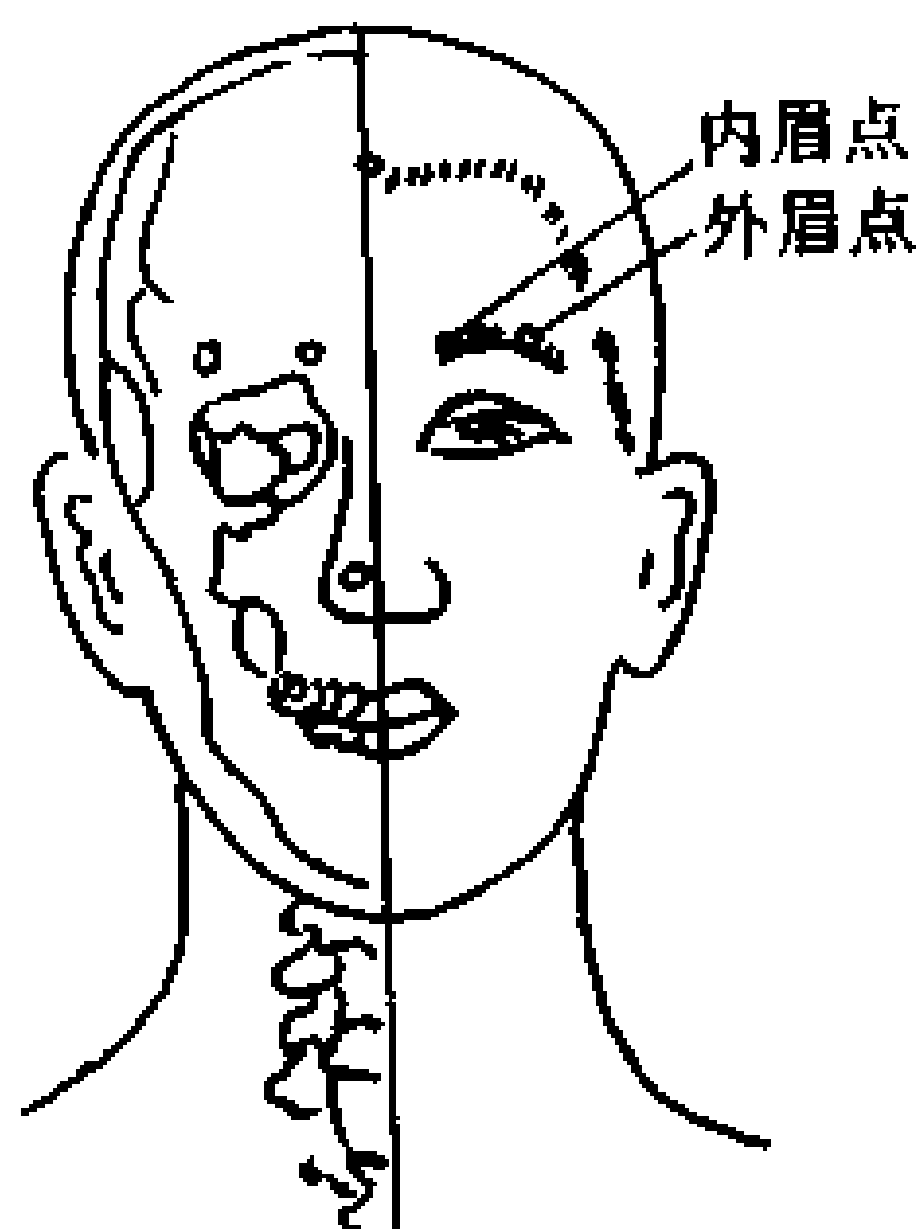


图 39-1

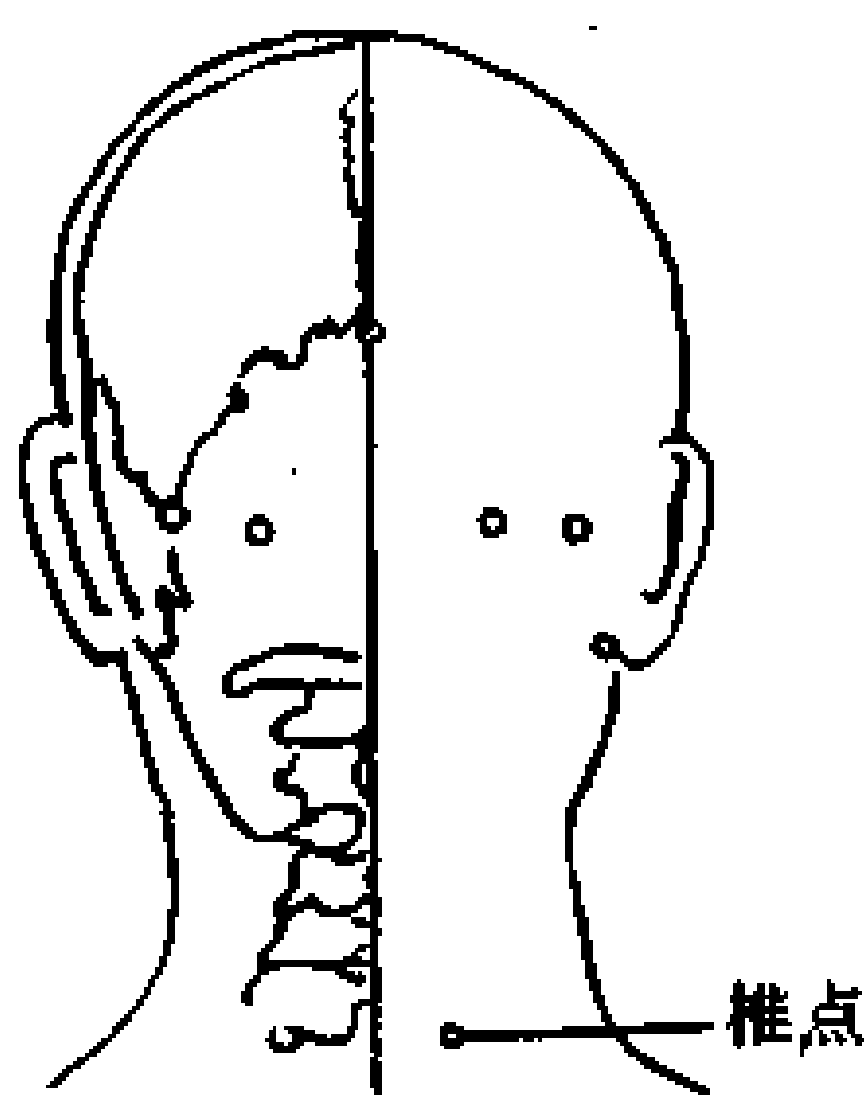


图 39-2

图 39 失眠取穴图

(2) 配穴：椎点。

【手法操作】

反复行捏脊法 5~6 遍，然后用轻手法点按内、外眉点（双侧穴）。效果不佳者，可加点椎点。

十六、郁证

郁证是指由于情志不舒、气滞邪郁所引起的疾病。常由于情志失调，使肝失条达，气机不畅，以致肝气郁结而成此证。

本证以精神抑郁，胸闷太息为特点。临床上表现为心情抑郁，情绪不宁，胁肋胀痛，或易怒善哭，以及咽中如有物梗阻，常伴有眩晕、失眠等。

【取穴】（图 40）

(1) 主穴：侧臂点、肋尖点、前心穴、肋点。

(2) 配穴：脊点、阳明点、天窗。

【手法操作】

先点主穴，如效果不佳，再加点配穴。

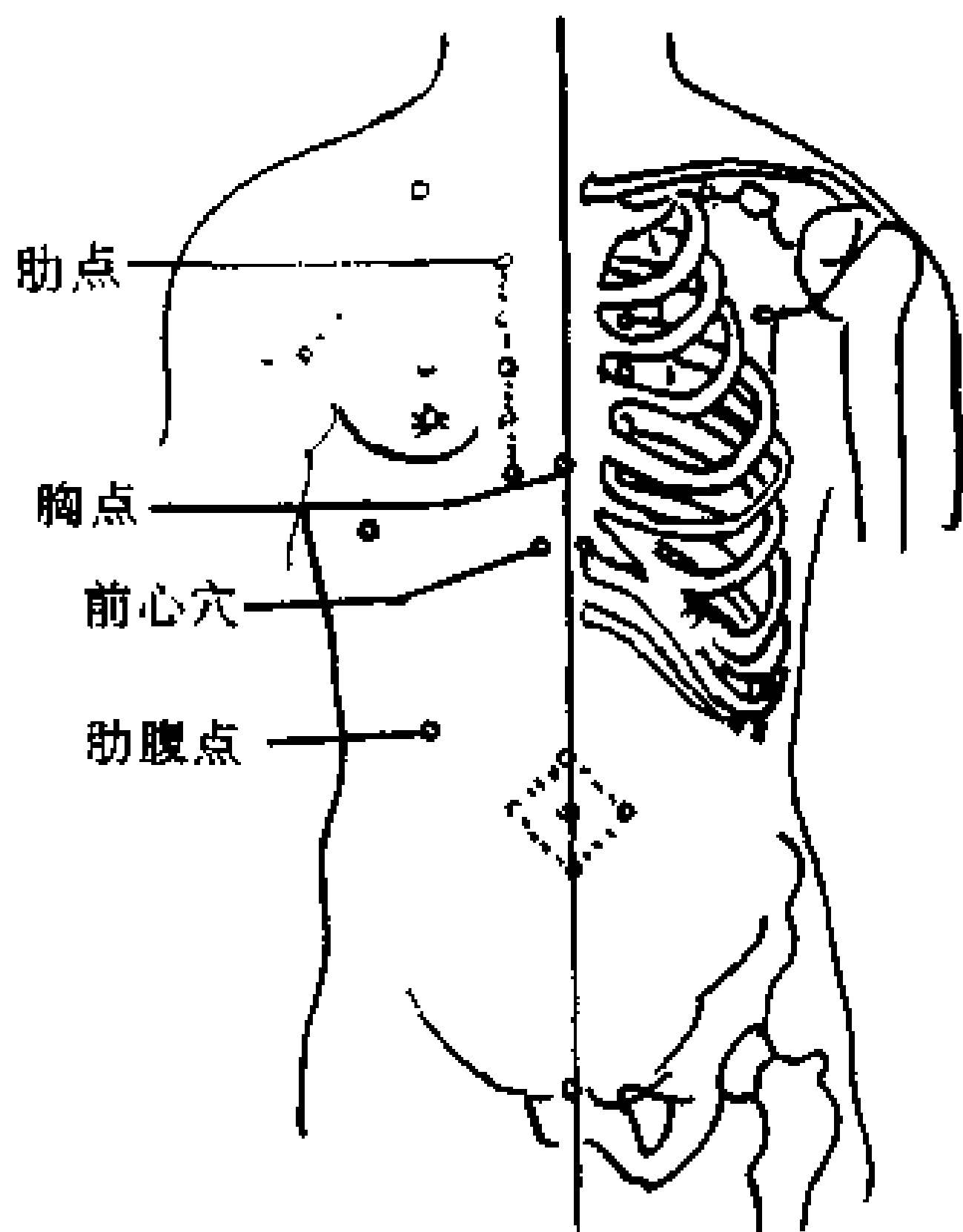


图 40-1

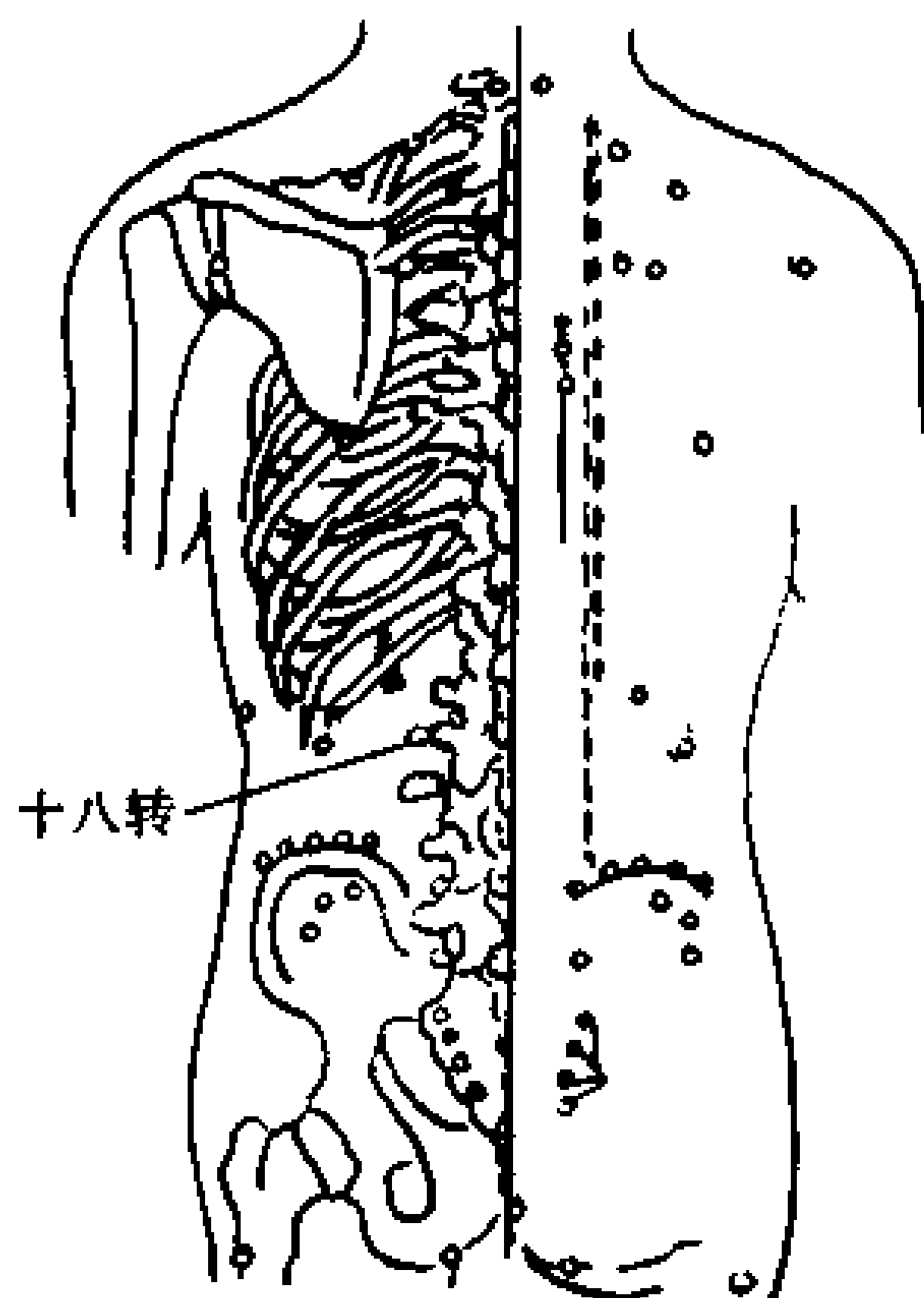


图 40-2

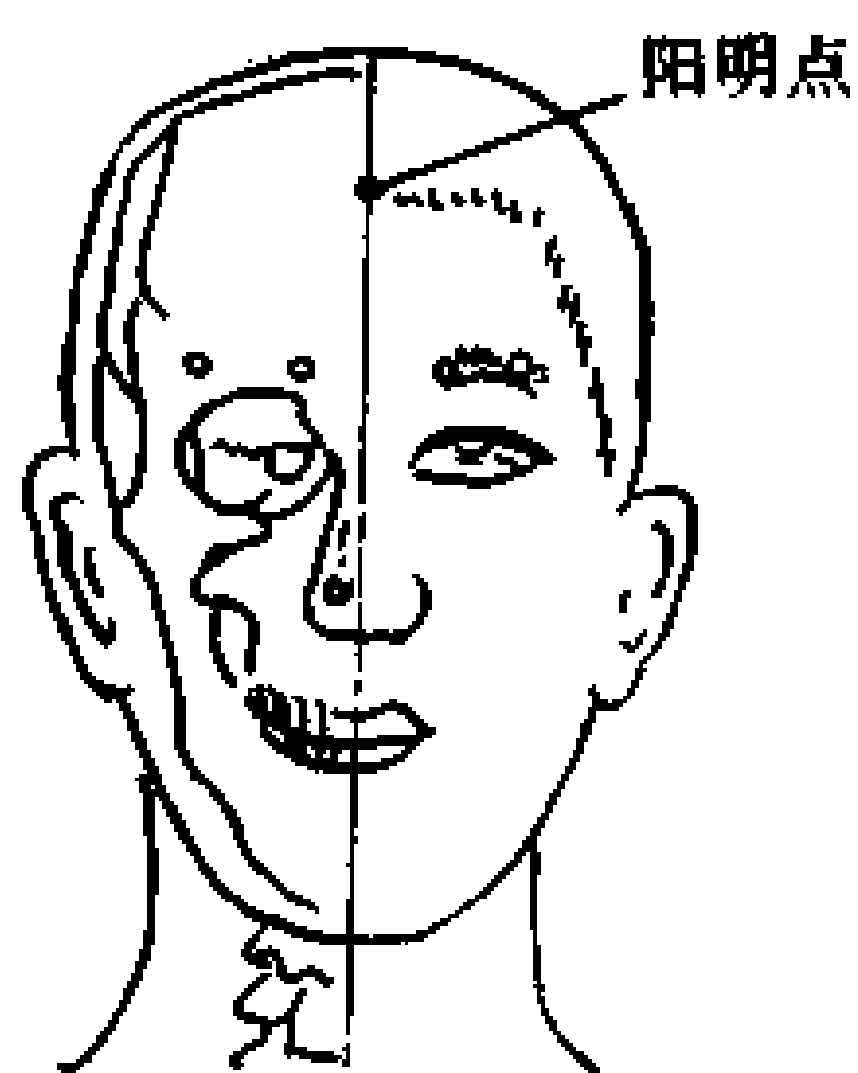


图 40-3

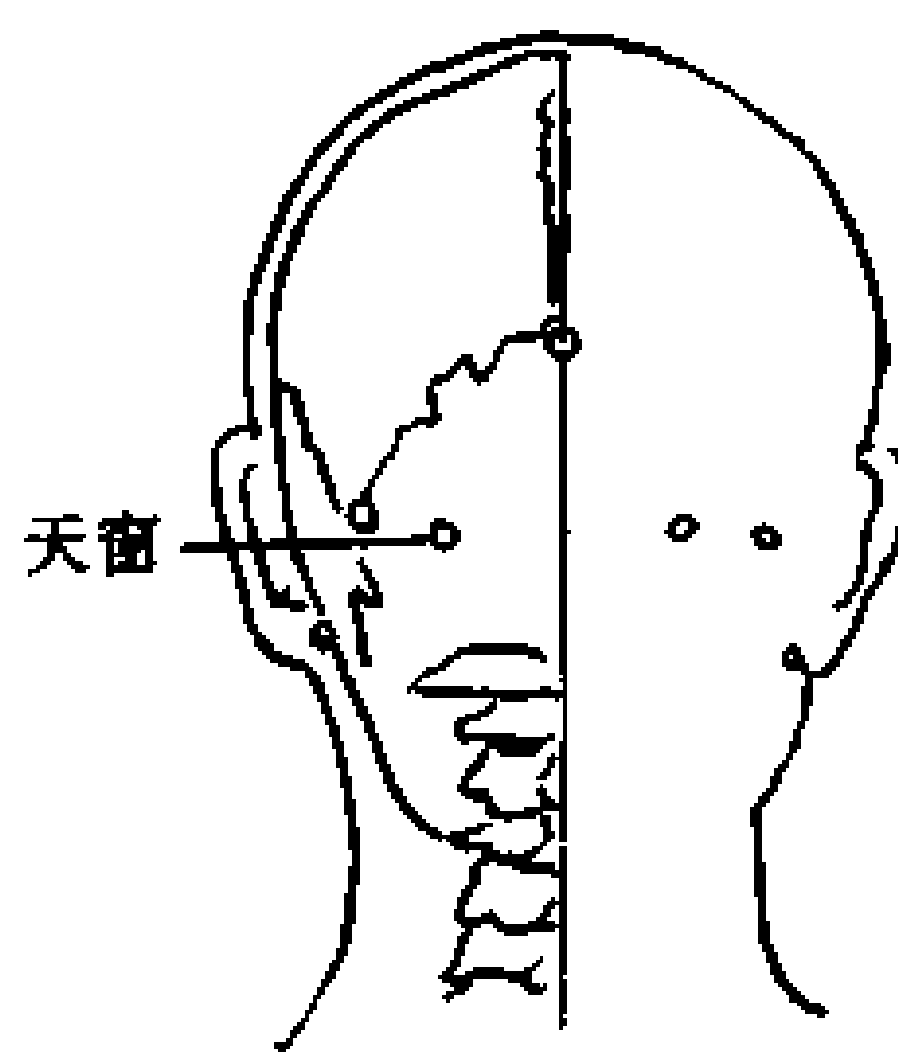


图 40-4

图 40 郁证取穴图

十七、癲证

癲证乃属精神失常的一种疾病。主要是由于情志所伤而引起的。或因忧郁伤肝，气郁生痰，蔽塞心窍；或因思虑太过，损伤心脾，久则心神失养，均可发为癲证。此外，本病与先天遗传亦有一定关系。

精神抑郁，神思恍惚，沉默痴呆；或喃喃独语，静而多笑；或语无伦次，颠倒错乱。

【取穴】（图 41）

（1）主穴：前心穴、胸点、肋点。

（2）配穴：十八转、天窗、颅点、肋腹点。

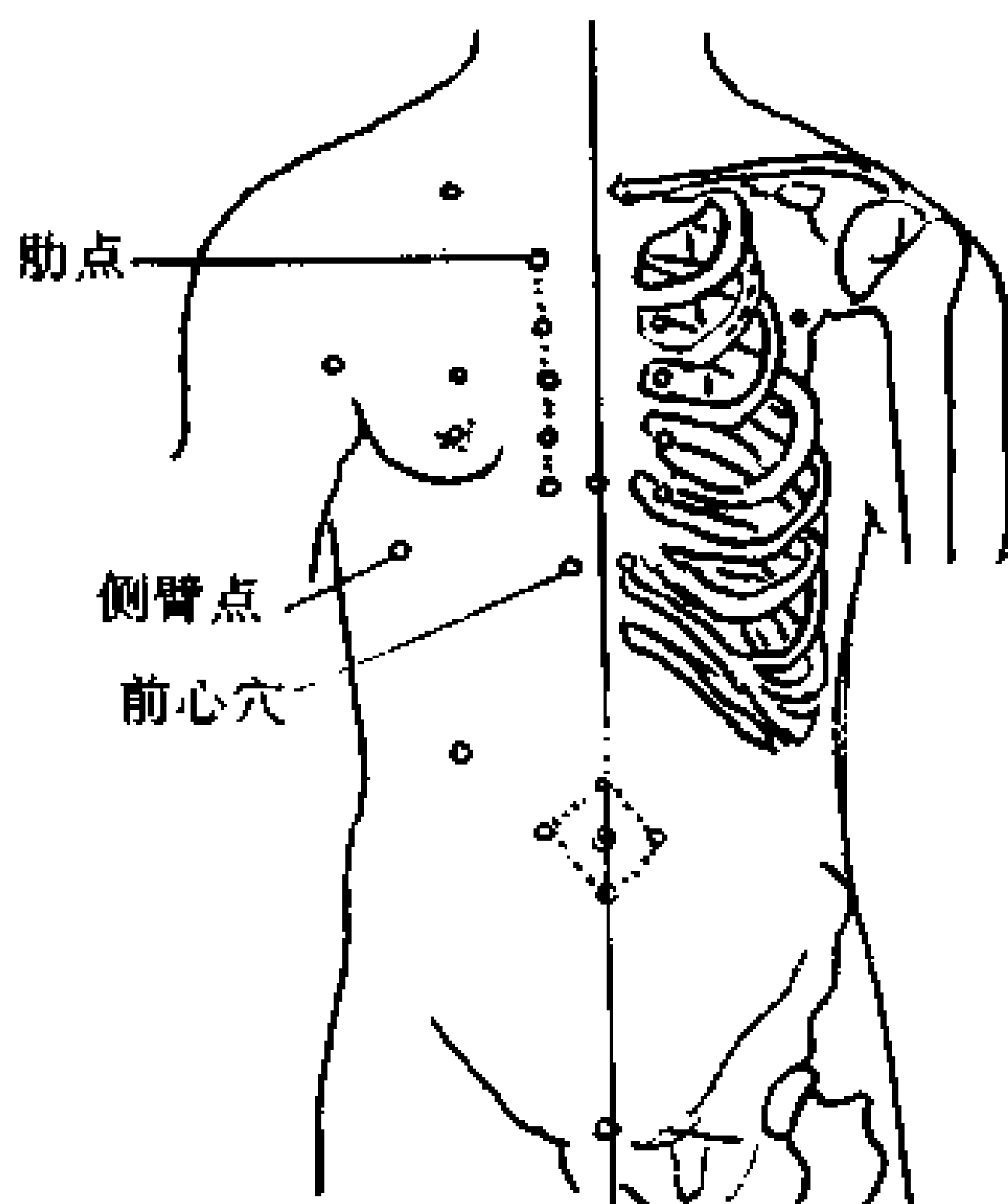


图 41-1

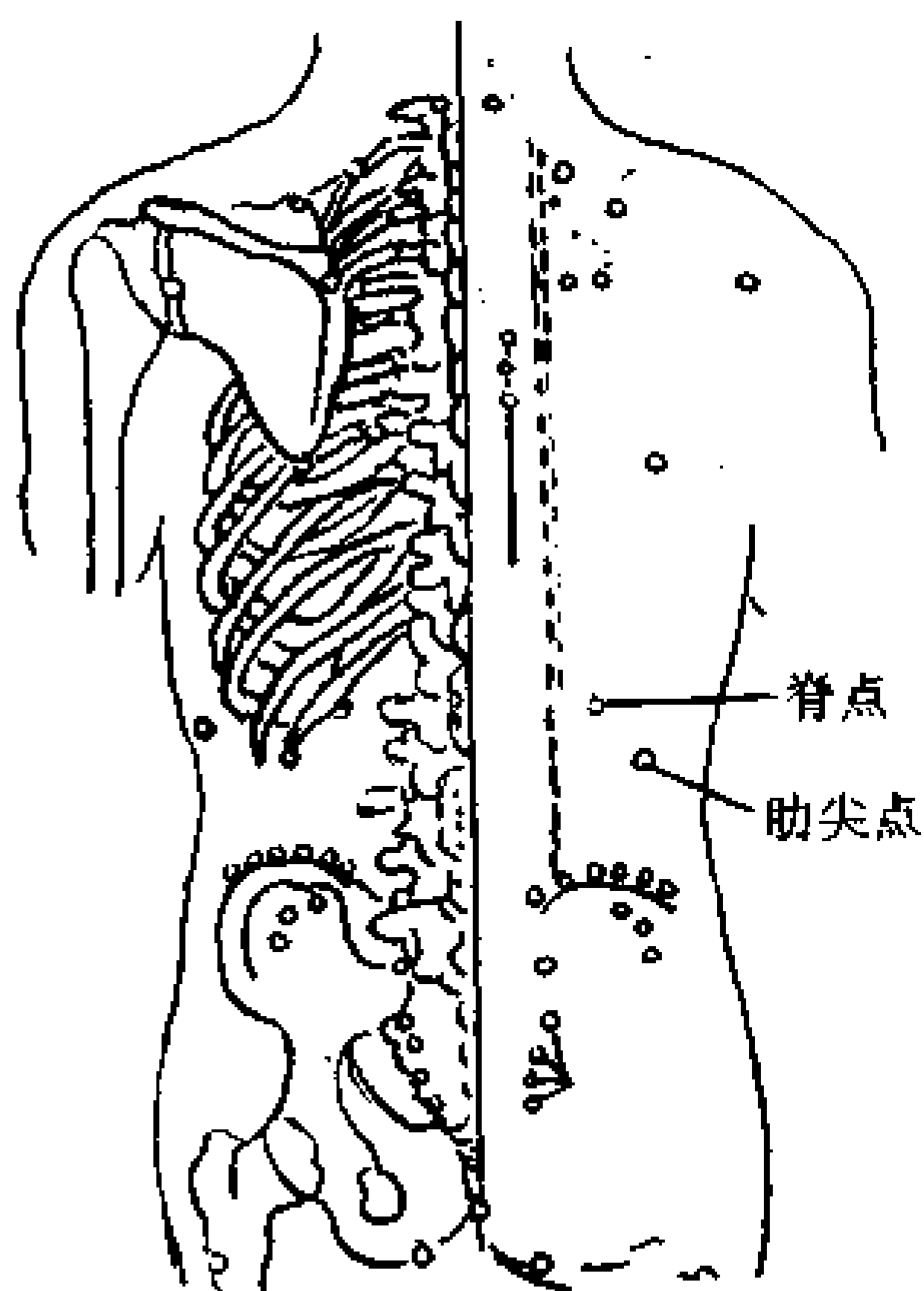


图 41-2

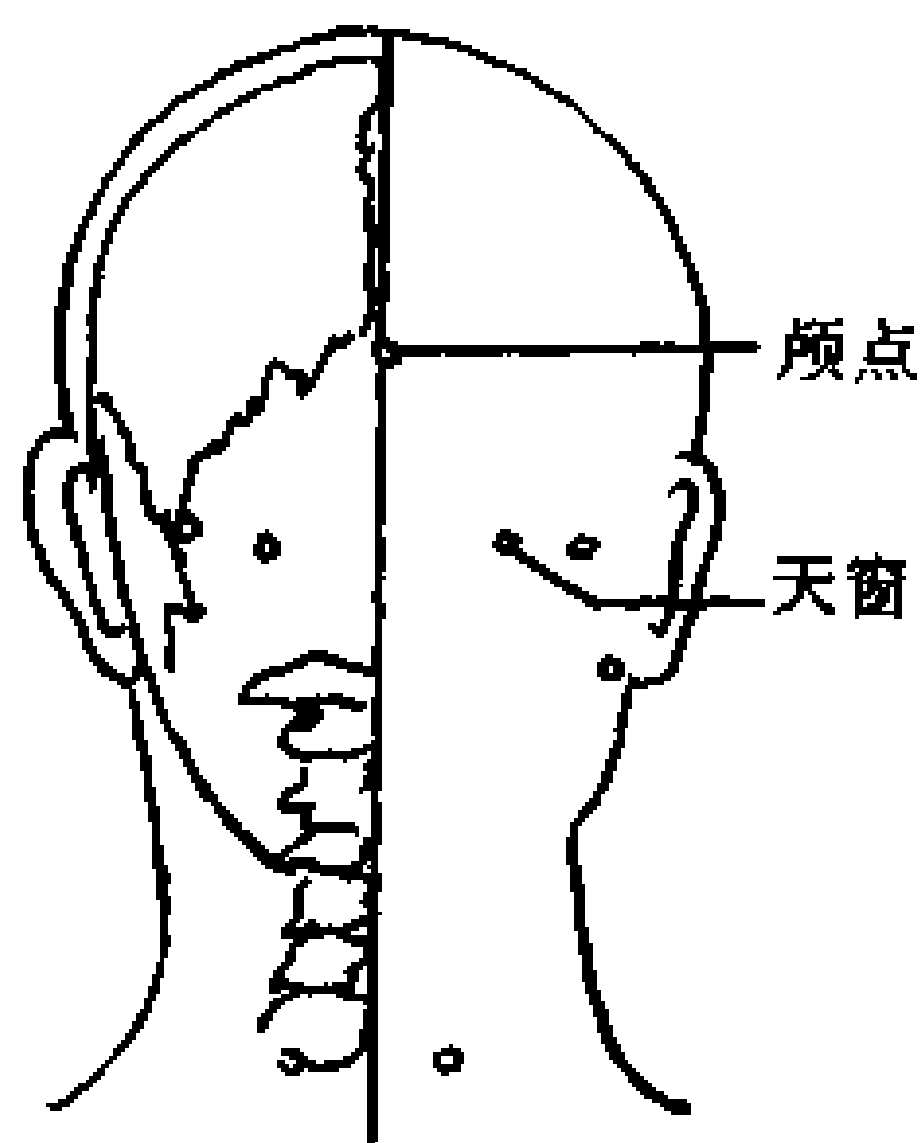


图 41-3

图 41 癲证取穴图

【手法操作】

手法不宜过重。

十八、痫证

“痫”是一种间歇性阵发性神志昏迷、肢体抽搐、口吐涎沫的疾病。又有“癫痫”和“羊痫风”等称。本病是以精神因素、饮食因素和先天因素等造成脏腑失调、积痰内风所致。

发作前常有眩晕、头痛、胸闷、乏力等症。发则突然昏仆，牙关紧闭，两目上翻，四肢抽搐、口吐涎沫，或有叫声；

亦可仅有短暂昏迷，或神志失常而无抽搐的小发作。有隔日或隔月发病的，也有一日数次发作的。

【取穴】（图 42）

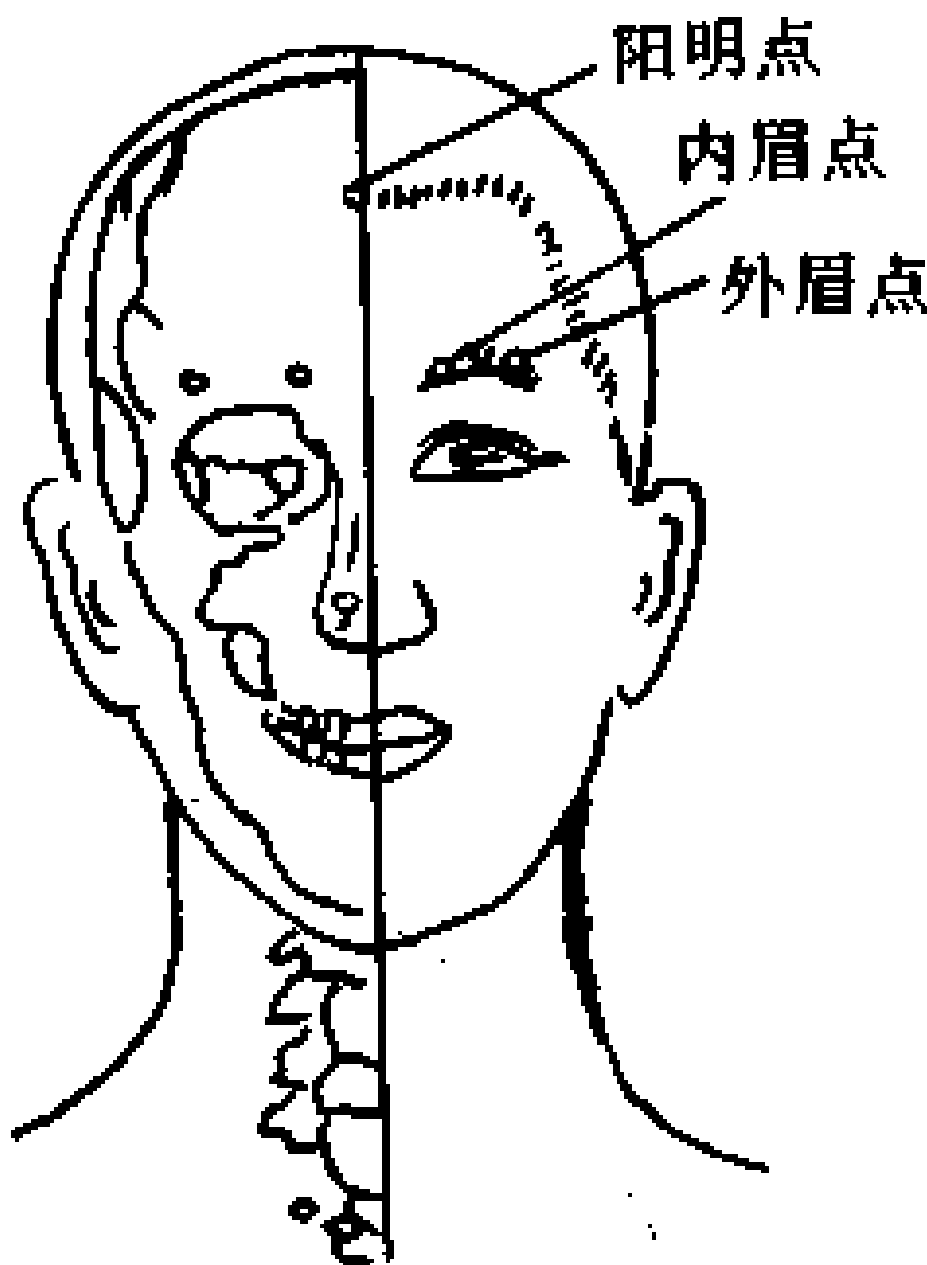


图 42-1

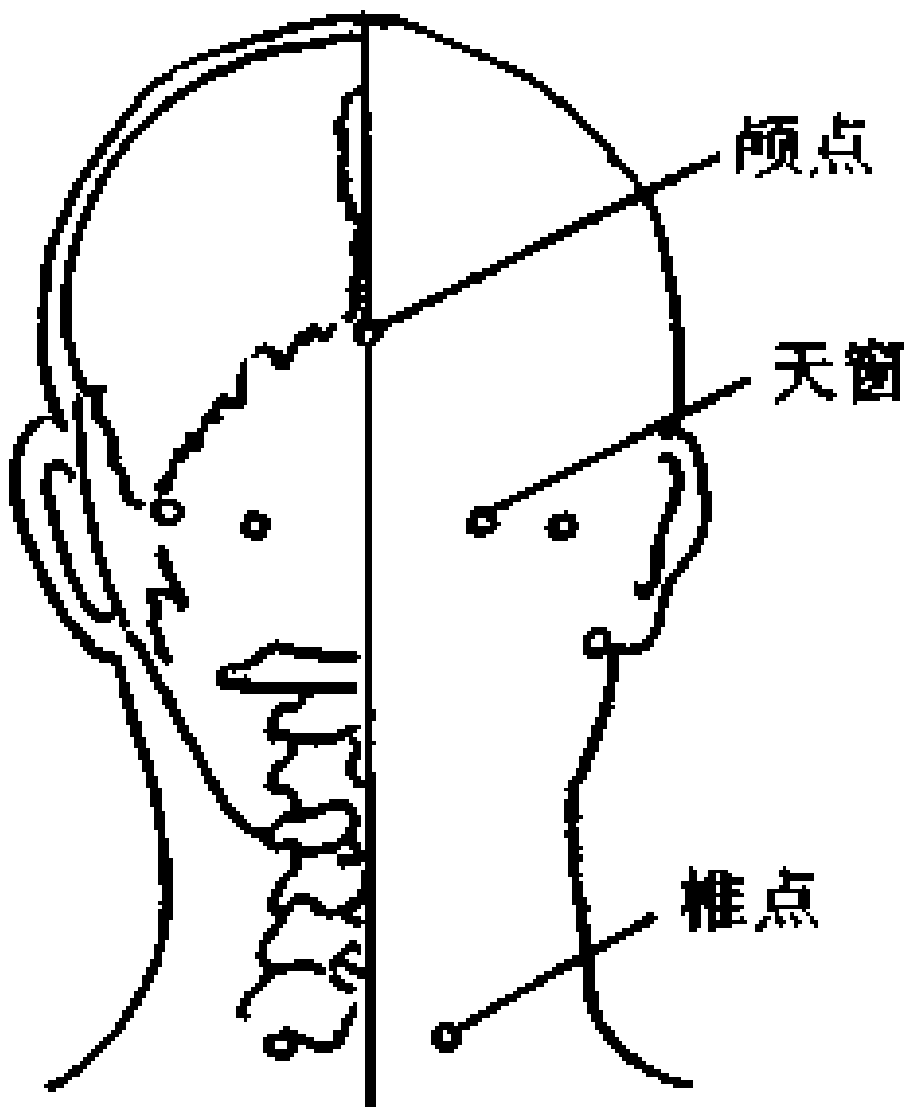


图 42-2

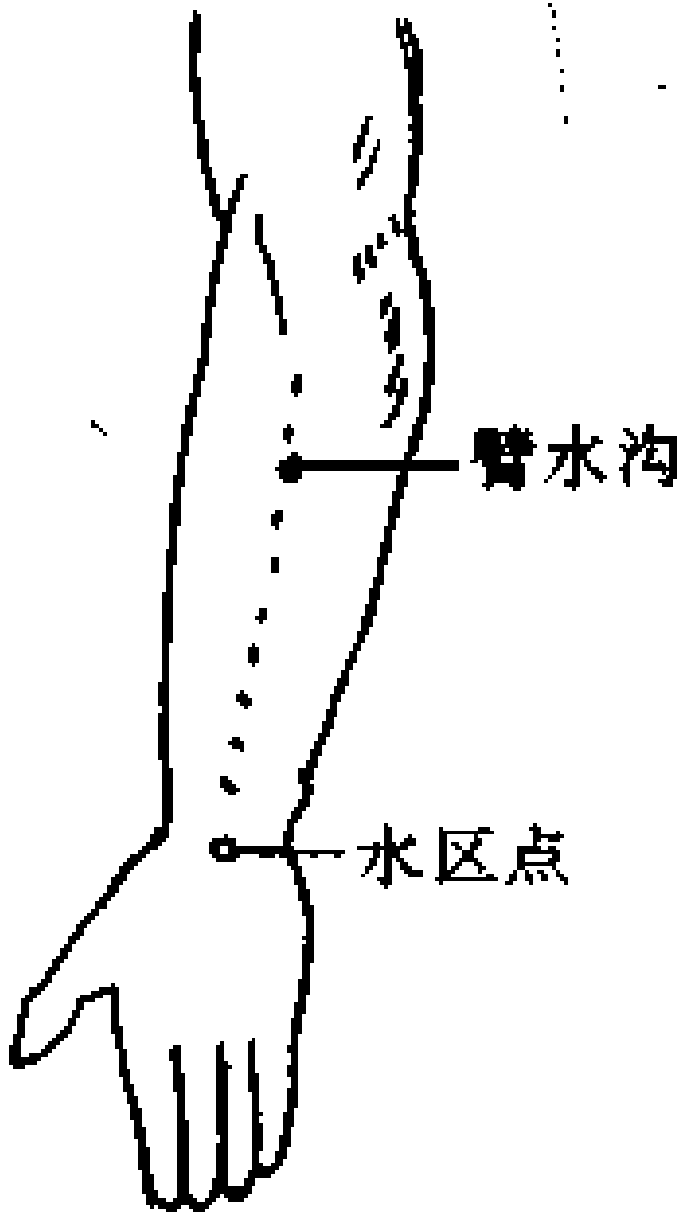


图 42-3

图 42 痫证取穴图

(1) 主穴：阳明点、天窗、颌点、椎点。

(2) 配穴：臂水沟，水区点（均掌侧穴），内、外眉点。

【手法操作】

如牙关紧闭，则应先点颌点、咬点（均取双侧穴）。

十九、厥证

厥证是指突然昏倒，不省人事，四肢厥冷为主症的病证。常见有气厥、血厥、痰厥、食厥、暑厥几种，而其病理则多因气机逆乱、升降失常所致。

厥的主要症状是一时昏倒，不省人事。但有虚实之分，实证则见气壅息粗，四肢僵直，牙关紧闭，脉多沉实；虚证见气息微弱，张口自汗，肤冷肢凉，脉沉微细。

【取穴】（图 43）

（1）主穴：前心穴，阳明点，内、外眉点，胸点。

（2）配穴：颌点、咬点。

【手法操作】

如牙关紧闭则应先点按颌点、咬点（重手法），并迅速点刮前心穴，然后再点按其他主穴。

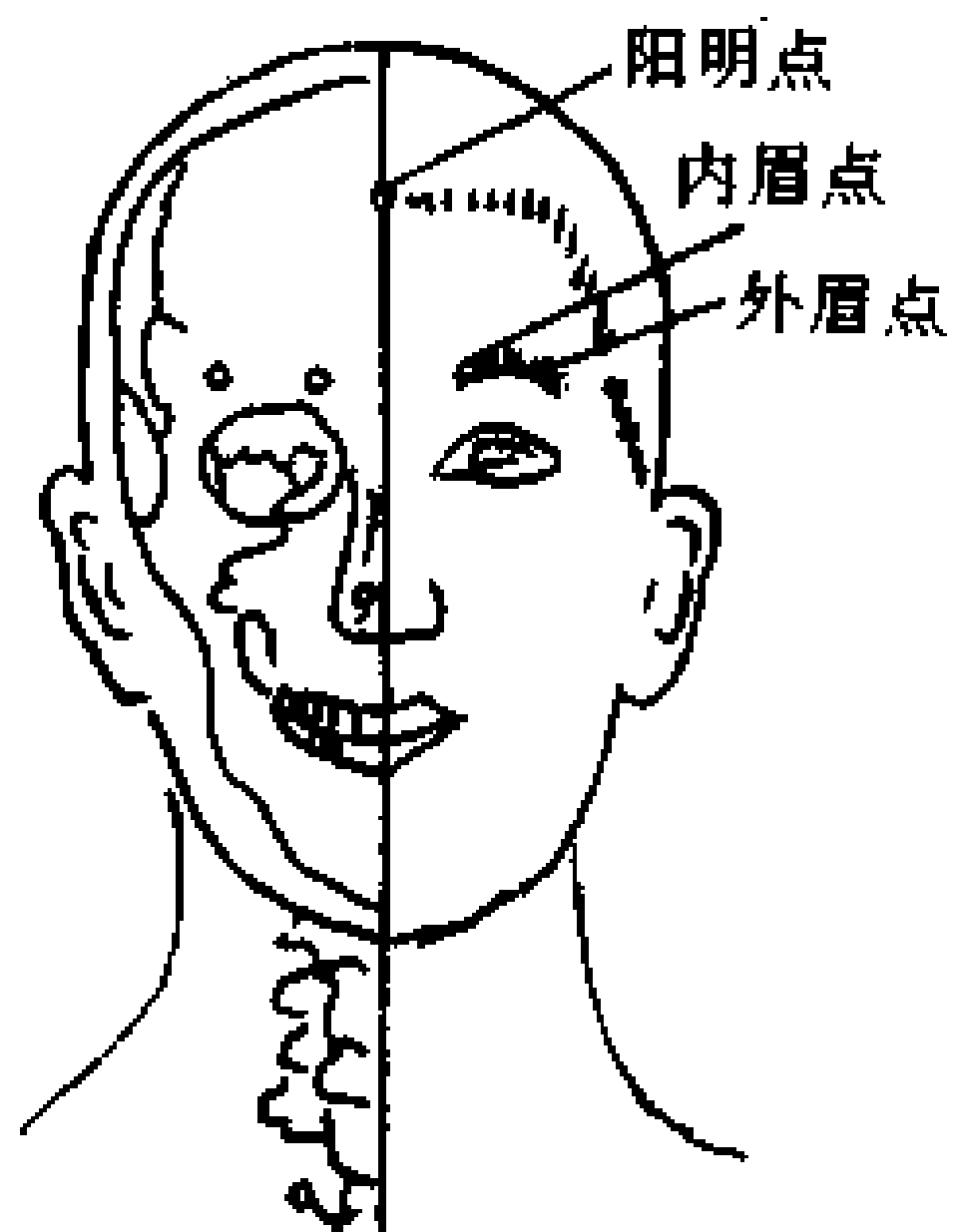


图 43-1

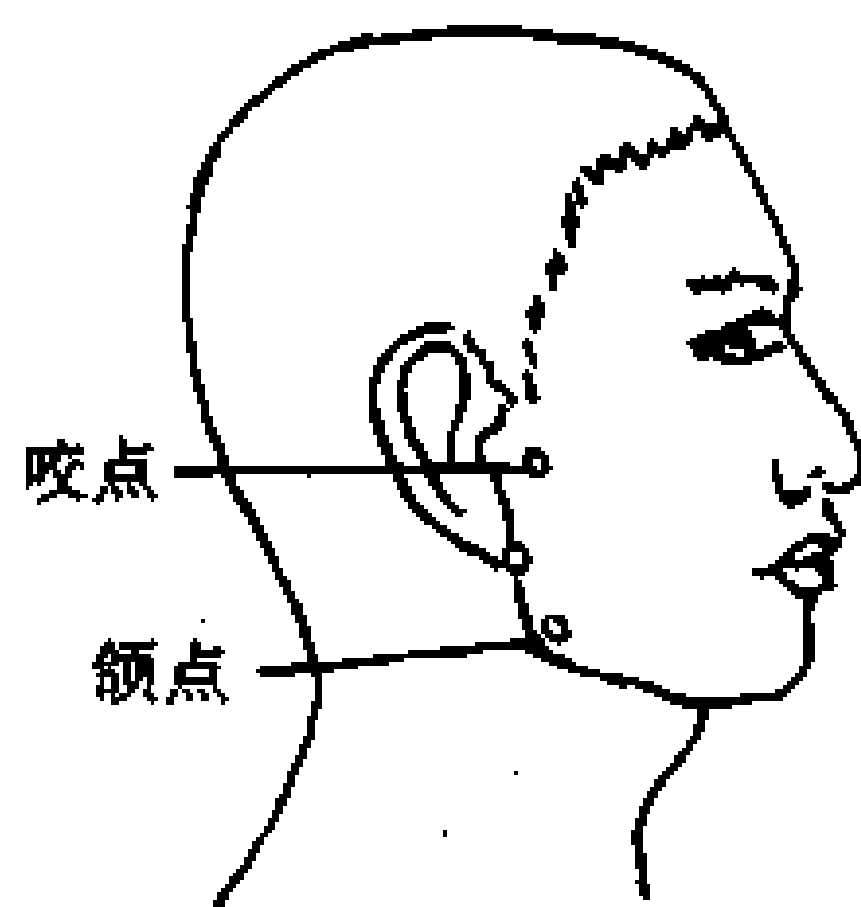


图 43-2

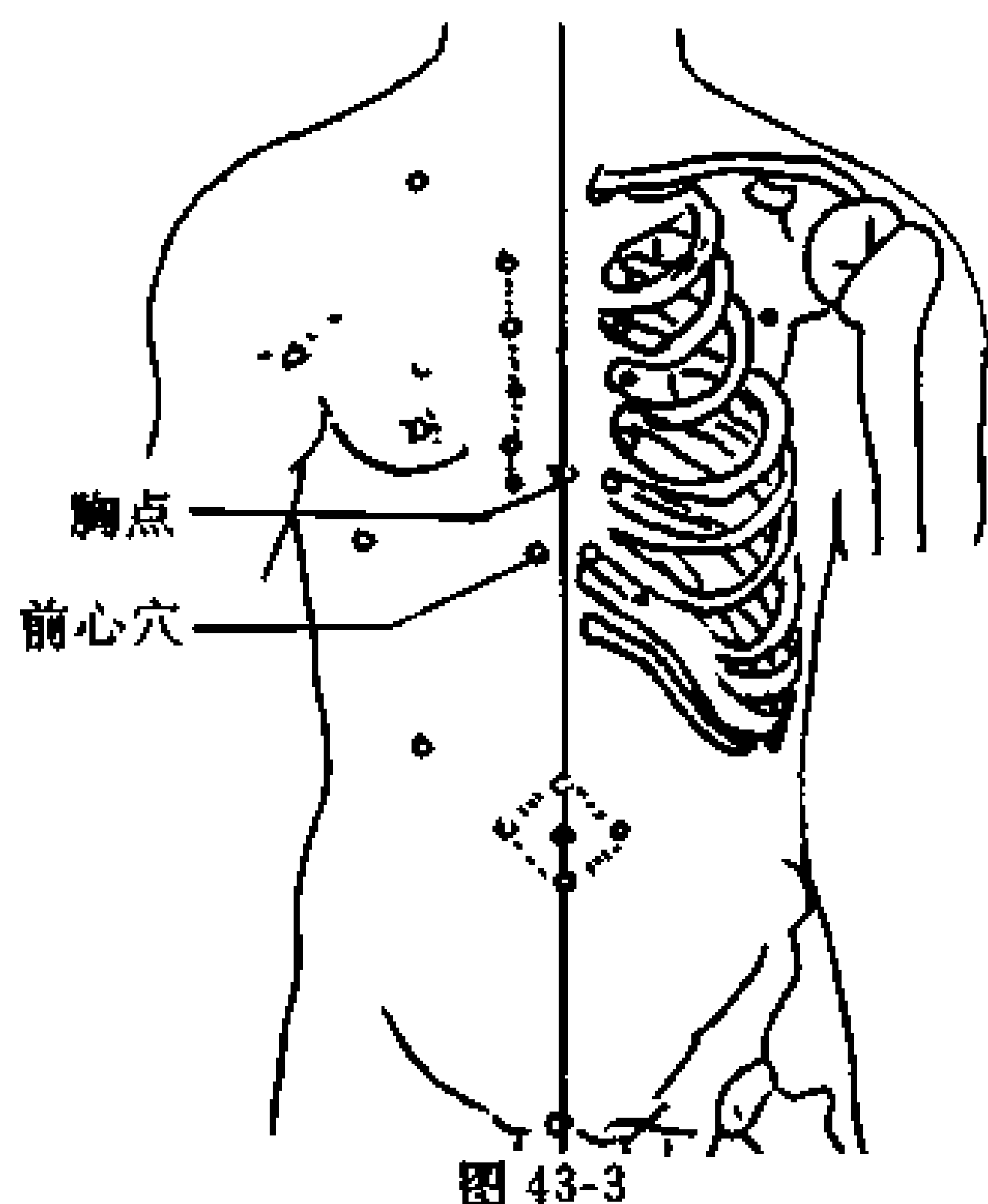


图 43 厥证取穴图

二十、痉证

痉证是以项背强急，四肢抽搐，甚至角弓反张为主症的疾病。多因热盛灼阴、筋脉失养，或创口不洁、感受风毒，而致破伤风。亦可由于阴血亏损、血不荣筋，或心脾不足，兼见气郁痰阻而成痉。

感受风毒，则见牙关发紧，面呈苦笑；热盛生风，则高烧抽搐；虚风内动，手足蠕动，微有抽搐；血不荣筋，则四肢麻木，筋惕肉瞤；气郁痰阻，则突然仆倒，手足抽搐。

【取穴】（图 44）

（1）主穴：后心穴（男取左穴、女取右穴）、椎点、连排点。

（2）配穴：十八转、前心穴、天窗。

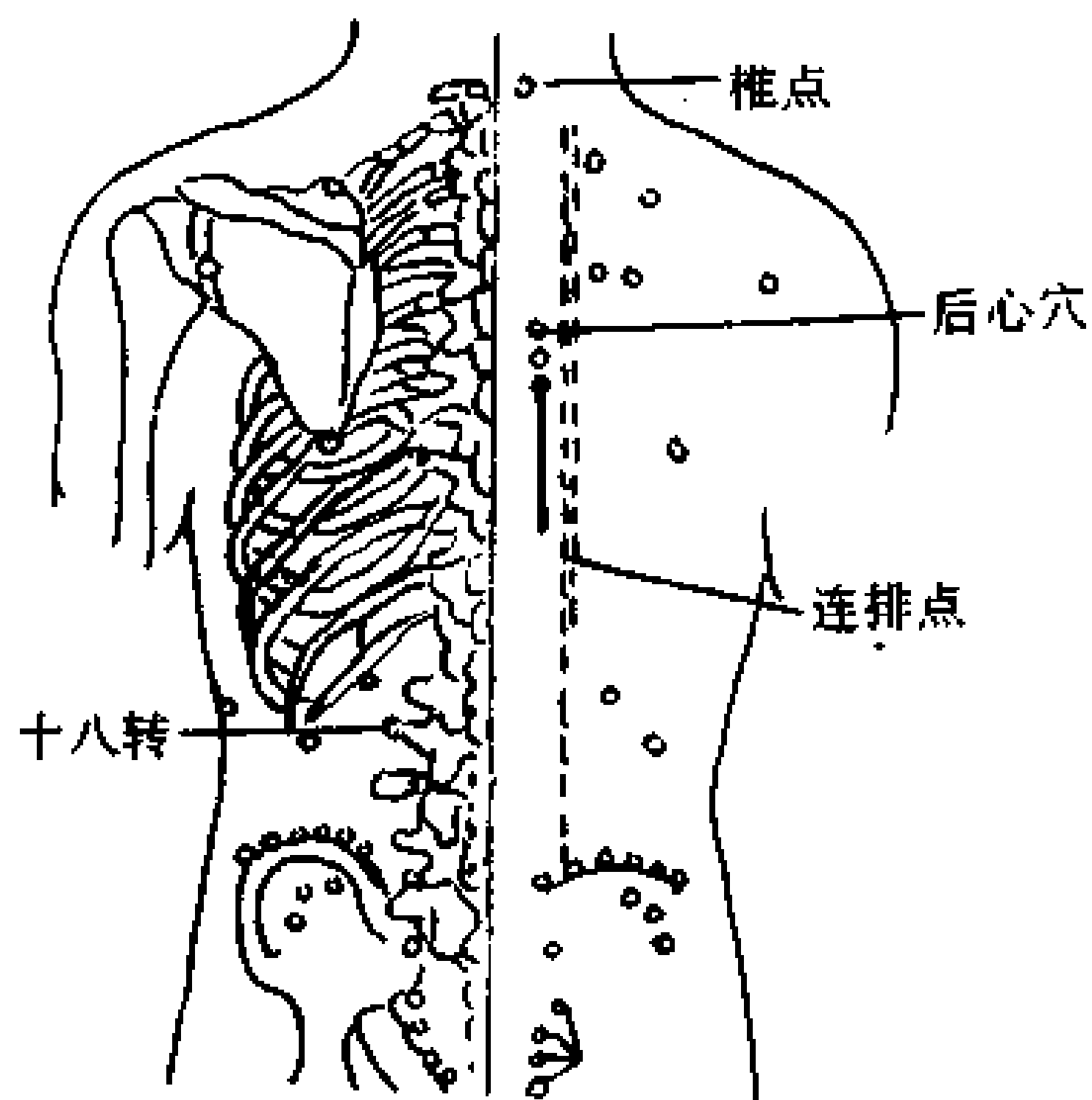


图 44-1

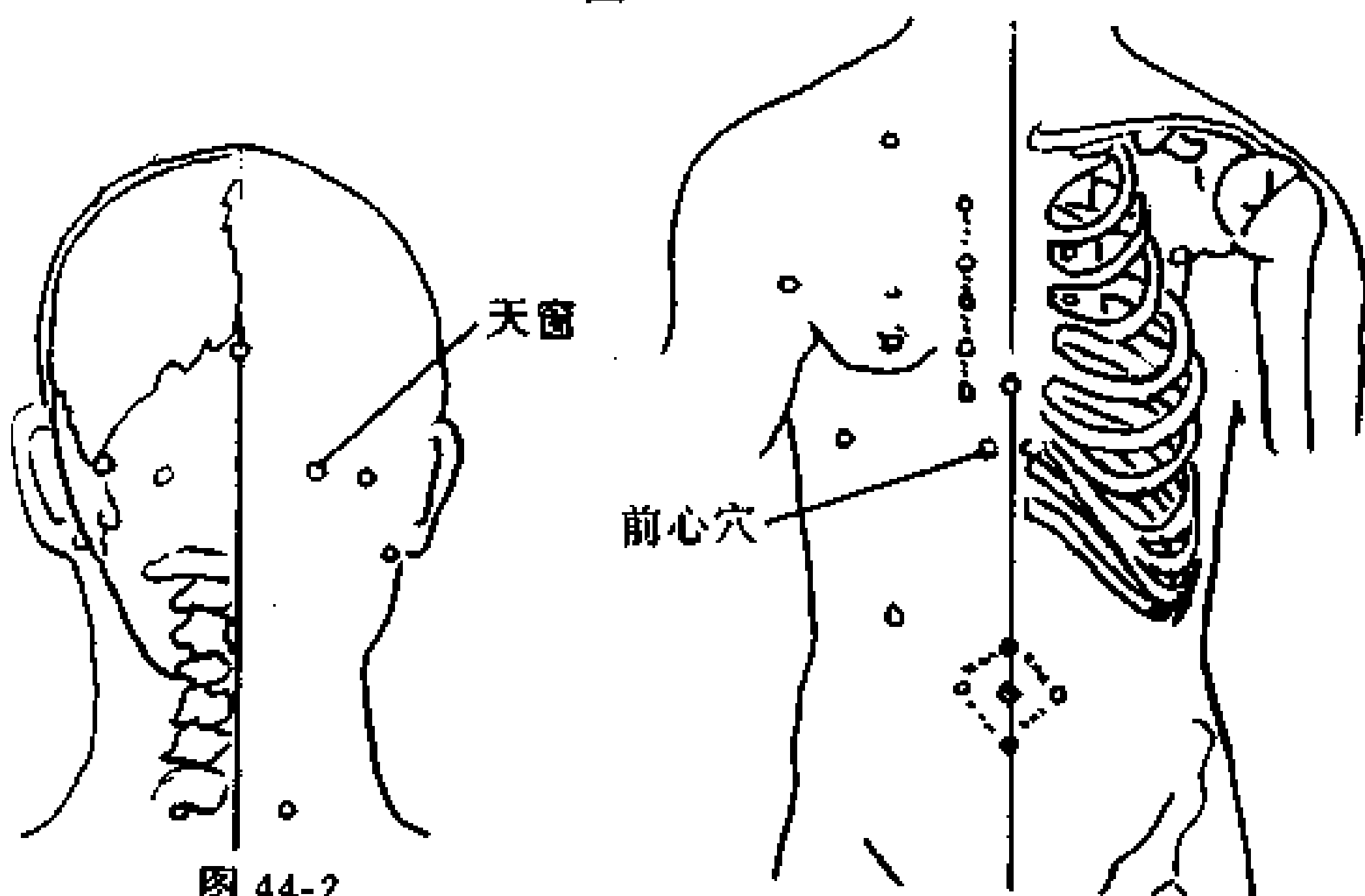


图 44-2

图 44-3

图 44 疼证取穴图

【手法操作】

先点主穴后，如效果不佳可取龙点（双侧），用重手法点

按 1~2 分钟。

二十一、中风后遗症

本症是指因中风所致口眼喎斜、半身不遂、言语不利为主症的疾病。包括脑溢血、脑血管栓塞等所引起的后遗症患者头晕头痛，目眩耳鸣，口眼喎斜，半身不遂。重则言语不利，患侧手足不得活动，卧床不能翻转身体，二便失禁或便秘；轻则虽能活动，但手足多不随意，二便如常。

【取穴】（图 45）

（1）主穴：颌点、垂点、连排点、后心穴、血筋。

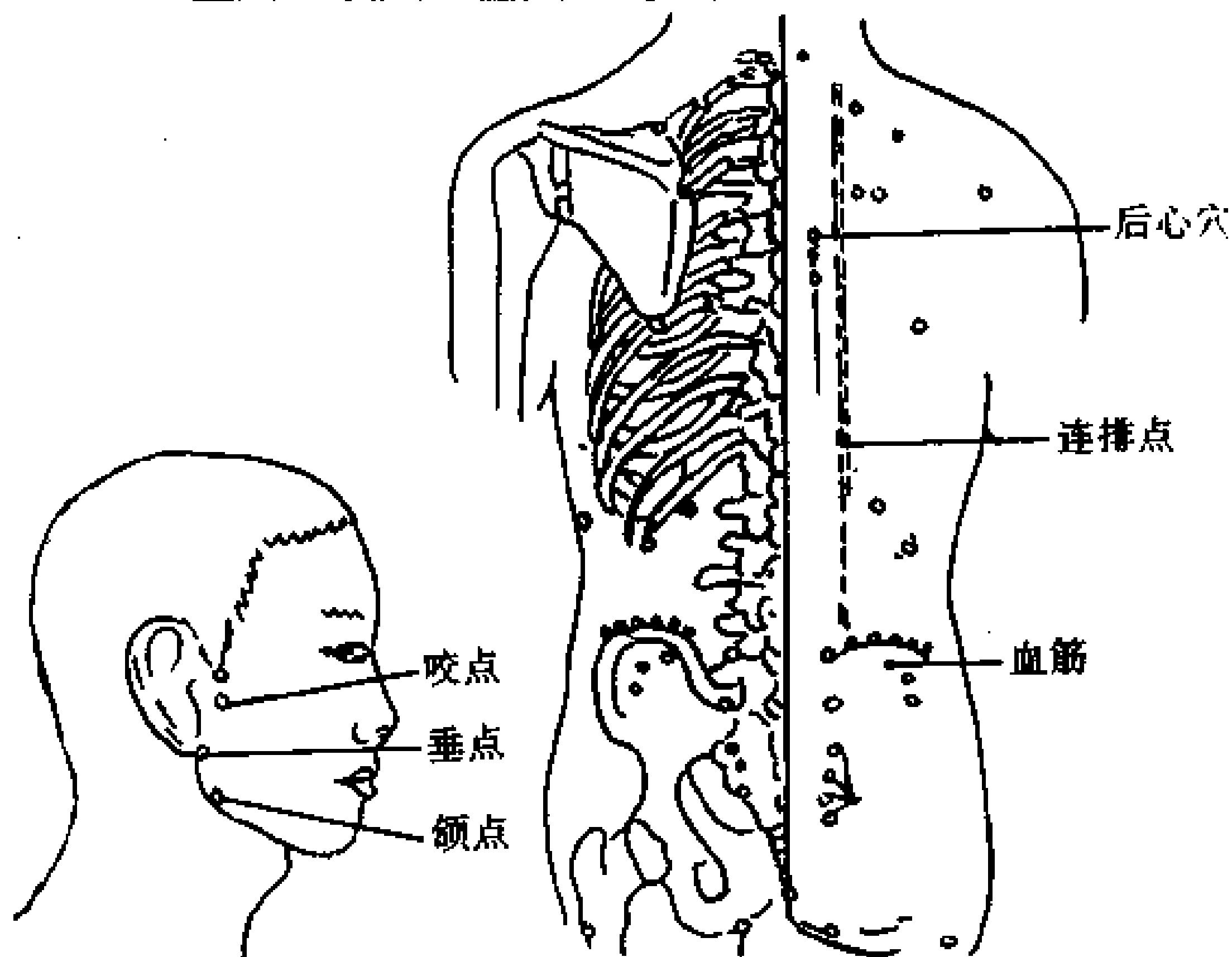
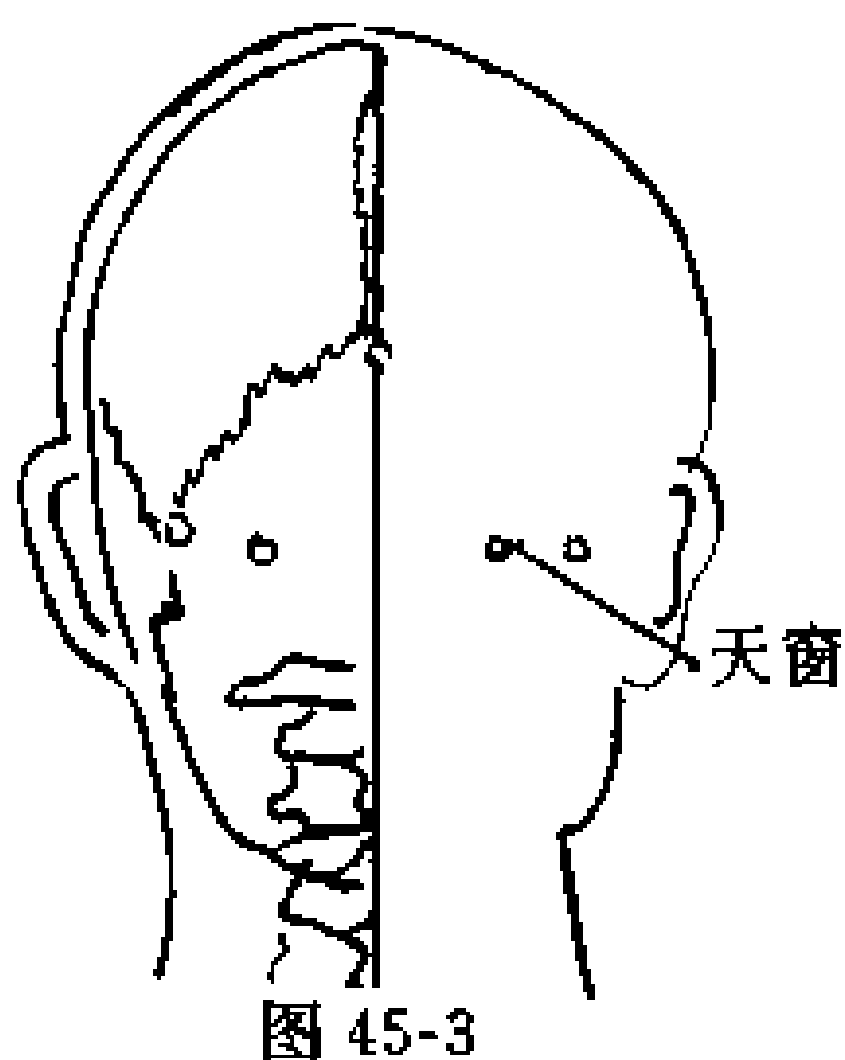


图 45-1

图 45-2



(2)配穴：咬点、天窗、外重点、下水沟、外筋、足点。

【手法操作】

头面部取健侧穴，下肢取患侧穴，首次施术手法宜重。每次施术均要点按主穴，配穴视情况而定，不必全部穴位都取。每天施术一次，7天为一疗程。

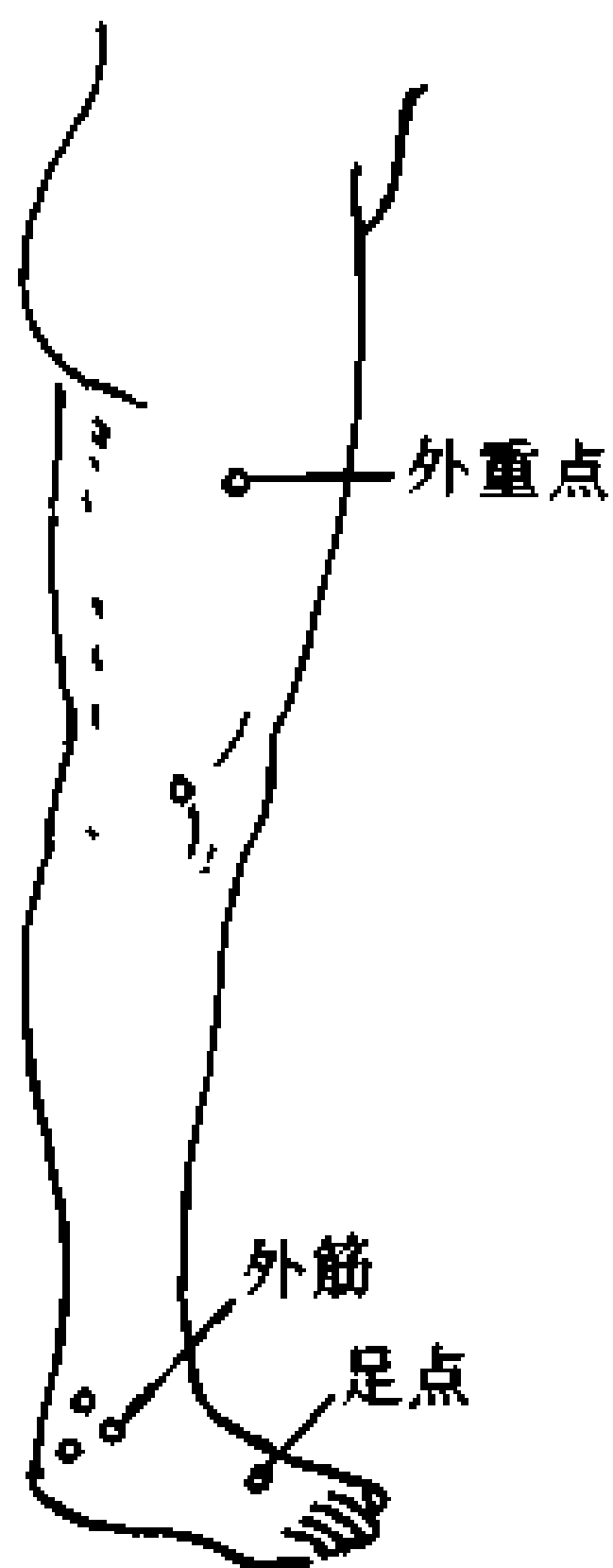


图 45-4

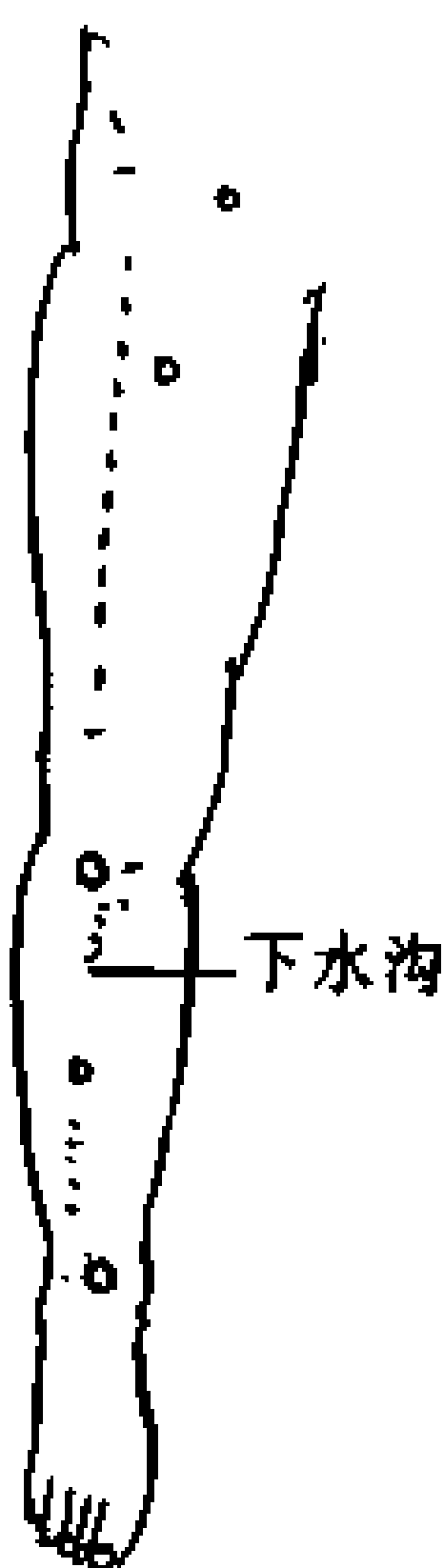


图 45-5

图 45 中风后遗症取穴图

二十二、痿证

痿证是以肢体筋脉弛缓、手足痿软不用、患肢枯萎为主的病证。多因肺热灼阴、筋骨经脉失养，或湿热浸淫、筋脉弛缓不用，或跌仆创伤、血瘀阻络、气血精微不能濡养筋脉；或肝肾亏损、筋骨失养所致。

本病可发生于下肢或上肢，单侧或双侧，或仅从指、趾开始，自觉软弱无力，活动不利，甚至瘫痪，或肌肉萎缩。

【取穴】（图 46）

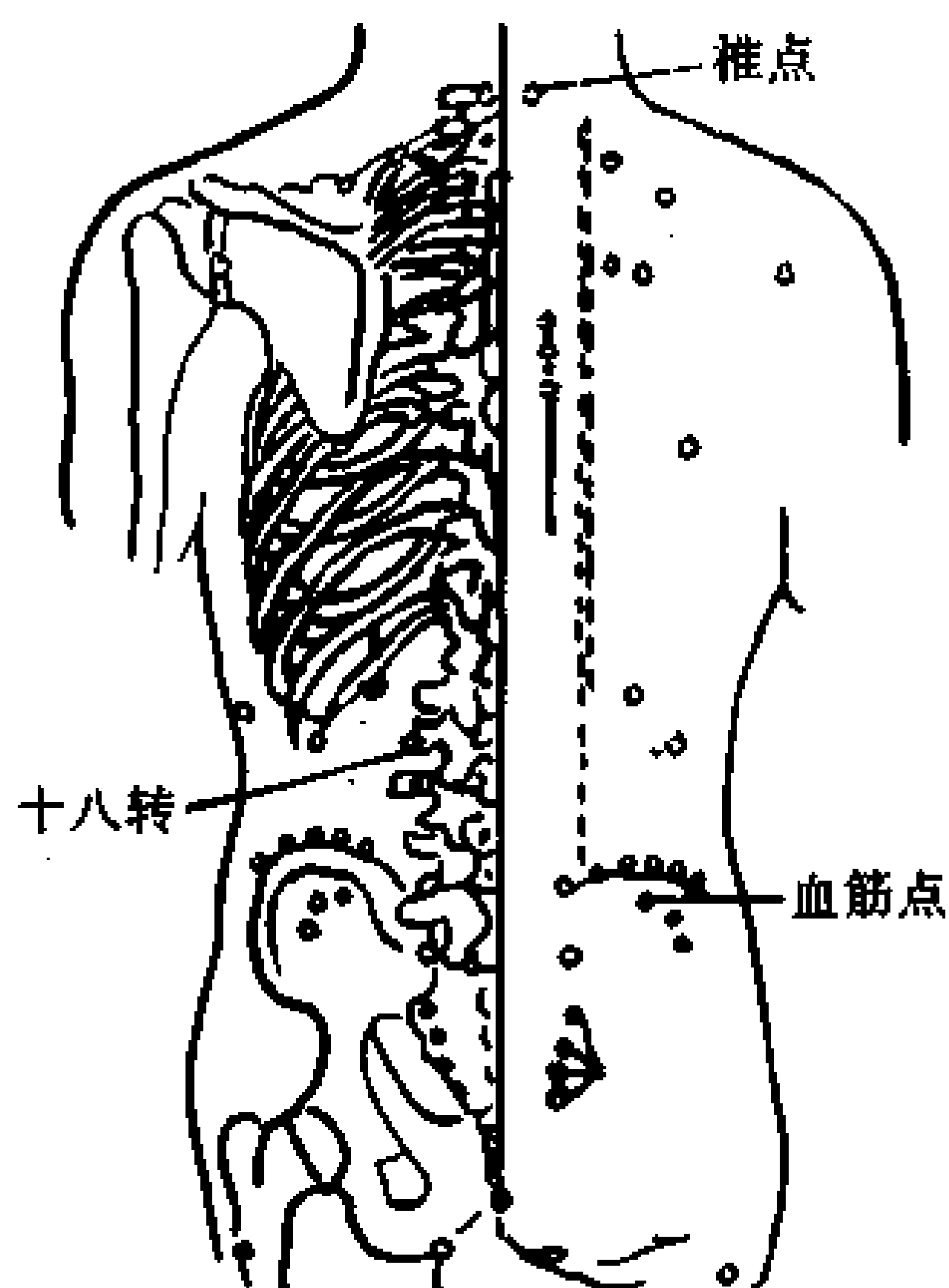


图 46-1

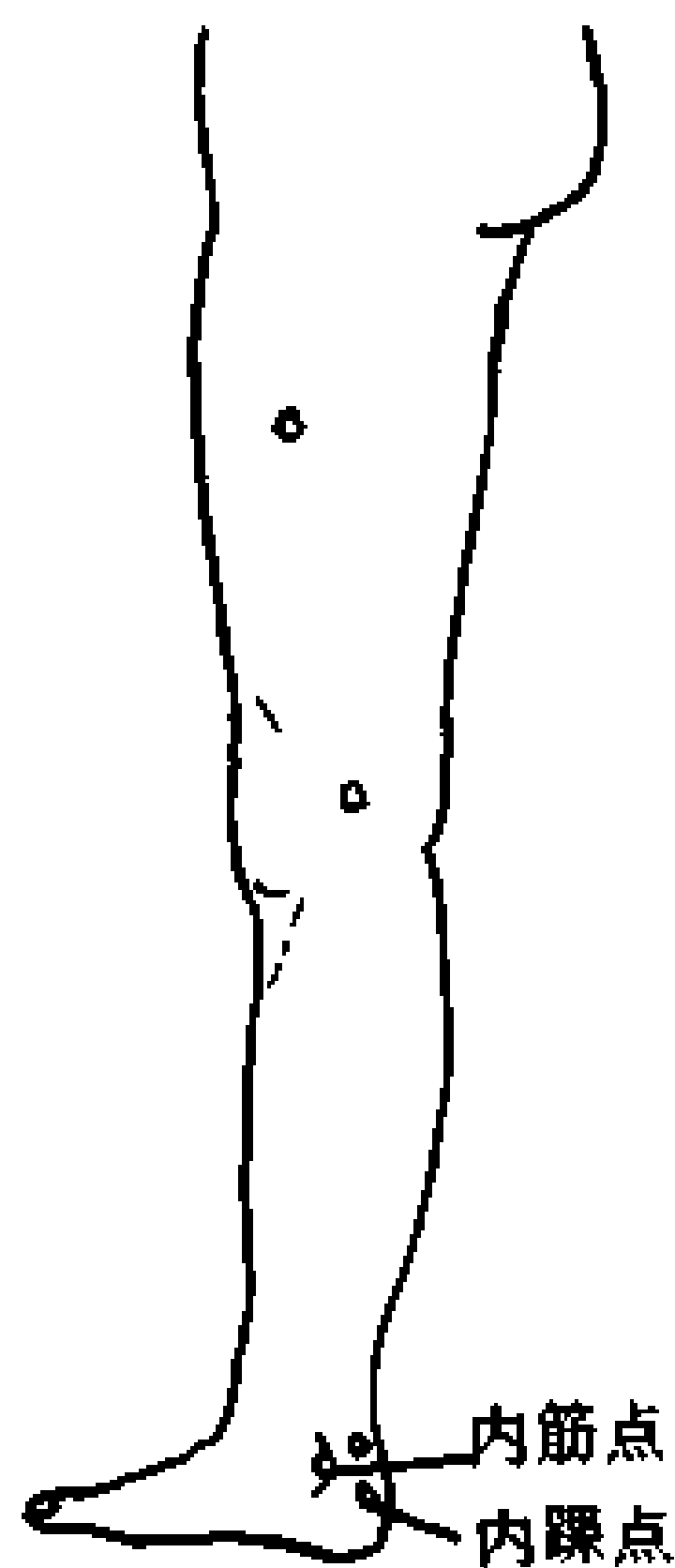


图 46-2

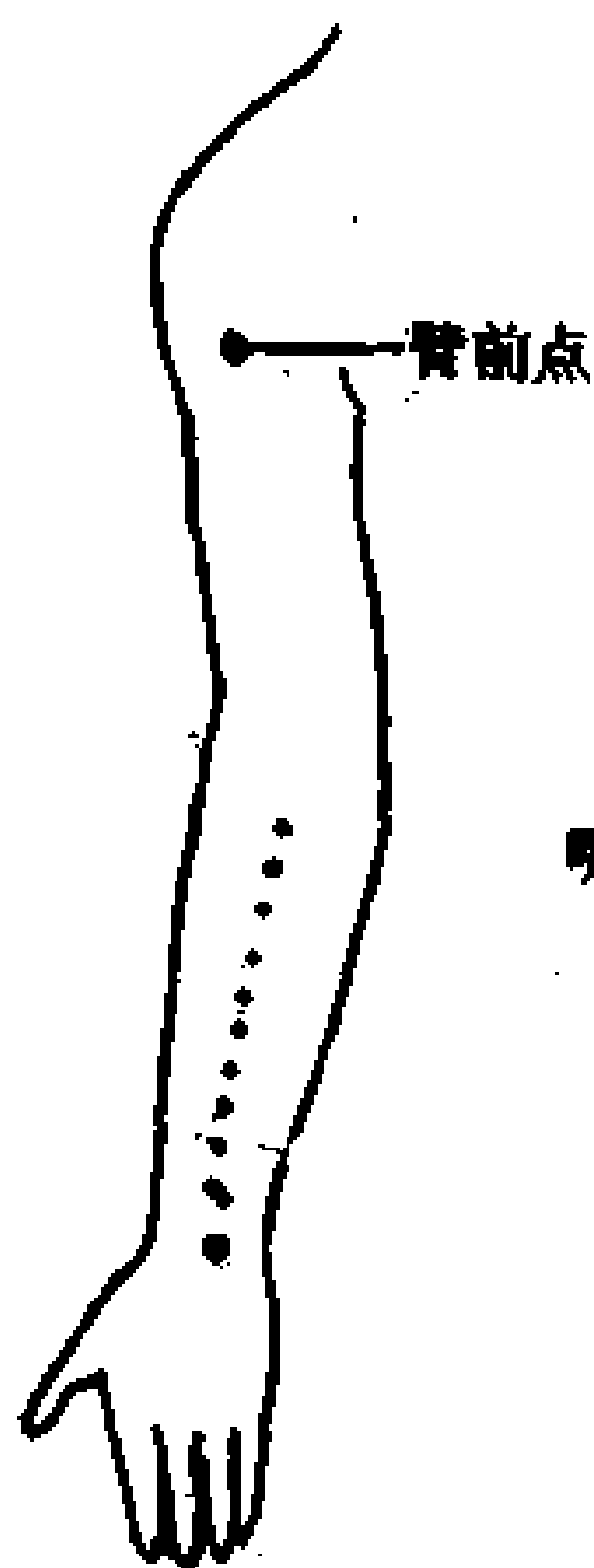


图 46-3

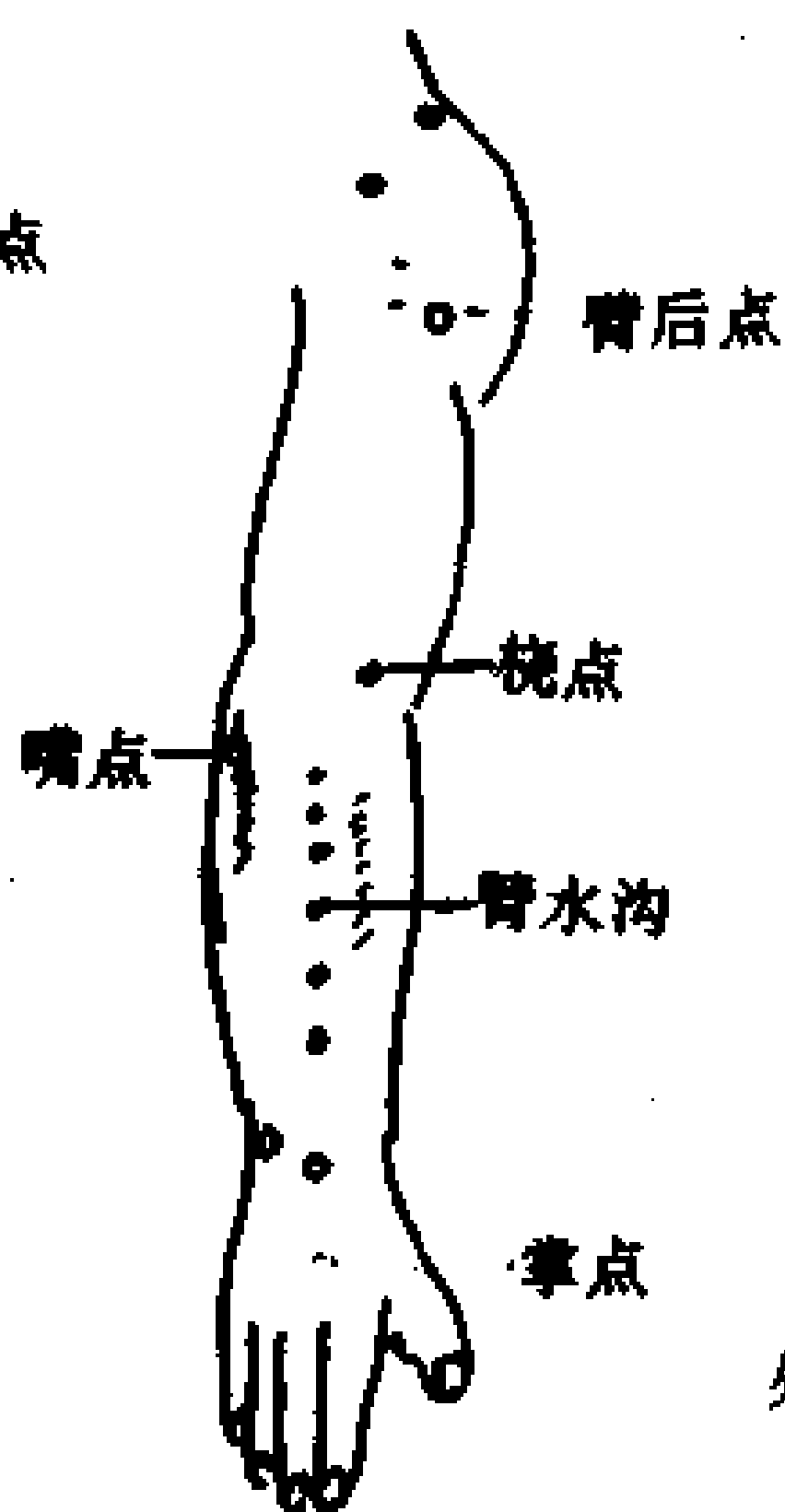


图 46-4

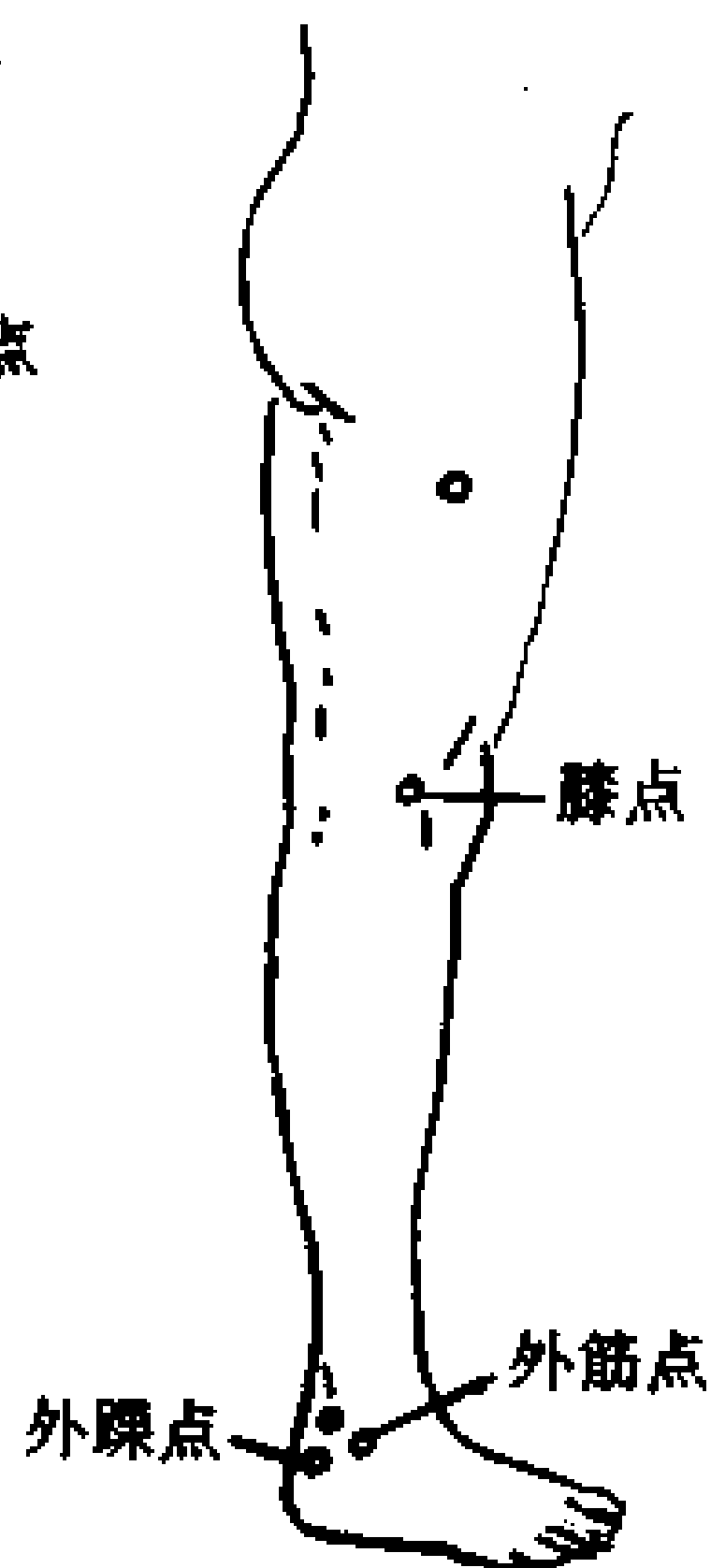


图 46-5

(1) 主穴：上肢取椎点、桡点、腕点、臂水沟；下肢取十八转、血筋、上水沟、下水沟、膝点、龙点。

(2) 配穴：上肢取臂前、臂后点，掌点；下肢取内、外筋，内、外踝点。

【手法操作】

轻症者点主穴为主，重症可酌加配穴，下肢应先行捏脊法。每天施术一次，首次可用重手法，7 天为一疗程。

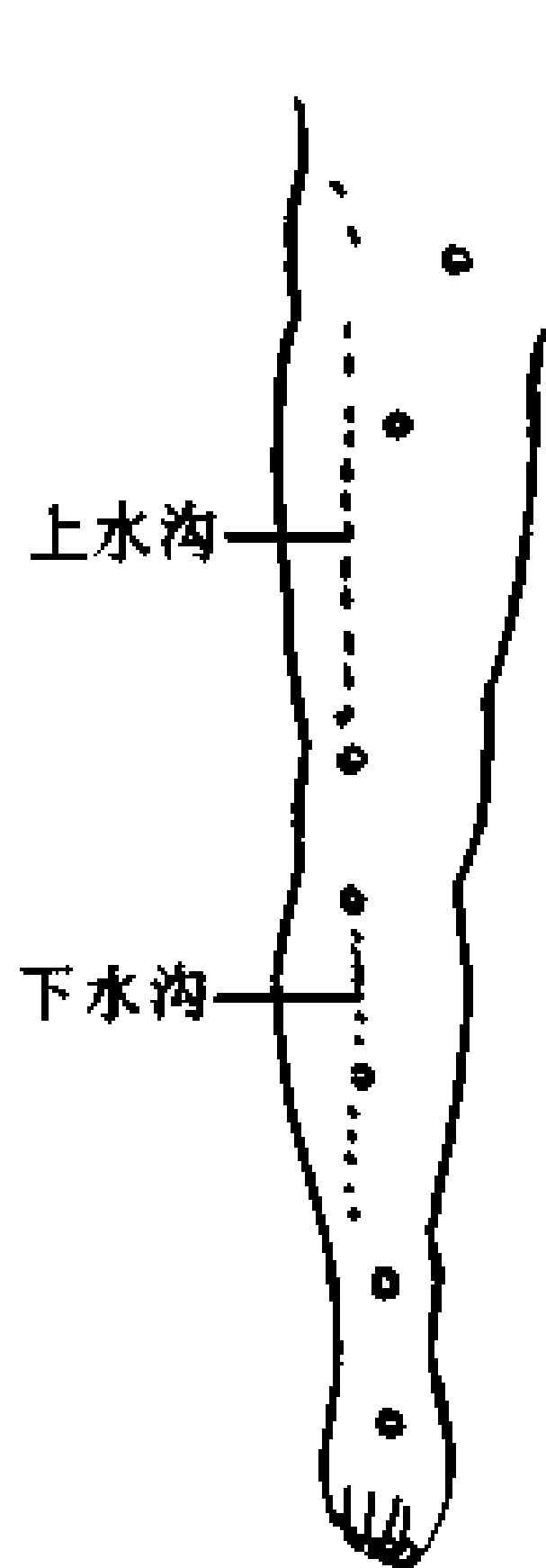


图 46-6

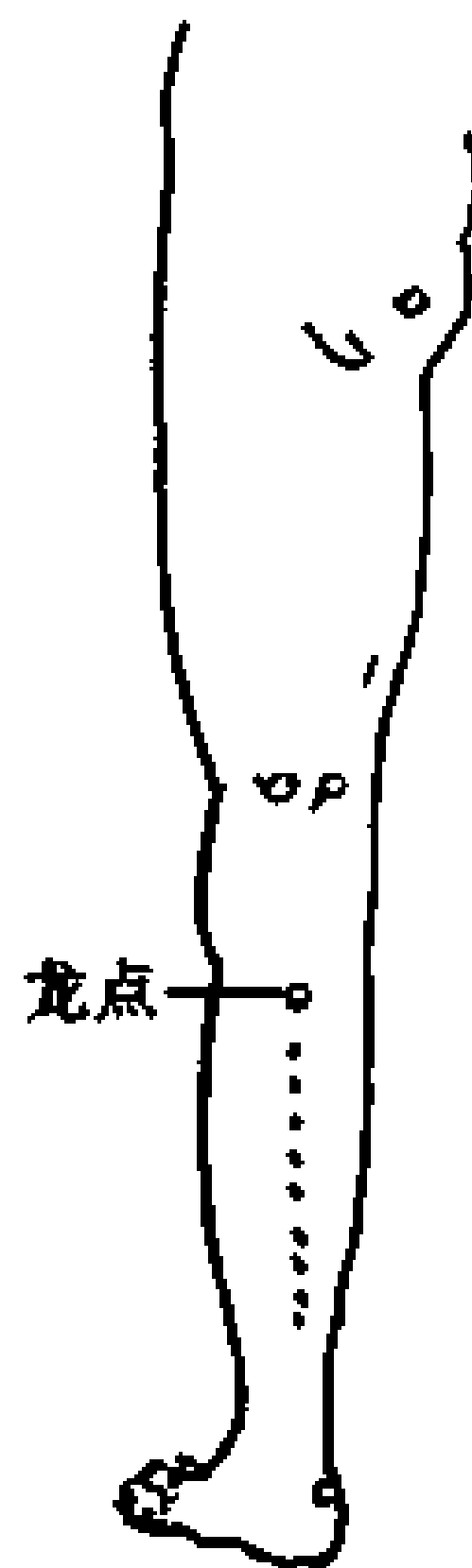


图 46-7

图 46 瘕证取穴图

二十三、疝气

疝气是指体腔内容物如肠段向阴囊内突出的一种病证。多伴有气痛症状，故亦称小肠气、小肠气痛等。本病多因肝脉不和、寒湿下注于阴囊所致。

一侧睾丸肿大，站立时则下坠，卧床时则入腹，有如狐之出入无常，故又有“狐疝”之称。

【取穴】（图 47）

（1）主穴：阳点、阴点。

（2）配穴：连环点、肾筋、棘点、肋腹点。

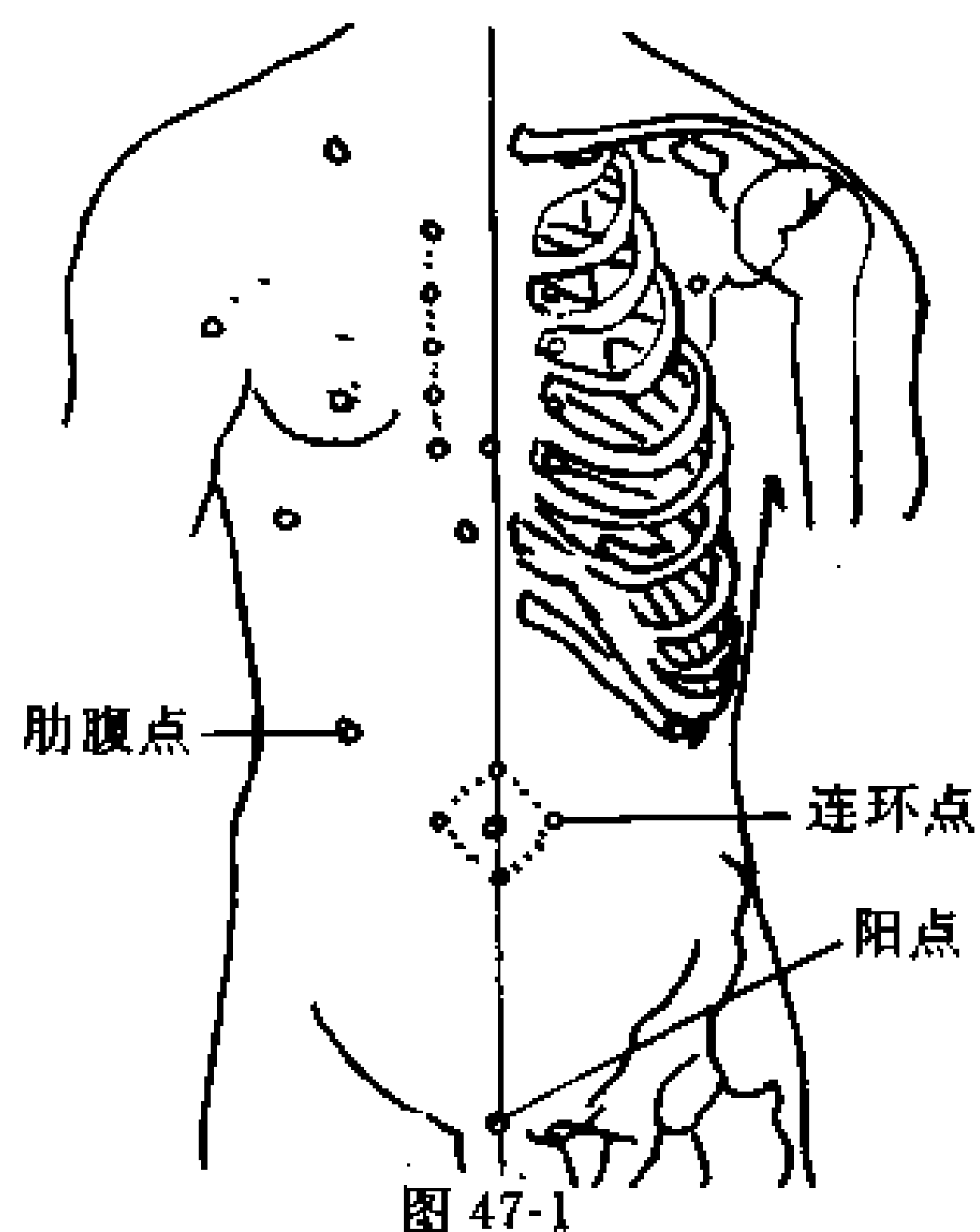


图 47-1

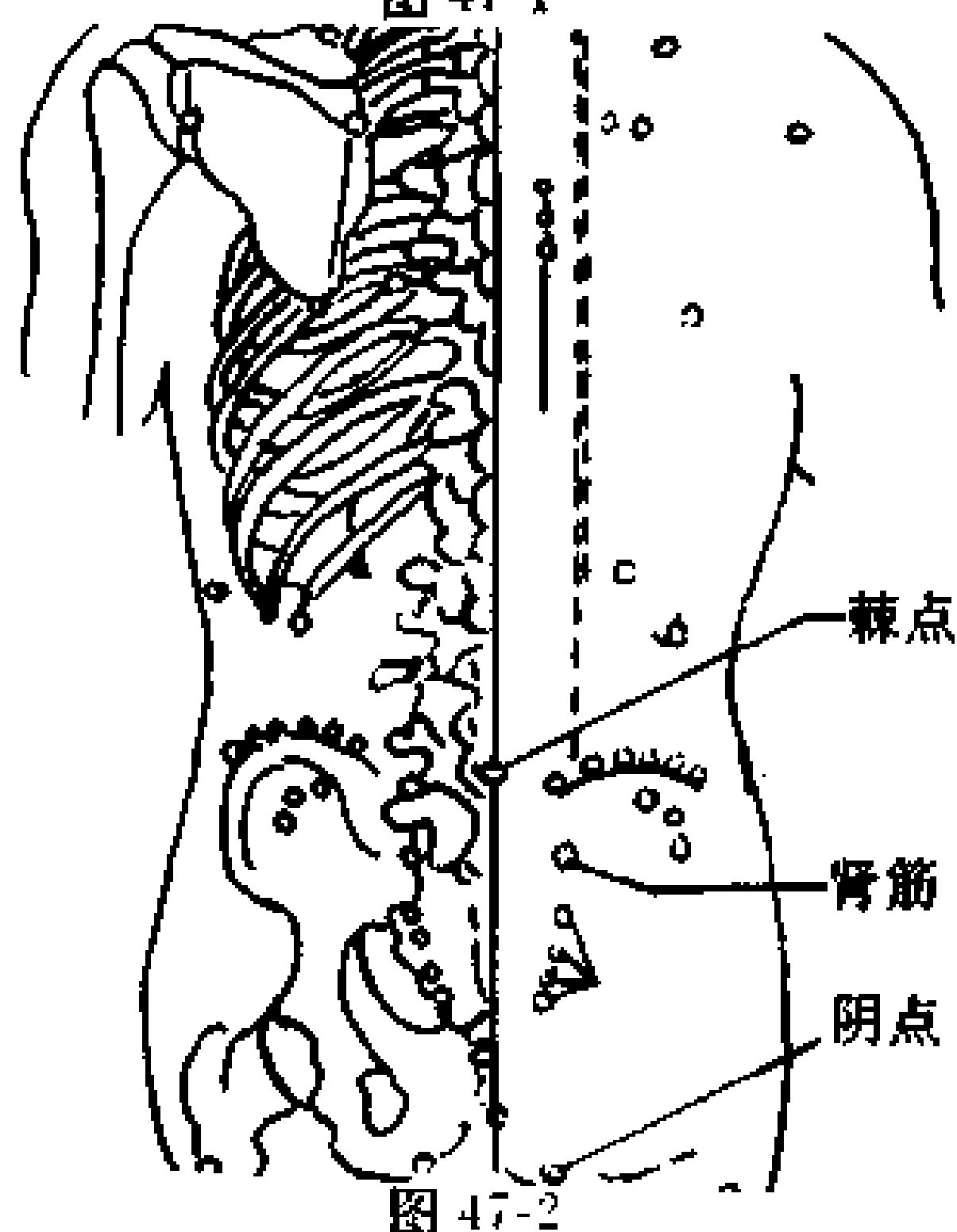


图 47-2

图 47 疝气取穴图

【手法操作】

以阳点为主，如效果不著可加阴点及配穴。

二十四、痛经

月经期或经期前后，小腹疼痛，或牵扯腰腿部疼痛者，称为痛经。主要由于气血阻滞，冲任两脉血行不畅所致。导致气血失调的原因有内伤气血，外感寒湿，以及精神刺激等。

本病以周期性的小腹疼痛为主症。可分寒、热、虚、实：一般经前或行经期疼痛者为实；经后而痛者为虚；按之痛甚者为实；痛减者为虚；得热则痛减为寒；痛甚于胀为血瘀；胀甚于痛为气滞。

【取穴】（图 48）

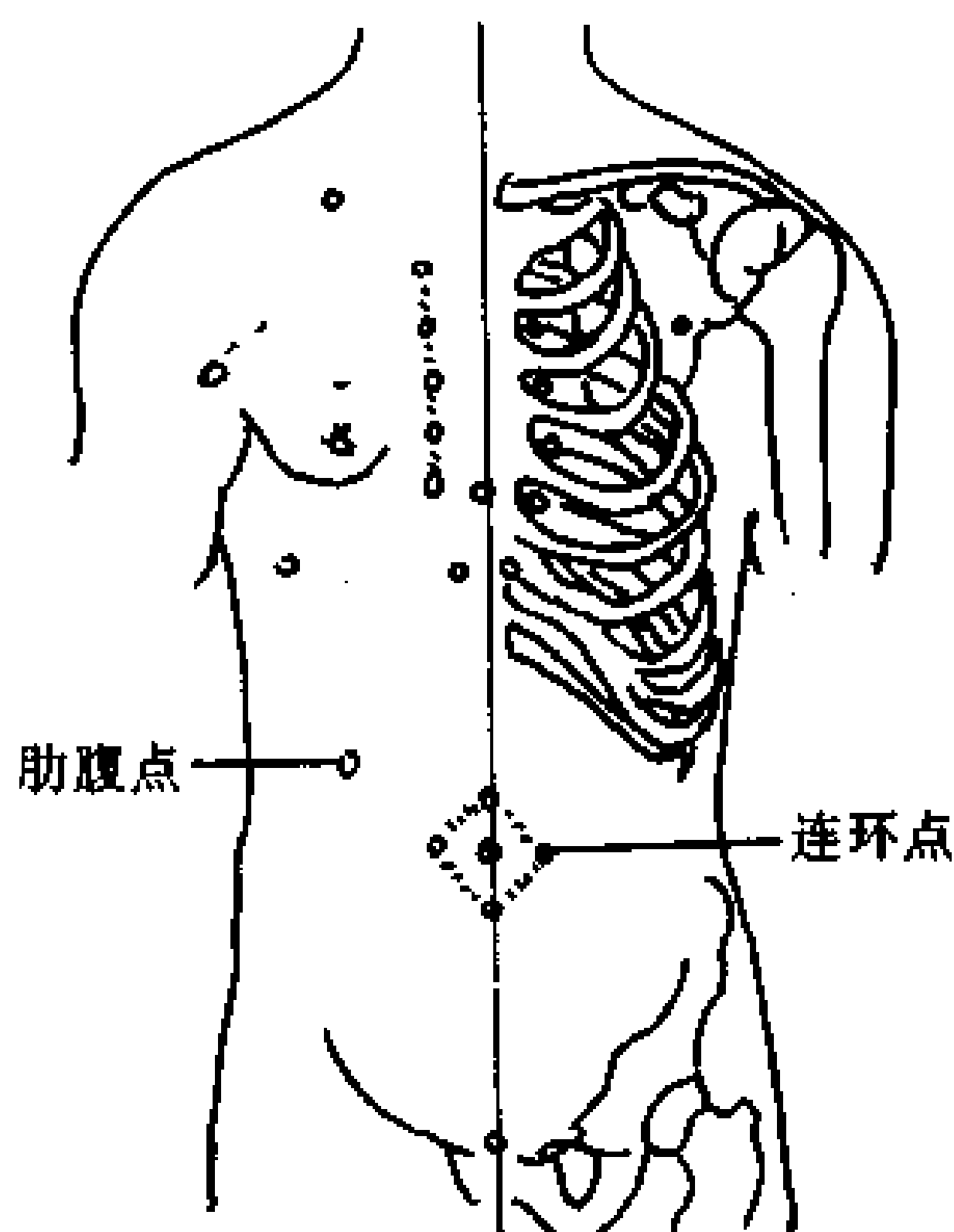


图 48-1

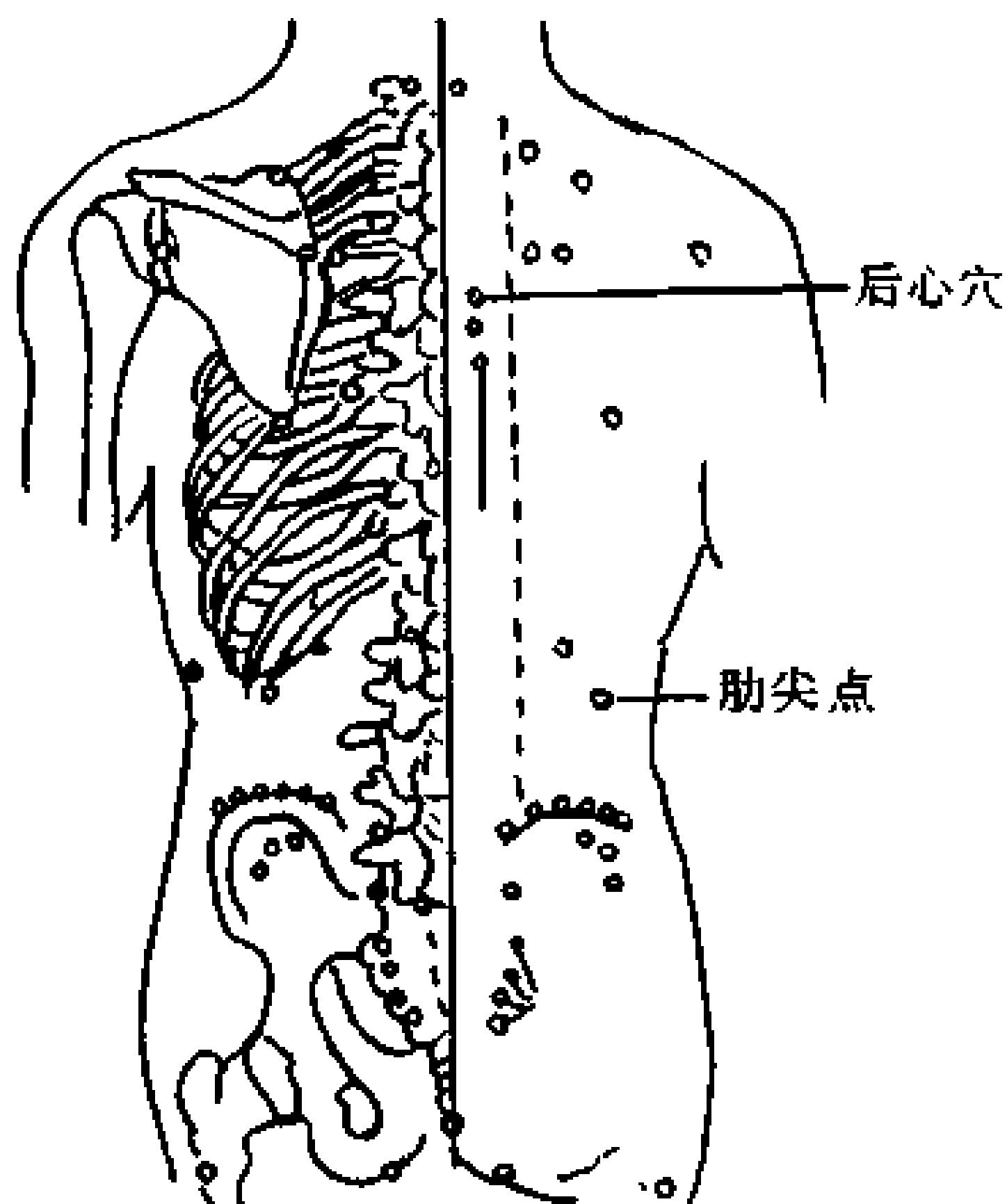


图 48-2

图 48 痛经取穴图

- (1) 主穴：后心穴（右侧穴）。
- (2) 配穴：连环点、肋腹点、肋尖点。

【手法操作】

先点主穴 1~2 分钟，如未愈可加点配穴。

二十五、乳痈

乳痈是指乳房硬结胀痛，甚则成脓、伴有寒热之病证，即急性乳腺炎。多因肝气郁结、胃热壅滞而成。

初起乳房出现硬结、胀痛，乳汁不畅，全身可有恶寒发

热；继则肿块增大，焮红剧痛，寒热不退，蕴酿成脓。

【取穴】（图 49）

（1）主穴：房上点、侧臂点。

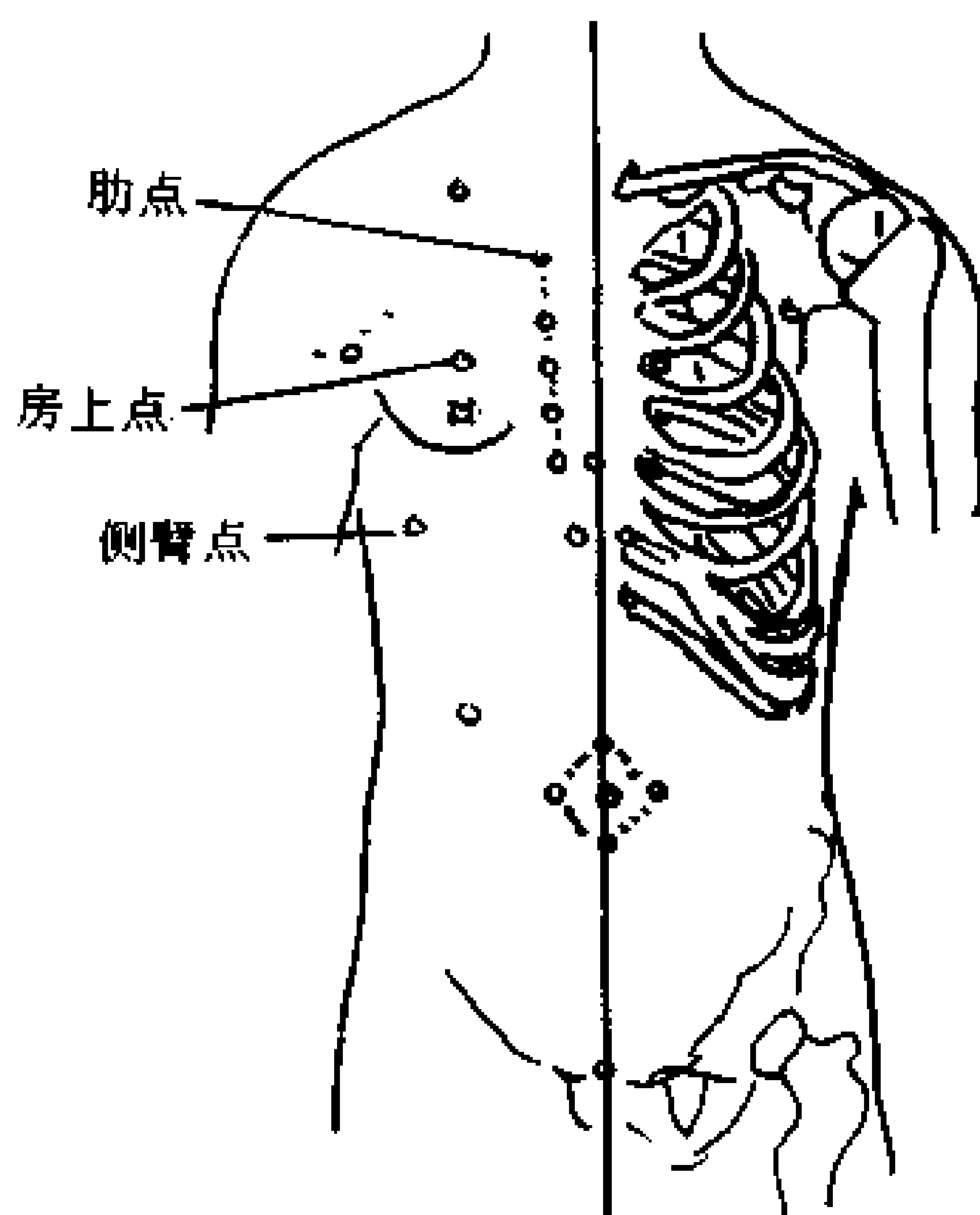


图 49 乳痛取穴图

（2）配穴：肋点。

【手法操作】

先点主穴，取患侧穴，手法不宜过重。如痛甚加点后心穴。

二十六、缺乳

产后乳汁甚少，或全无乳汁，称为缺乳。多因气血两虚，

无乳汁可行；或因肝气郁滞，乳汁被阻，乳络不通而致。气血两虚者，乳少或无，面白乏力；肝郁气滞者，则乳汁不行，乳房胀痛。

【取穴】（图 50）

（1）主穴：侧臂点、前心穴。

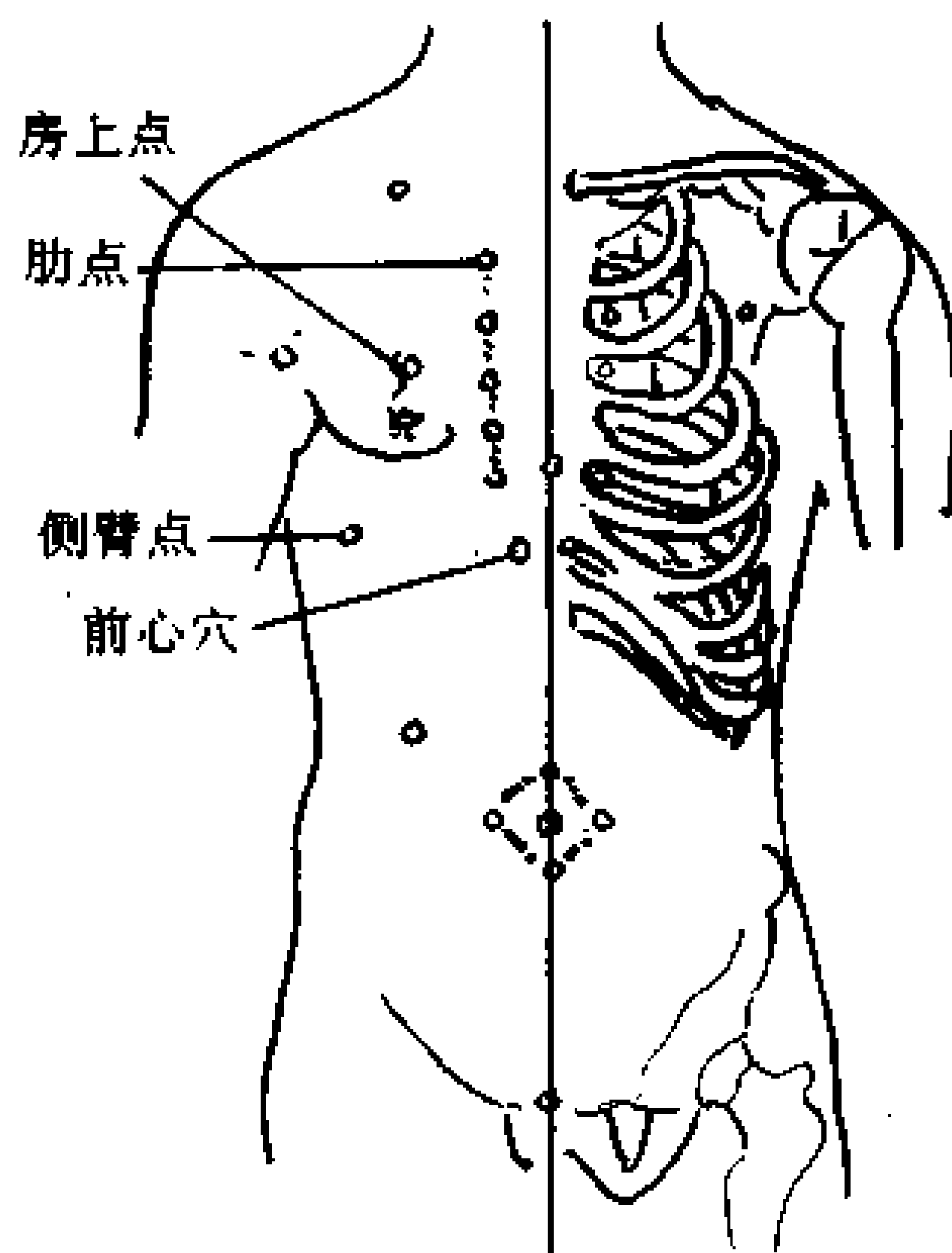


图 50 缺乳取穴图

（2）配穴：房上点、肋点（取双侧穴）。

【手法操作】

手法不宜重，施术后嘱患者用大鱼际自行揉摩乳房 20～30 次。

二十七、疳证

疳证是指由于喂养不当，或因多种疾病的影响，使脾胃受损，气液耗伤而导致全身虚弱羸瘦、面黄发枯等常见的小儿慢性病证。脾胃失调是形成疳证的主要原因。常见有饮食失节、脾胃受损，或喂养不当、营养失调，以及其他因素如长期吐泻、慢性腹泻等转化而成疳证。

长期形体消瘦，肌肉松弛，面色及皮肤色泽不华，毛发

稀疏，有明显的脾胃症状，如大便不正常、厌食或异嗜病史，以及肚腹膨胀等现象。严重者，有老人貌，骨瘦如柴。

【取穴】（图 51）

（1）主穴：前心穴、连排点。

（2）配穴：连环点。

【手法操作】

手法宜轻，每天施术一次。并用腹部揉刮法、捏脊法。重症者可用金锁匙 15 克、蓬莪术 8 克炖鸡内脏（去肠）配服，两天一次，5 次为一

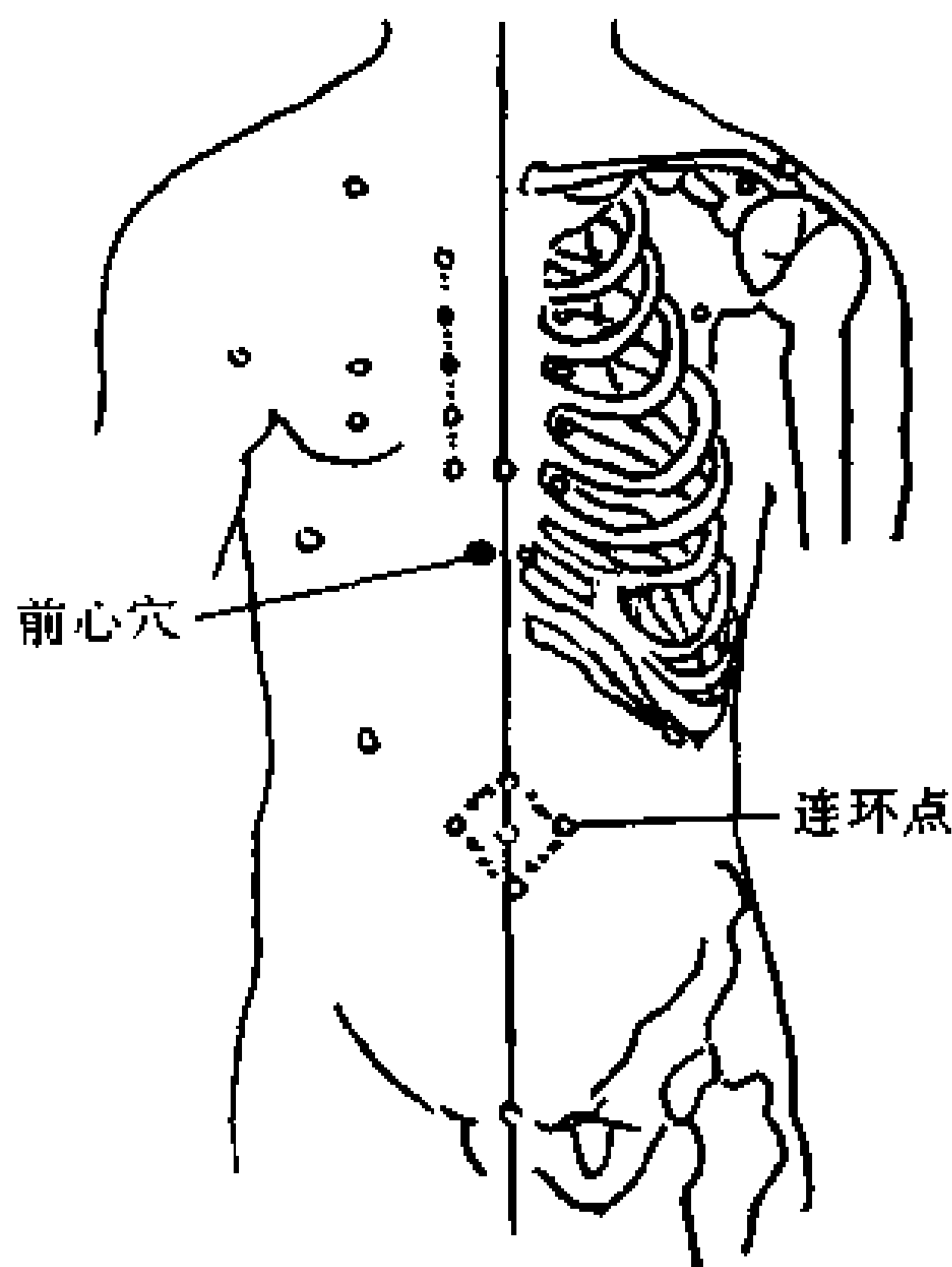


图 51-1

疗程（民间验方）。

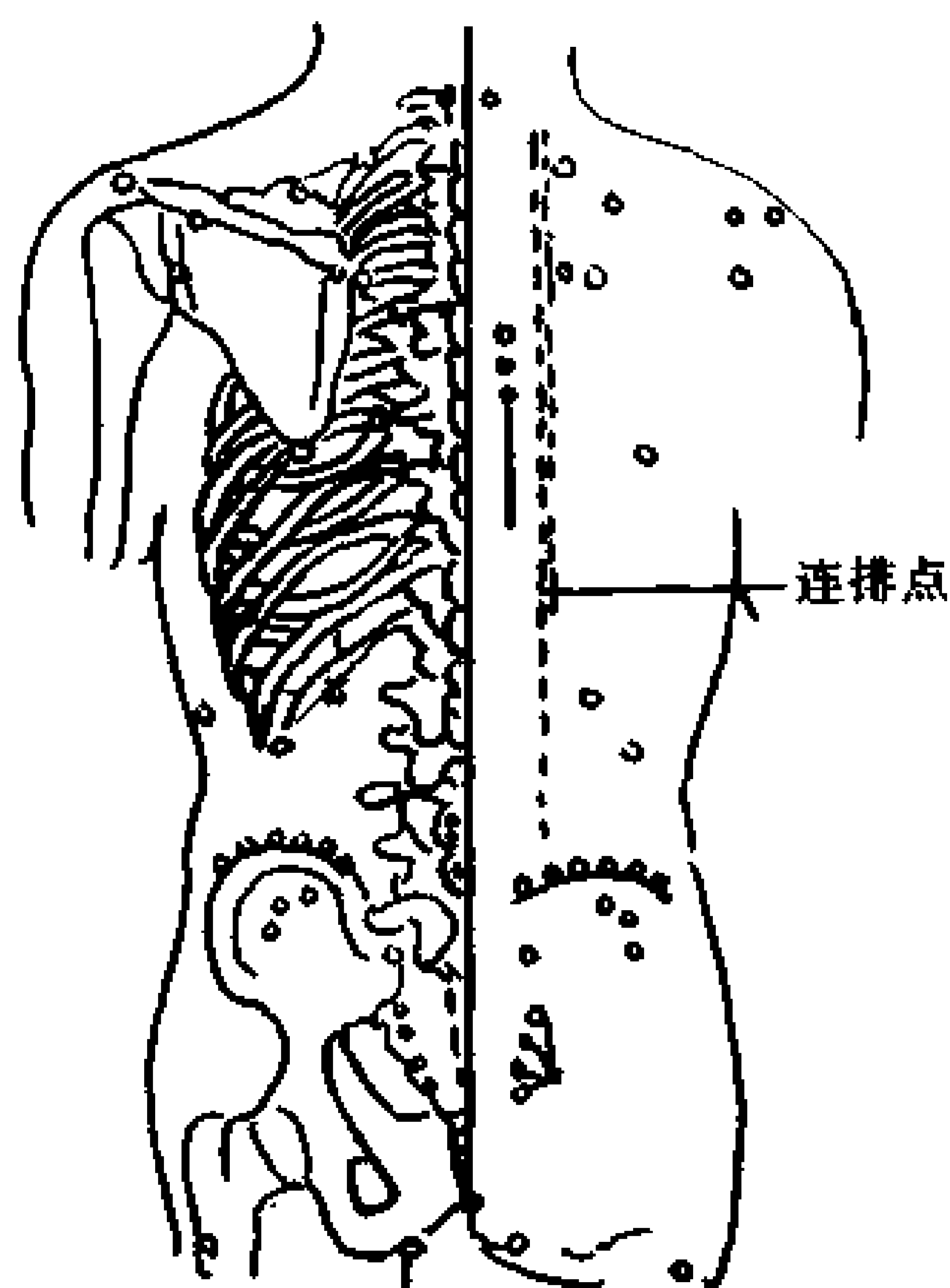


图 51-2

图 51 痞证取穴图

二十八、小儿呕吐

呕吐是指以食物由胃中经口而出为主症的一种小儿常见病证。常见的病因有乳食积滞、胃有积热、脾胃虚寒、肝气犯胃，或跌仆惊恐等，由于胃失和降、气逆于上所致。

食入即吐，多为胃热呕吐；食后才吐，常属脾胃虚寒；吐

出物其味酸臭，多因乳食积滞；睡卧不宁，哭闹不安，面色忽青忽白而吐者，多由惊恐；暖气泛酸而吐者，属肝气犯胃。

【取穴】（图 52）

（1）主穴：前心穴、连环穴。

（2）配穴：连排点。

【手法操作】

手法宜轻，并用腹部揉刮法行手法后，在小儿背部用手掌由上而下轻摩。或取连排点，用轻手法点按。

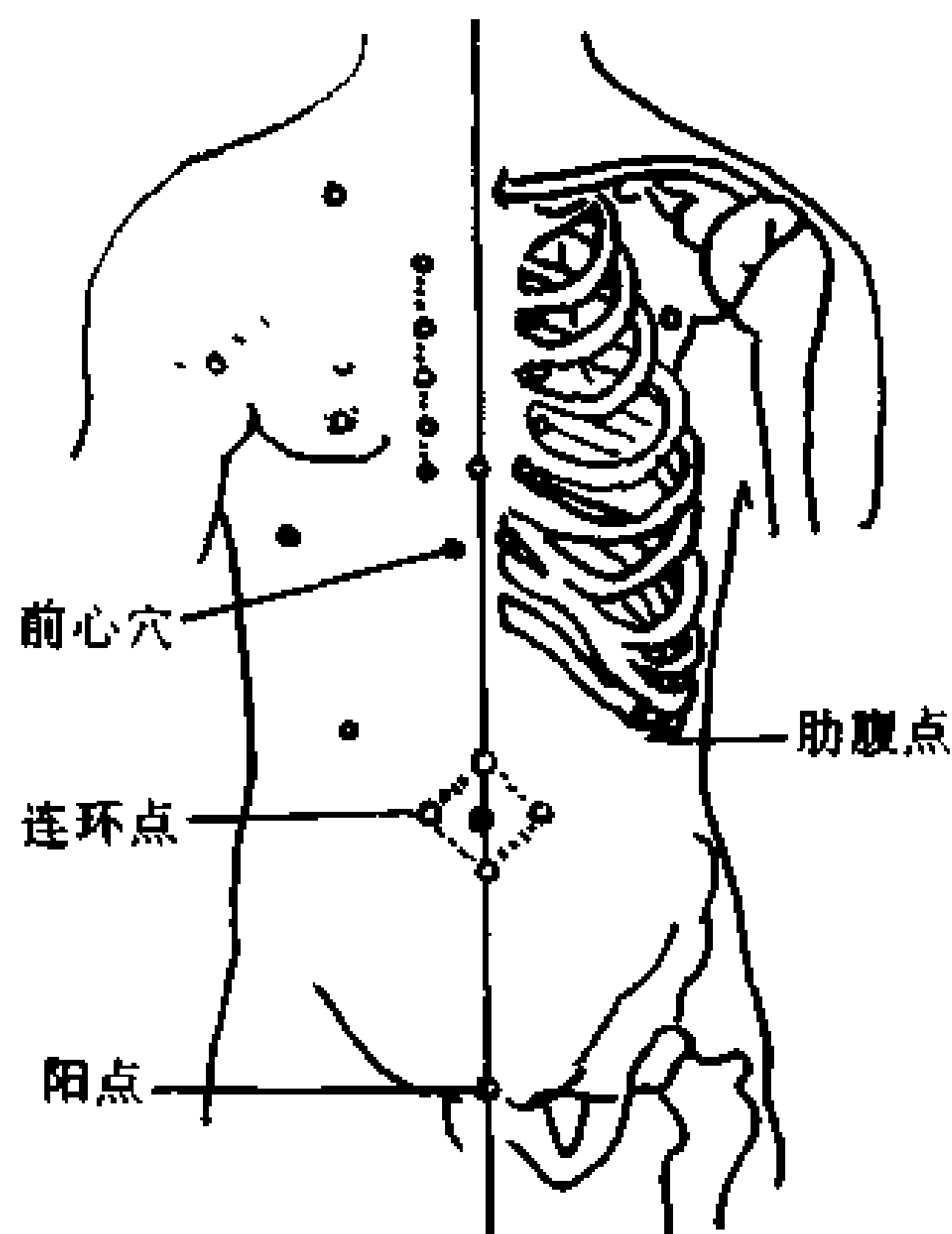


图 52-1

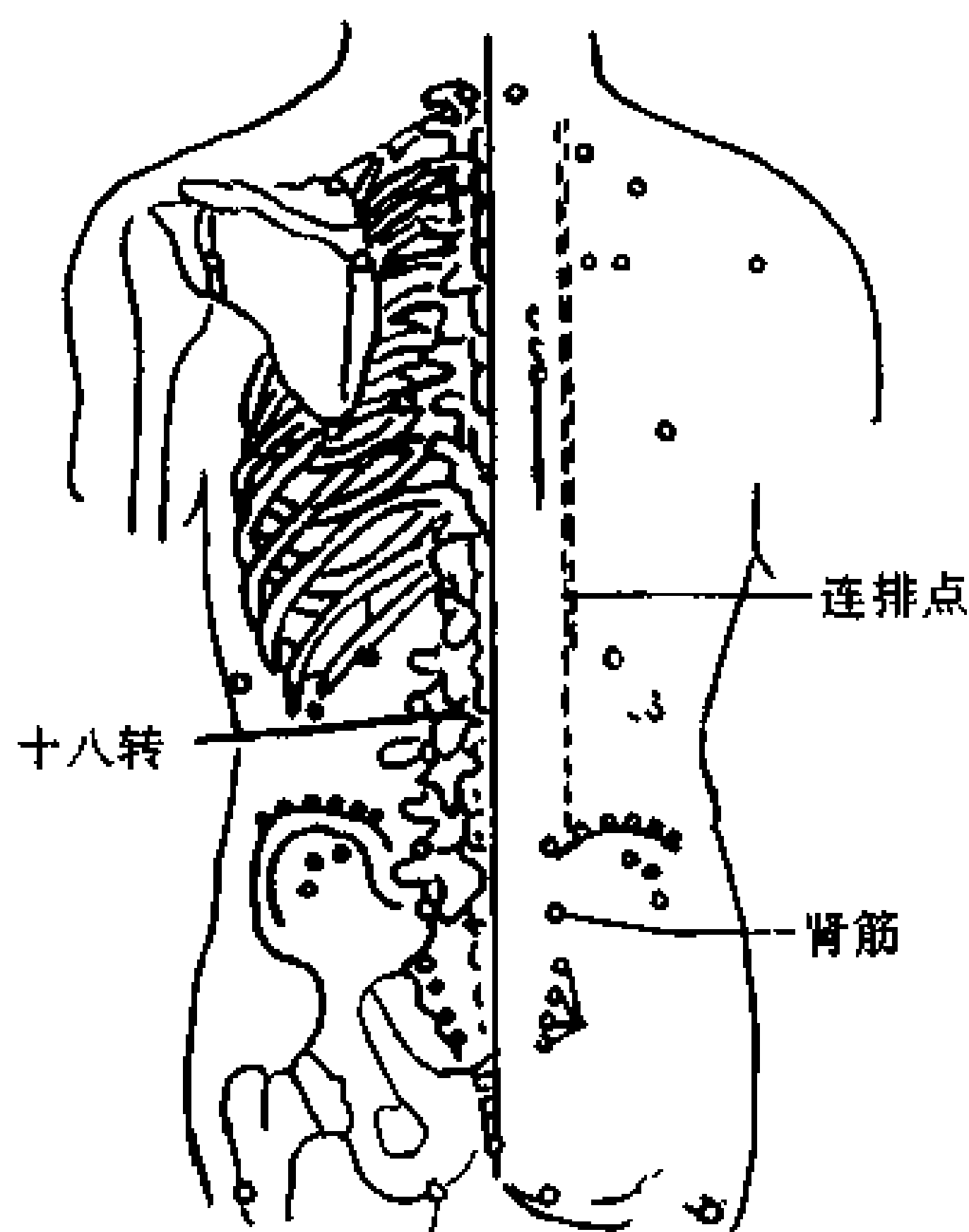


图 52-2

图 52 小儿呕吐、厌食、尿频取穴图

二十九、厌食

厌食是指小儿较长时期见食不贪、食欲不振、甚则拒食的一种常见病证。由于平素饮食不节，或因喂养不当，以及长期偏食等，使脾胃不和、受纳运化失健所致。

长期见食不贪，肌肉消瘦，并排除其他急、慢性消化系统疾病。其形体虽较消瘦，但无大便不调、脾气急躁、精神

萎靡和腹膨作胀等疳证症状。

【取穴】（见图 52）

（1）主穴：连环点。

（2）配穴：十八转、肋腹点。

【手法操作】

手法宜轻。施术后可用大鱼肌在小儿腹部进行揉摩 2 分钟，并用腹部揉刮法，反复 2~3 次。

三十、小儿尿频

尿频是小儿常见的一种尿道疾病。临床以尿频、尿急为特征。尿频的发生，多因湿热之邪蕴结下焦，使膀胱气化功能失常所致。

尿频有急慢性之分：急性起病较急，小便频数短赤，尿道灼热疼痛，常伴畏寒发热；慢性多由体质素亏，或治疗不当，病情迁延，小便混浊，淋漓不尽，神倦面黄，眼睑微肿。常易反复发作，缠绵不已。

【取穴】（见图 52）

（1）主穴：阳点。

（2）配穴：肾筋。

【手法操作】

手法宜轻，或用点揉法。并用骶骨反转法反复 3~5 次。

三十一、小儿遗尿

遗尿又称遗溺、尿床，是小儿睡中小便自遗、醒后方觉

的一种疾病。因下元虚寒、肾气不足，或脾肺气虚、膀胱失约，或肝经湿热、火热内迫等，致膀胱气化功能失调，闭藏失职，不能约制水道，而为遗尿。

多发于3~12岁的儿童，常在睡眠中遗尿，数日一次，或每夜遗尿，甚则一夜数次。

【取穴】（图53）

- （1）主穴：后心穴（男取左穴、女取右穴）、连排点。
- （2）配穴：肾筋、棘点、阴点。

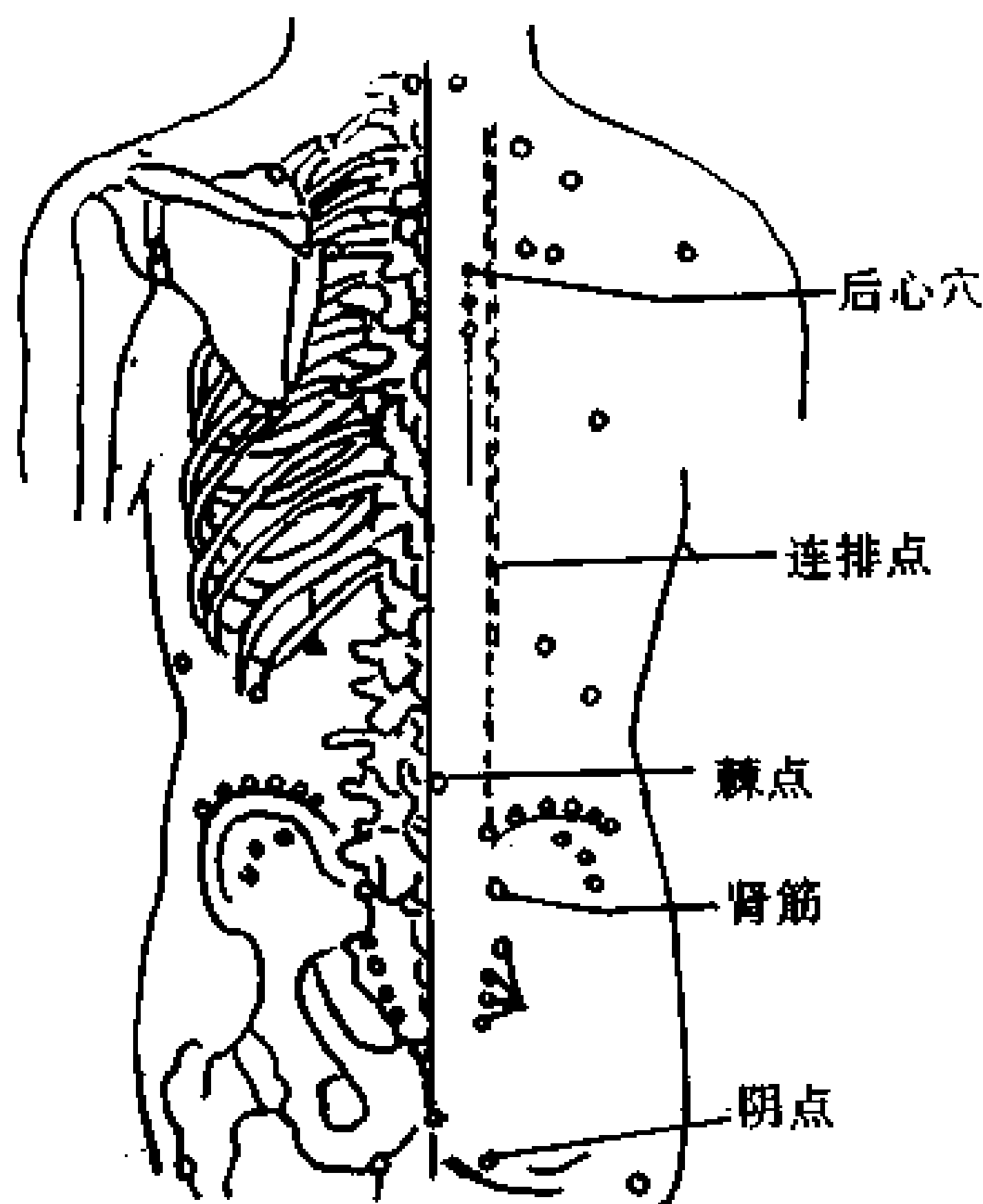


图53 小儿遗尿取穴图

【手法操作】

点揉法，手法宜轻。

三十二、夜啼

初生儿白天如常，入夜则啼哭不安，或每夜定时啼哭，甚则通宵达旦，故称为夜啼。本病主要因脾寒、心热、惊恐而致。

脾寒者啼哭低弱，睡喜蜷曲，腹喜摩按；心热者啼哭声较响，见灯火甚则哭声更剧，烦躁不安；惊恐者夜间突然啼哭，似见异物状，哭声不已，睡中时作惊惕。

【取穴】

(1) 主穴：十八转、阳明点。(图 54)

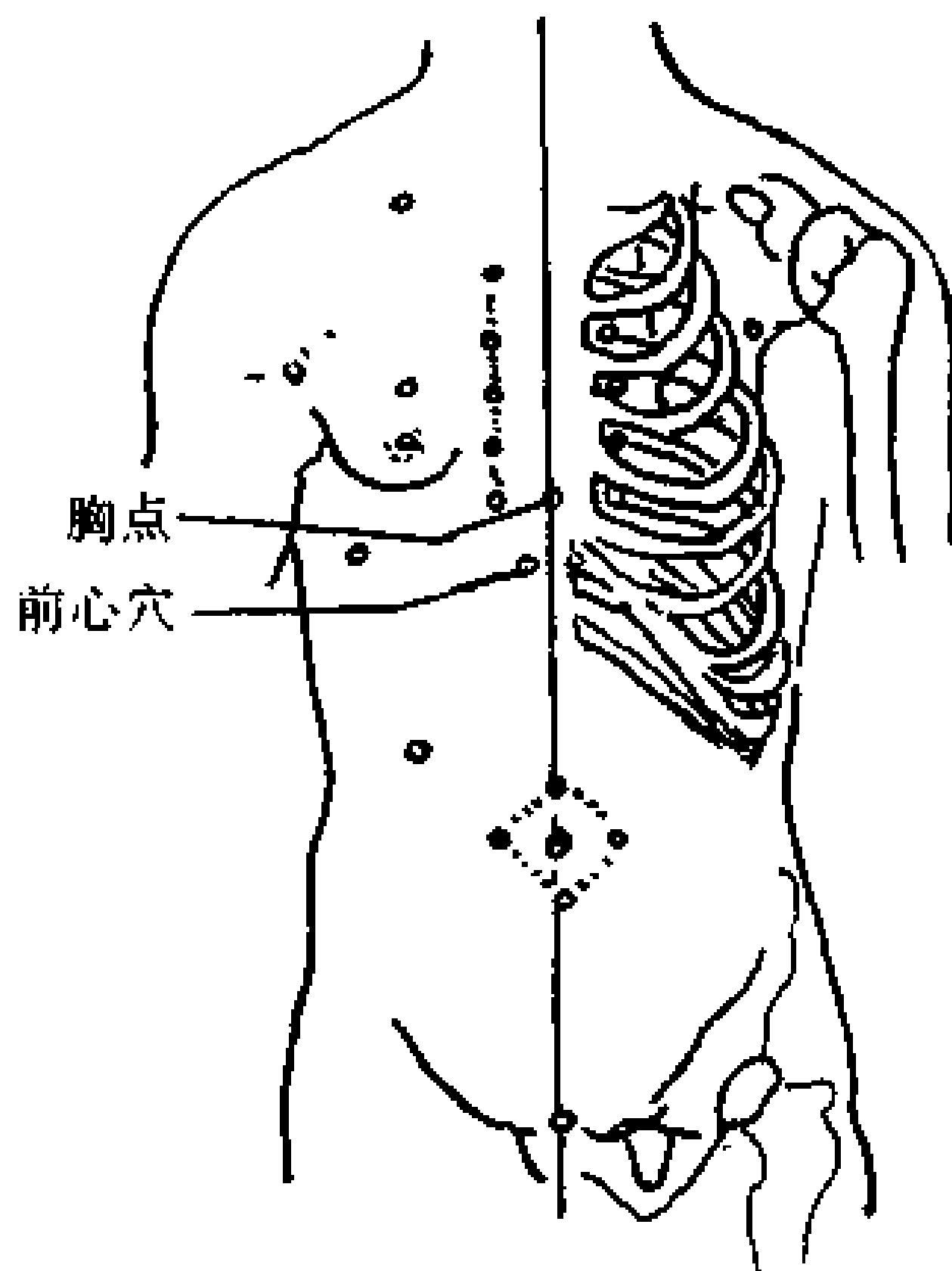


图 54-1

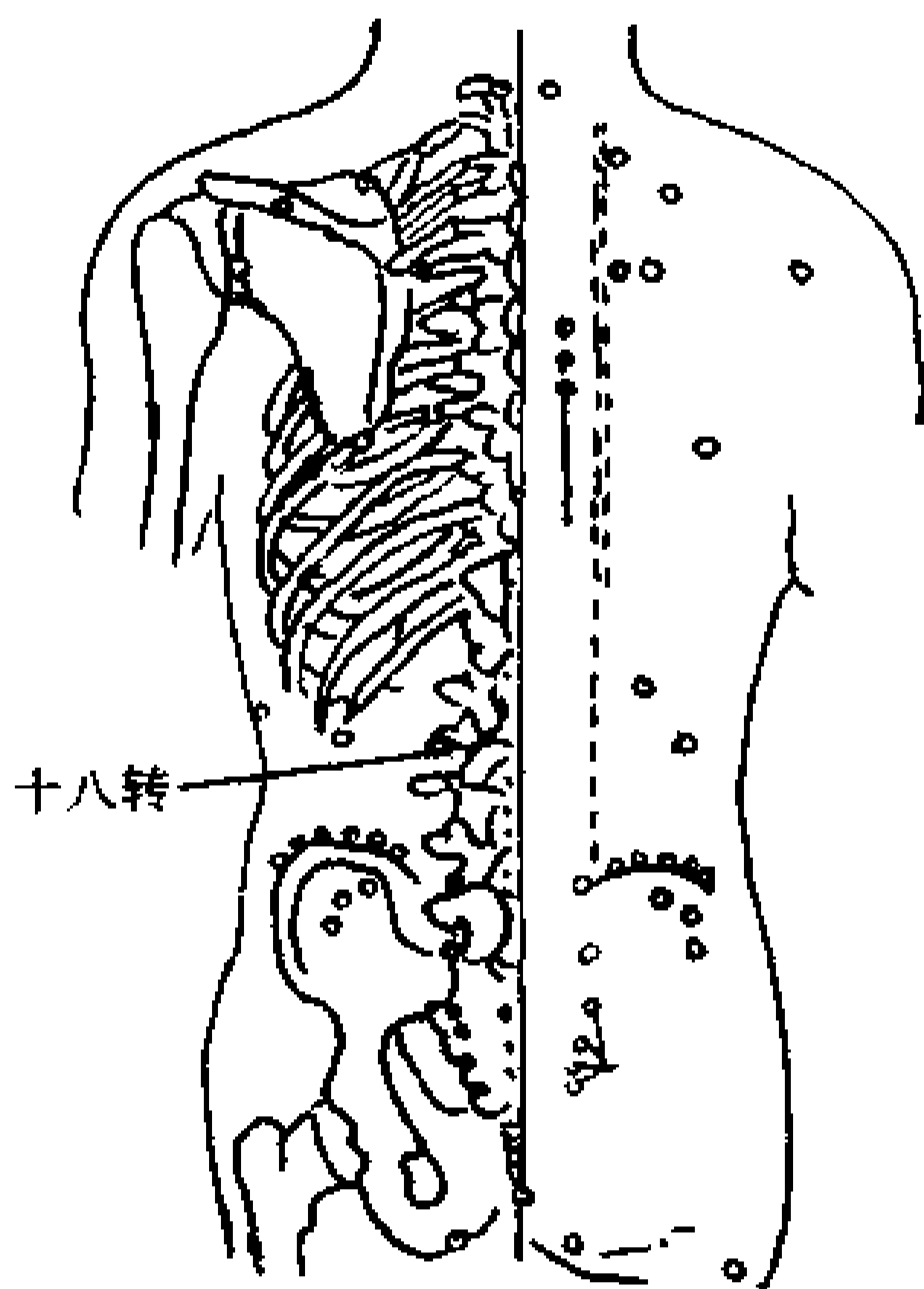


图 54-2

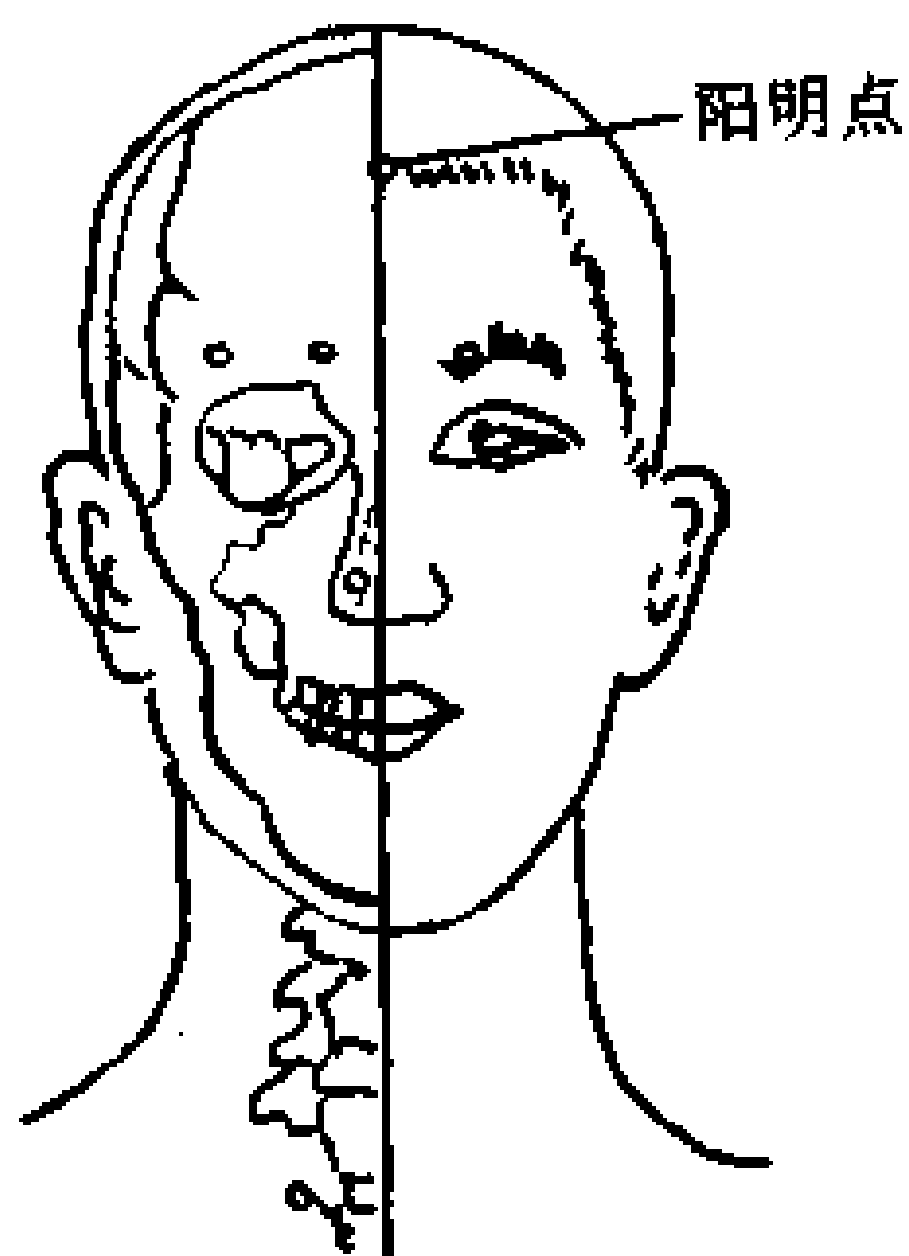


图 54-3

图 54 夜啼取穴图

(2) 配穴：胸点、前心穴。

【手法操作】

先点主穴，效果不佳再加点配穴，手法宜轻

三十三、颈部扭挫伤

颈部因过度扭转或受暴力冲击而引起的软组织损伤，称为颈部扭挫伤。日常生活中，颈部可因突然扭转或前屈、后伸而受伤，如在高速行驶的车上，因突然刹车可使头部猛烈

前冲；打篮球投篮时头部突然后仰；嬉闹扭斗时颈部过度扭转，或头部受到暴力冲击时，均可引起颈部扭挫伤。

伤后多为单侧颈部疼痛，有负重感，疼痛向背部放散，颈部活动受限，呈僵直状，每于旋头或仰头时疼痛加剧，痛处可摸到肌肉痉挛所致的肿块或索状硬结，患侧的肩胛骨内缘和下角处有明显的压痛点。必要时可拍摄X线照片，以排除颈椎骨折及脱位。

【取穴】（图 55）

（1）主穴：椎点、肩上点、天窗。

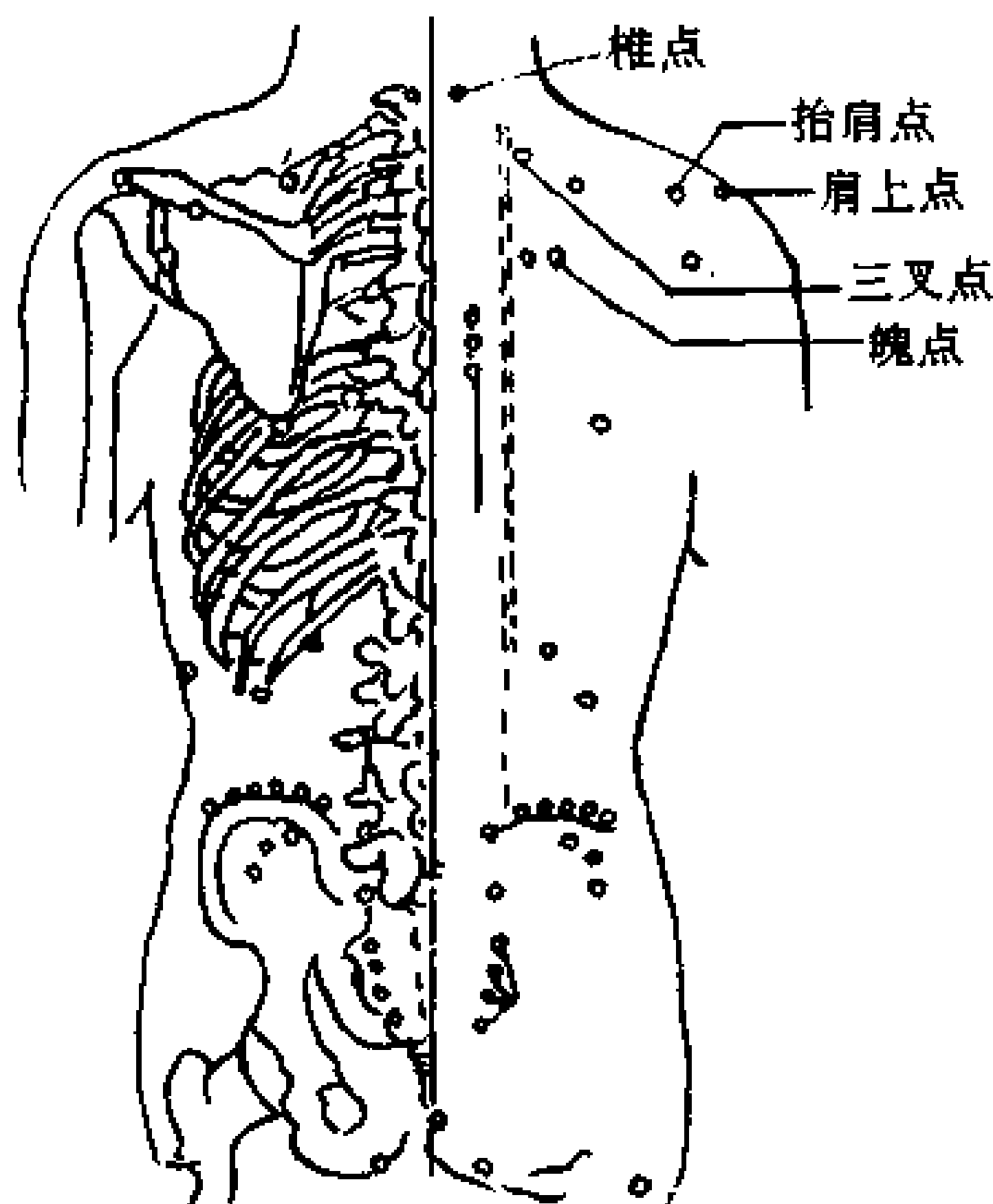


图 55-1

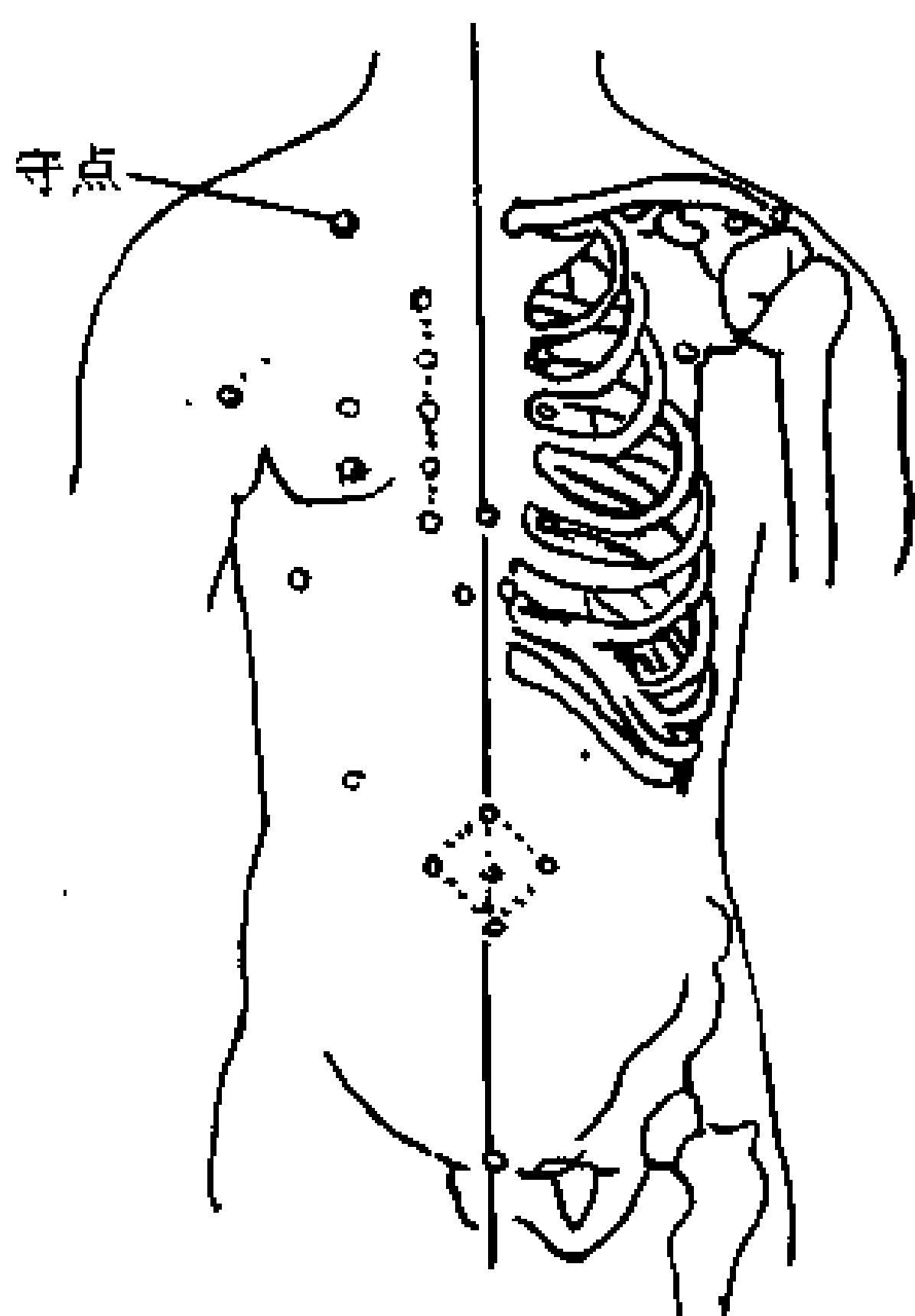


图 55-2

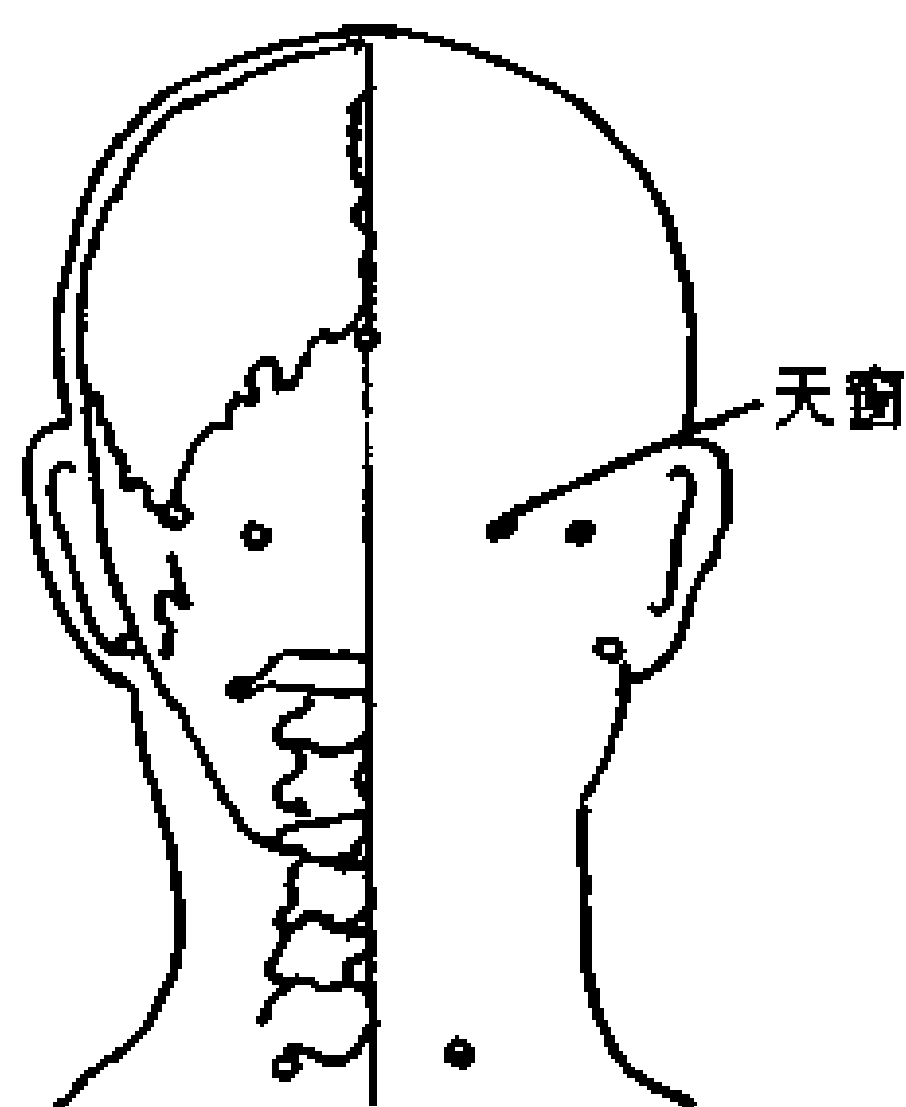


图 55-3

图 55 颈部扭挫伤、落枕取穴图

(2) 配穴：魄点、守点、三叉点。

【手法操作】

(1) 先点主穴，同时嘱患者头部略前屈，并左右摆动。若症未愈，可点配穴，并揉捏颈筋。反复施术至患者头部能左右活动为止。

(2) 若头部俯仰活动困难时，再点两侧椎点及三叉点，同时嘱患者头部前后活动即愈。

(3) 若肩井穴区域酸痛，可点魄点解之；胸锁乳突肌酸痛加点守点；颈部挫伤则局部伤处的穴位禁止施术；损伤较重者可配合中药内外治之。

三十四、落枕

因睡眠姿势不良或风寒侵袭，引起颈部酸痛、活动不利等症状，称为落枕，又称失枕、失颈。主要是因为睡眠时姿势不良，使头颈长时间处于过度偏转位置；或睡眠时枕头过高、过低、过硬，使头颈长时间处于过伸或过屈位置。不良的睡姿与枕头的不合适，均可使颈部肌肉处于过度紧张状态，时间较长即可发生静力性损伤。此外，颈部遭受风寒侵袭也是常见病因，如严冬受寒，盛夏贪凉，风寒外束，使颈部肌肉气血凝滞、经络痹阻、僵硬疼痛、活动不利。

睡眠后颈部出现疼痛，头部常歪向患侧，活动欠利，不能自由旋转后顾。颈部肌肉痉挛压痛，触之如条索状、块状，在胸锁乳突肌、斜方肌及菱形肌部位亦常有压痛。因风寒外束引起的颈项强痛者，常兼有恶寒、发热等表症。

【取穴】（见图 55）

（1）主穴：椎点、肩上、抬肩。

（2）配穴：魄点、守点。

【手法操作】

先反复点主穴，然后提拔或揉捏颈筋，至头部活动正常为止。若胸锁乳突肌酸痛或头部俯仰活动困难时，继续点椎点（双侧），并点配穴，反复施术 3~4 次。

三十五、颈椎病

由于颈椎骨质的退行性变而刺激或压迫其周围的神经、

血管及其他组织，引起一系列不同形式的综合征，称之为颈椎病。

本病多见于40岁以上的中老年人。常发于长期低头伏案工作者，如誊写、缝纫、刺绣等职业者较易发生。或由于年老肝肾不足，筋骨懈惰，引起颈部韧带肥厚钙化，椎间盘退化，骨质增生等病变，影响到椎间孔变窄，神经根受压时，即逐渐出现颈椎病的各种症状。

多数患者渐渐感到一侧肩、臂、手的麻木疼痛，或以麻木为主，或以疼痛为主。颈部后伸、咳嗽、甚至增加腹压时疼痛可加剧。部分患者可有头晕、耳鸣、耳痛、视物不清或握力减弱及肌肉萎缩等，此类患者的颈部常无疼痛感觉。臂丛神经牵拉试验可为阳性：即检查者一手扶患者头部的患侧，一手握患侧上肢，将其外展90°，两手作相反方向牵拉，若有放射痛或麻木则为阳性；椎间孔压缩试验可为阳性：即患者坐位，颈后伸，偏向患侧，检查者以左手托下颌，右手从头顶逐渐压下，出现颈痛或放射痛者为阳性。X线平片示颈曲变直或向后成角，多有椎间隙狭窄、骨质增生、椎间孔缩小、钩椎关节骨刺形成等。

【取穴】（图56）

（1）主穴：后心穴（男取左侧，女取右侧）、龙点、椎点、颅点、天窗。

（2）配穴：肩上、守点、抬肩（均取患侧）。

【手法操作】

先反复点主穴，后点配穴，反复3~5次，手法由重转轻，然后用拇、食、中指揉捏颈椎两侧，每天施术一次，7天为一疗程。可根据病情配合中药内治。

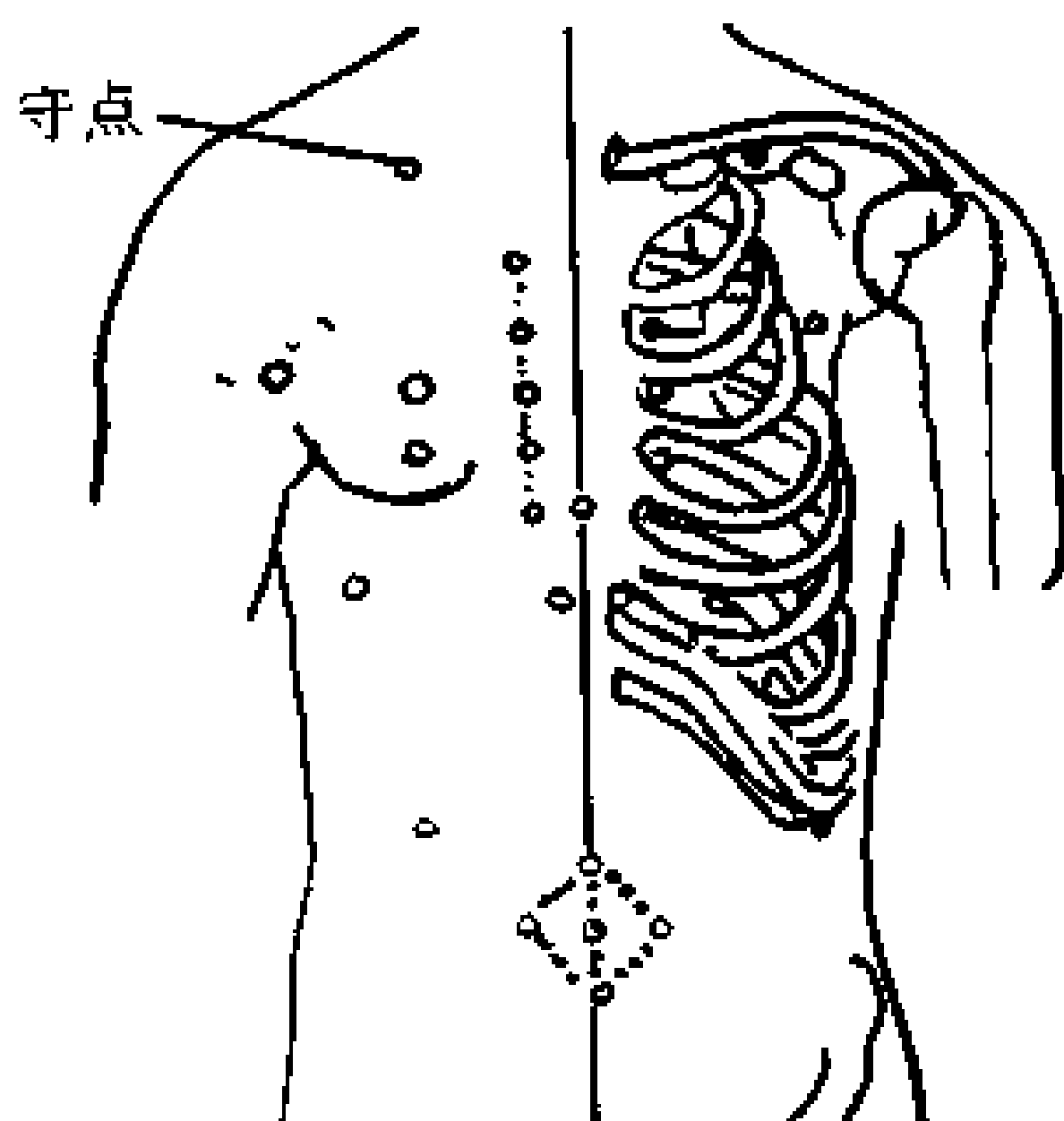


图 56-1

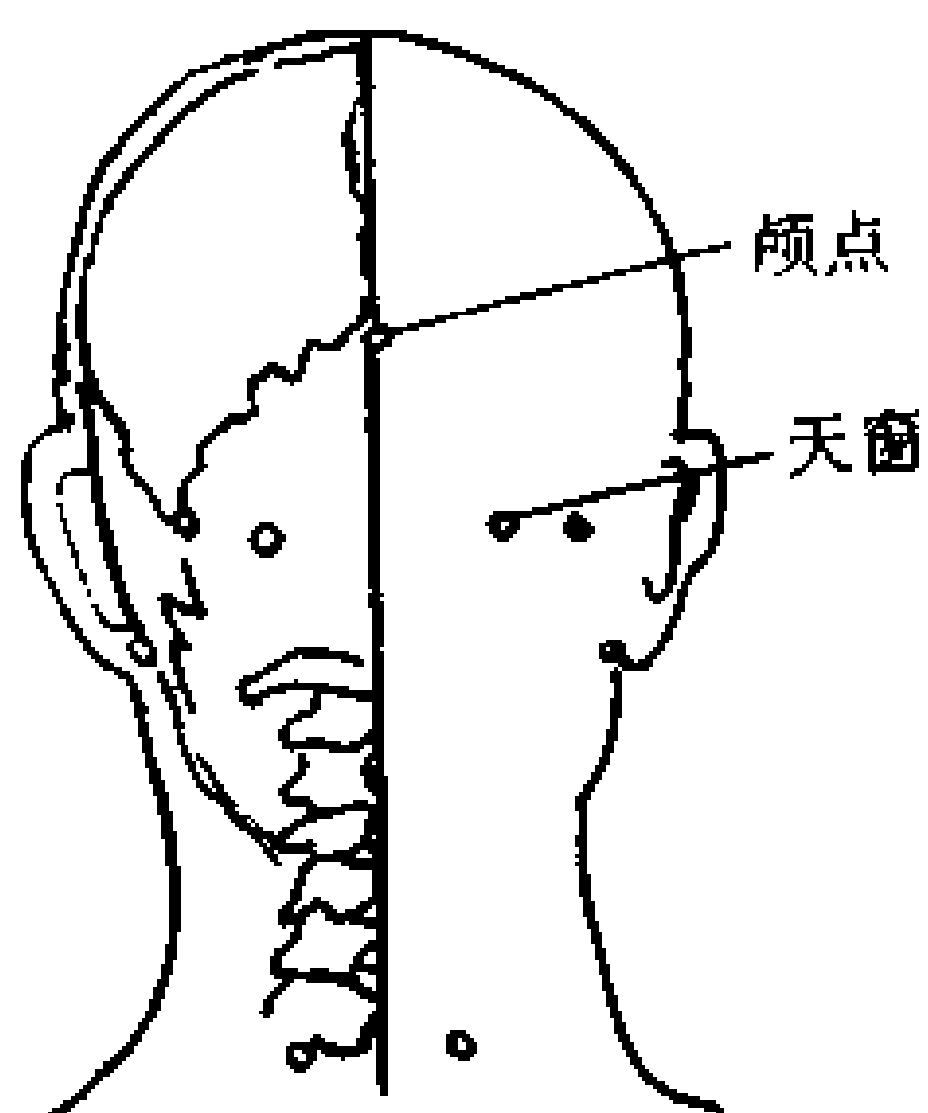


图 56-2

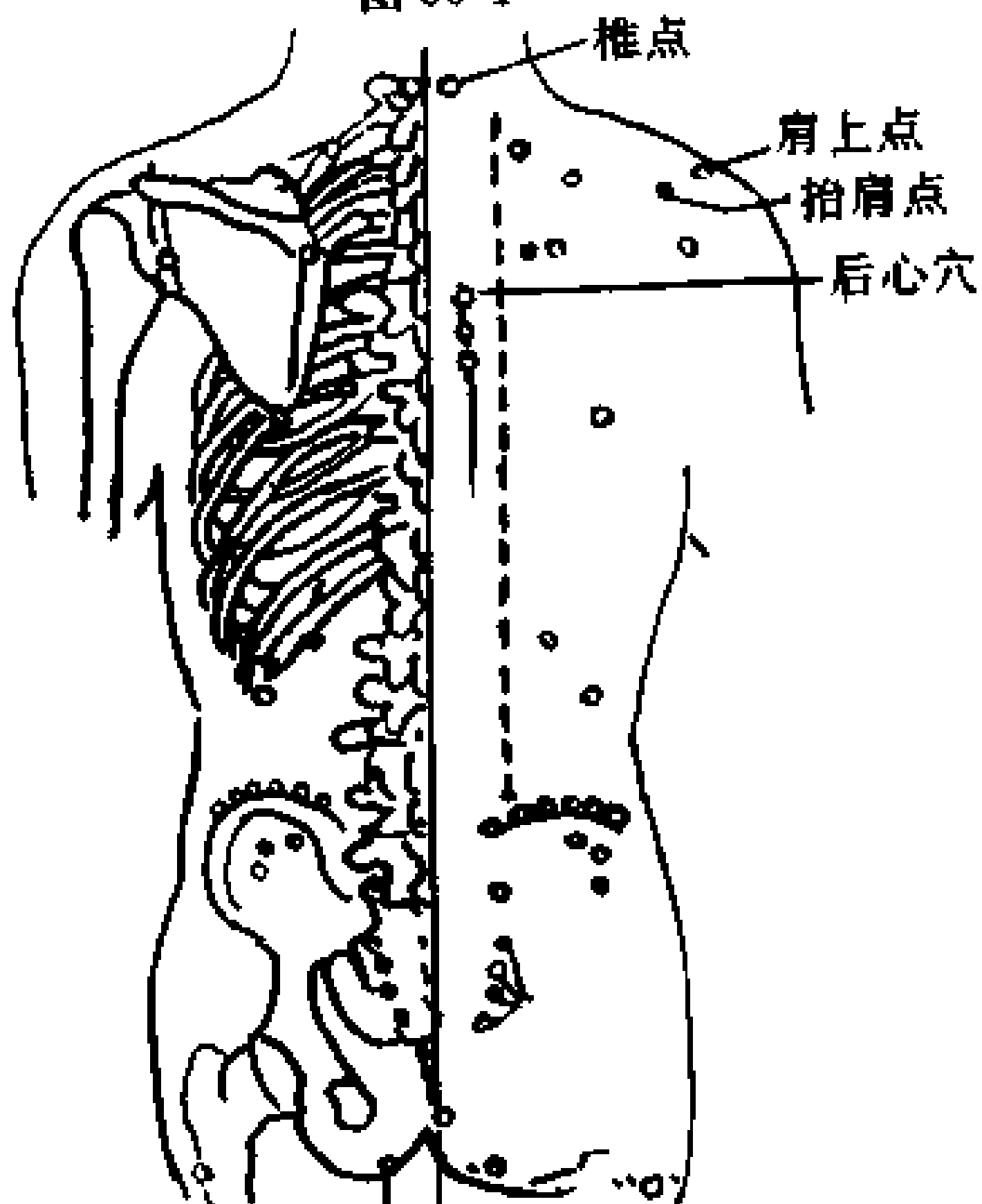


图 56-3

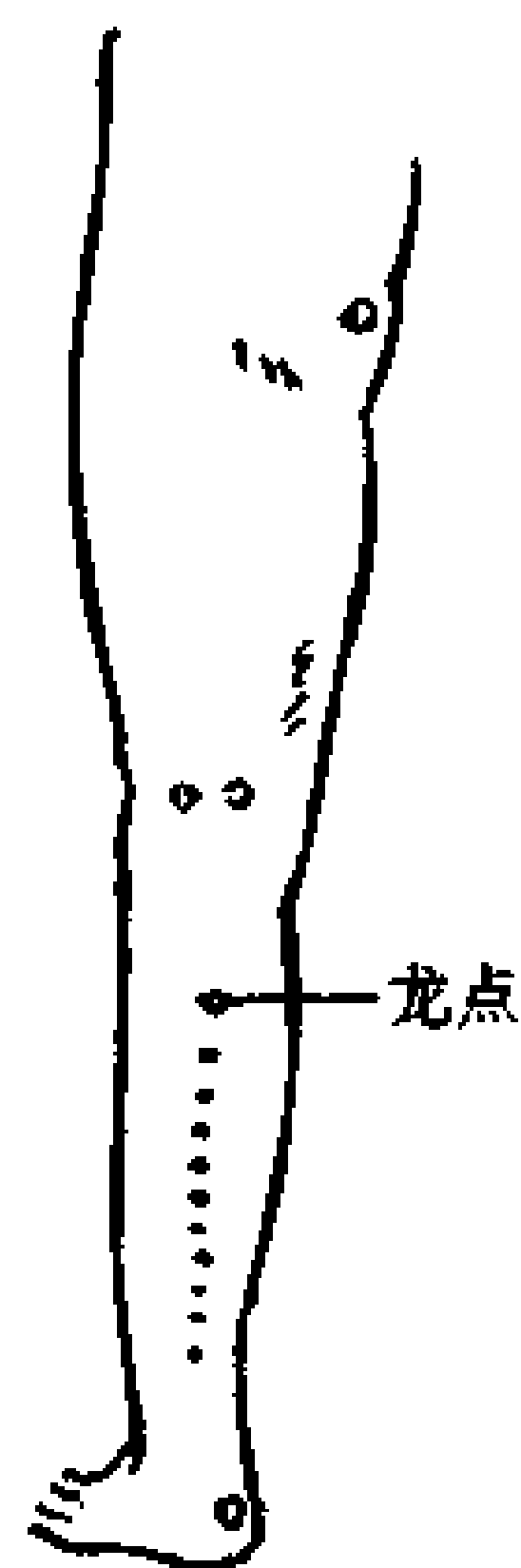


图 56-4

图 56 颈椎病取穴图

三十六、肩部扭挫伤

因外伤致肩部关节囊、筋膜、肌肉的扭转、牵拉或挫伤，使肩部肿胀、疼痛、功能障碍者，称为肩部扭挫伤。

肩关节过度扭转，可引起关节囊、筋膜的损伤或撕裂。重物打击肩部，可引起局部肌肉或脉络的损伤或撕裂，致使瘀肿疼痛、功能障碍。当上肢突然外展或已外展的上肢受外力使之突然下降，均可使冈上肌腱部分或全部断裂。如有肩部筋膜严重扭挫或撕裂，则肿痛难以消除，可形成慢性疾病过程，继发肩凝症等。

伤后局部肿胀，或有轻度瘀血斑，疼痛，肩关节活动受限，但以自主活动单向受限为主；肩部压痛，压痛最明显之处，多是损伤最严重部位。如有冈上肌撕裂时，则外展上肢的力量减弱，且被动外展 $60^{\circ} \sim 120^{\circ}$ 时局部疼痛加剧。

【取穴】（图 57）

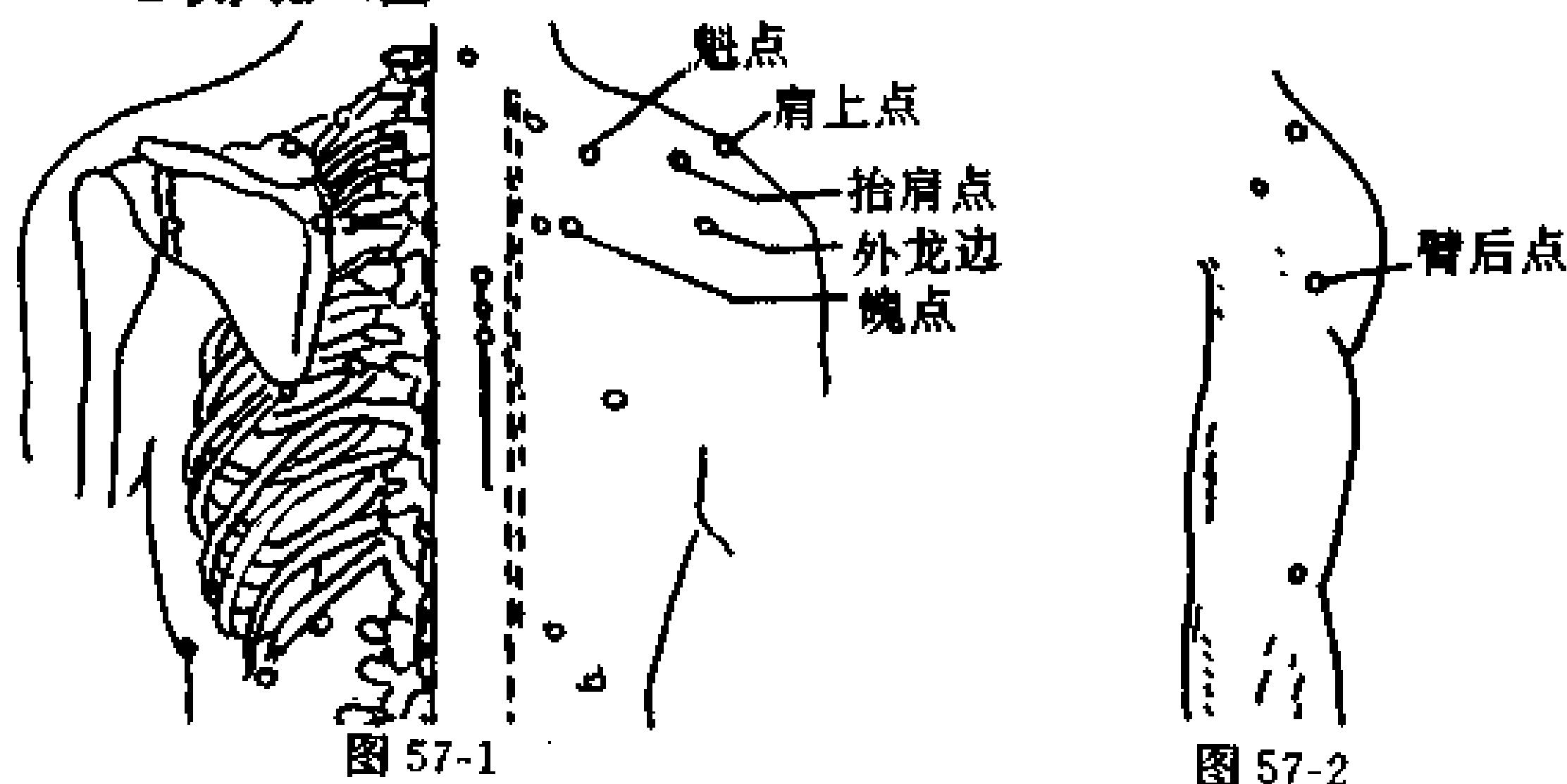


图 57 肩部扭挫伤取穴图

(1) 主穴：抬肩点、肩上点。

(2) 配穴：魄点、魁点、外龙边、臂后点。

【手法操作】

先反复点主穴，然后根据酸痛部位再选点配穴，若为挫伤，则损伤局部的穴位禁止施术。视伤情轻重可配合中药制剂外治。

三十七、肩关节周围炎

因劳损、外伤或感受风寒湿邪而致肩关节囊及其周围软组织发生无菌性炎症的一系列改变，使之疼痛、活动障碍，但排除其骨质本身疾患者，称为肩关节周围炎，又称冻结肩、漏肩风、五十肩、肩凝症等。

本病多与老年人体弱，肝肾不足，气血虚弱，筋骨失于濡养有关。加上劳损或外伤或感受风寒湿邪等原因，致使经脉不通、气血凝滞、外邪郁结，“不通则痛”。筋肉萎缩受限，严重者软组织萎缩粘连，肩关节功能严重障碍。

患者肩及臂部常有疼痛，严重者夜间加剧，影响睡眠。合并外邪侵袭者，可于受凉后疼痛加重。肩部活动受限，如上臂的抬举、外展、旋转及环转等动作均有障碍，肩部僵凝，不能摸背梳头，甚至洗脸、漱口也有困难。病程长者，邻近肌肉挛缩、变硬，久则失去活动功能，肩部运动仅由肩胛骨的运动而代偿。肩部可有多处压痛点，压痛点常见于喙突处、肩峰下、结节间沟处、肩胛骨内侧缘等。

【取穴】（图 58）

(1) 主穴：椎点、抬肩点、魁点、魄点、腋点（均取患侧穴）。

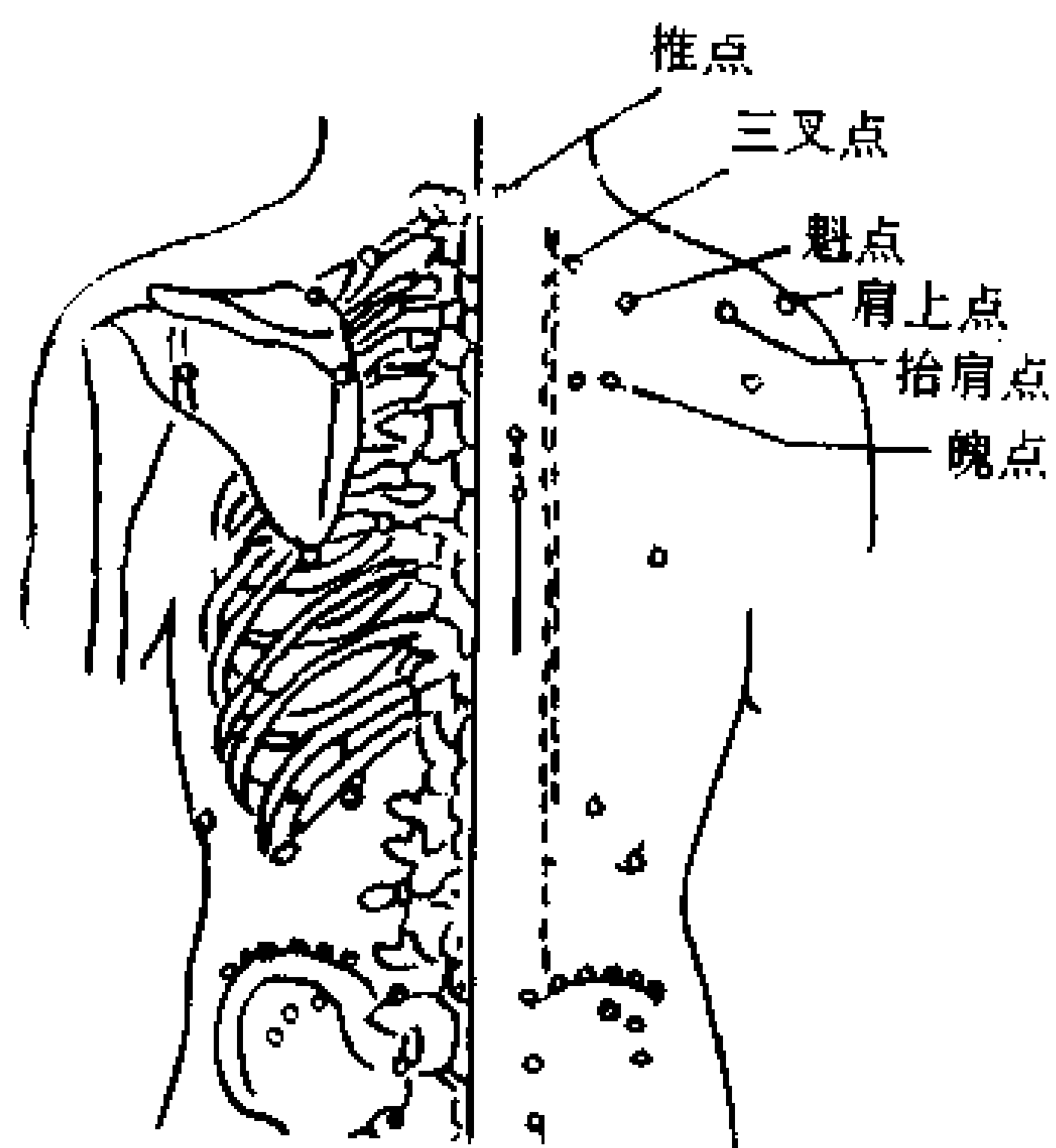


图 58-1

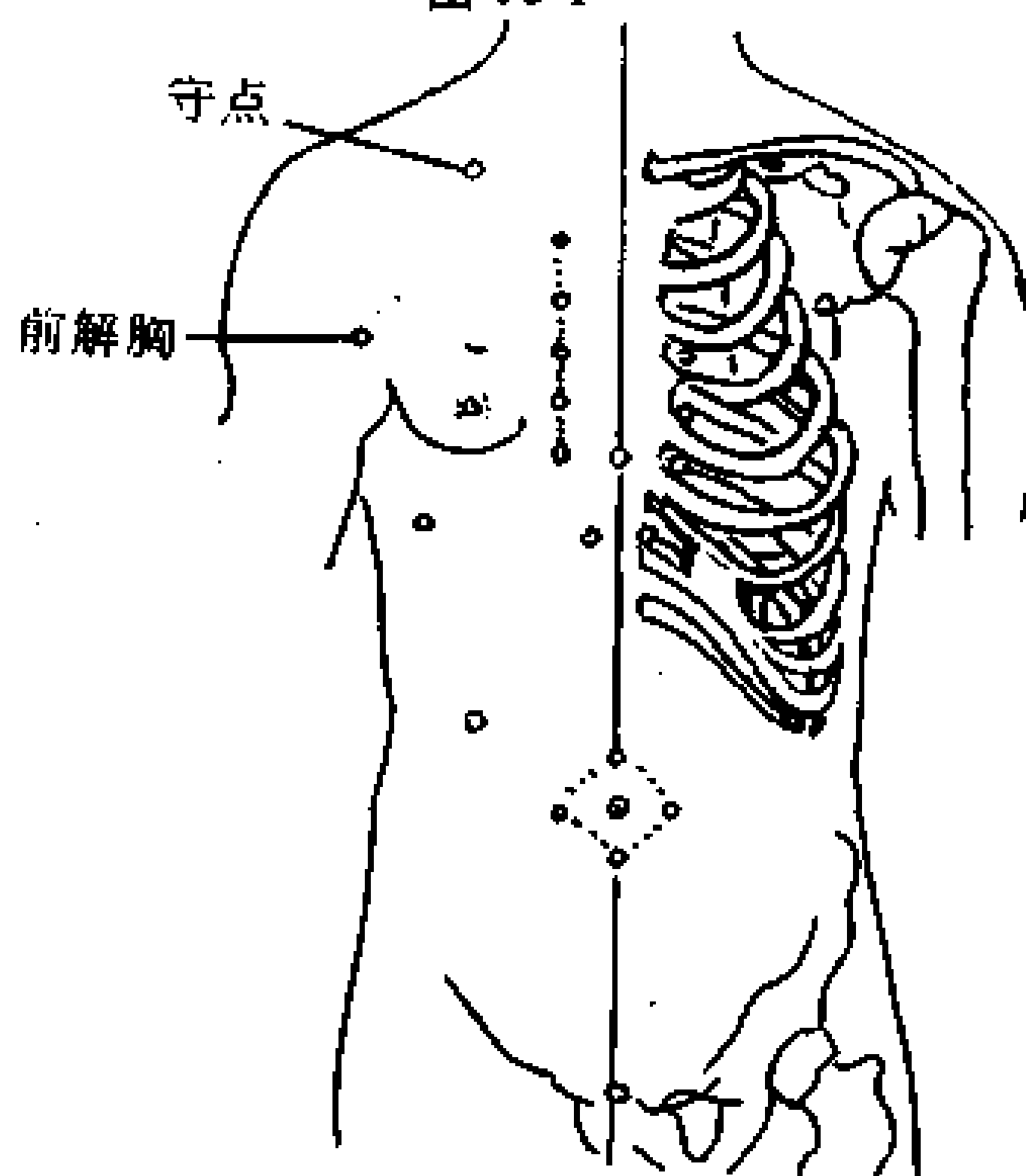


图 58-2

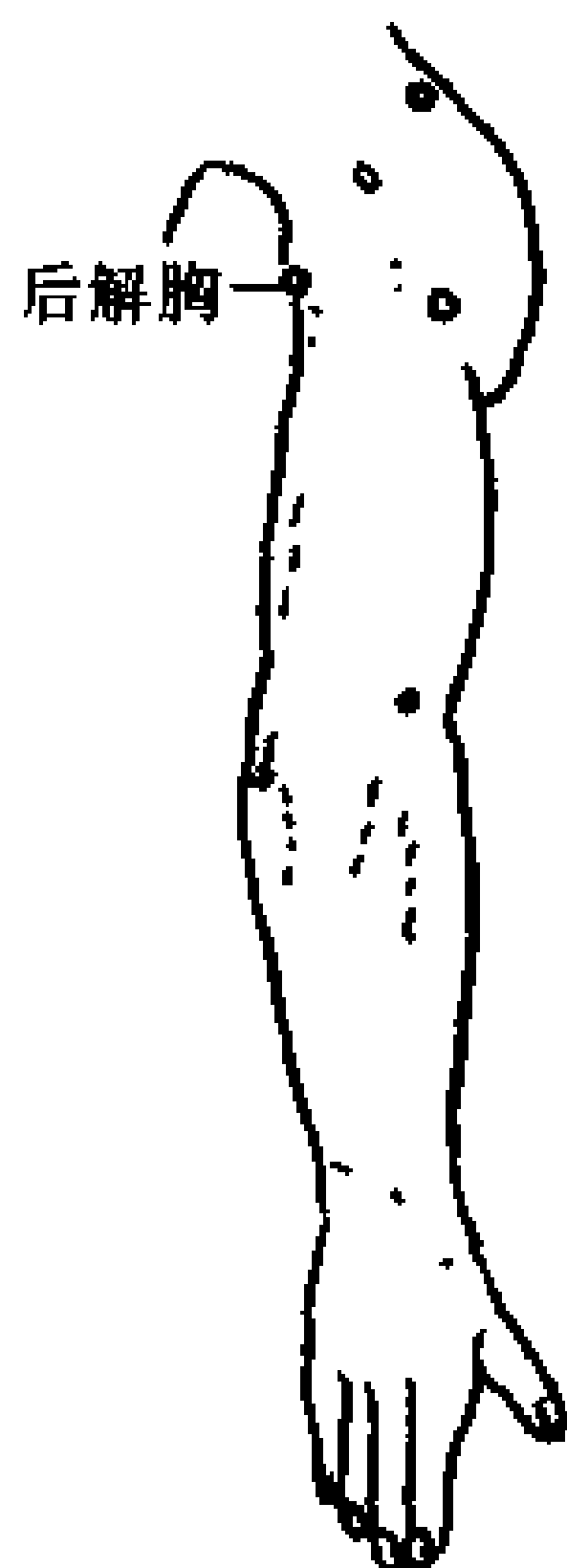


图 58-3



图 58-4

图 58 肩关节周围炎取穴图

(2) 配穴：守点，三叉点，前、后解胸，肩上点。

【手法操作】

急性发作酸痛较甚者，先点后心穴止痛，然后再点主穴，每次选取 3~4 穴，反复轮换。由于上肢活动时肩部酸痛的部位不同，可根据酸痛部位选取 3~4 个配穴，反复轮换。急性期手法宜轻，施术后嘱患者配合作肩部各种活动。

三十八、肘部扭挫伤

肘部受直接或间接暴力的作用引起的软组织损伤，使肘部肿胀疼痛，功能障碍，统称为肘部扭挫伤。

直接暴力的打击可造成肘关节挫伤；跌打、失足滑倒、手掌着地、肘关节处于过度外展或过度伸直位，可致肘关节扭伤。临床上以关节囊、侧副韧带和肌腱等损伤多见。

伤后肘关节处于半屈伸位，呈弥漫性肿胀、疼痛、功能障碍，有的出现瘀斑。压痛点往往在肘关节的内后方和内侧副韧带附着部。严重的扭挫伤要注意与骨折相区别，通过X线摄片予以确诊。

【取穴】（图 59）

（1）主穴：椎点、桡点、嘴点。

（2）配穴：臂水沟。

【手法操作】

先反复点主穴，后点配穴。若挫伤则施术时手法宜轻，局部瘀肿明显时可配合中药外治。

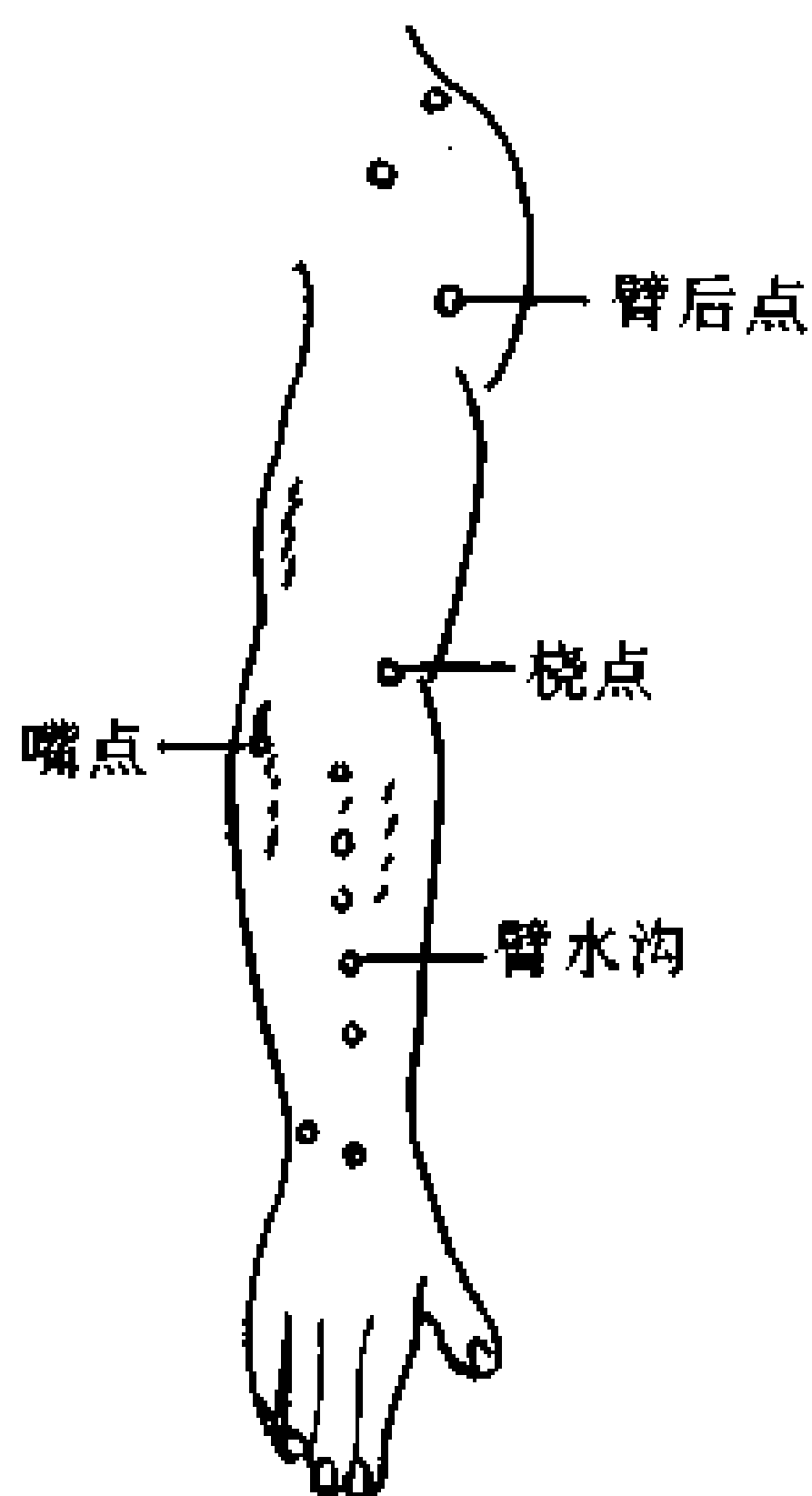


图 59-1

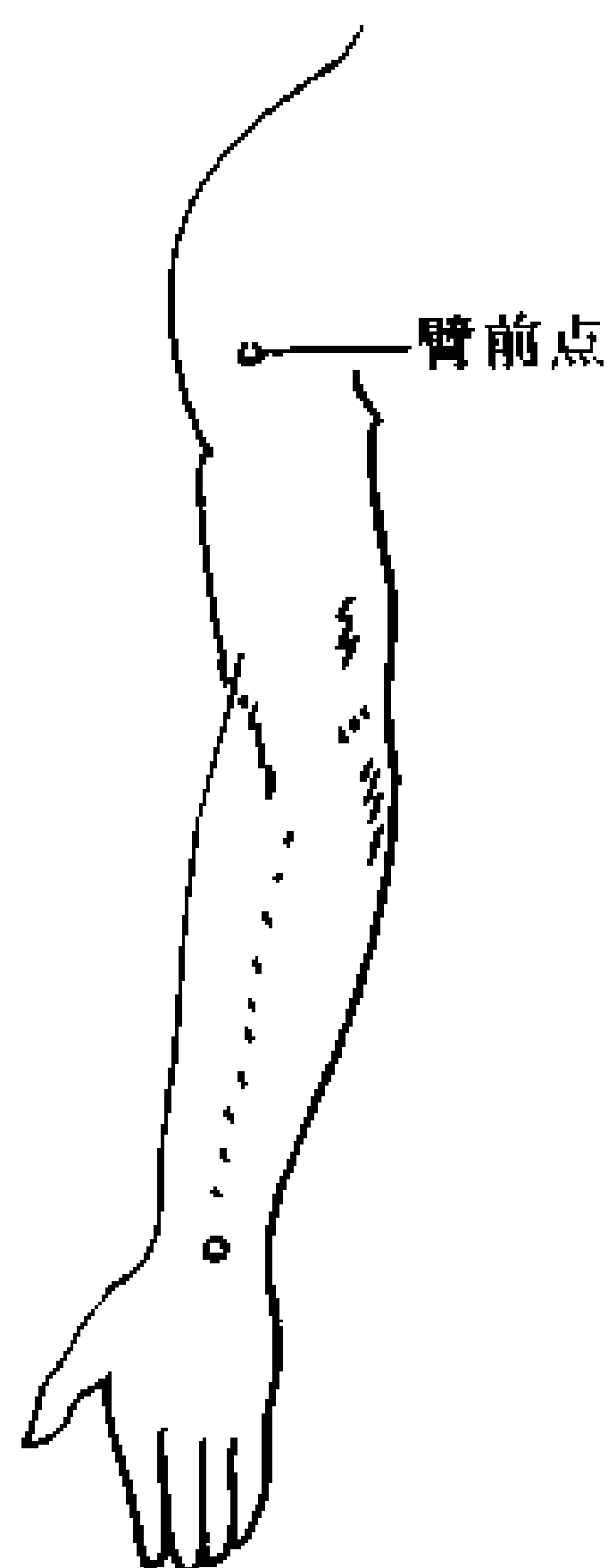


图 59-2

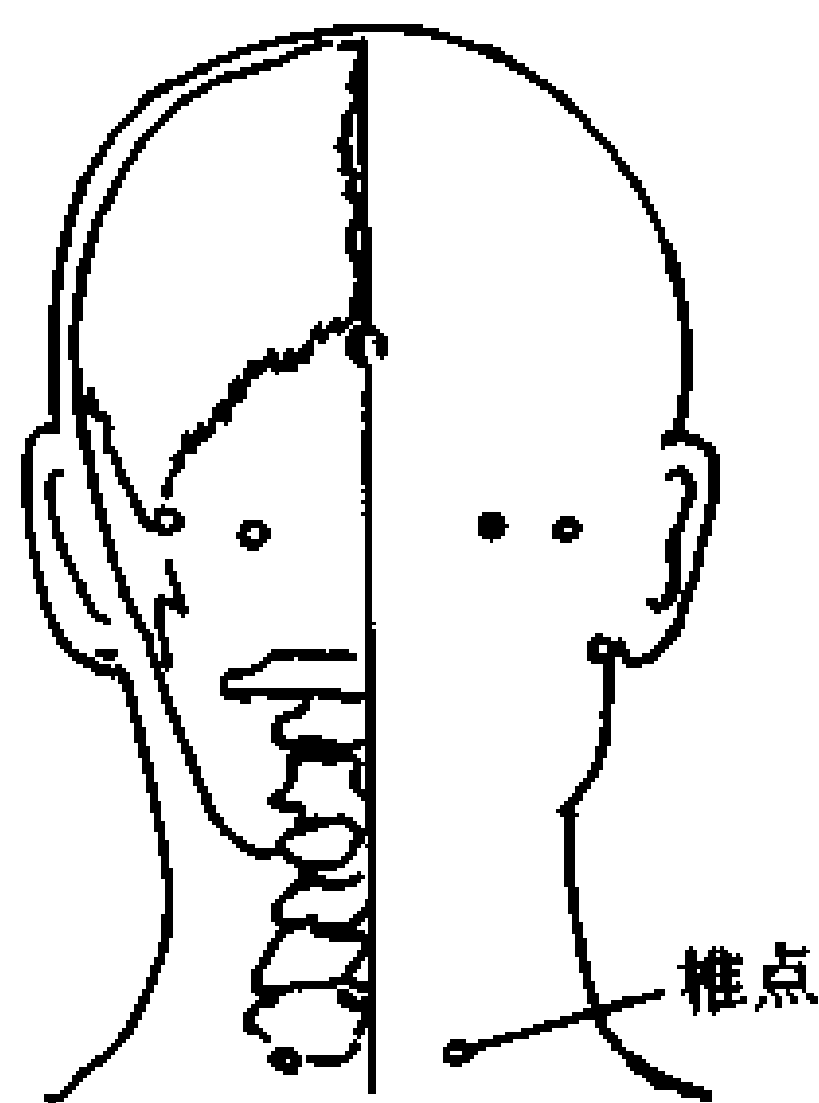


图 59-3

图 59 肘部扭挫伤、骨化性肌炎(创伤性肘关节炎)取穴图

三十九、骨化性肌炎（创伤性肘关节炎）

肘关节损伤后（骨折、脱位、软组织损伤等）引起关节周围软组织内的钙化、骨化，并影响关节功能，称为骨化性肌炎。

引起本病的主要原因是外伤，其次是反复多次的积累性损伤。肘关节的骨折、脱位或软组织损伤造成关节内出血、骨膜下血肿。由于骨膜下出血和周围软组织相沟通，因此，血

肿部位机化、钙化、骨化后影响关节功能活动。也有部分职业（木工、钳工、厨师等）性质使得肘关节反复多次的牵拉损伤，造成关节周围的软组织出血、渗出，最后形成钙化或骨化，影响关节活动，此种损伤多伴有创伤性关节炎发生。

肘关节周围软组织肿胀、酸痛或胀痛，关节活动障碍；软组织广泛压痛。由于关节功能障碍，有废用性肌萎缩出现。X线表现为早期关节周围有云雾状阴影，继之则肘关节前、后、侧方有广泛钙化物出现。同时可以伴有关节内创伤性改变，包括间隙变窄、软骨下骨质硬化、骨膜下增生等。

【取穴】（见图 59）

（1）主穴：嘴点、椎点。

（2）配穴：臂前点、臂后点、臂水沟。

【手法操作】

先反复点椎点，后点其他各穴，施术后再用大鱼际肌揉按肘部 2～3 分钟。

四十、肱骨外上髁炎

由于急、慢性损伤造成肱骨外上髁周围软组织疼痛，称为肱骨外上髁炎。本病因多见于网球运动员，故又称为网球肘。

本病多见于经常旋转前臂、伸屈肘关节的工作者，如木工、水电工以及网球运动员等。由于长期劳损，伸腕肌腱起始处反复受到牵拉刺激，引起部分肌纤维撕裂，使局部轻微出血呈无菌性炎症而产生粘连，或局部的滑膜增厚等变化，致使肌肉痉挛、局部疼痛和沿伸腕肌放射性串痛。

肘外侧疼痛，甚至可向上臂及前臂放散，不能端提重物，不能伸腕，前臂旋转痛，劳累后加重。严重者不能端水杯，甚至提笔写字也痛。肱骨外上髁部压痛明显，作抗阻力的腕关节背伸和前臂旋后动作时，可引起患处疼痛。

【取穴】（图 60）

- （1）主穴：桡点。
- （2）配穴：臂后点、臂水沟。

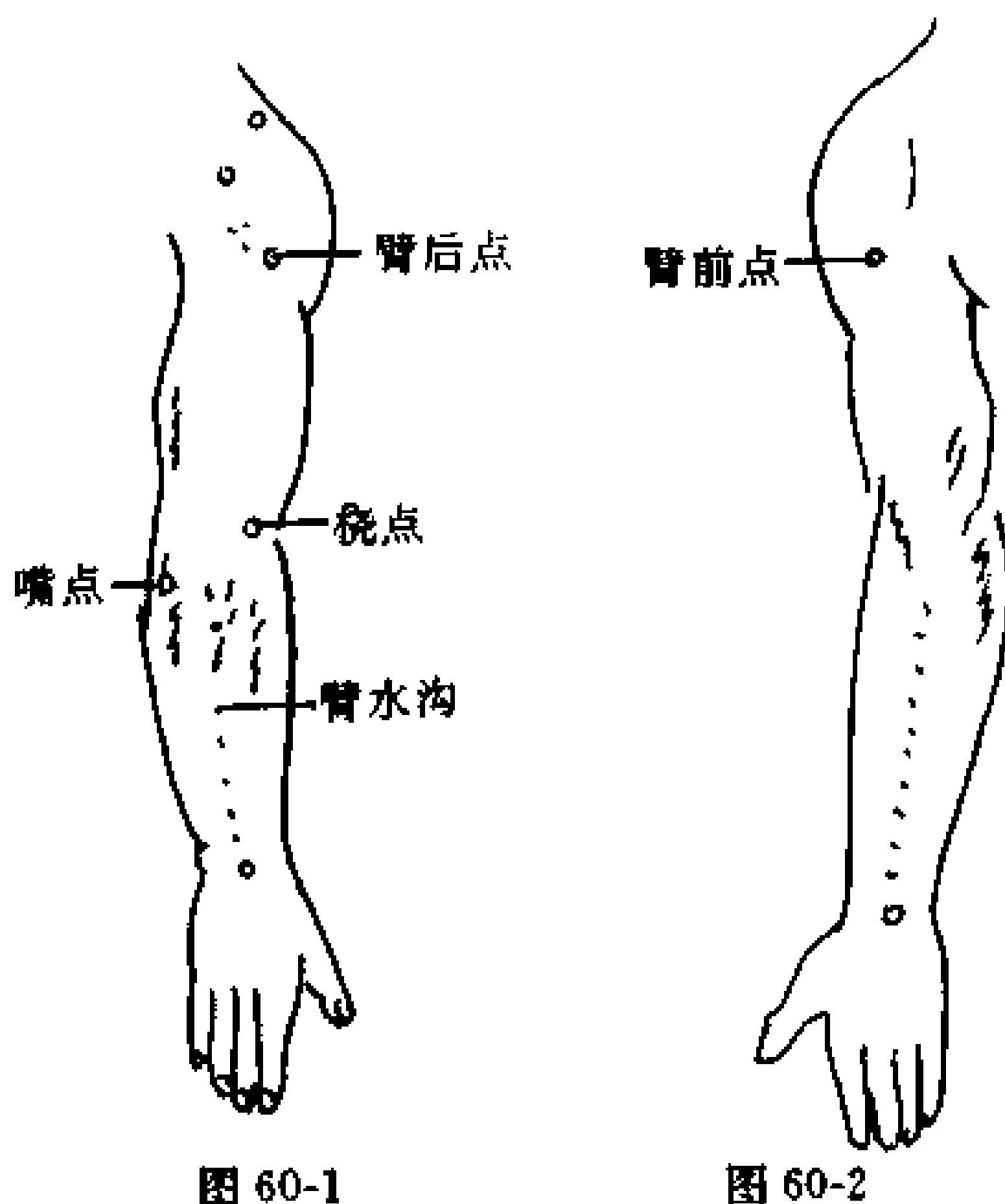


图 60 肱骨内上髁炎、肱骨外上髁炎取穴图

【手法操作】

反复点穴位。并嘱患者禁止揉按肱骨外上髁局部。

四十一、肱骨内上髁炎

由于损伤或劳损引起肱骨内上髁周围软组织疼痛者，称为肱骨内上髁炎。因传统观念认为本病多见于学生，故又称学生肘，实际上学生患此病者并不多。

急性扭挫伤和积累性损伤引起屈肌群和旋前圆肌起点部位的牵拉，造成肌腱附着点的出血或渗出，形成小血肿和局部损伤性炎症肿胀，刺激或挤压尺神经皮支，引起疼痛。若治疗不及时，形成粘连、肌肉收缩时亦可引起疼痛。

肘内侧疼痛，不能提重物，前臂旋前、屈腕时疼痛加重，压痛点在肱骨内上髁及周围软组织，屈肌群抗阻试验阳性（即伸肘、伸腕、旋后位抗阻力引起肱骨内上髁疼痛）。

【取穴】（见图 60）

（1）主穴：嘴点。

（2）配穴：臂前点。

【手法操作】

先反复点穴位后，再拔伸中指。

四十二、腕部扭挫伤

腕关节部位因受到间接暴力或直接暴力作用而致的损伤，称为腕部扭挫伤。

由于跌仆时手掌或手背着地，或用力过猛，或因暴力直接打击，迫使腕部过度背伸、掌屈及旋转活动，引起韧带、筋膜的扭伤或撕裂。

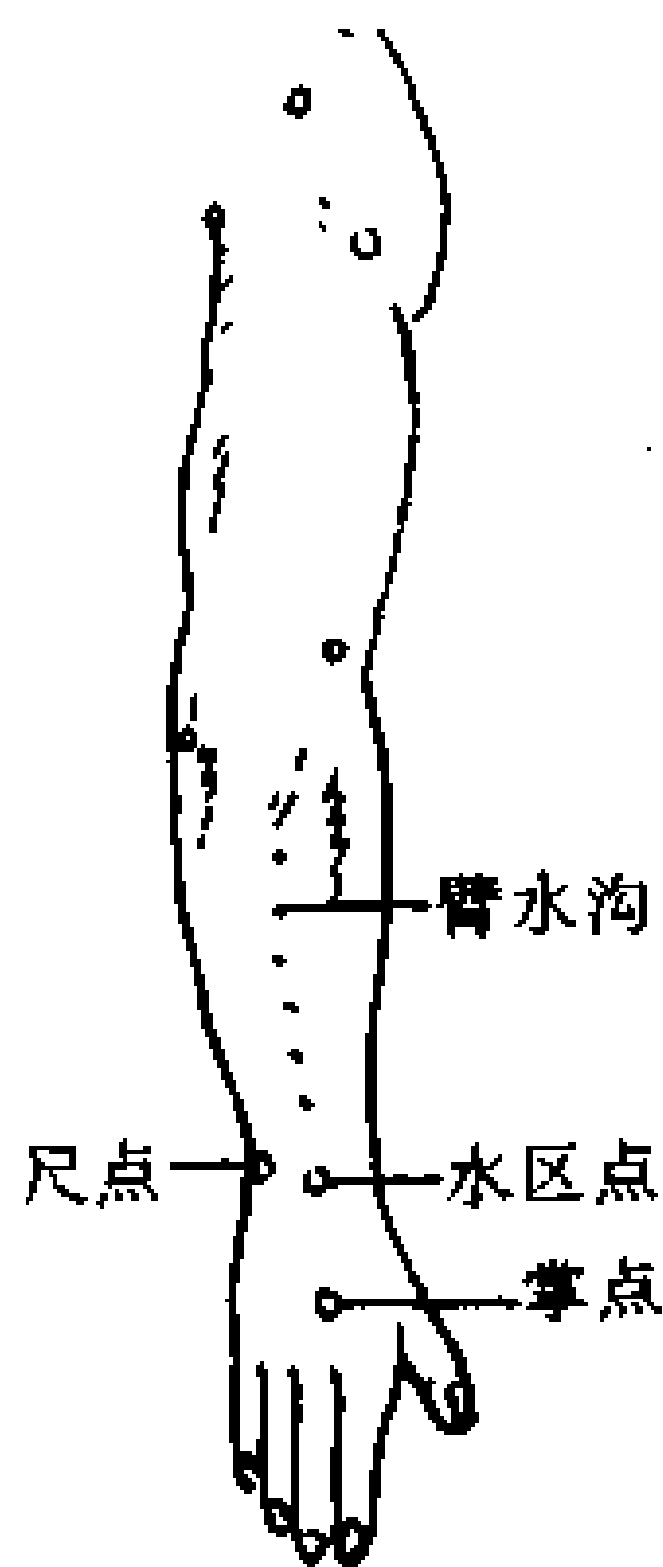


图 61 腕部扭挫伤、桡骨茎突腱鞘炎、腕管综合征取穴图

伤后腕部肿胀、疼痛，或酸痛无力、功能障碍，活动时疼痛加剧。在韧带撕裂部有明显压痛，伤侧腕韧带牵拉试验阳性。

【取穴】（图 61）

（1）主穴：尺点。

（2）配穴：水区点、掌点（取背侧穴）。

【手法操作】

先反复点穴位后，再反复作腕部背伸、掌屈、内外旋转活动。若挫伤瘀肿，则局部的穴位禁止点按，并酌情配合中药外治。

四十三、桡骨茎突腱鞘炎

桡骨茎突部位的腱鞘，因劳损或风寒刺激，发生创伤性炎症改变，称为桡骨茎突腱鞘炎。

手腕部过度劳累可导致本病的发生。如家庭妇女、木工、钢板誊写员等，因工作性质使外展拇长肌及伸拇短肌的肌腱在共同的腱鞘发生损伤性炎症，造成纤维管道的充血水肿、肥厚、管腔变窄、肌腱在管内滑动困难，而产生相应症状。

有慢性劳损史，腕部桡侧疼痛，握物无力，活动或受寒冷刺激时疼痛加剧，疼痛可向手部及前臂放射，桡骨茎突处

有明显压痛，局部可有轻度肿胀，可摸到肥厚的腱鞘，握拳尺偏试验可引起桡骨茎突处明显疼痛。

【取穴】（见图 61）

（1）主穴：水区点。

（2）配穴：掌点、尺点、臂水沟。

【手法操作】

反复点穴后，再拔伸第一、二、三指。

四十四、腕管综合征

腕管综合征是指正中神经在管内受到压迫，并引起桡侧三个半手指麻木等神经症状的疾病。

腕部外伤，包括骨折、脱位、扭挫伤等，引起腕横韧带增厚；或腕管内各侧肌腱周围发生炎性变化，滑膜鞘增生，体积增大；或腕管内在的脂肪瘤、腱鞘囊肿等而引起腕管内容物增多，均可导致腕管的相对狭窄，使正中神经在腕管内受压，而发生神经刺激症状。部分患者无外伤史，可为慢性劳损等因素引起。

桡侧三个半手指感觉异常、麻木、刺痛，夜间症状加剧，影响睡眠；手腕部温度增高时，疼痛更为明显。手甩动后，手指麻木刺激减轻。寒冷季节患指可有发冷、紫绀等改变。按压腕横韧带部或尽量背伸腕关节时，可使症状明显加剧。病程长者，可有大鱼际肌的萎缩。

【取穴】（见图 61）

（1）主穴：尺点。

（2）配穴：臂水沟、掌点。

【手法操作】

先反复点穴位后，屈伸腕关节，再拔伸第二、三、四指，术后用洗伤药酒涂擦患处，并用大鱼际肌揉摩患处。

四十五、髌部扭挫伤

因外力导致髌部软组织的扭伤、牵拉或挫伤称为髌部扭挫伤。

多因摔跤或从高处坠下时，髌关节过度收、展、屈、伸而致。其周围肌肉和韧带可能被撕裂或断裂，圆韧带、关节囊水肿或发生嵌顿等现象。

受伤后局部疼痛、肿胀，功能障碍，患肢呈保护性姿态，

如跛行、拖拉步态、骨盆倾斜等，患侧腹股沟部有明显压痛及轻度肿胀，在股骨大粗隆后方亦有压痛，髌关节各方向运动时，均出现疼痛加剧。

【取穴】（图 62）

（1）主穴：血筋。

（2）配穴：髌点、股点、腿点、前灵点。

【手法操作】

先点血筋穴，后点其他穴位，反复施术后嘱患者活动髌关节。若挫伤瘀

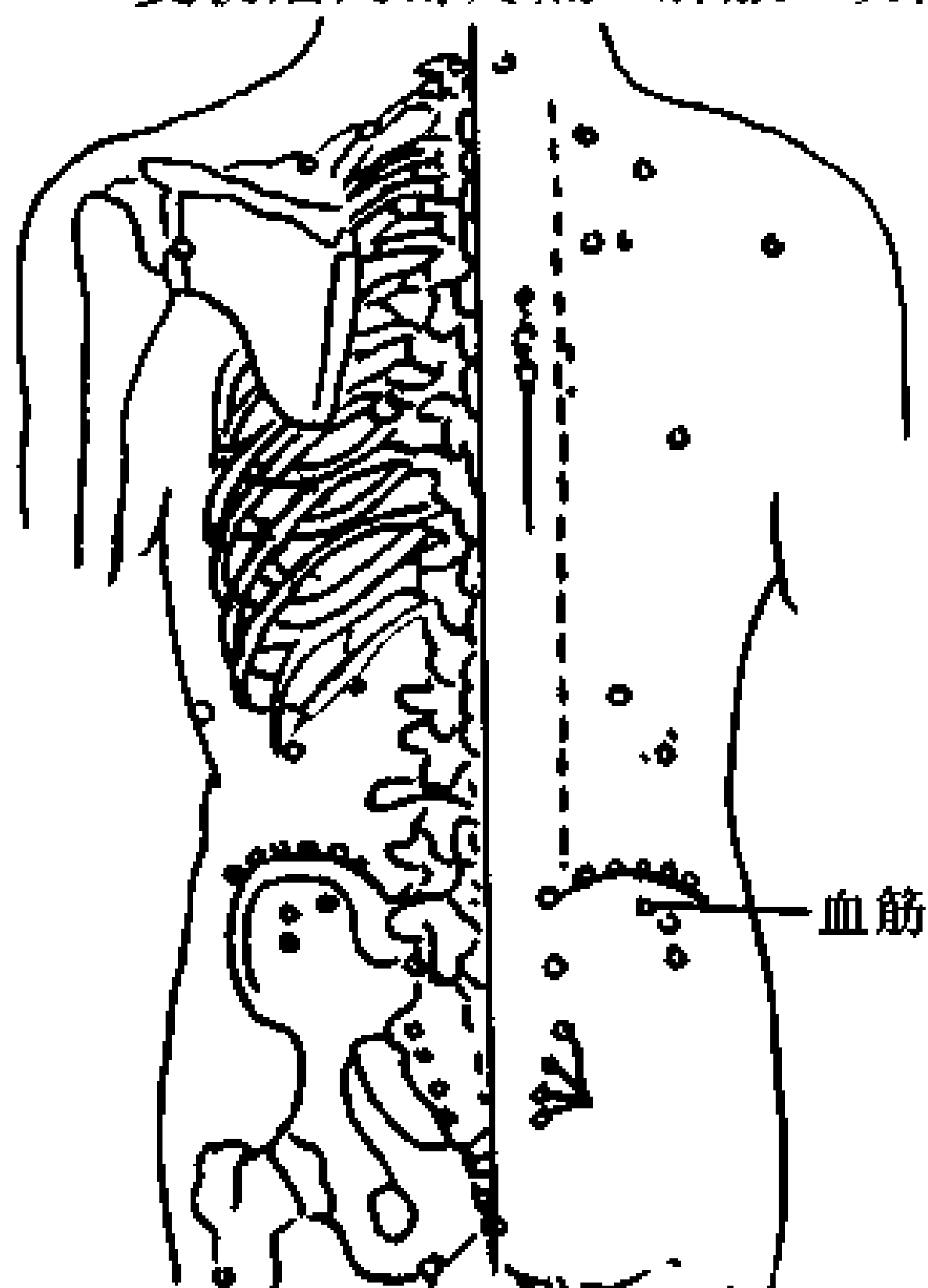


图 62-1

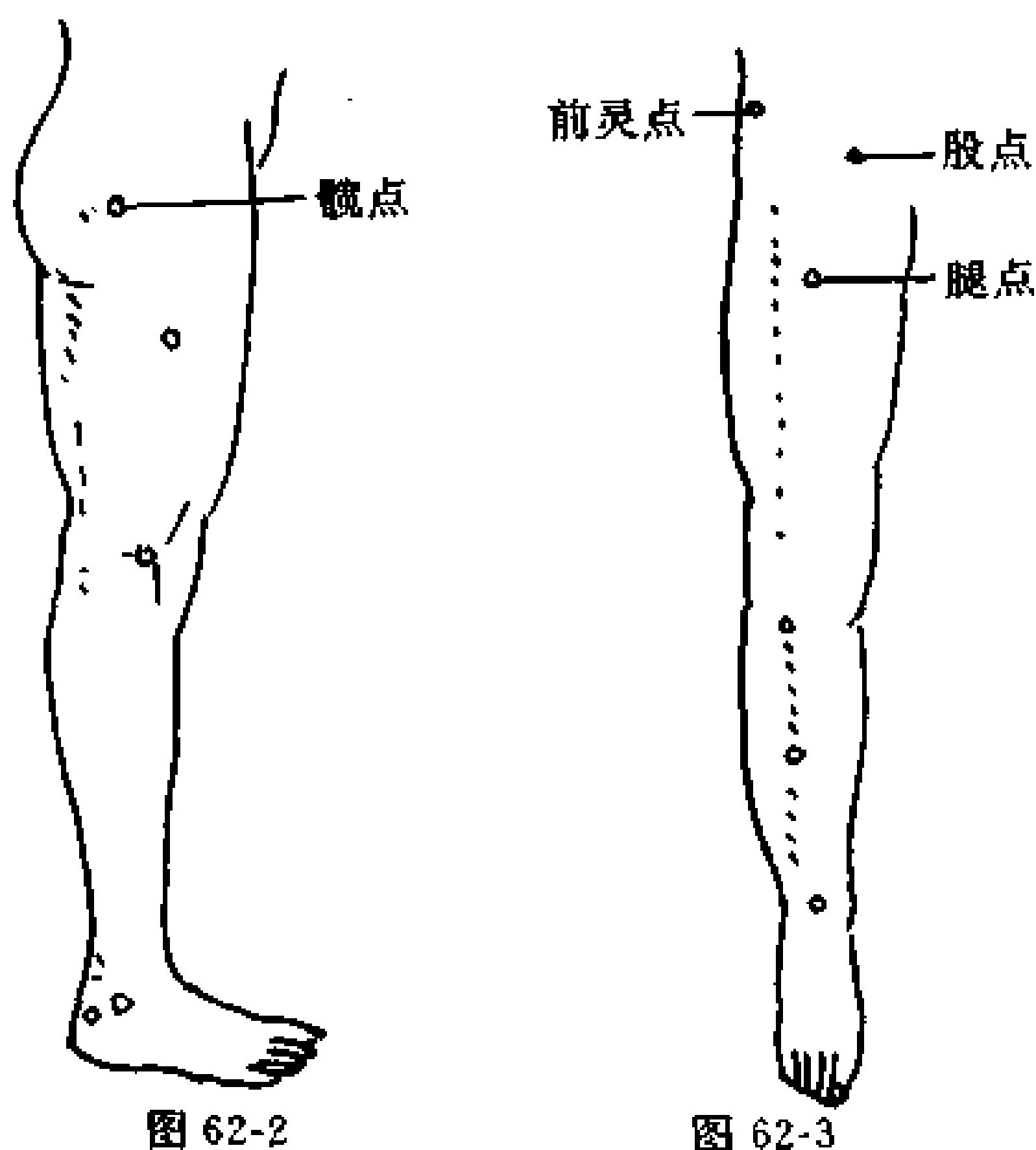


图 62 髌部扭挫伤取穴图

肿、疼痛较甚者，可酌情配合中药内治。

四十六、股内收肌损伤

股内收肌受到直接暴力或间接暴力作用而引起的损伤，称为股内收肌损伤。

外来的暴力使大腿突然过度外展，超过了股内收肌肌纤维的弹性限度，引起肌纤维部分断裂，或在起始点部位发生撕脱性损伤。股内收肌也可受直接暴力引起挫伤，也可因长期用力内收大腿引起内收肌的劳损。损伤部位可渗血或出血，治疗不及时或治疗不当，日久肌纤维发生机化；损伤部位的

粘连，刺激闭孔神经引起内收肌反射性痉挛；损伤严重者可因损伤处出血多而形成血肿，促使肌纤维加速机化。同时，也可发生肌纤维骨化，形成骨化性肌炎，从而严重影响下肢功能活动。

有股内收肌的扭伤、挫伤或劳损史。大腿内侧疼痛尤以耻骨部位疼痛为甚。大腿内收、外展活动时疼痛、功能障碍。股内收肌痉挛、压痛，耻骨部内收肌起点压痛最为明显。髋关节被动外展疼痛明显，内收肌抗阻试验阳性。若发生骨化性肌炎，则X线片可显示内收肌部位有钙化阴影。

【取穴】（图 63）

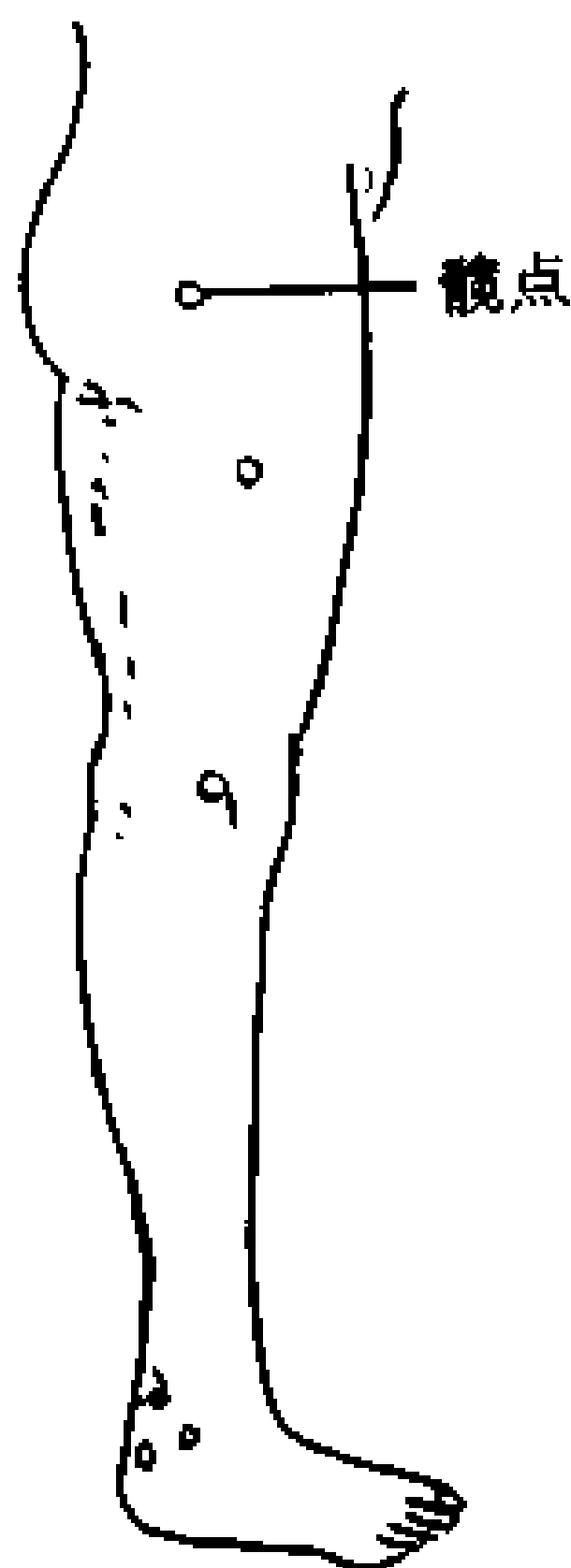


图 63-1

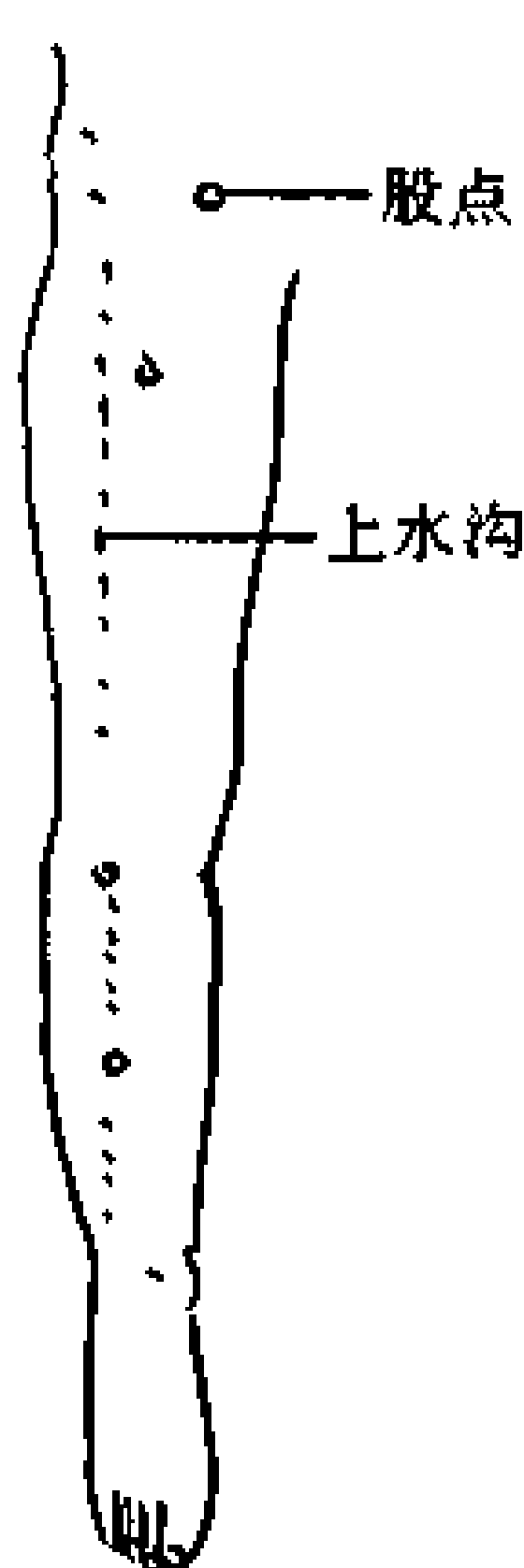


图 63-2

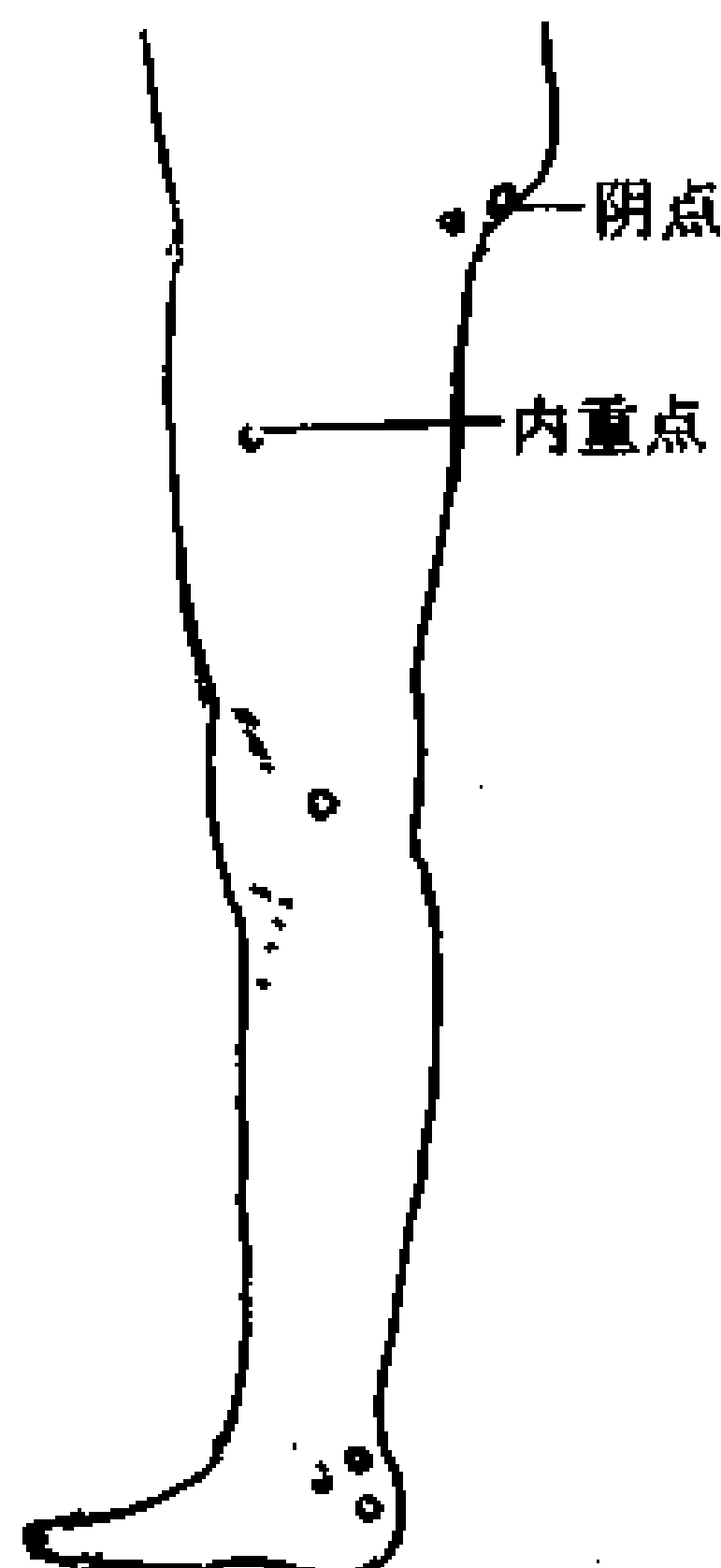


图 63-3

图 63 股内收肌损伤取穴图

(1) 主穴：血筋。

(2) 配穴：股点、髌点、内重点、上水沟、阴点。

【手法操作】

先点血筋穴，再反复点其它穴位，手法不宜过重。

四十七、股四头肌扭挫伤

股四头肌受到直接暴力或间接暴力引起的损伤，称为股四头肌扭挫伤。

由于剧烈或突然的踢物，如踢足球、起跑或冲刺时，股

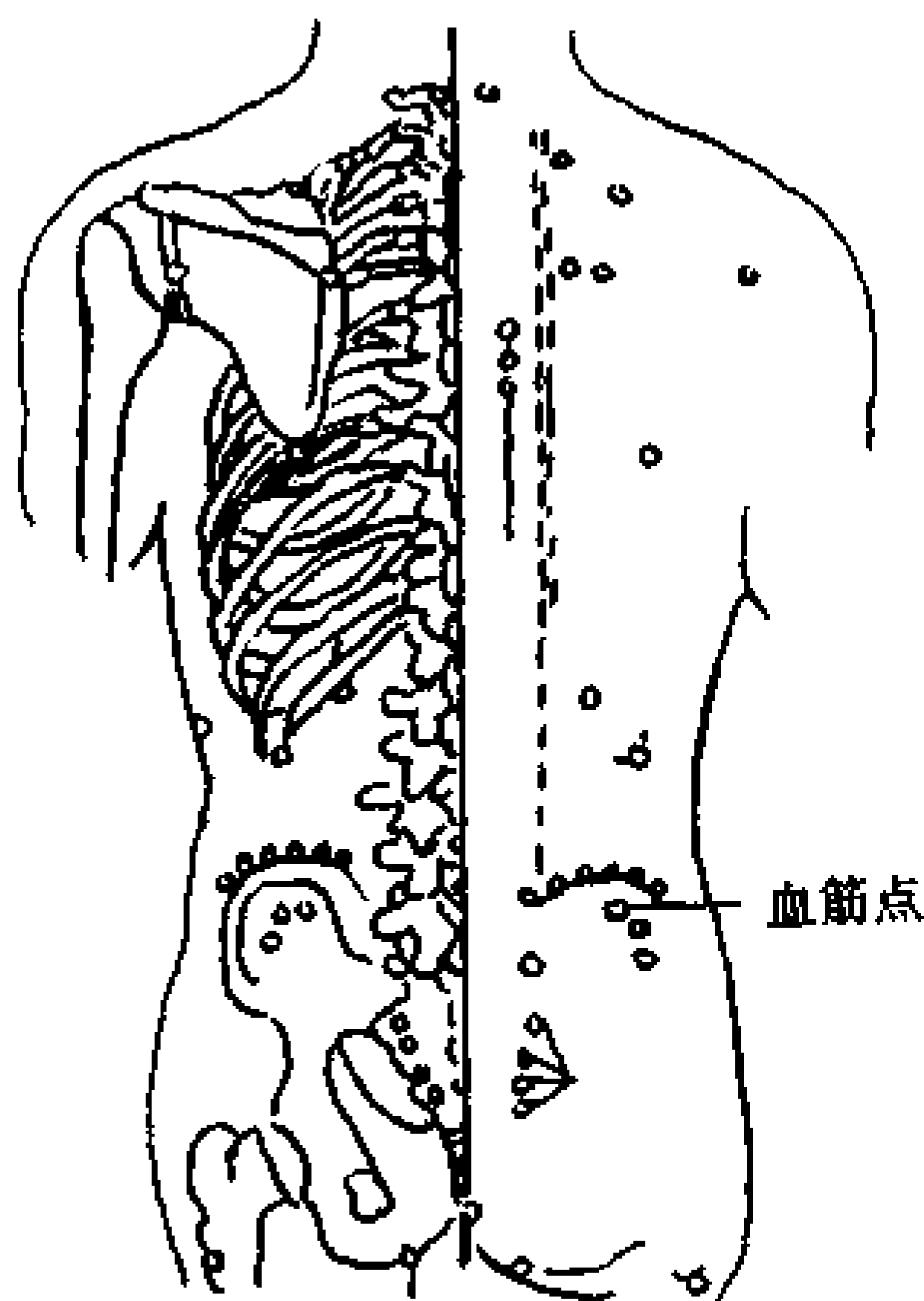


图 64-1

四头肌猛烈收缩，或过度被动牵拉，都可引起股四头肌的扭伤，尤其是起点部位髌前下棘处的拉伤。外来的直接暴力打、砸、碰、撞等作用于大腿前面时，均可引起股四头肌的挫伤。股四头肌扭挫伤后，局部出血，肿胀明显，肿胀可刺激神经而疼痛，使肌肉收缩能力降低，从而影响到髌膝关节的屈伸功能。

伤后患处疼痛，肿胀，局部压痛明显。髌

膝关节活动功能障碍，走路呈跛行。屈髋伸膝的股四头肌抗阻试验阳性。

【取穴】（图 64）

（1）主穴：血筋点。

（2）配穴：外重点、上水沟、上水区点。

【手法操作】

先反复点血筋，再点其他穴位。若挫伤局部瘀肿，可酌情配合中药外治。

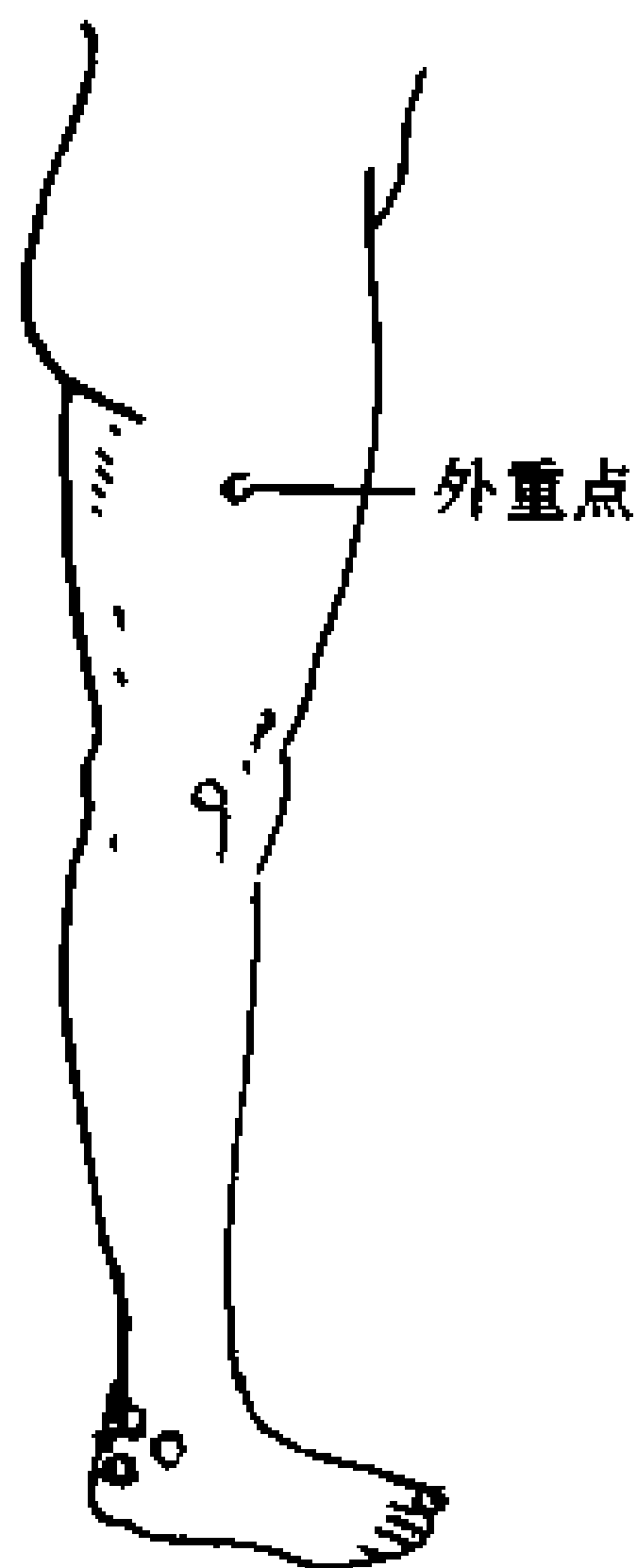


图 64-2

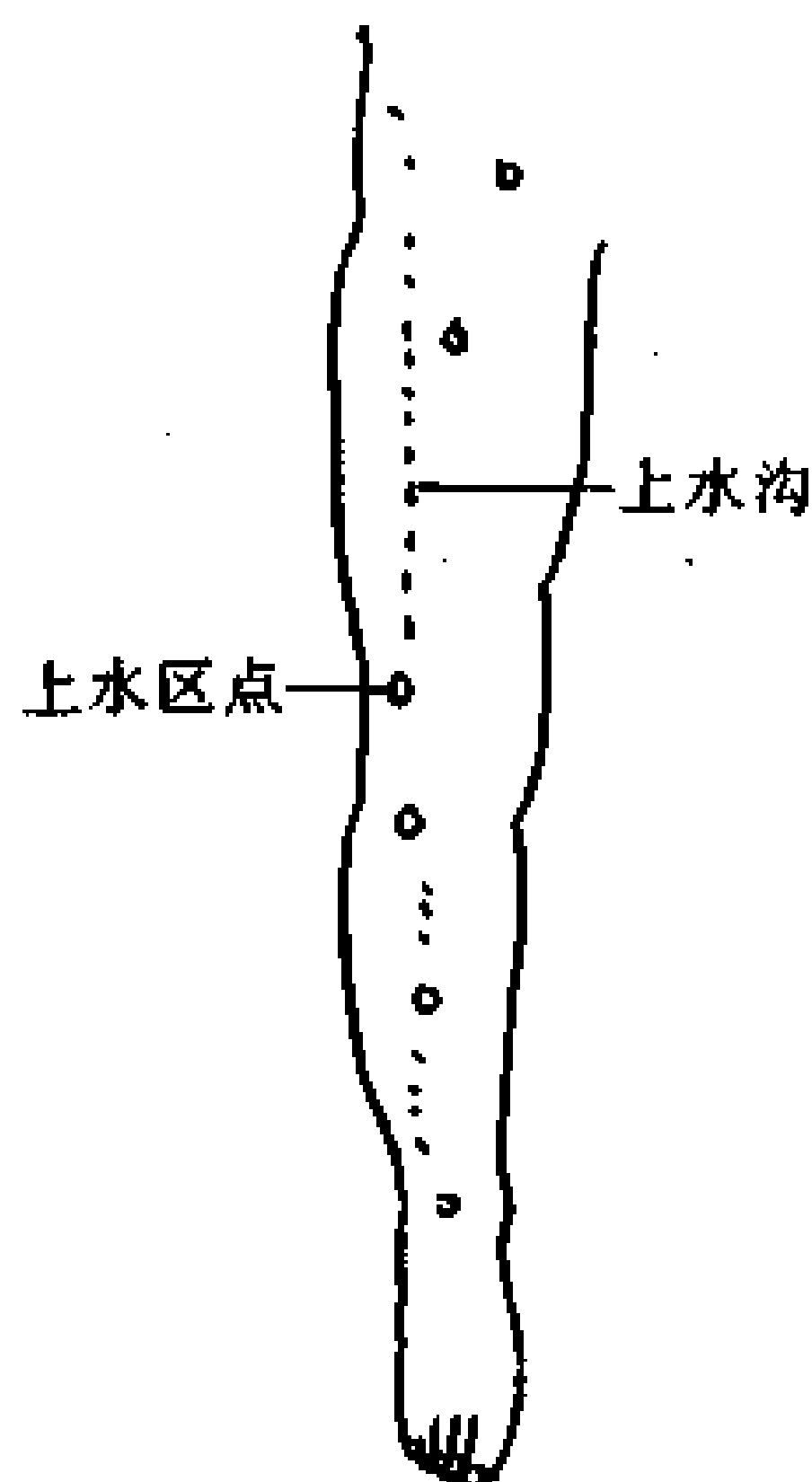


图 64-3

图 64 股四头肌扭挫伤取穴图

四十八、腘绳肌拉伤

腘绳肌的猛烈收缩，或受到过度牵拉，使腘绳肌起止点或肌腹、肌腱受到部分撕裂伤者，称为腘绳肌拉伤。

由于过伸性牵拉而发生损伤，如踢腿、劈叉、压腿、跑跳或走路蹬空，均可造成腘绳肌牵拉，而引起坐骨结节腘绳肌附着点的撕裂伤，以及肌腹、肌腱和止点处的撕裂伤。

有明显的大腿后侧拉伤史，伤时可听到撕裂声，伤后在大腿后侧肌群有发紧和疼痛感。伤轻者，疼痛局限，行走时疼痛；重复拉伤动作时，疼痛加剧。伤重者，疼痛剧烈，步履艰难，有时疼痛可向大腿周围放射。检查时可见大腿后侧皮下瘀血肿胀、压痛，肌肉痉挛；让患者屈曲小腿，作腘绳肌抗阻试验为阳性。

【取穴】（图 65）

（1）主穴：上水沟。

（2）配穴：膝点，膝内、外 1/3 点。

【手法操作】

先反复点穴位后，再行髌骨旋转法。若疗效不明显，可加点血筋穴。

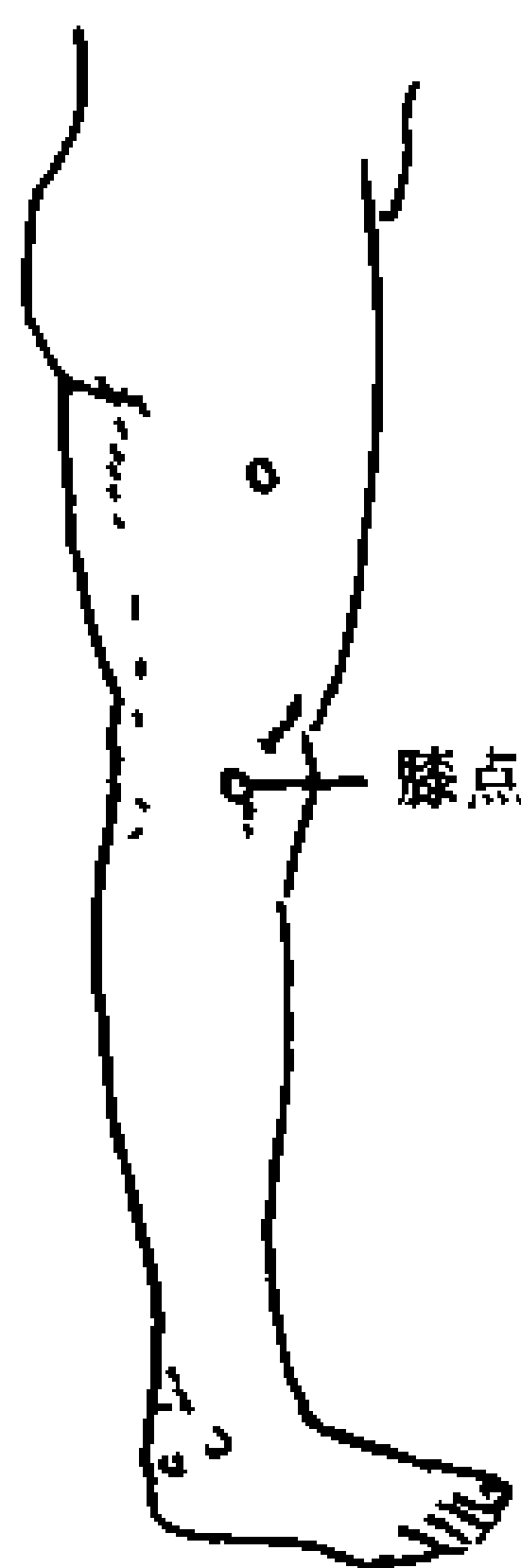


图 65-1

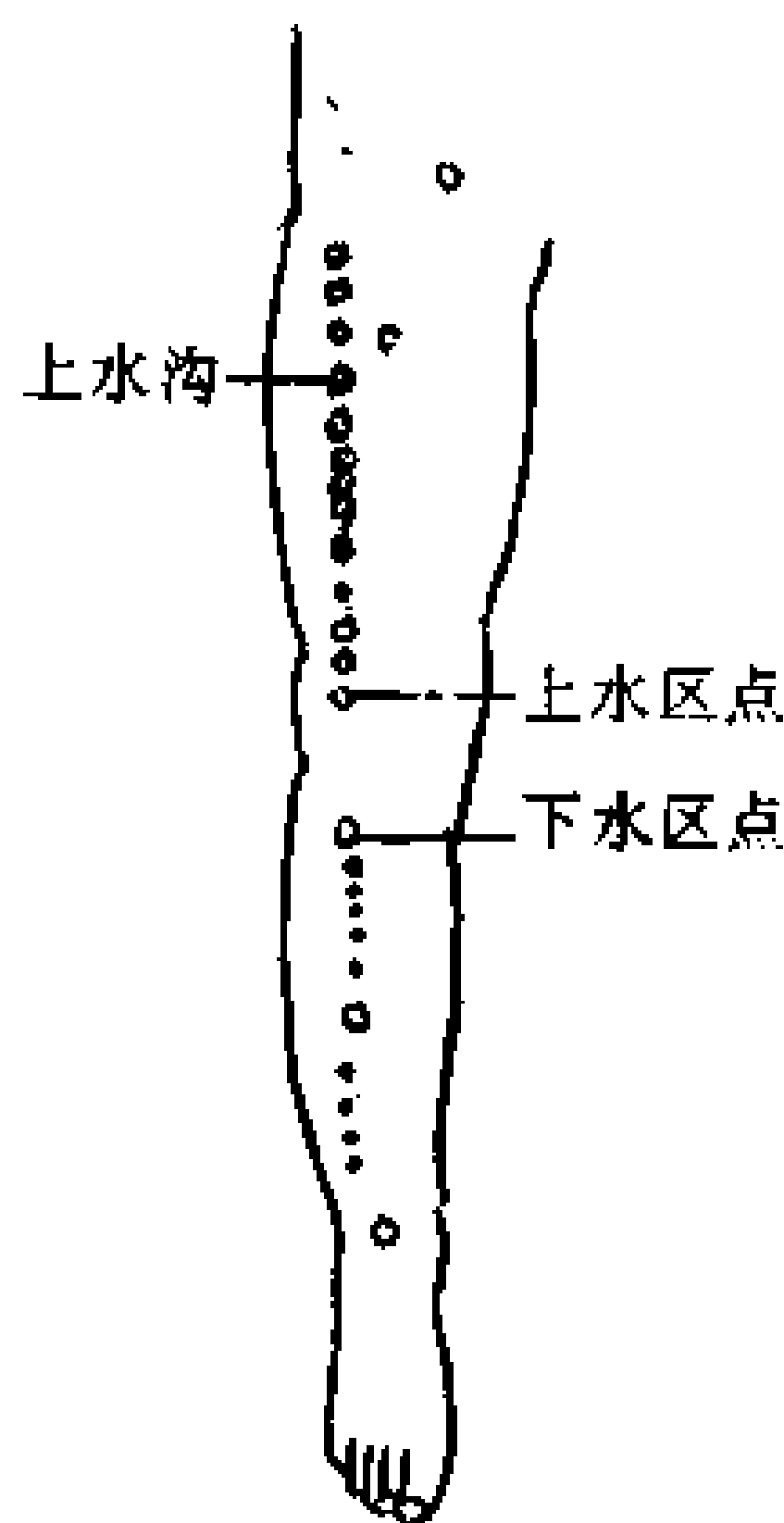


图 65-2

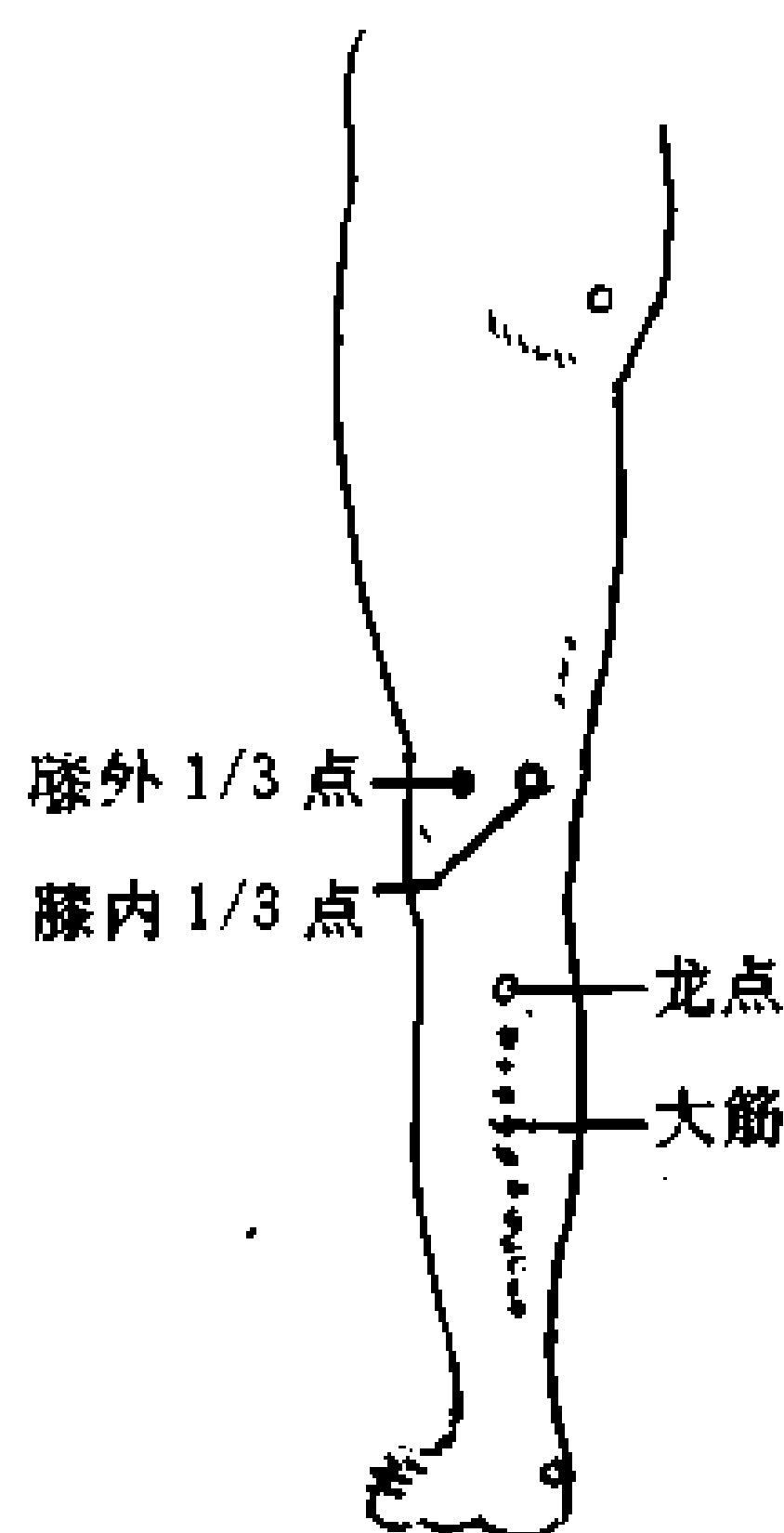


图 65-3

图 65 腓绳肌拉伤、膝关节侧副韧带损伤、髌骨软化症取穴图

四十九、膝关节侧副韧带损伤

膝关节外伤后，引起侧方韧带性损伤、关节不稳及疼痛者，称为膝关节侧副韧带损伤。

膝关节微屈时稳定性相对较差，外伤暴力造成膝关节过度内翻或外翻，使得被牵拉的韧带超出生理负荷，而发生拉伤、撕裂等损伤。由于膝关节呈现生理外翻（约 $0^{\circ} \sim 10^{\circ}$ 范围），且膝外侧易受到外力的冲击，使膝过度外翻，故临床上

内侧副韧带损伤占绝大多数，根据伤力大小而发生内侧副韧带不全断裂或完全断裂，以及合并半月板、前十字韧带损伤等。

伤后局部肿胀、疼痛，可有瘀斑，压痛明显，膝关节屈伸功能障碍。内侧副韧带损伤时，压痛点在股骨内上髁；外侧副韧带损伤时，压痛点在腓骨小头或股骨外上髁。侧副韧带分离试验阳性。

【取穴】（见图 65）

（1）主穴：大筋。

（2）配穴：上、下水区点，膝内、外 1/3 点。

【手法操作】

先反复点穴位后，再行髌骨旋转法，并作膝关节屈伸活动。若内侧扭伤加内重点、风湿点；外侧扭伤加外重点、膝点。膝关节炎的多数患者可在髌骨中心偏外上方寻找条索状阳性物进行点刮（施术时患者的关节腔有酸痛之感）。若膝关节不能伸直、腘窝部酸痛，可加点泉公穴、龙点，并揉按大筋穴。

五十、髌骨软化症

由多种原因引起髌骨软骨损伤和退行性病变，称为髌骨软化症，亦称髌骨劳损。

膝关节处于半屈曲位，反复多次屈伸旋转，髌骨和股骨关节面之间反复摩擦，互相错动、撞击，致使软骨关节面被磨损而致本病。如田径、登山运动员、舞蹈演员等膝部的过度伸屈活动，使髌股之间长期猛烈磨损而引起劳损。与此同

时，关节滑膜及髌韧带也可有一定程度的充血、渗出增加等变化。

膝部疼痛，上下楼或半蹲位时加重。有时可出现“假交锁”征象，轻微活动，在髌下出现清脆响声，即可解锁，这是髌软骨面不平引起的。有时出现“软腿”征象，髌骨研磨试验阳性，挺髌试验阳性，髌下脂肪垫压痛阳性等。

【取穴】（见图 65）

（1）主穴：龙点。

（2）配穴：上、下水区点，上水沟（取前侧），膝点，大筋。

【手法操作】

先反复点穴位后，再行髌骨旋转法，手法宜轻。嘱患者膝部宜保温，忌用冷水冲浴。

五十一、膝关节创伤性滑膜炎

膝关节外伤或多种原因刺激后引起滑膜损伤或破裂，使滑膜发生多量渗出液，积聚于关节腔内，称为膝关节创伤性滑膜炎。

膝关节是全身关节中滑膜面积最大者，广泛布满整个膝关节囊的内面。由于膝部损伤或手术刺激，以及积累性损伤等因素损伤或刺激滑膜，使之充血、渗出，产生大量积液。由于渗出物增多，关节内压增高，阻碍淋巴回流，形成恶性循环。同时，积液日久，纤维素沉着，则易发生纤维性机化，关节滑膜在长期慢性刺激下逐渐增厚，引起粘连，影响关节活动，由于股四头肌日久萎缩，使关节不稳定。

新伤者，膝关节肿胀严重，髌上囊膨隆，膝关节自动伸直和被动屈曲，均可加剧疼痛。病程较久者，则以关节内积液为其特点，膝部酸胀钝痛，肿胀不消，浮髌试验阳性。

【取穴】（图 66）

- （1）主穴：风湿点。
- （2）配穴：上、下水区点，膝点，大筋，上水沟（取前侧）。

【手法操作】

反复点穴位后，再行髌骨旋转法。手法宜轻，施术后用洗伤药酒擦患处。

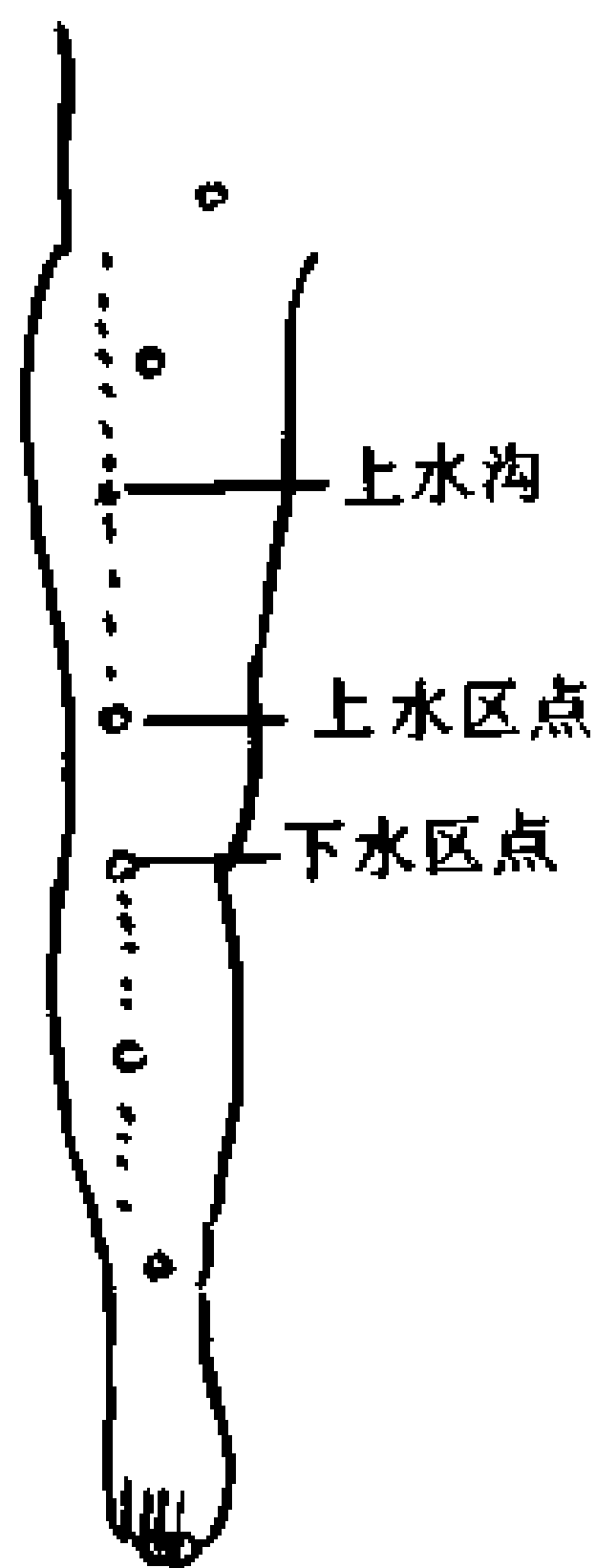


图 66-1



图 66-2

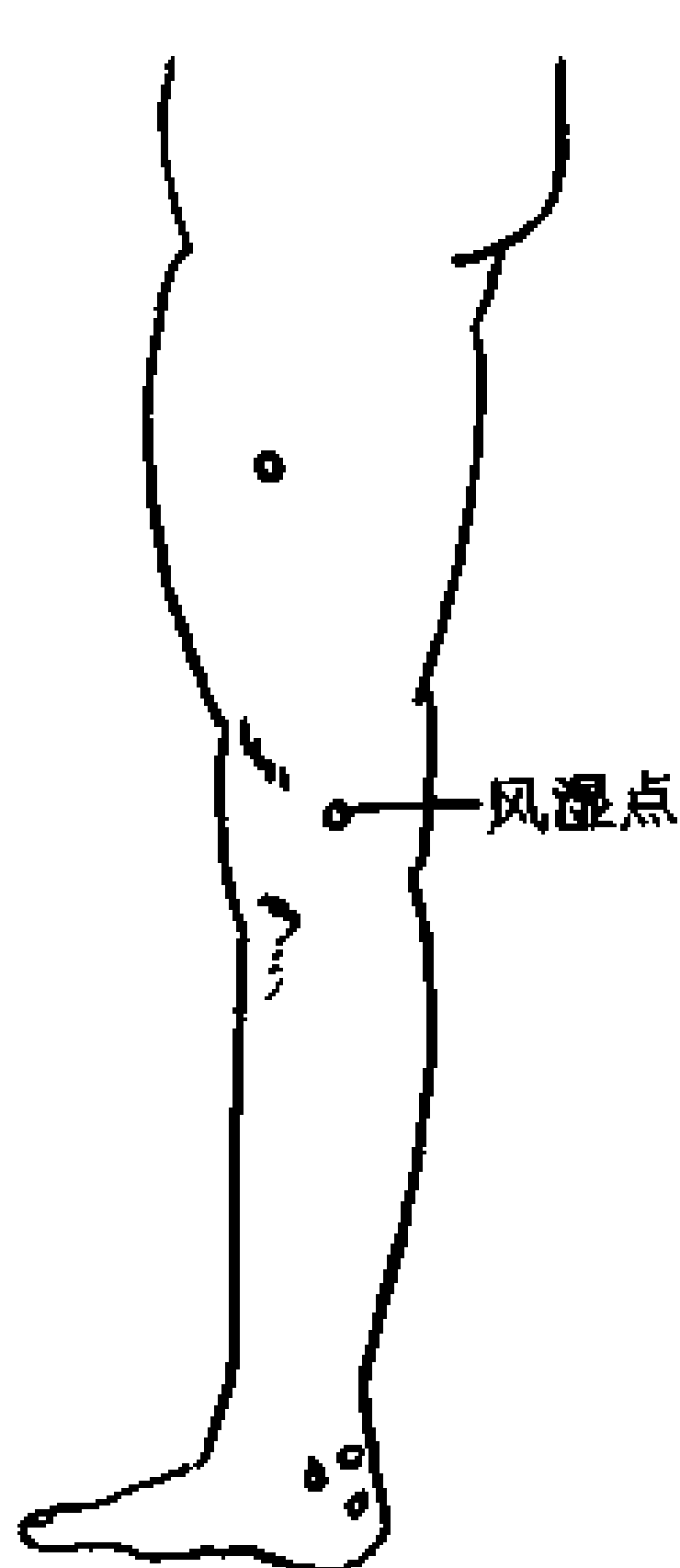


图 66-3

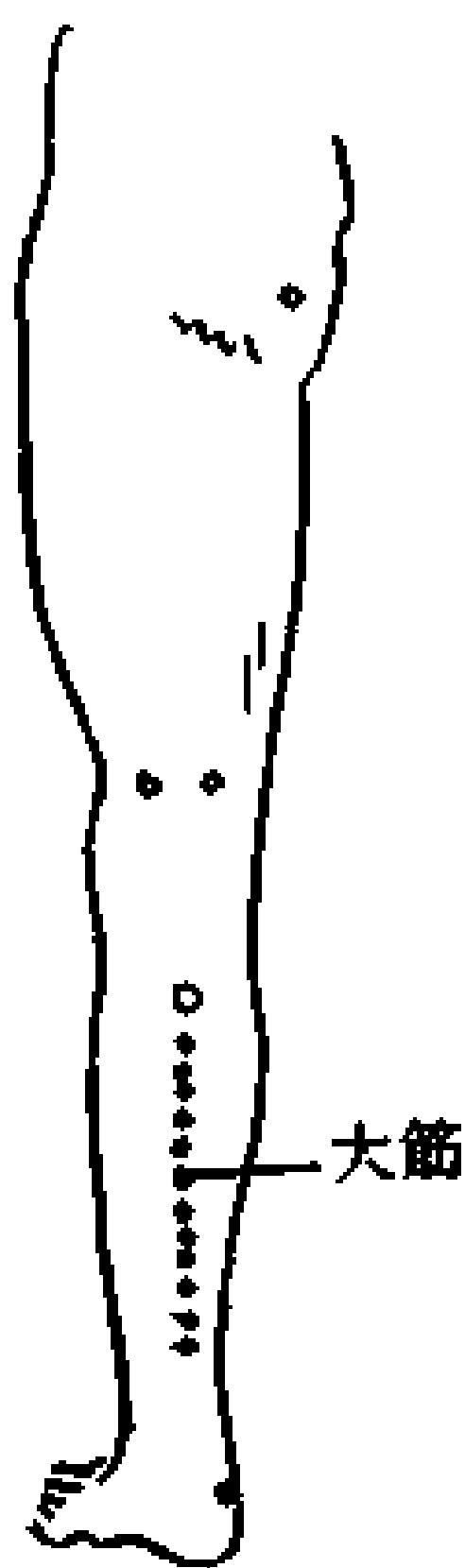


图 66-4

图 66 膝关节创伤性滑膜炎取穴图

五十二、腓肠肌损伤

腓肠肌因过度牵伸或慢性劳损而致损伤，称为腓肠肌损伤。

常因肌肉强力收缩，如网球及篮球运动员强力的弹跳，或踝关节过度背伸，或长期慢性劳损而致伤。多为牵拉性损伤，少见部分断裂。损伤部位可发生于腓肠肌在股骨二髁之附着部、跟腱附着部以及肌与腱的联合部。

急性损伤者，伤后局部肿胀、疼痛，压痛明显。大多数

发生在肌腱联合处，一般有广泛皮下瘀斑，并可触及断裂部失去连系的间隙。肌腱固有的条索弹性感消失，患者多以足尖着地行走，不敢用全足负重，严重者丧失走路的功能。如为慢性劳损，则发生于股骨髁附着部或跟腱部位，局部疼痛，肌肉萎缩，但肿胀不明显。若被动牵拉或主动收缩小腿后部肌肉时，均感觉损伤部位的疼痛，局部可触及条索状物。

【取穴】（图 67）

（1）主穴：龙点。

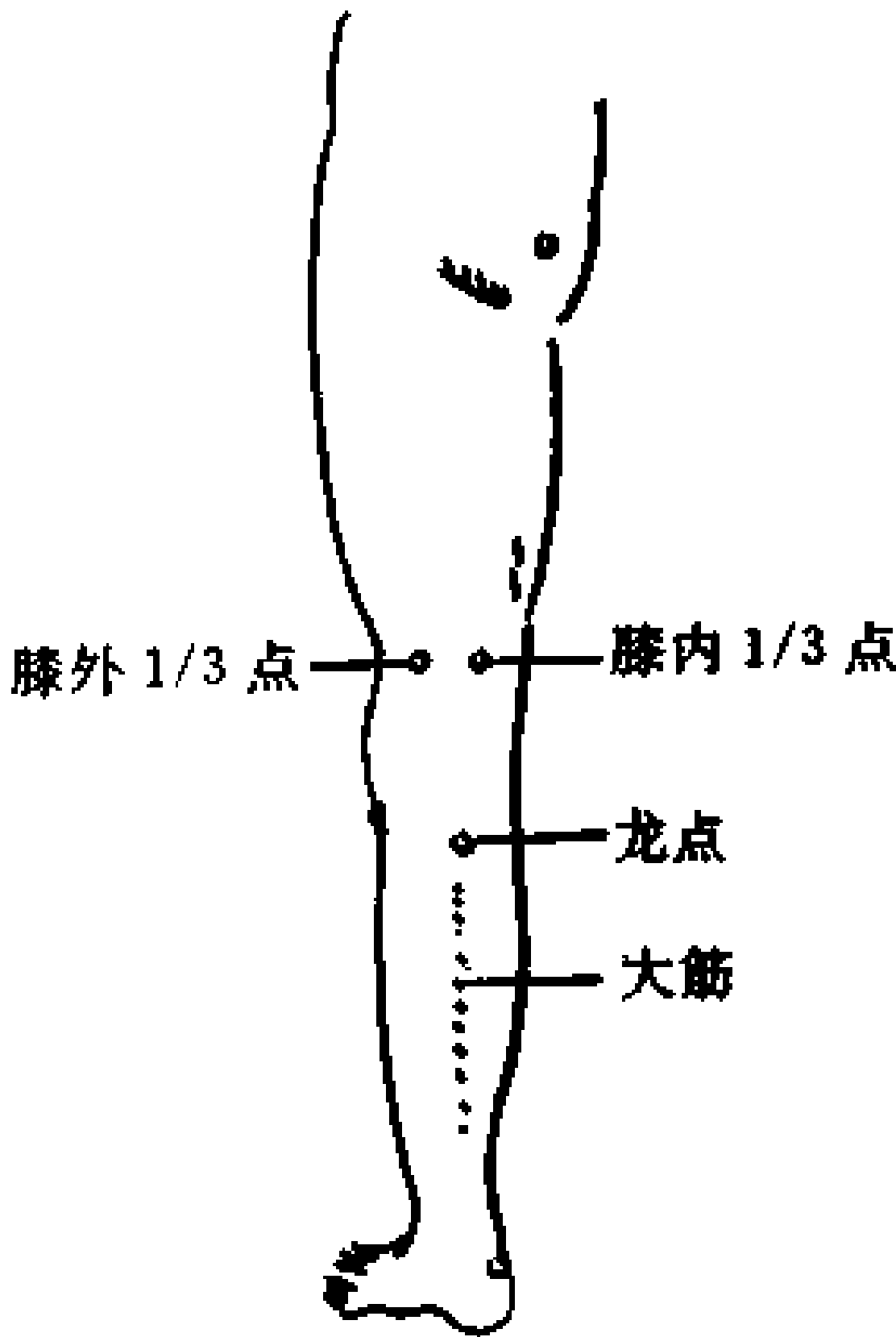


图 67-1

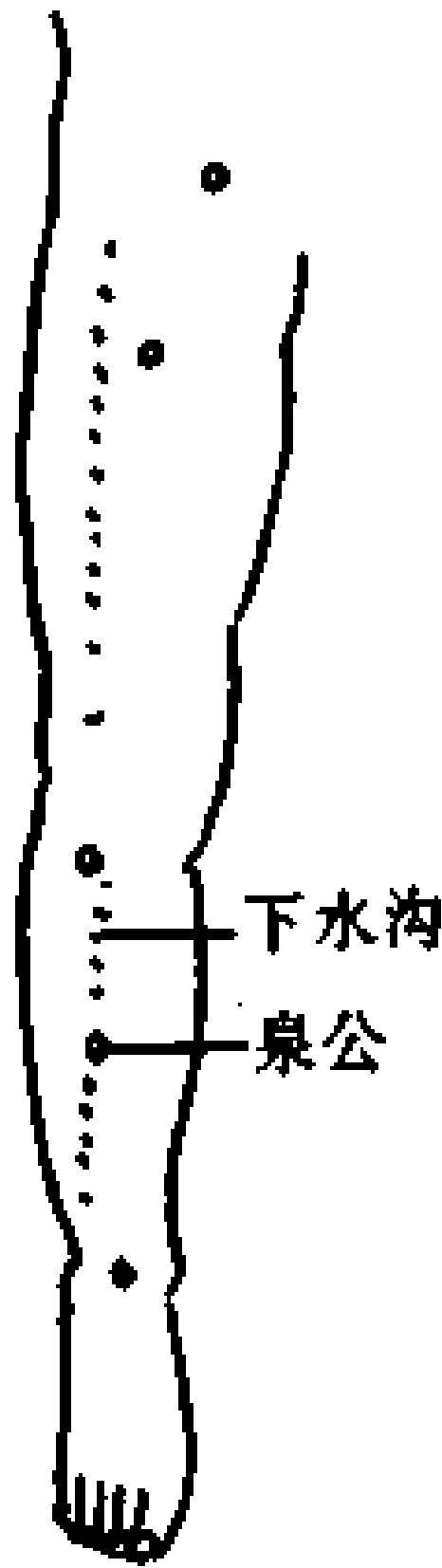


图 67-2

图 67 腓肠肌损伤取穴图

(2) 配穴：泉公，大筋，膝内、外 1/3 点，下水沟。

【手法操作】

反复点穴位后，再屈伸活动踝关节。若疗效不明显，可点跟点、挛点。

五十三、踝关节扭伤

因扭伤引起踝部筋与骨缝的损伤并除外踝部骨折、脱位者，称为踝关节扭伤。

行走不平道路，上下楼时不慎踏空，或骑车跌倒等，如踝关节处于跖屈位时，因距骨可向两侧轻微活动而使踝关节不稳定，易引起损伤。临床上分内翻扭伤和外翻扭伤两类，以前者为多见。

受伤后踝部立即出现肿胀疼痛，不能走路或尚可勉强走路，伤后 2~3 天局部可出现瘀斑。内翻扭伤时，在外踝的前下方肿胀，压痛明显，若将足部作内翻动作时，则外踝前下方产生剧痛；外翻扭伤时，在内踝的前下方肿胀，压痛明显，若将足部作外翻动作时，则内踝前下方发生剧痛。

【取穴】（图 68）

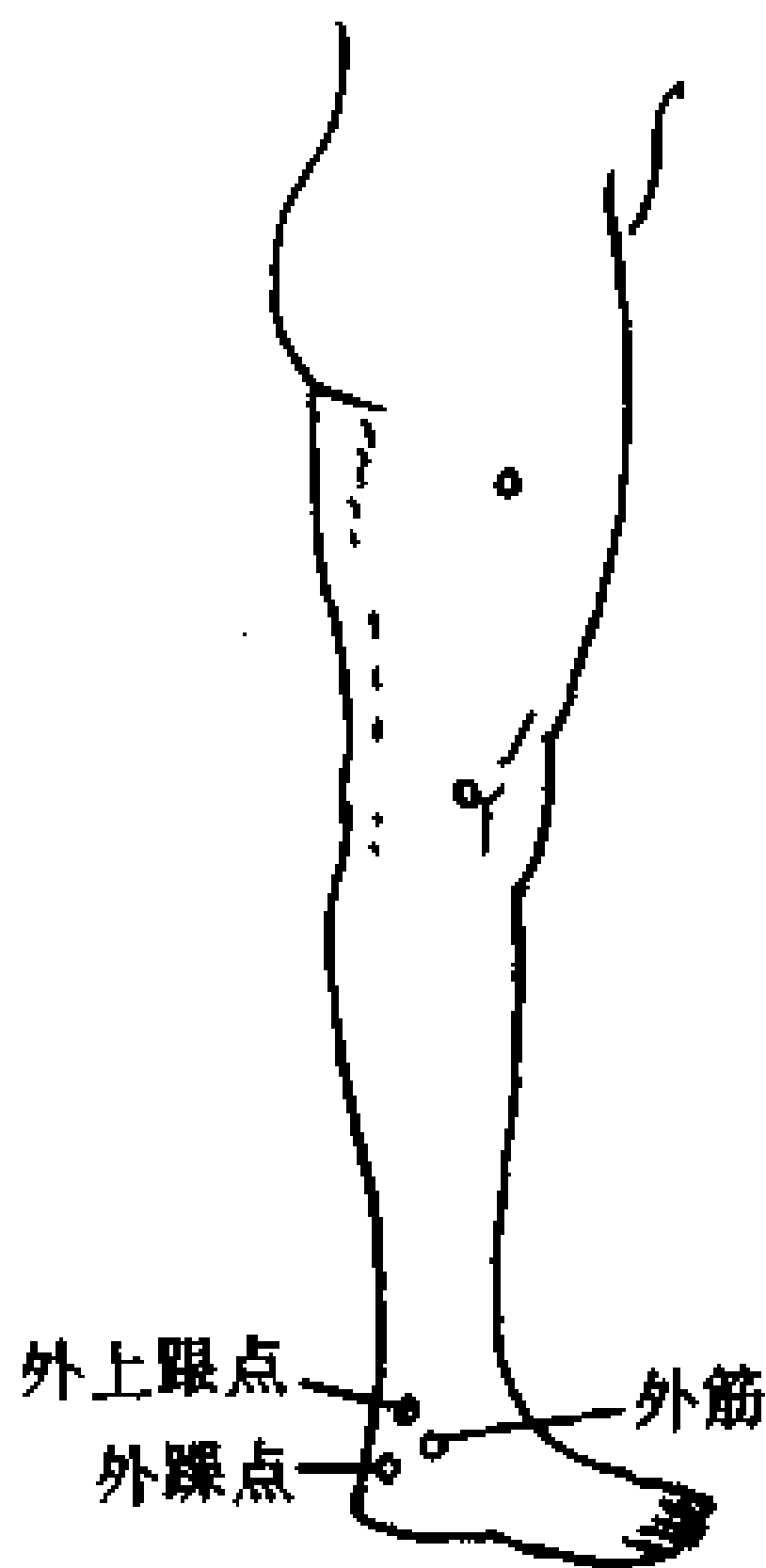


图 68-1

- (1) 主穴：大筋。
- (2) 配穴：下水沟，挛点，内、外筋，内、外上跟点，内、外踝点。

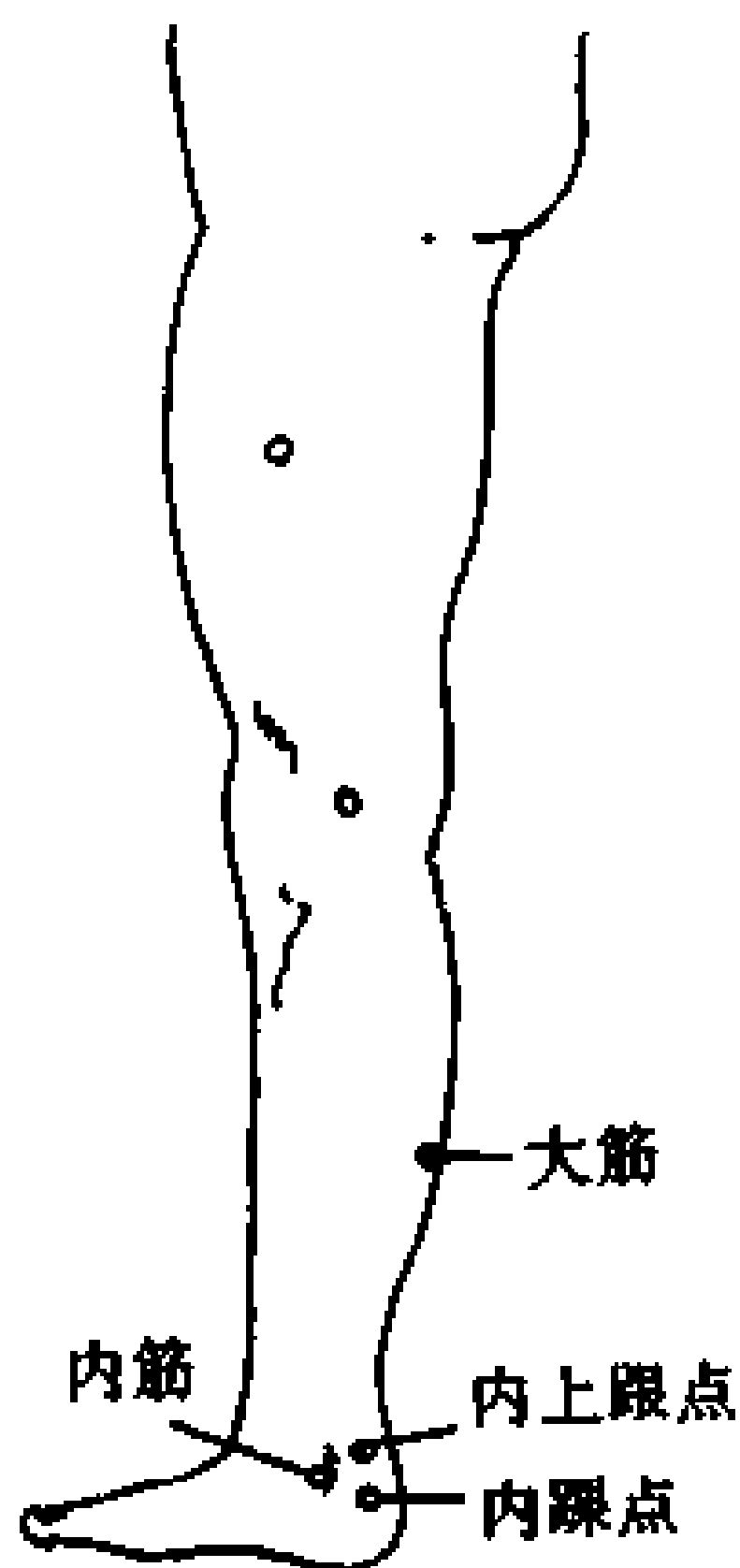


图 68-2

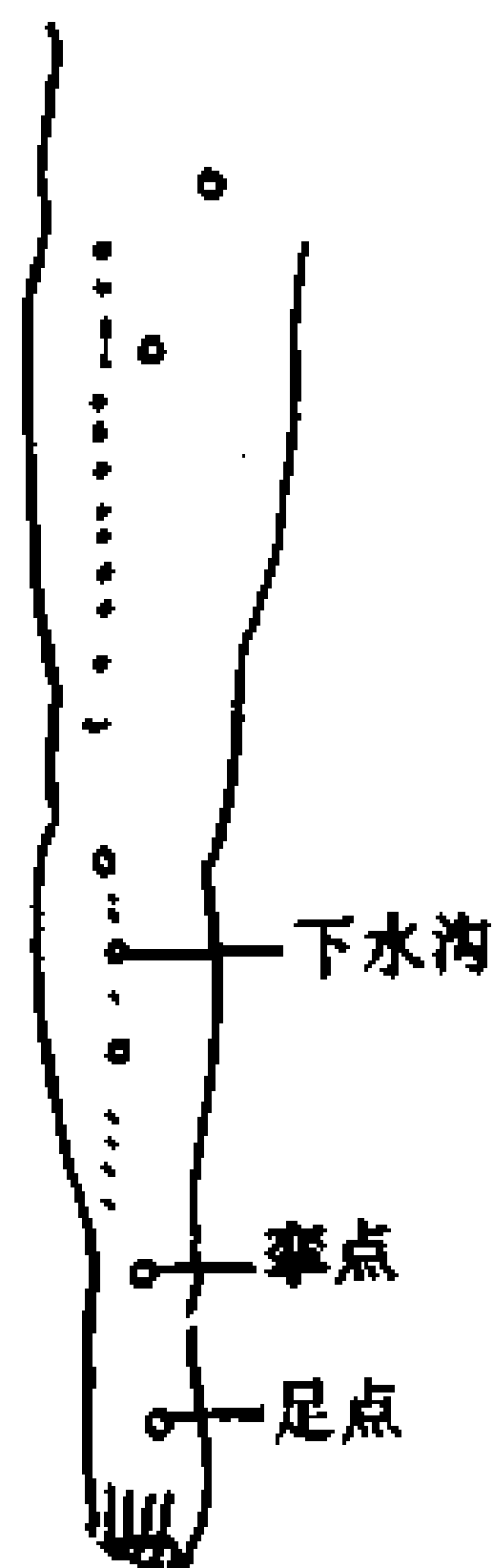


图 68-3

图 68 踝关节扭伤、跖管综合征取穴图

【手法操作】

内翻取大筋、下水沟、挛点、外上跟点、外踝点、外筋；外翻取大筋、下水沟、挛点、内上跟点、内踝点、内筋。反复点穴后，再行踝关节屈伸活动。

五十四、跖管综合征

因足部劳损或踝部损伤后引起跖管内病变,压迫神经,出现足部神经受压综合征,并除外骨与关节病变者,称为跖管综合征。

跖管为内踝的后下方与距、跟骨和屈肌支持带所构成的一个缺乏弹性的骨纤维管。管内有肌腱、神经和血管通过,由前向后排列着胫后肌腱、屈趾长肌腱、胫后神经和胫后动静脉、屈拇长肌腱等。若踝部扭伤、劳损,骨折畸形愈合,或发生腱鞘炎等,尤其是屈拇长肌腱受到反复牵拉,引起腱鞘充血、水肿、鞘壁增厚,使管腔相对变窄,压迫管内胫后神经而产生跖管综合征。

足底和足跟内侧疼痛、麻木,劳累后明显,休息后减轻。若病程较长可出现足底灼痛,夜间或行走后更为严重。部分患者局部可有皮肤干燥、汗毛脱落、无汗,严重者足部内在肌萎缩。压迫或叩击跖管部位,踝过度背伸或足外翻时,可使疼痛加剧。

【取穴】(见图 68)

- (1) 主穴:内、外筋。
- (2) 配穴:挛点、足点。

【手法操作】

先点穴位后,再拔伸第二、三、四足趾。

五十五、跟痛症

由于慢性损伤所引起的跟骨底面的疼痛，称为跟痛症。

跖腱膜自跟骨跖面结节起，向前伸展，止于五个足趾近侧节的骨膜上，如果长期、持续的牵拉，可在跖腱膜的跟骨结节附着处发生慢性损伤，引起局部疼痛。且常伴有跟骨结节部的前缘骨刺形成。

起病缓慢，多为一侧发病，可有数月或数年的病史。早晨起床后站立时疼痛较重，行走片刻后则疼痛减轻，但行走过久疼痛又加重。局部检查不红不肿，在跟骨跖面的跟骨结节处压痛，如跟骨骨刺较大时，可触及骨性隆起。

【取穴】（图 69）

（1）主穴：大筋。

（2）配穴：跟点，内、外上跟点，挛点。

【手法操作】

反复点穴位后，再用拇、食、中指揉捏跟部内外侧。施术后以洗伤药酒擦跟部。

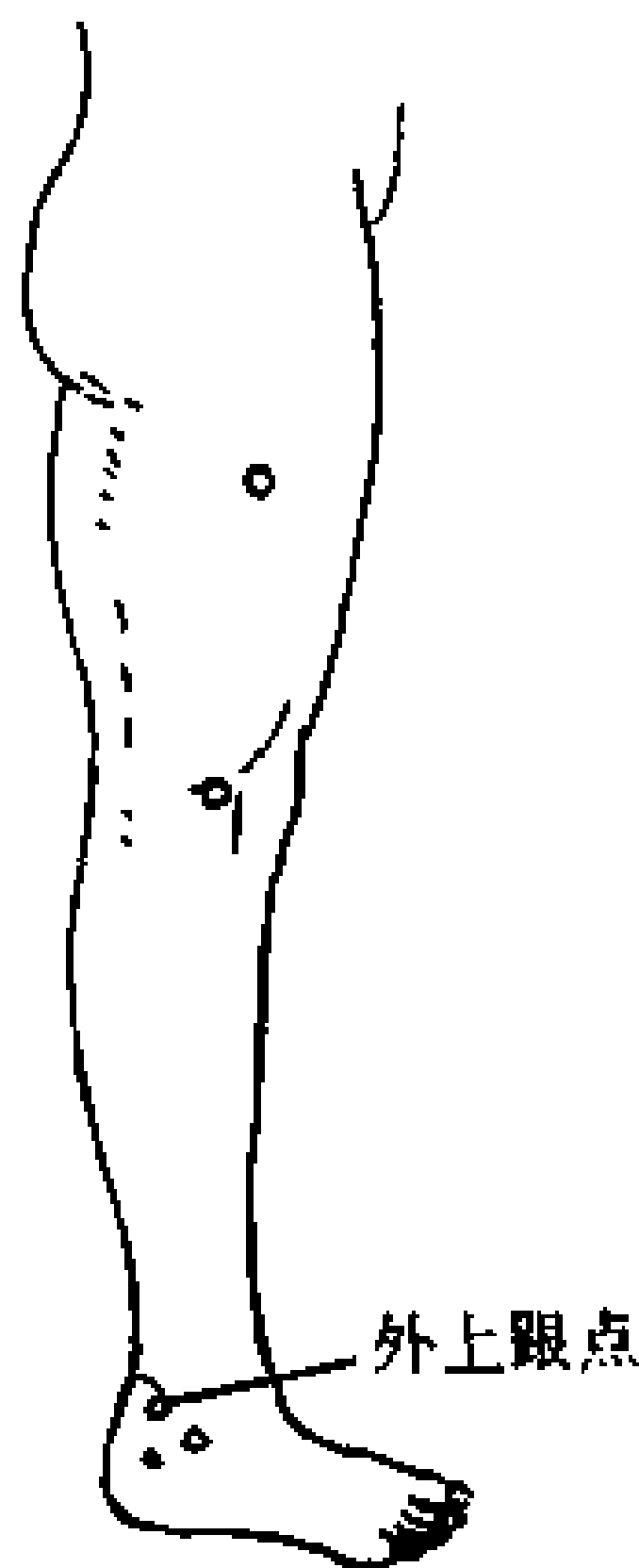


图 69-1

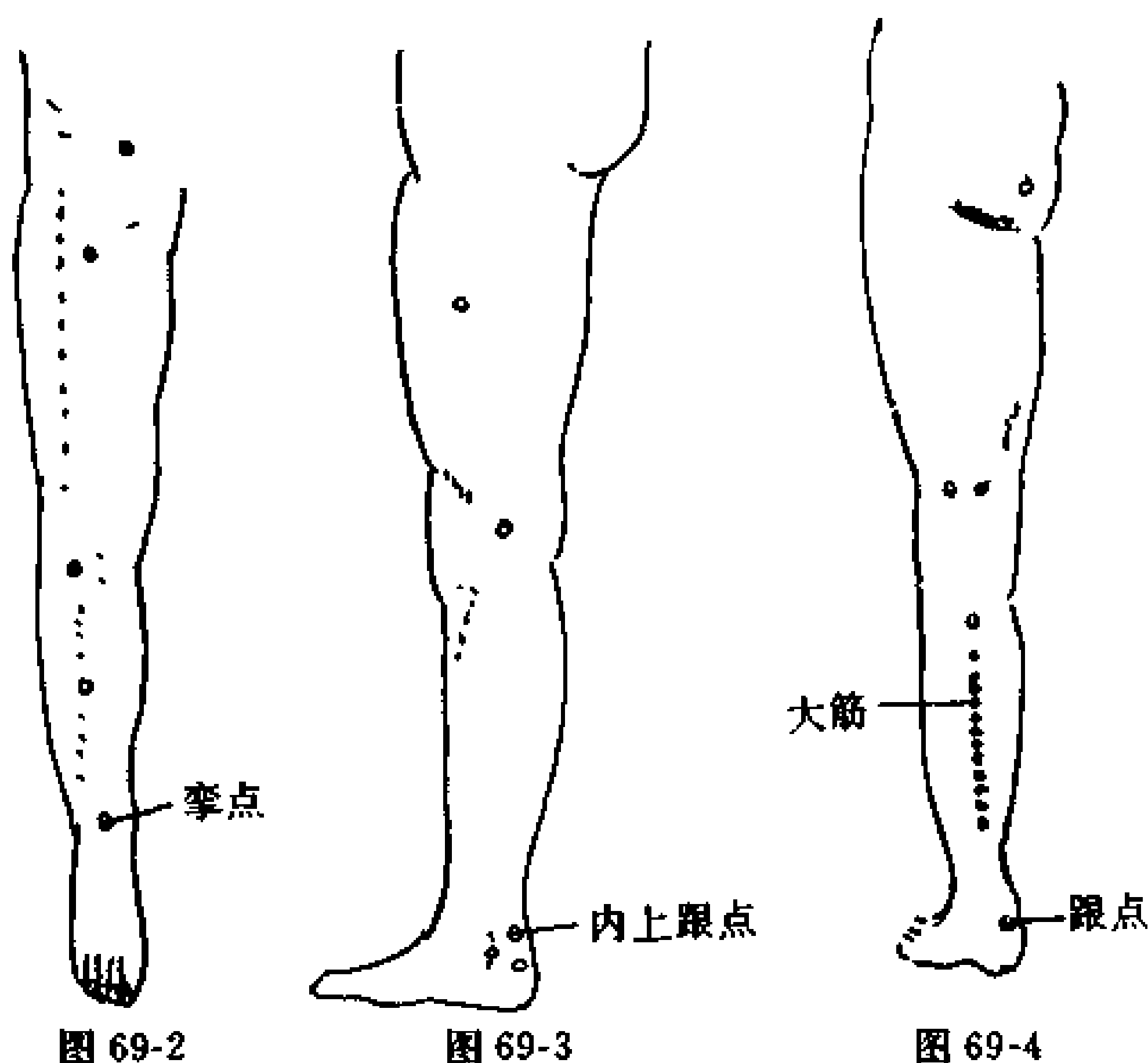


图 69 . 跟痛症取穴图

五十六、颞颌关节功能紊乱症

因外力使下颌关节突与颞下颌窝之间发生微小移动，而引起开口障碍者，称为颞颌关节功能紊乱症。

常见的有开口过大、嚼硬物、下颌体遭受打击、颞骨弓骨折或慢性炎症等，这些因素均可引起关节软骨盘损伤或破裂，嵌夹于关节间；或引起肌肉痉挛、充血、粘连，或有骨性障碍等，导致一侧关节紧张而另一侧关节松弛，造成两个关节同时向侧方微小错动，而影响口的并合。

患者开口受限，咬合不严，语音失常，双颞颌关节有酸痛感，局部无肿或轻肿，双侧颞颌关节部疼痛，患侧较重，肌肉紧张板硬。

【取穴】（图 70）

（1）主穴：椎点。

（2）配穴：颌点、咬点、垂点、咪点。

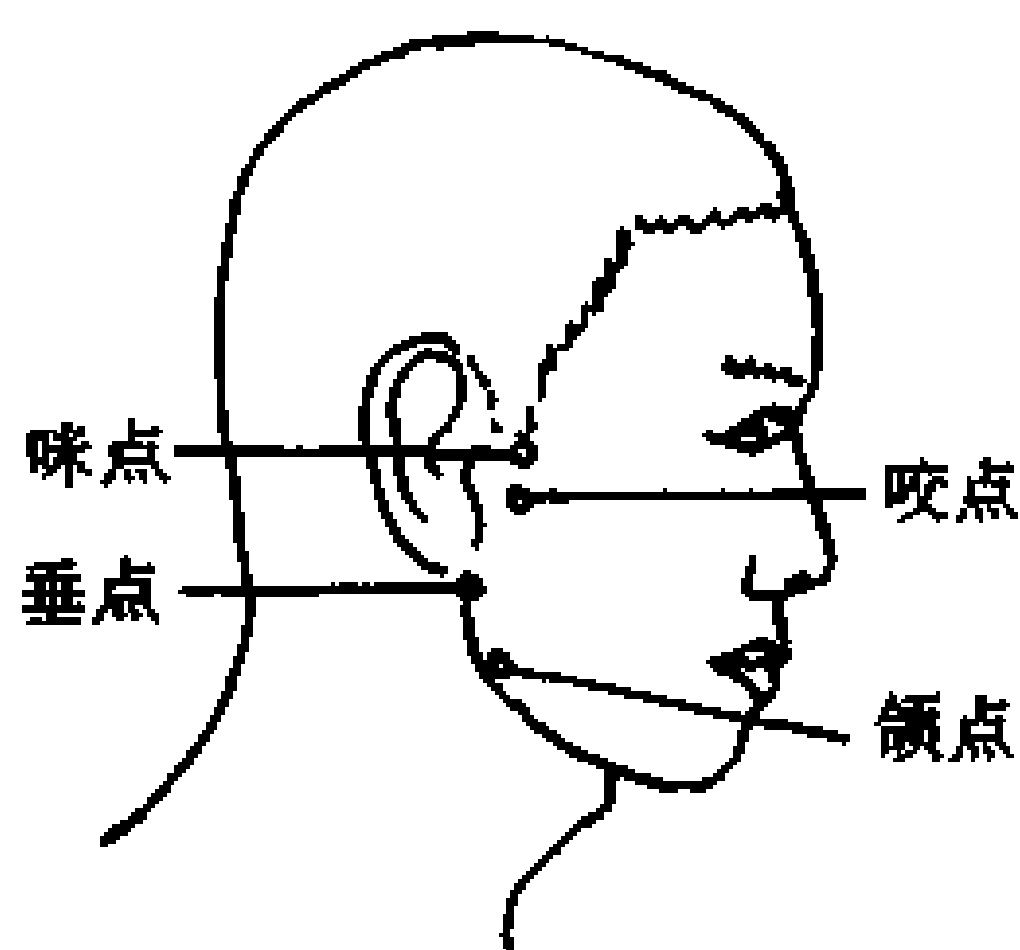


图 70-1

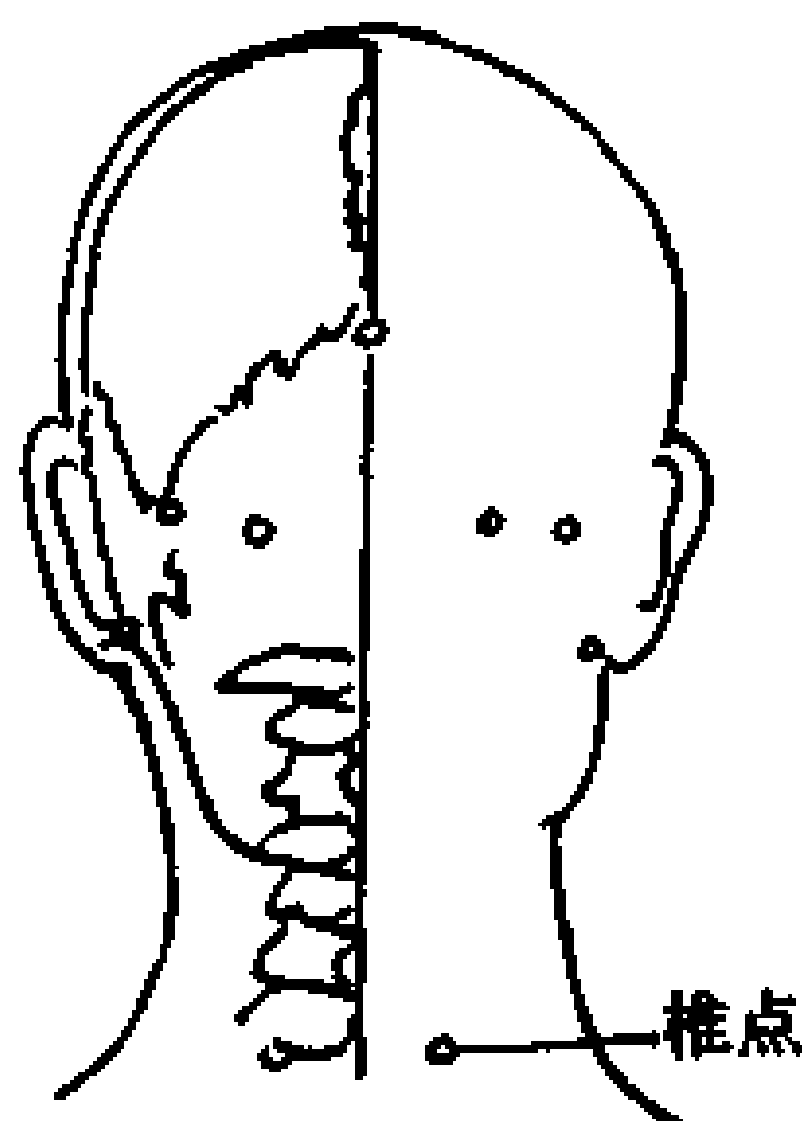


图 70-2

图 70 颞颌关节功能紊乱症取穴图

【手法操作】

先反复点椎点（双侧），后点其他穴位，同时嘱患者作咬牙活动。

五十七、胸部挫伤

由于外力作用使胸廓软组织和胸肋关节损伤，出现以胸痛为主要特征的疾病，称为胸部挫伤。

多为直接暴力所致，如武术对打中被拳或棍棒击伤胸部；篮球比赛时胸部被撞击；游泳跳水时姿势不良，呈门板式入水，胸壁被水面拍击伤；劳动时被推车柄撞伤或桌子棱角碰伤等等。这些损伤多为胸部肌肉挫伤，撞击严重者可累及肺部组织。

伤后局部疼痛、肿胀，皮肤可有挫裂伤或有大片瘀斑。有的出现窜痛，咳嗽时剧痛，咯痰不畅或痰中带血，胸闷不适，不能平卧。检查局部压痛尖锐，部位较集中，甚者可触到肿硬高突之软组织肿块。

【取穴】（图 71）

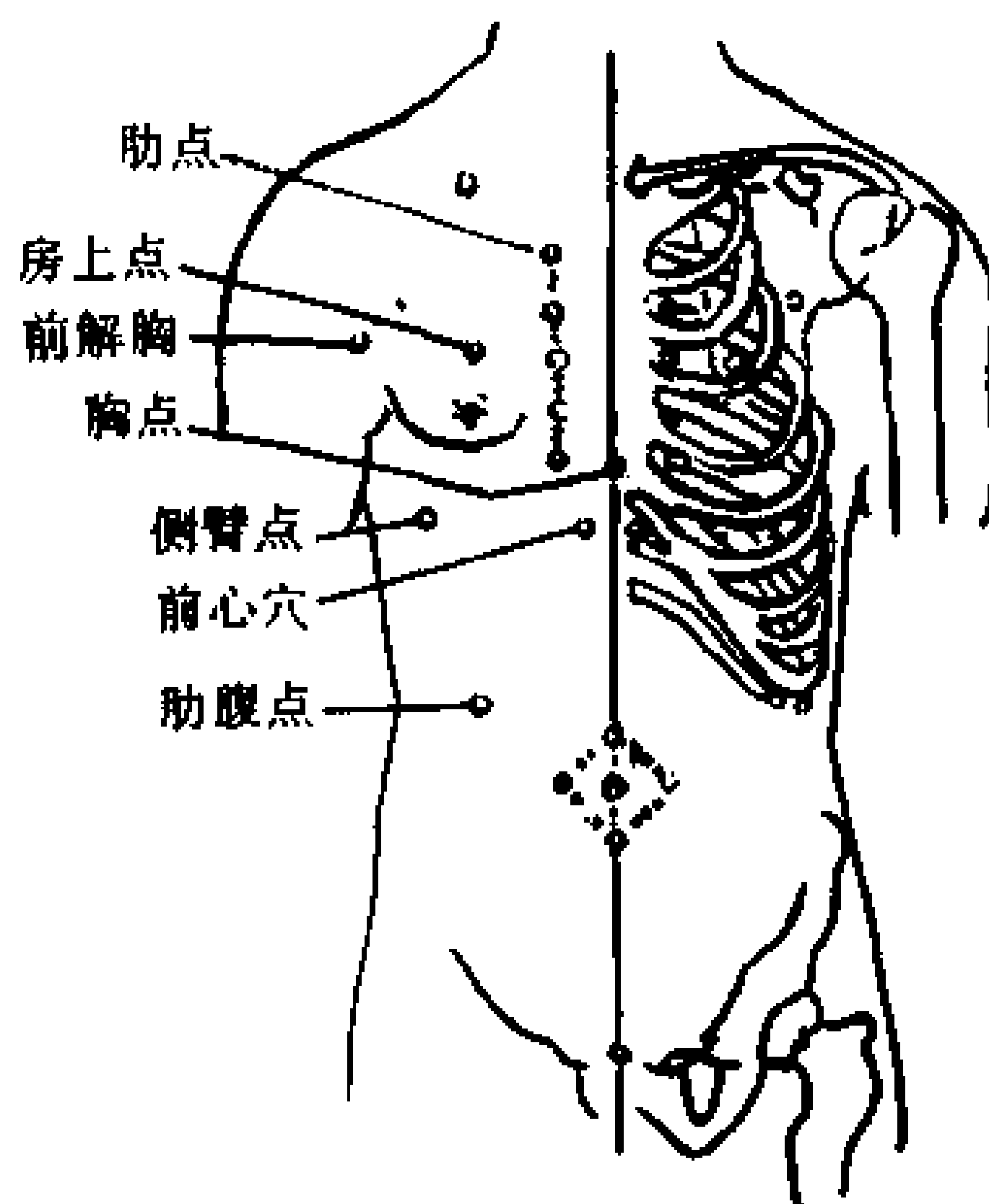


图 71 胸部挫伤、肋软骨炎取穴图

(1) 主穴：前心穴、胸点、肋点、房上点。

(2) 配穴：侧臂点、前解胸。

【手法操作】

先点前心及胸点，后点其他主穴。若疗效不佳再点配穴。
挫伤较严重者可酌情配合中药内治。

五十八、肋软骨炎

由多种原因导致的肋软骨痛性肿胀者，称为肋软骨炎。

起因不明，一般认为属病毒的感染，或损伤或机械应力所致，诱发因素则认为是钙化。

肋软骨处肿胀、疼痛，深呼吸、咳嗽或挤压胸壁时疼痛加剧。肋软骨处可摸到痛性硬块，局部温度可升高，但皮肤不红。

【取穴】（见图 71）

(1) 主穴：前心穴。

(2) 配穴：肋腹点、侧臂点。

【手法操作】

反复点穴位，手法宜点震法。

五十九、背肌筋膜炎

因外伤后治疗不当、劳损或外感风寒等原因，造成背部慢性疼痛，称之为背肌筋膜炎。

背部肌肉均有筋膜覆盖。由于肌肉的急性扭挫伤没有得到及时适当的治疗，或由于单一姿势如长期弯腰、经常负重

等，使背肌及筋膜长期受外力的牵拉，多次轻微的外伤，慢慢积累后形成，使肌肉及筋膜发生无菌性炎症、水肿、渗出，久之则粘连及纤维性变。如再复受风寒湿侵袭，疼痛可加剧，进一步刺激肌肉反射性收缩，又加重了这种慢性损伤，使背部僵硬发板、酸痛。

背部酸痛，肌肉僵硬发板，有沉重感。天气变化可使症状加重。早起背部酸痛较重，稍加活动后疼痛可有所减轻，但疲劳后症状又加重。检查背部无固定压痛点或压痛较为广泛。背部沿骶棘肌走行方向常可触到条索状的改变。

【取穴】（图 72）

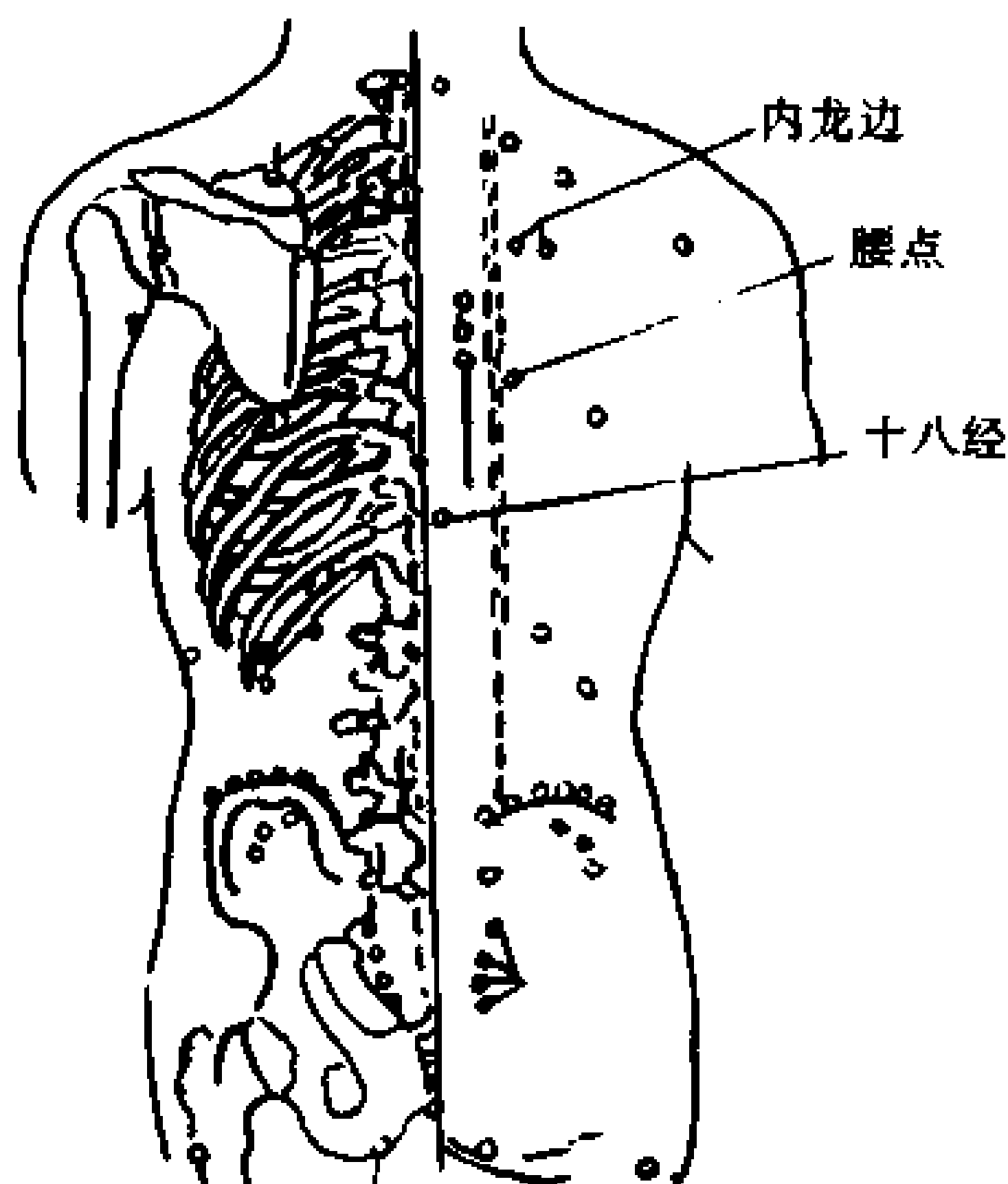


图 72 背肌筋膜炎取穴图

(1) 主穴：腰点。

(2) 配穴：内龙边（双侧穴）、十八经。

【手法操作】

反复点穴后，再用大鱼际肌在背部进行揉摩数分钟。

六十、岔气

因间接暴力造成肋间软组织牵拉伤及肋椎关节半脱位，引起胸部疼痛、呼吸运动受限者，称为岔气。

举重时用力过猛，或搬扛重物用力不当，或因身体扭转，或咳嗽时闭气用力过猛等原因，致使肋椎关节半脱位及肋间软组织牵拉伤，造成肌肉韧带撕裂，组织间出血渗出，酸性代谢产物积累，压迫或刺激肋间神经，引起肋间神经痛。

患者自觉气闷不适，气阻不得上下，胸胁部胀满作痛，不敢深呼吸，不敢咳嗽，每当咳嗽或转动身体时疼痛加重，痛无定处，或为窜痛，有时牵扯到背部和下腹，有时出现带状灼痛区。如为肋椎关节半脱位，则在伤处按之痛甚，肋间隙不等宽。

【取穴】（图 73）

(1) 主穴：前心穴。

(2) 配穴：胸点、房上点、肋点。

【手法操作】

先反复点胸点、前心穴，再点其他穴位。

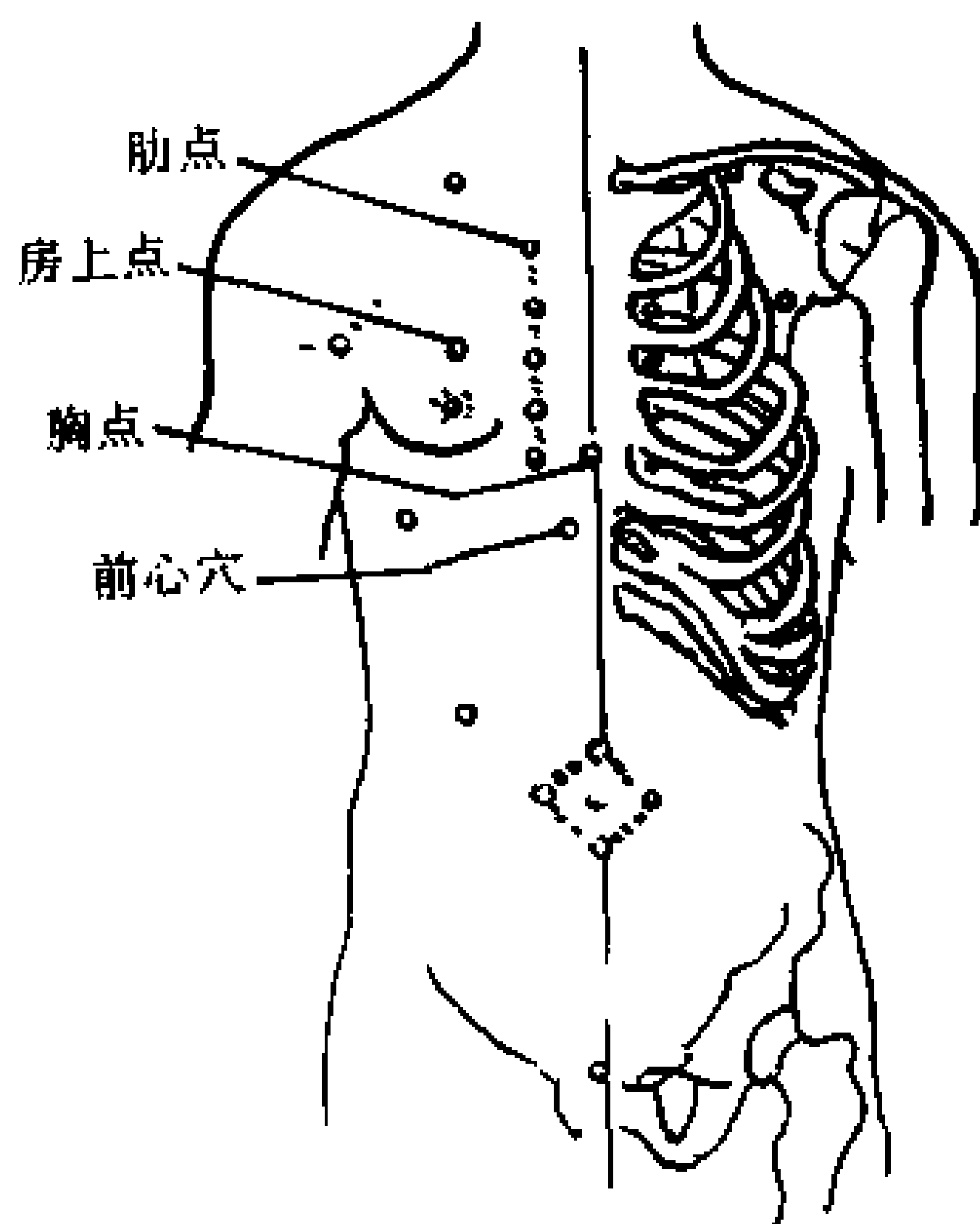


图 73 气取穴图

六十一、急性腰扭伤

因活动失衡而致腰部肌肉、韧带、筋膜、椎间小关节的损伤，称为急性腰扭伤。

本病常因搬运重物时姿势不正，或用力不当，或腰部活动范围过大而致肌肉、韧带、筋膜受伤，或椎间小关节受到过度牵拉和扭转而受伤。

有明显的损伤病史。损伤严重者，受伤当时即可感到腰部有一响声并伴有断裂感，随之出现一侧或两侧腰痛，疼痛

可因腰部活动、咳嗽、喷嚏和用力大小便时加重，部分患者牵扯到下肢腿部，患者躯干倾斜，行走迟缓，腰部活动受限，腰呈板样硬，弯腰困难，局部压痛明显。

【取穴】（图 74）

- （1）主穴：腰点、连排点、掌点（取背侧穴）。
- （2）配穴：肾筋、肋尖点、脊点、反点、棘点、环点、灵 1、灵 2。

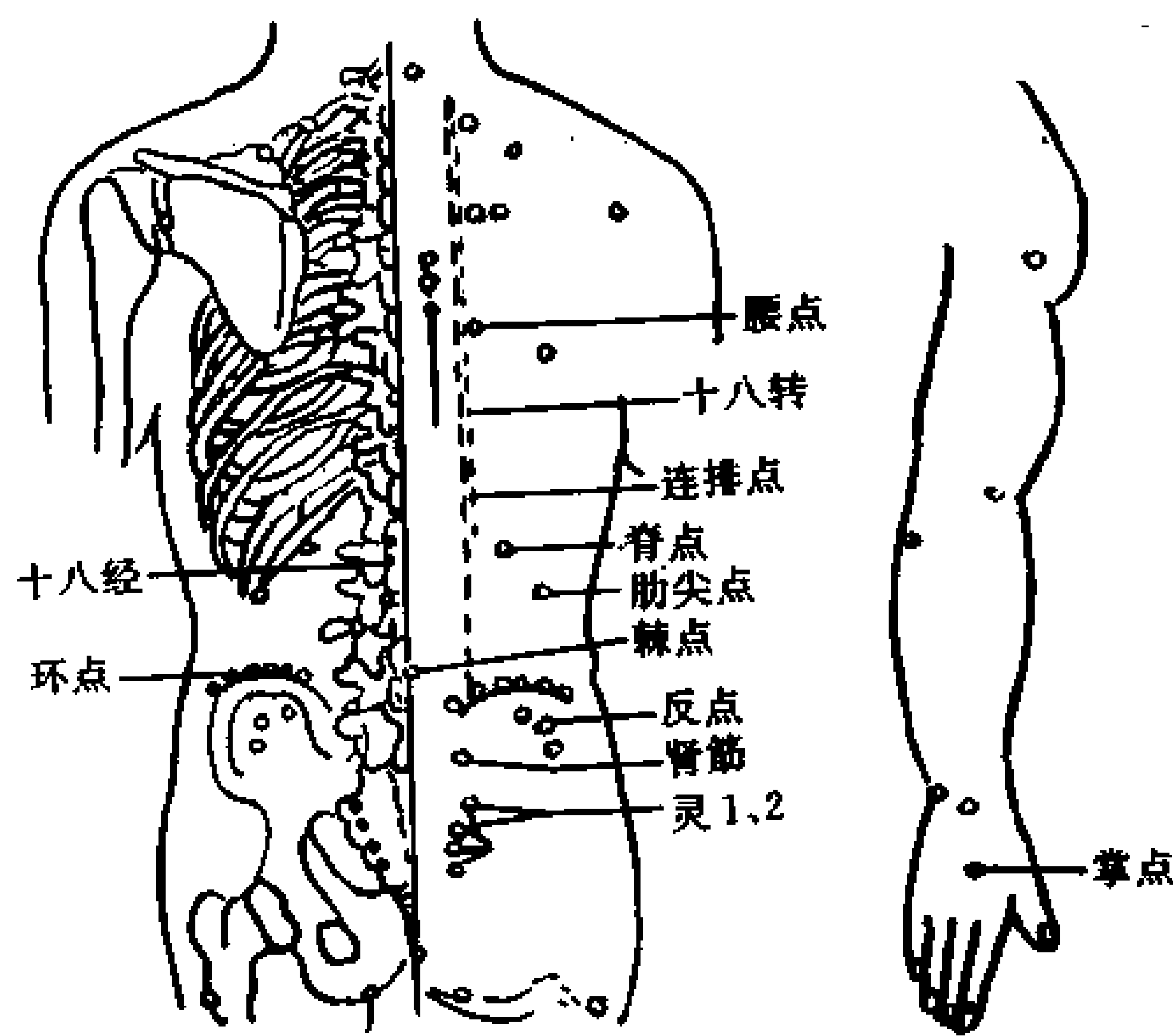


图 74-1

图 74-2

图 74 急性腰扭伤、腰部劳损、腰椎后关节紊乱症取穴图

【手法操作】

疼痛甚者先点后心穴，再反复点主穴后，嘱患者作缓慢步行1分钟，再次行手法。若遗有腰侧、腰骶或骶髂部酸痛，可根据酸痛部位选取该处穴位为配穴。若为腰部挫伤，则损伤局部的穴位禁止施手法，并酌情配合中药内治。

六十二、腰部劳损

腰部肌肉、筋膜与韧带等软组织因受慢性损伤而出现的病变，称为腰部劳损。

引起腰部劳损的病因较多，如长期腰部姿势不良，或长期从事腰部持力及弯腰活动等工作，均可引起腰背筋膜、肌肉的劳损，或筋膜松弛，或有微小撕裂损伤；腰部急性外伤后，未能得到及时而有效的治疗，迁延日久而成慢性腰痛；脊柱退行性改变或腰骶部骨骼的先天性结构异常，由于肌肉的起止点随之发生异常或该部位活动不平衡，则容易导致劳损。

腰部劳损主要表现为慢性腰痛，疼痛时轻时重，活动过度或劳累或气候变化时加重，休息时可减轻。少数患者有臀部和大腿后上部胀痛。腰肌或筋膜劳损时，骶棘肌处、髂骨嵴后部或骶骨后面腰背肌止点处有压痛；棘上或棘间韧带劳损时，压痛点多在棘突上或棘突间。老年人脊柱退行性改变而致腰痛者，往往腰痛持久不愈，晨起俯仰欠利，稍作活动后腰部转见灵活。X线片上可见椎体边缘骨质增生。

【取穴】（见图74）

- （1）主穴：连排点、十八转、腰点、肾筋。
- （2）配穴：十八经、棘点。

【手法操作】

患者取俯卧位，先反复点主穴后，若效果不明显再点配穴。施术后行捏脊法。

六十三、腰椎后关节紊乱症

因腰部不正确的活动或负重造成腰椎小关节的微细错位，产生腰部疼痛，活动受限，称为腰椎后关节紊乱症。

当腰部在不正确的姿势下负重及突然的闪扭时，造成腰椎后关节的错位，使松弛的滑膜嵌顿在关节缝隙内，以致腰部肌肉痉挛，两侧失去平衡。

多有腰部突然闪扭病史，腰部疼痛。轻者，腰肌酸痛，腰功能活动正常，但后伸时疼痛加重；重者，腰痛剧烈，腰功能活动受限，不能动弹，不能直腰。部分患者可有向臀部或骶尾部牵扯痛。患椎椎旁压痛明显，有时可出现患椎棘突高起或偏歪，局部肌肉紧张。

【取穴】（见图 74）

（1）主穴：连排点。

（2）配穴：腰点、十八转、棘点。

【手法操作】

反复点穴位后，再行捏脊法，手法宜轻。

六十四、第三腰椎横突综合征

因脊柱遭受急性伸屈或扭转外力，使第三腰椎横突附近软组织损伤而出现疼痛等病症，称为第三腰椎横突综合征。

本病多有不同程度的腰部损伤。如腰椎弯度过大，长期弯腰工作中，横突与肌肉附着处产生慢性牵拉性损伤，撕裂出血，造成多数小肌疝，同时腰神经感觉支也会受牵拉而产生疼痛，引起局部肌肉痉挛；或因慢性劳损，使第三腰椎横突周围发生水肿、渗出、纤维增生等慢性炎症。此外，突然弯腰扭伤，使第三腰椎横突周围的肌肉筋膜被撕裂，出现损伤性炎症或肌疝等。

腰部一侧或两侧的慢性疼痛，晨起或弯腰时疼痛加重，弯腰直起时困难，稍事活动，疼痛减轻。疼痛多呈持续性，少数患者诉疼痛向臀部或大腿外侧至膝外侧放射。腰活动度正

常，第三腰椎横突部位有明显压痛，有时可触及一纤维性的软组织硬结，腰2~3椎旁或骶部常有麻木区或过敏区。X线拍片除第三腰椎横突明显过长外，有时左右横突不对称，或向右倾斜。

【取穴】（图75）

（1）主穴：棘点。

（2）配穴：肾筋、十八经、肋点。

【手法操作】

反复点各穴位，手法不宜太重。

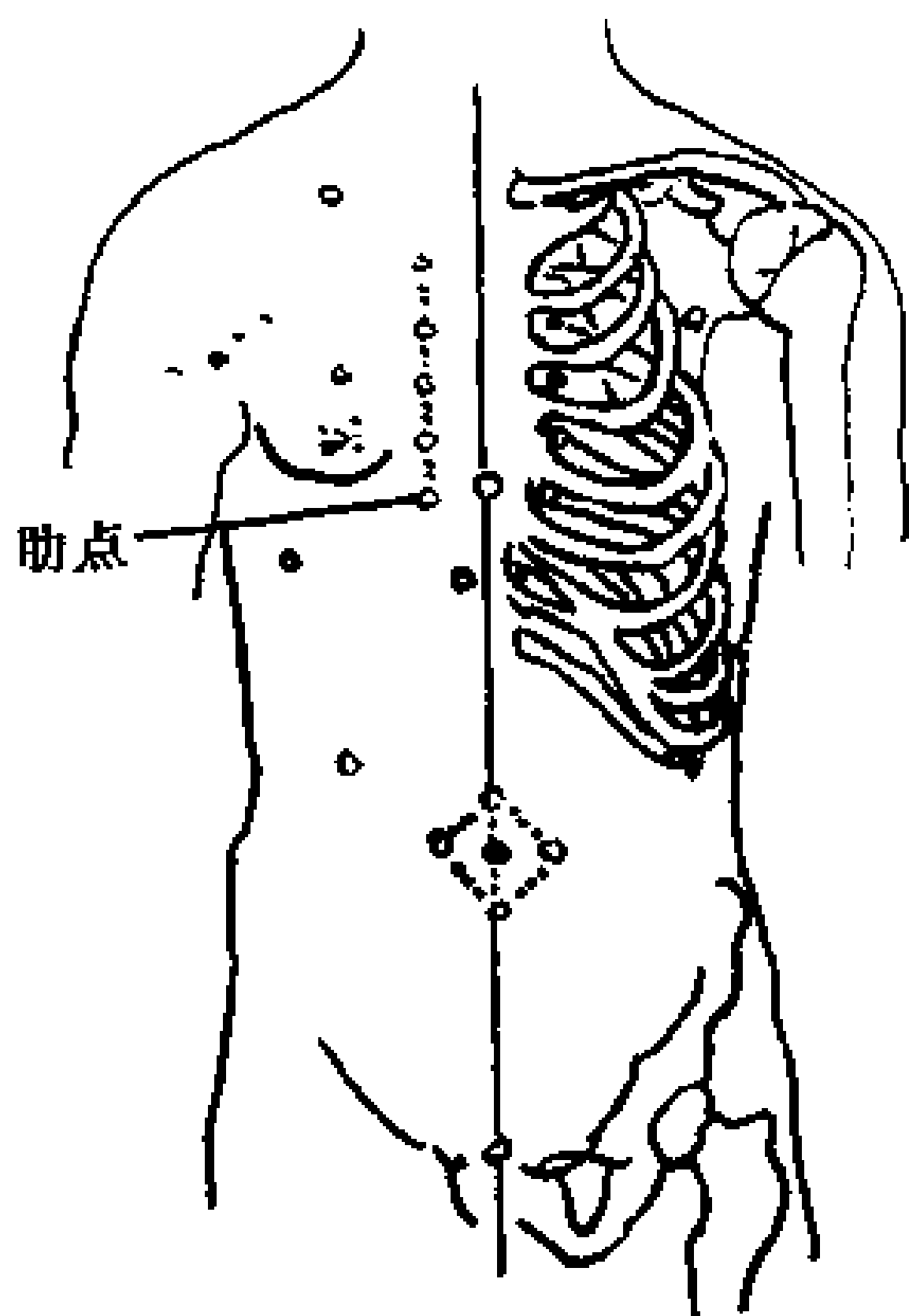


图 75-1

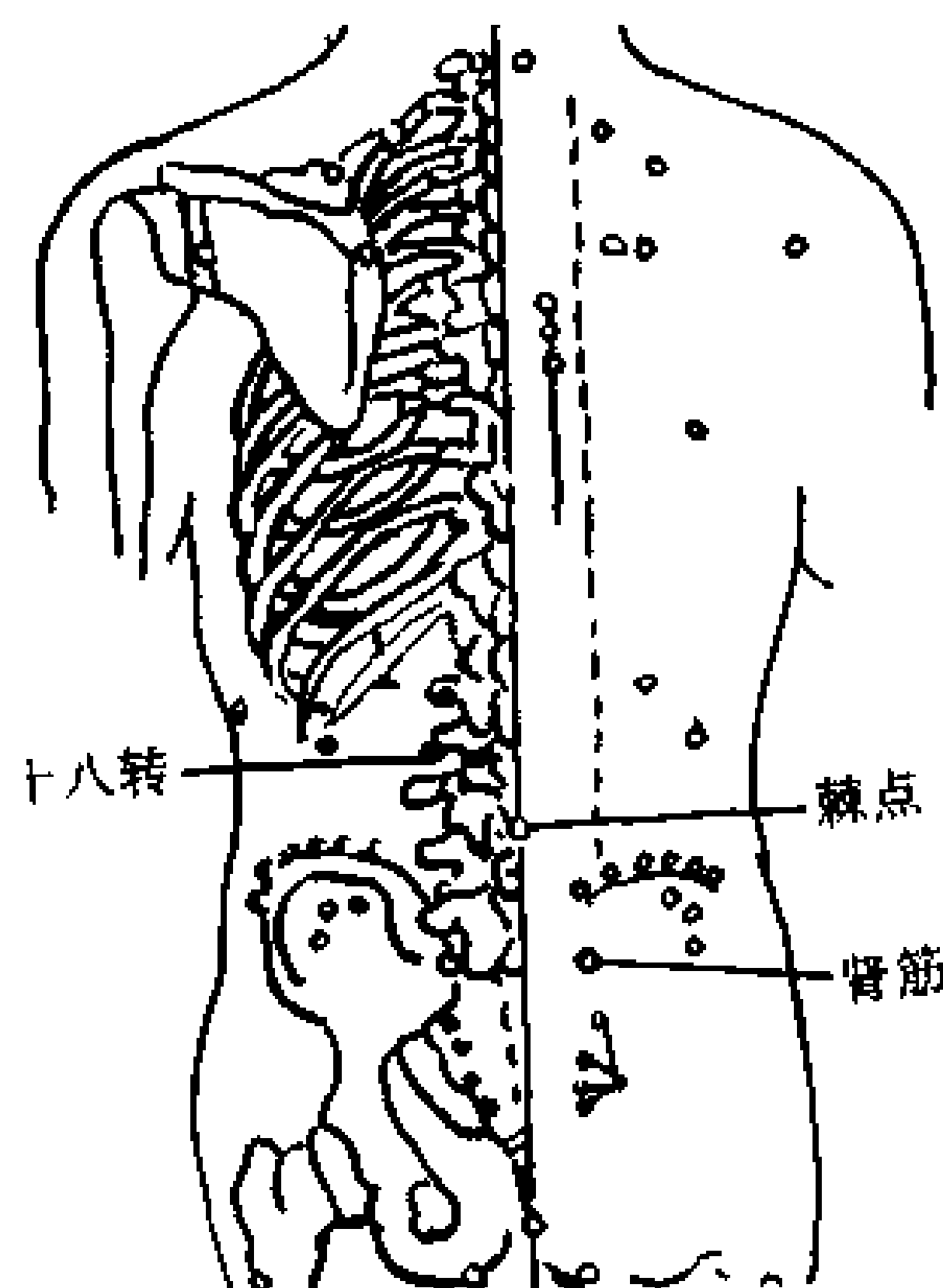


图 75-2

图 75 第三腰椎横突综合征取穴图

六十五、腰椎间盘突出症

由于外力的作用致使腰椎间盘纤维环破裂，髓核向外突出，压迫邻近的脊神经根或脊髓而出现的病症，称为腰椎间盘突出症。

腰椎间盘突出病因主要是椎间盘本身退行性变，再加某种外因，如外伤、慢性劳损以及受寒湿等因素综合的结果，而使腰椎间盘纤维环发生破裂，以致髓核突出，压迫脊神经根或脊髓（马尾神经），引起腰痛和一系列神经症状。

多有不同程度的腰部外伤史，主要症状是腰部疼痛及下

肢放射性疼痛。腰痛常在腰骶部附近，在腰椎下段棘突旁和棘突间有深压痛，并沿患侧的大腿后侧向下放射至小腿外侧、足跟部或足背外侧，多为单侧下肢痛。若椎间盘突出较大或位于椎管中央时，可为双侧疼痛。咳嗽、喷嚏及用力排便时，均可使症状加重；步行、弯腰、伸膝起坐等动作也使疼痛加剧，屈髋屈膝、卧床休息时疼痛减轻。病程较长者，其下肢放射痛部位感觉麻木。脊柱侧弯，腰生理前突减小或消失，腰部功能活动呈不对称性受限，局部肌肉痉挛，触之硬韧，直腿抬高试验阳性，甚至有腓绳肌痉挛。在椎间盘突出的腰椎间隙棘旁有深在压痛，并引起或加剧下肢放射痛。下肢皮肤感觉可发生异常，跟腱反射可减弱或消失，肌力减弱，日久甚至肌肉萎缩。

【取穴】（图 76）

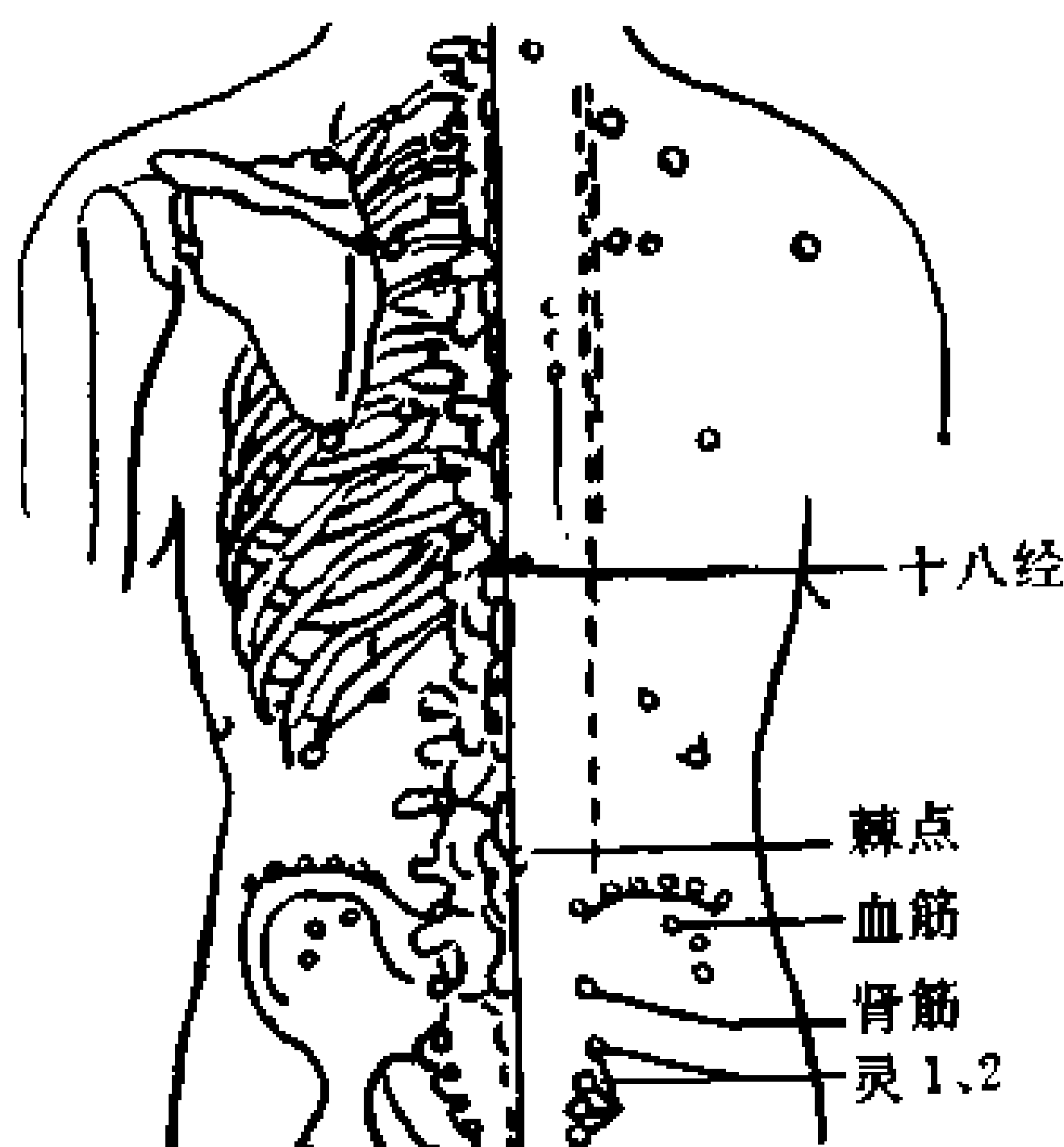


图 76-1

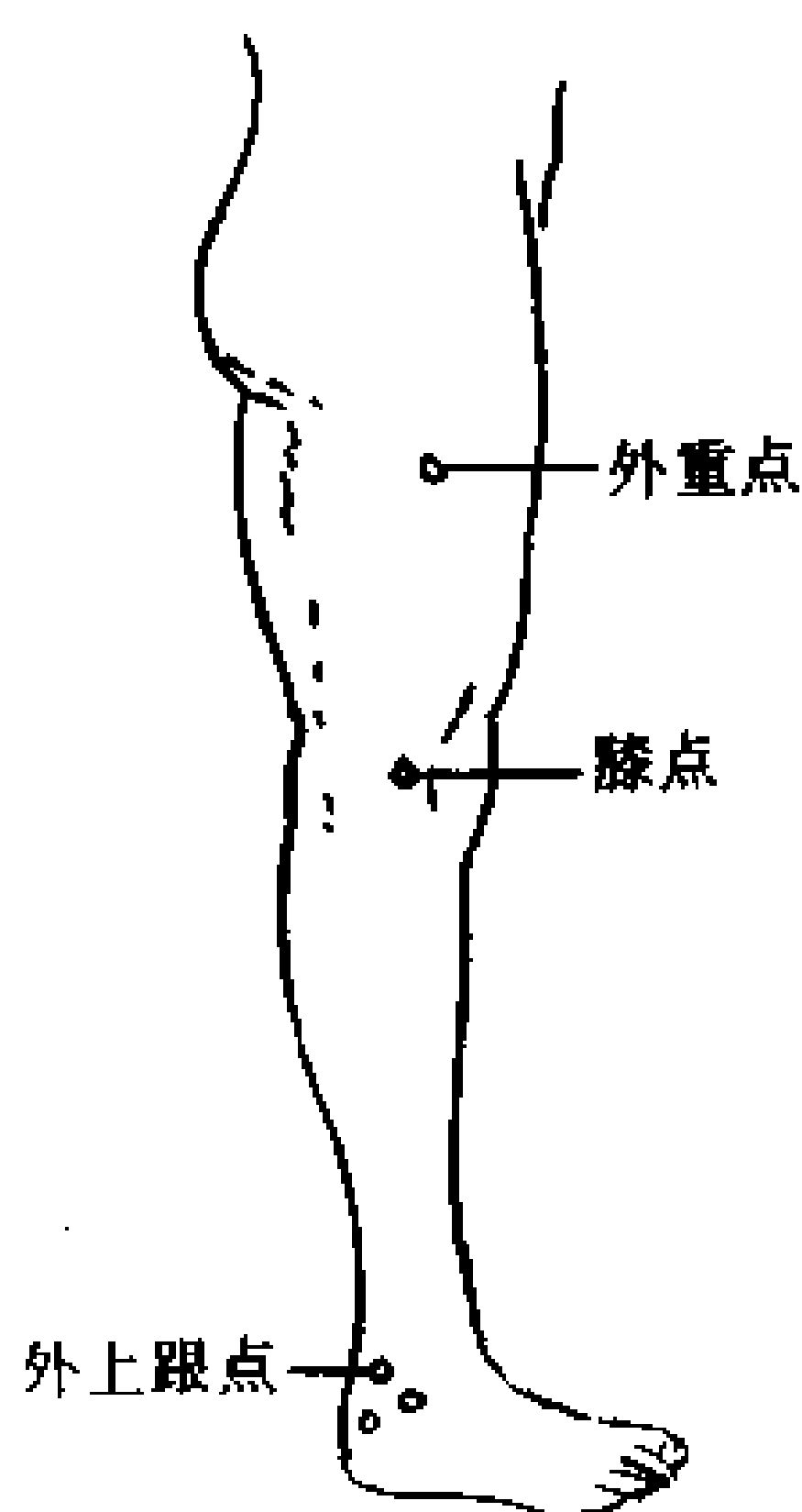


图 76-2

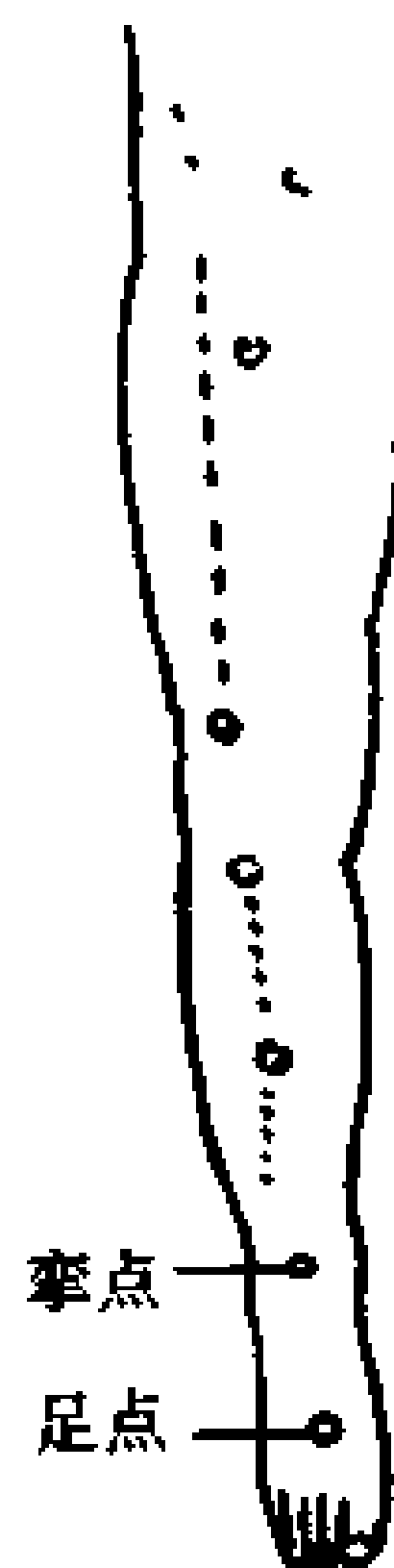


图 76-3

图 76 腰椎间盘突出症取穴图

- (1) 主穴：十八经、棘点、肾筋、血筋。
- (2) 配穴：灵 1、灵 2、外重点、膝点、外上跟点、挛点、足点。

【手法操作】

先反复点主穴，后反复点配穴，然后行拔伸按压法。治疗前患者必须先作 CT 或 X 线拍片定位确诊。

六十六、梨状肌损伤综合征

由于梨状肌损伤后刺激或压迫坐骨神经引起臀腿痛，称为梨状肌损伤综合征。

髋部扭闪时，髋关节急剧外旋，梨状肌猛烈收缩；或髋关节突然内收内提，使梨状肌受到牵拉，均可使梨状肌遭受损伤。损伤后，局部充血、水肿，肥厚的梨状肌刺激或压迫坐骨神经而引起臀腿痛。

臀部疼痛和下肢沿坐骨神经分布区放射性疼痛，可因劳累或感受风寒湿而加重。严重者自觉臀部有“刀割样”或“烧灼样”疼痛，不能入睡，走路跛行。梨状肌部位有压痛和放射痛，局部可触及条索状隆起，或肌腹呈弥漫性肿胀，肌束变硬、坚韧、弹性减低。沿坐骨神经可有压痛，直腿抬高试验多为阳性。

【取穴】（图 77）

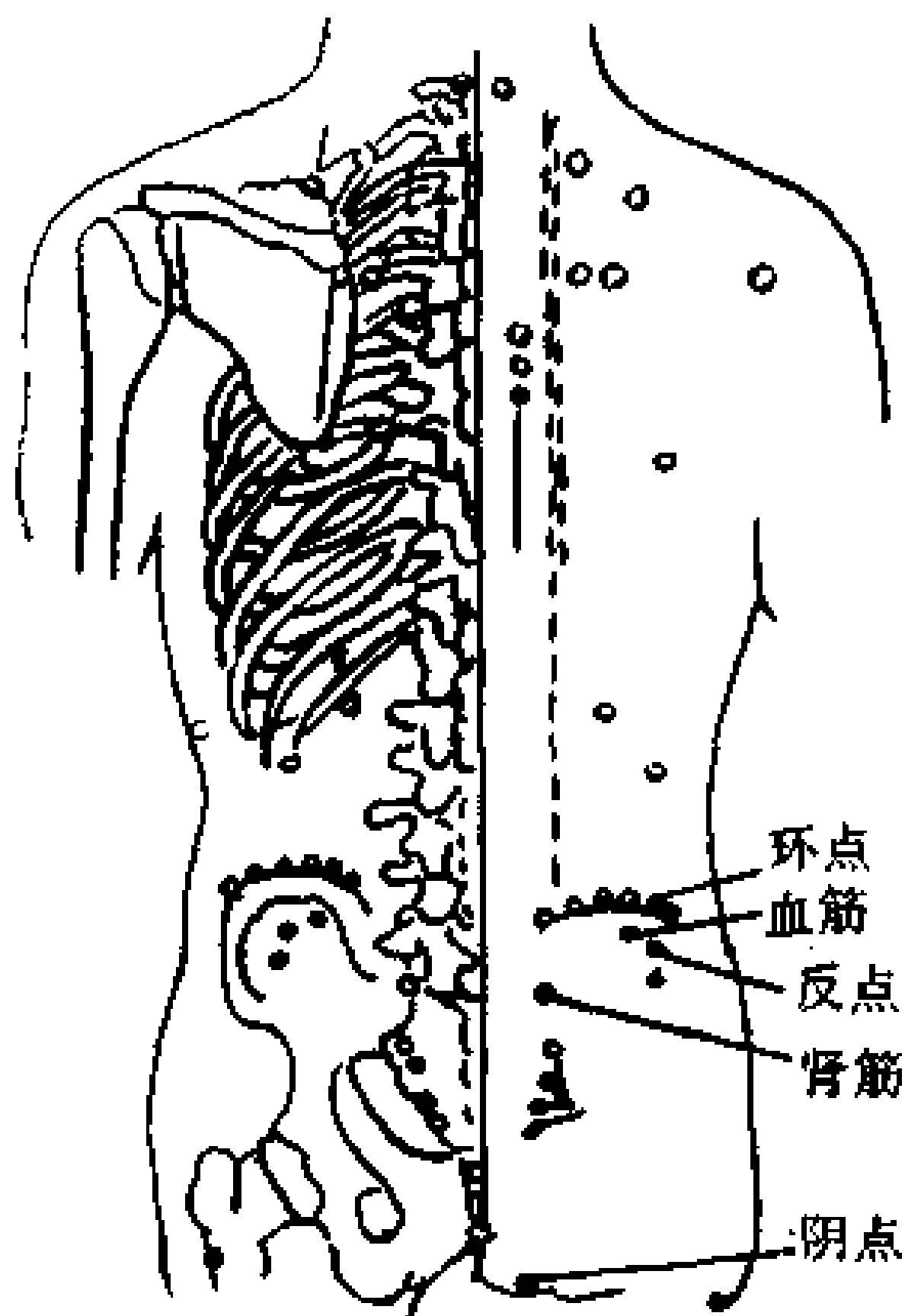


图 77 梨状肌损伤综合征取穴图

(1) 主穴：血筋。

(2) 配穴：肾筋、环点、阴点、反点。

【手法操作】

反复点穴位后，再用大鱼际肌揉按梨状肌 1~2 分钟。

六十七、骶髂关节扭伤

骶髂关节受到间接暴力作用，引起周围韧带撕裂或骶髂关节半脱位，称为骶髂关节扭伤。

当抬持或搬重物斜扭，或因摔倒时臀部或半身着地，身体向左或向右扭转而使骨盆部位产生旋转剪力，这一剪力主要作用于骶髂关节，使得骶髂关节超过了正常的生理活动范围，轻则引起关节周围的韧带撕裂伤，重则可造成关节脱位。

伤后即感到一侧下腰部疼痛无力，转动困难，活动时疼痛加重。患侧不能负重，患侧髋膝关节呈半屈曲位，按压或叩击髭后上棘，可引起骶髂关节的疼痛，骨盆分离试验阳性，患侧骶髂关节旋转试验、“4”字试验亦呈阳性。

【取穴】（图 78）

(1) 主穴：肾筋。

(2) 配穴：棘点、反

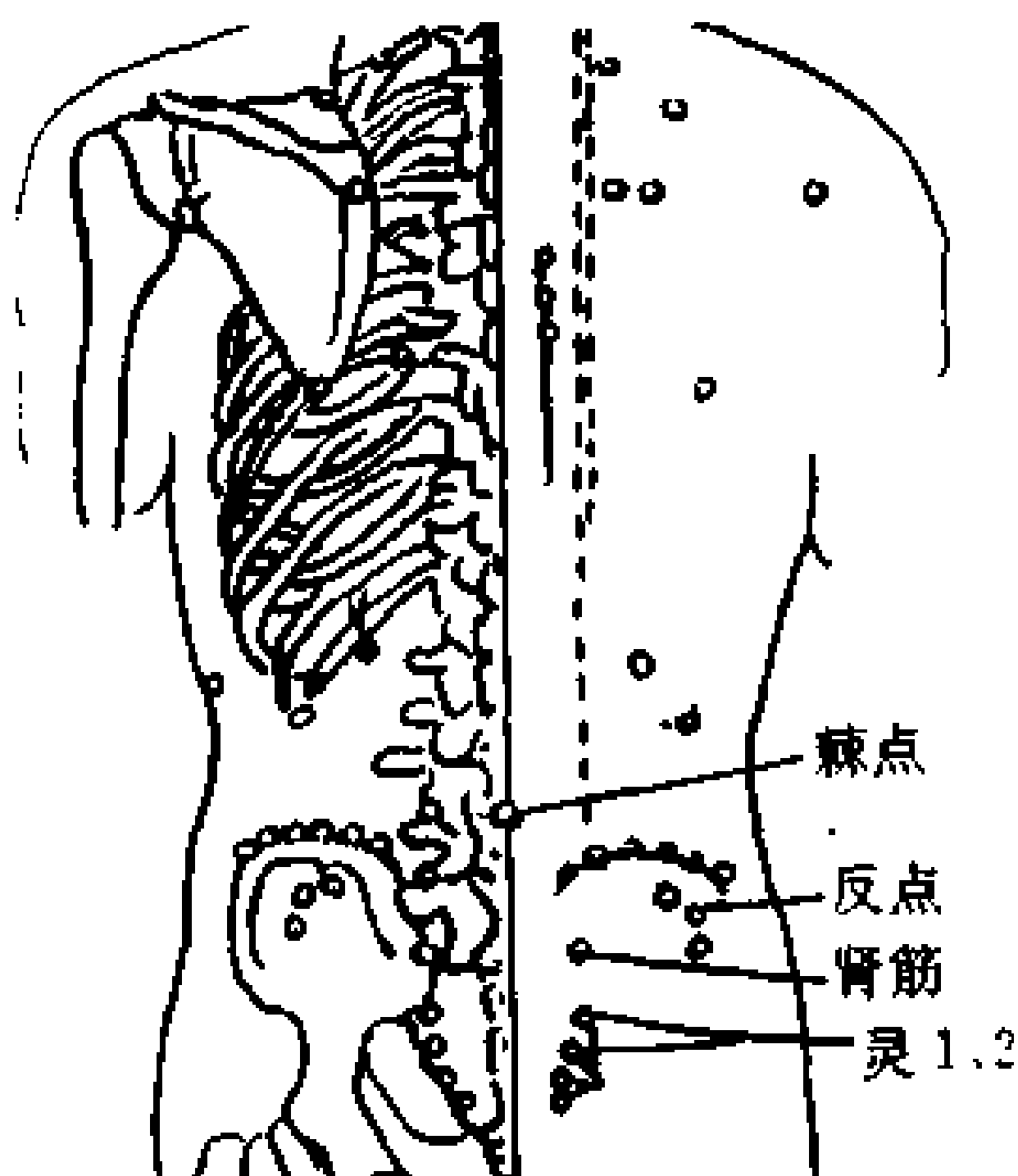


图 78 骶髂关节扭伤取穴图

点、灵 1、灵 2。

【手法操作】

反复点穴位（手法宜重），再揉按骶髂部。

六十八、骶尾关节扭挫伤

骶尾部受到直接或间接的暴力作用引起骶尾关节周围的韧带撕裂伤者，称为骶尾关节扭挫伤。

骶尾关节是由骶骨与尾骨组成的微动关节，周围有坚强的韧带联系，平时有一定的活动度。不慎摔倒臀部着地时，重者造成胸腰椎压缩骨折、骶骨骨折、骶尾关节脱位或半脱位；轻者则引起骶尾部韧带的撕裂伤或挫伤，骶尾关节错缝。

伤后骶尾部疼痛、肿胀，压痛明显，行走困难，坐位时不能使尾骶部着力。

【取穴】（图 79）

（1）主穴：肾筋。

（2）配穴：灵 3、灵 4、暗点。

【手法操作】

反复点各穴后，再揉按骶尾部。挫伤较重者宜配合中药内治。

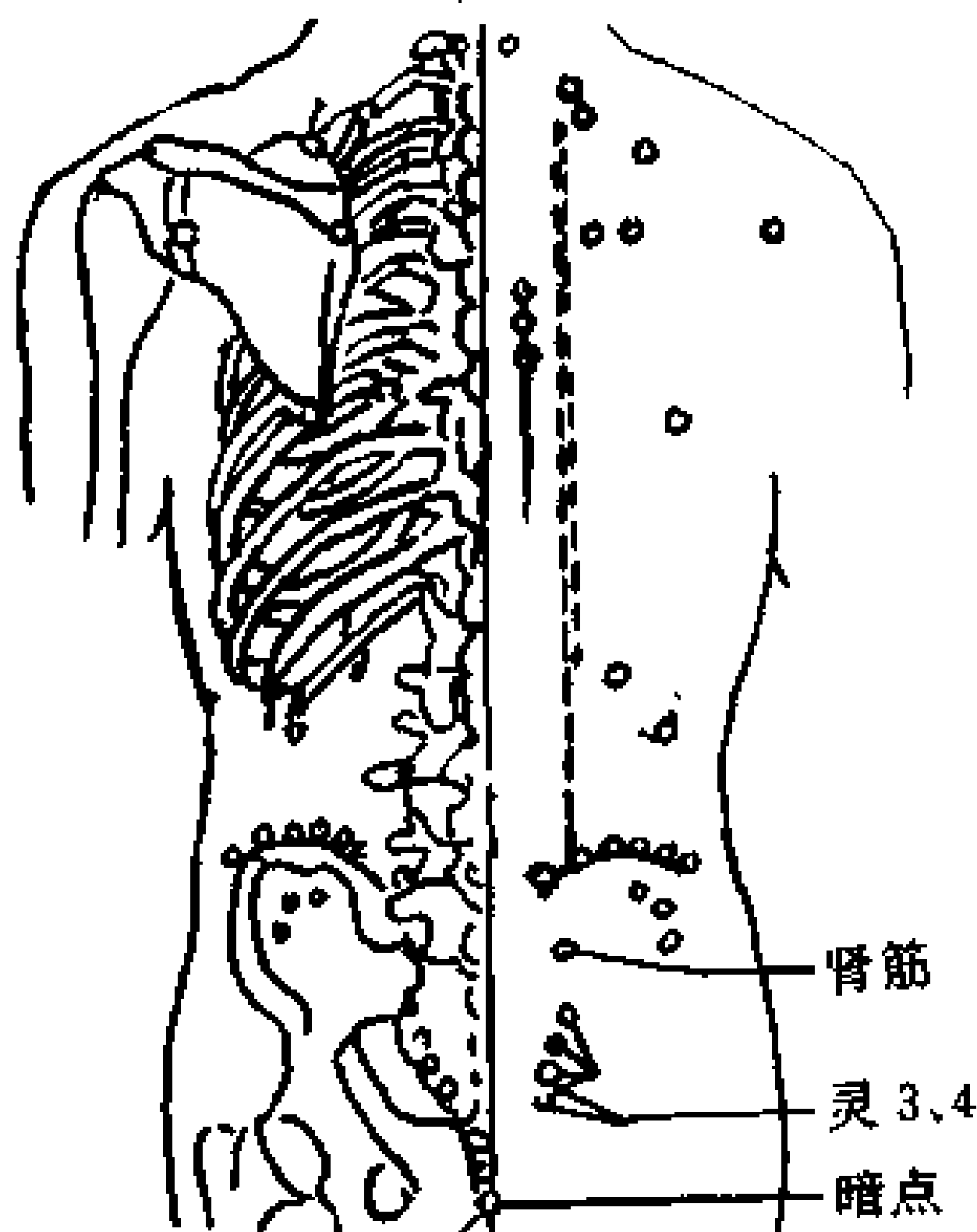


图 79 骶尾关节扭挫伤取穴图

六十九、类风湿性关节炎

类风湿性关节炎是一种以关节病变为主、病程起伏不定的全身性慢性疾病。

本症是非器官特异性自身免疫性疾病，患者血液中有类风湿因子（抗 IgG 抗体）存在。抗 IgG 抗体同自身的 IgG 结合后，形成抗原-抗体复合物，附着于关节的滑膜上，再结合并激活补体而形成炎症。目前研究还证明：类风湿性关节炎的发病与整个淋巴系统的细胞调节缺陷有关；亦与慢性病毒或支原体的持续感染有关。本病开始以关节滑膜病变为主，表

现为滑膜增厚，逐步侵袭肌腱、韧带等结缔组织，后期则发生软骨和骨的破坏。

关节肿痛在发病初期往往呈间歇性，单侧或双侧交替发作，而后转为缓解与加剧交替的持续性发作和双侧对称性疼痛，以夜间为主。发病的关节常为多发性，呈游走性多发性关节炎，病变累及手、足诸小关节，亦可累及膝、踝、髋关节和腕、肘、肩

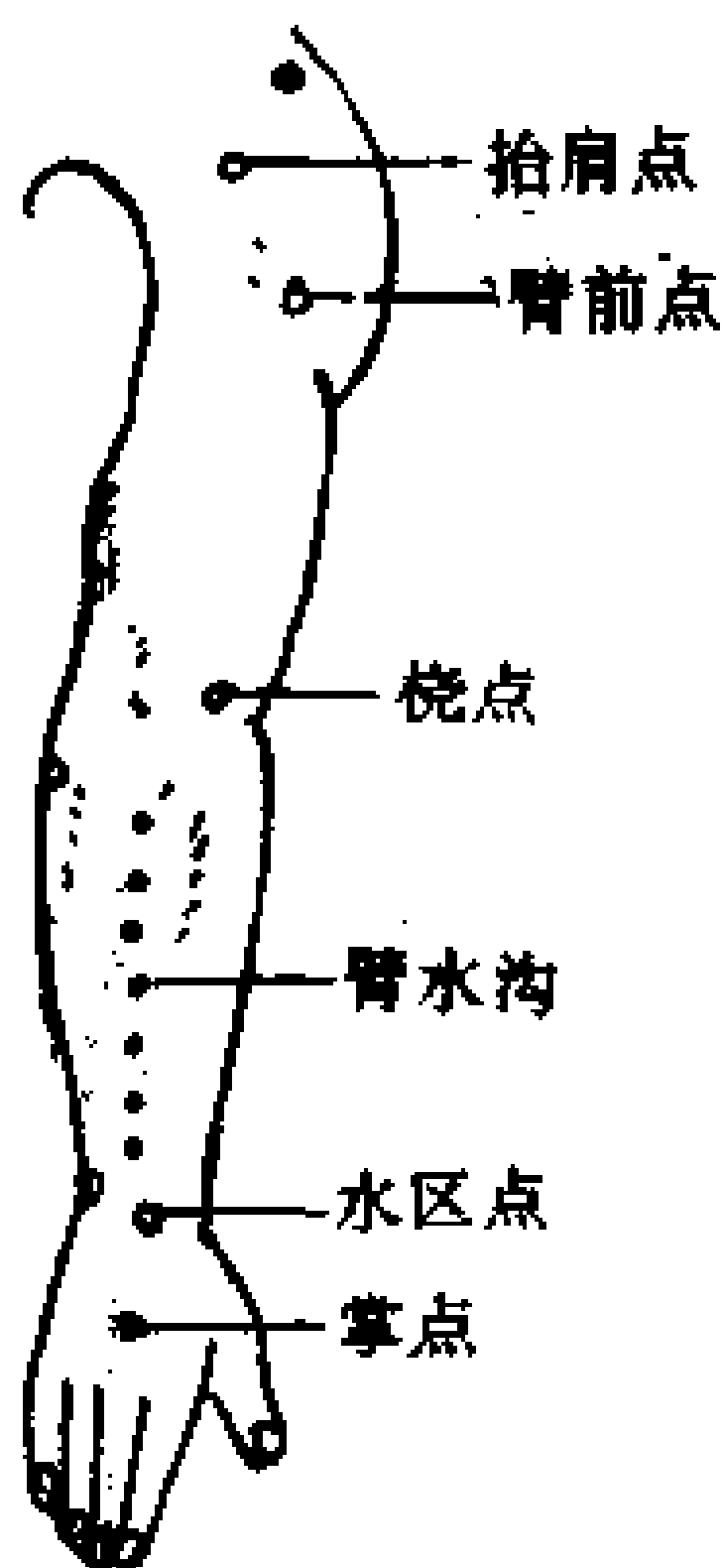


图 80-1

关节，脊柱之诸关节亦常被侵犯。四肢诸小关节局部常呈现红、肿、热、痛等炎症现象。手、足诸小关节常变形、增大，活动受限，以至骨性强直。

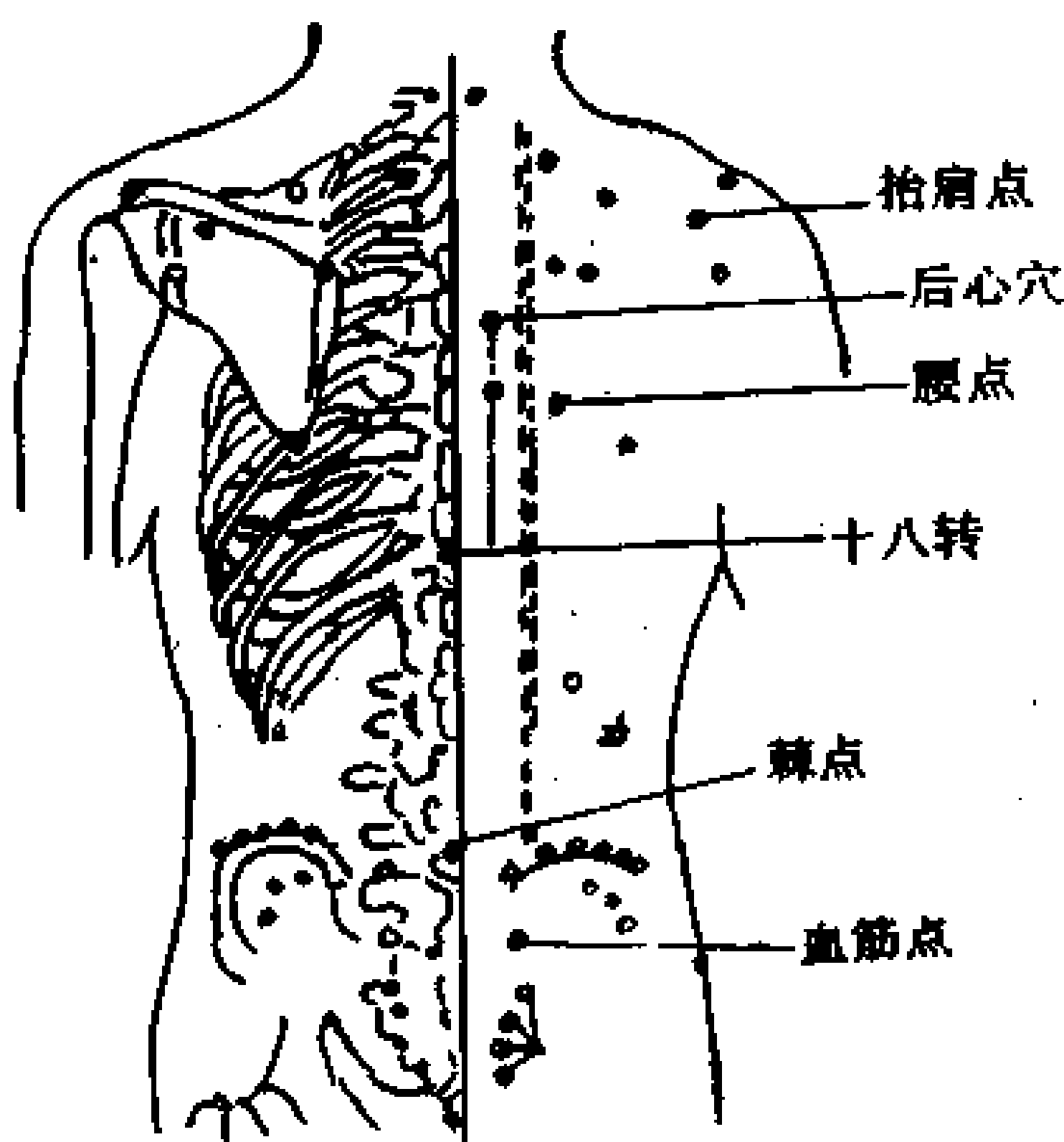


图 80-2

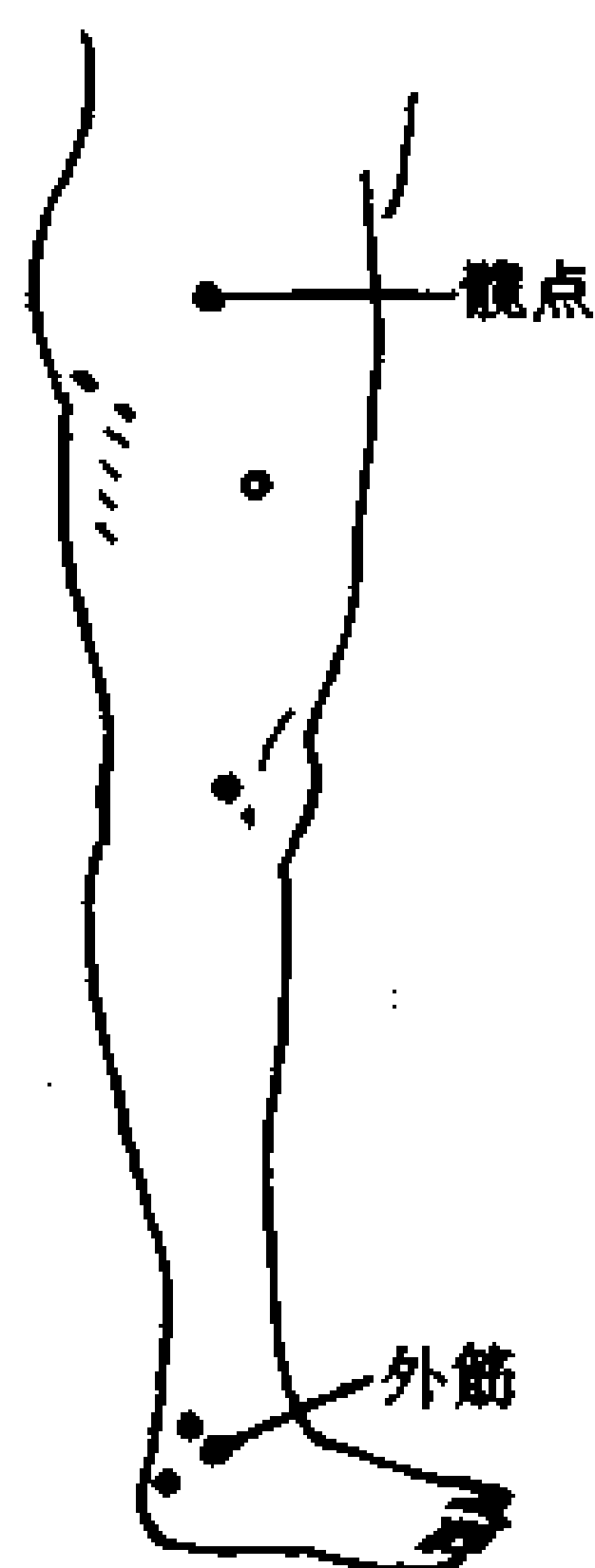


图 80-3

【取穴】（图 80）

（1）主穴：上肢：抬肩点、臂前点；下肢：龙点、风湿点；脊柱：后心穴、十八转。

（2）配穴：上肢：桡点、臂水沟、水区点、掌点；下肢：髌点，股点，上水区点，膝内、外 1/3 点，挛点，内、外筋，足点；脊柱：腰点、棘点、血筋点。

【手法操作】

穴位均取双侧，每个穴位点按 2-3 分钟；治疗中须配合内、外用药。

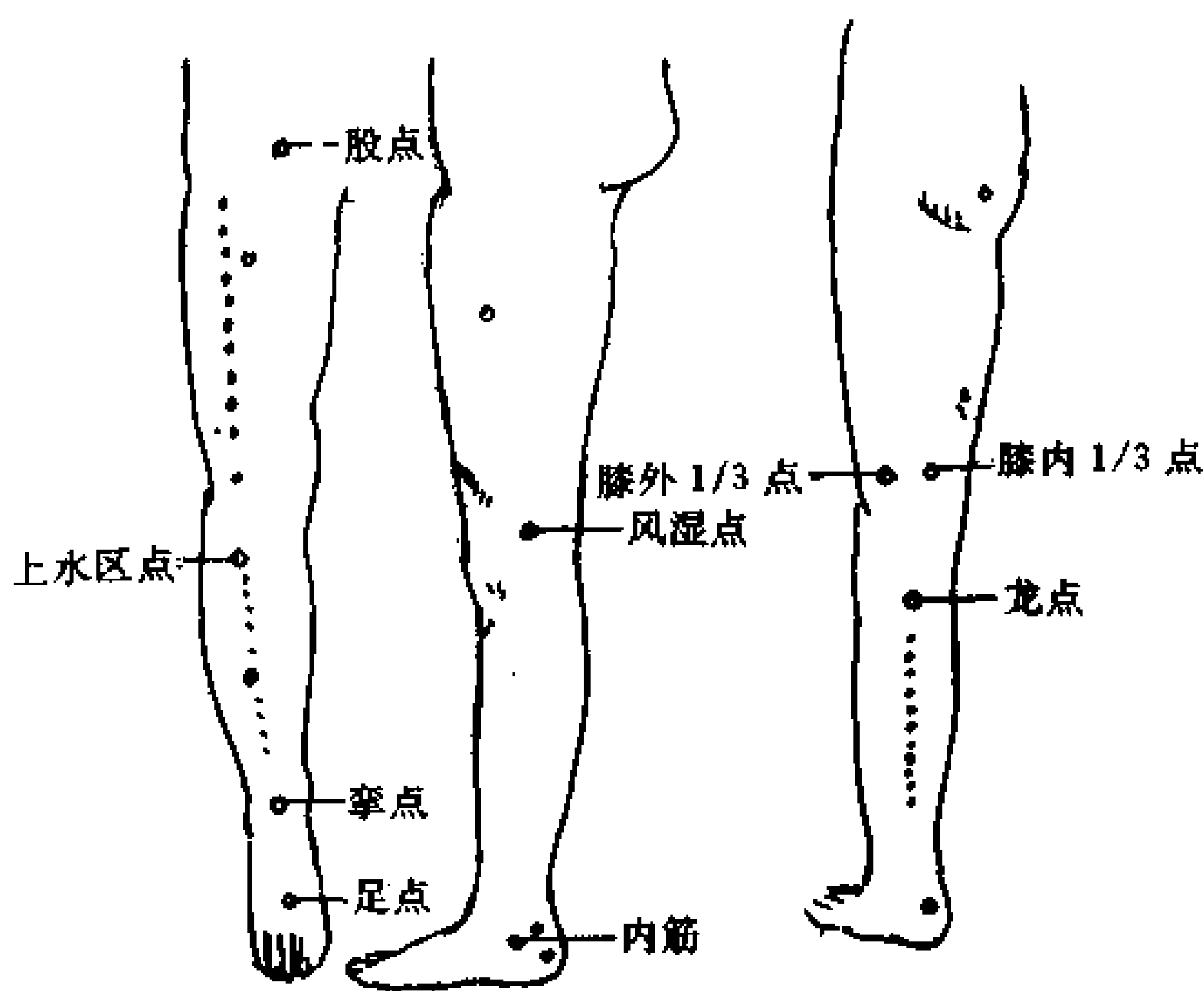


图 80-4

图 80-5

图 80-6

图 80 类风湿性关节炎取穴图

七十、先天性斜颈

胸锁乳突肌的先天性单侧挛缩，导致头颈不对称畸形，头倾向患侧，下颌转向健侧，称为先天性斜颈。胸锁乳突肌发生纤维变性，或环枢椎的旋转性固定，或颈椎畸形均，可引起斜颈。

患儿多在出生后不久，出现一侧胸锁乳突肌变硬，呈核状块并有萎缩，头向健侧旋转时，在达一定程度之后出现阻力。随着时间的延长，颈部向病侧倾斜，而下颌部则向健侧

扭转。日久颜面亦随之变形，不对称。最后颈椎骨会出现与之相应的改变。

【取穴】（图 81）

（1）主穴：后心穴、椎点、抬肩点。

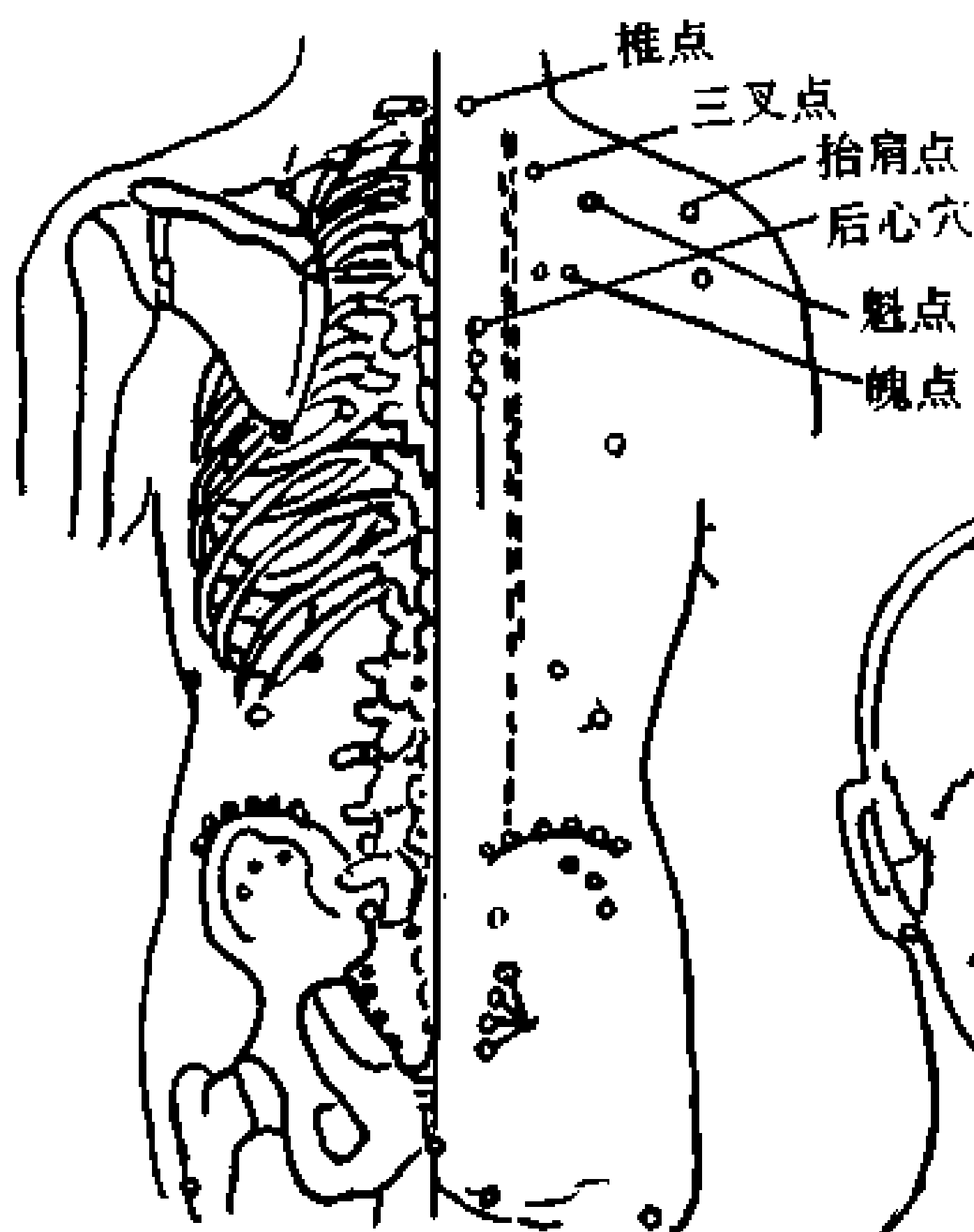


图 81-1

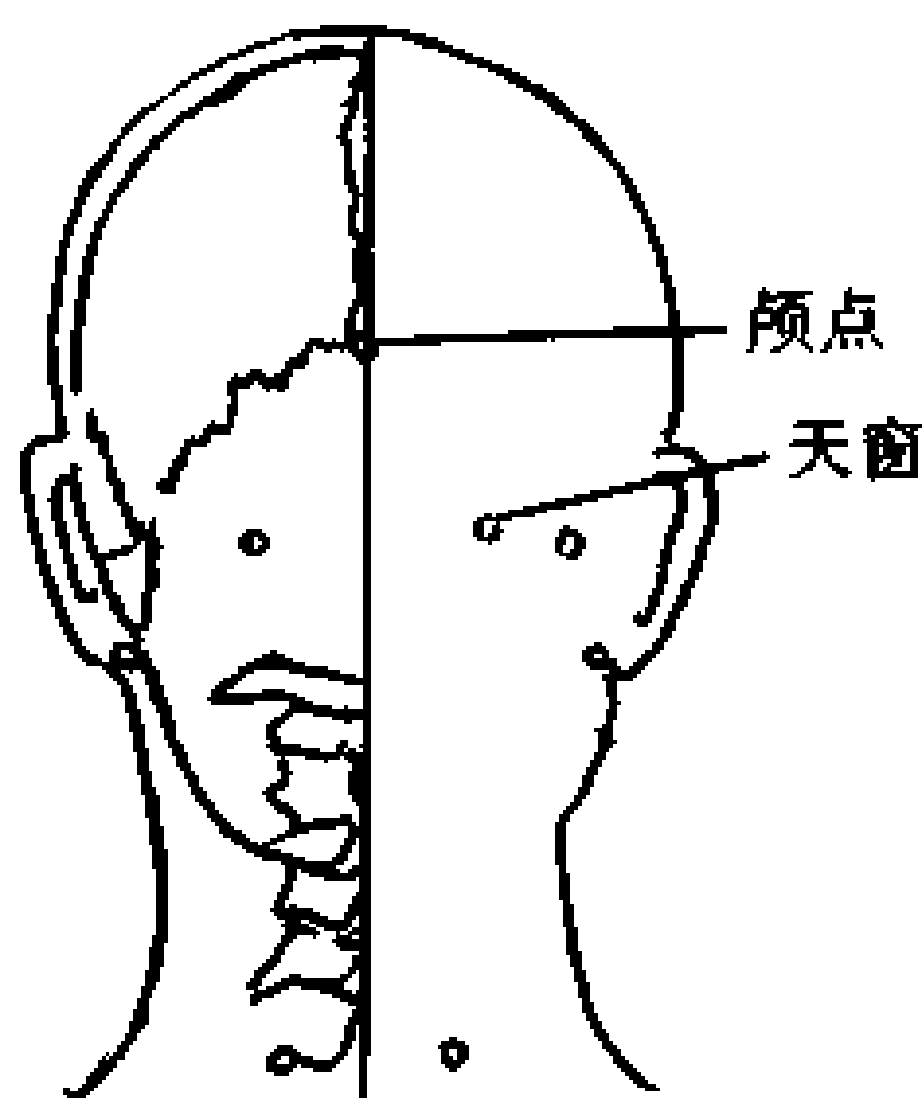


图 81-2

图 81 先天性斜颈取穴图

（2）配穴：颅点、天窗、三叉点、魁点、魄点。

【手法操作】

均取双侧穴位，小儿手法宜轻，点穴后用大鱼际肌或小鱼际肌推按患颈侧 3~5 分钟。

七十一、大脑损伤后遗症

颅脑损伤较为严重，或早期治疗不及时，不适当，以致遗留程度不等的后遗症。

部分病人表现痴呆，有头痛、头晕、耳鸣、视力障碍或失明、偏瘫、语言障碍，甚至失语、癫痫发作等器质性损伤后遗症。更多的病人在受伤后很长时间内主诉繁多，而神经系统检查却无客观发现。

【取穴】（图 82）

（1）主穴：后心穴（男取左穴，女取右穴）、椎点、天窗（取双侧穴）。

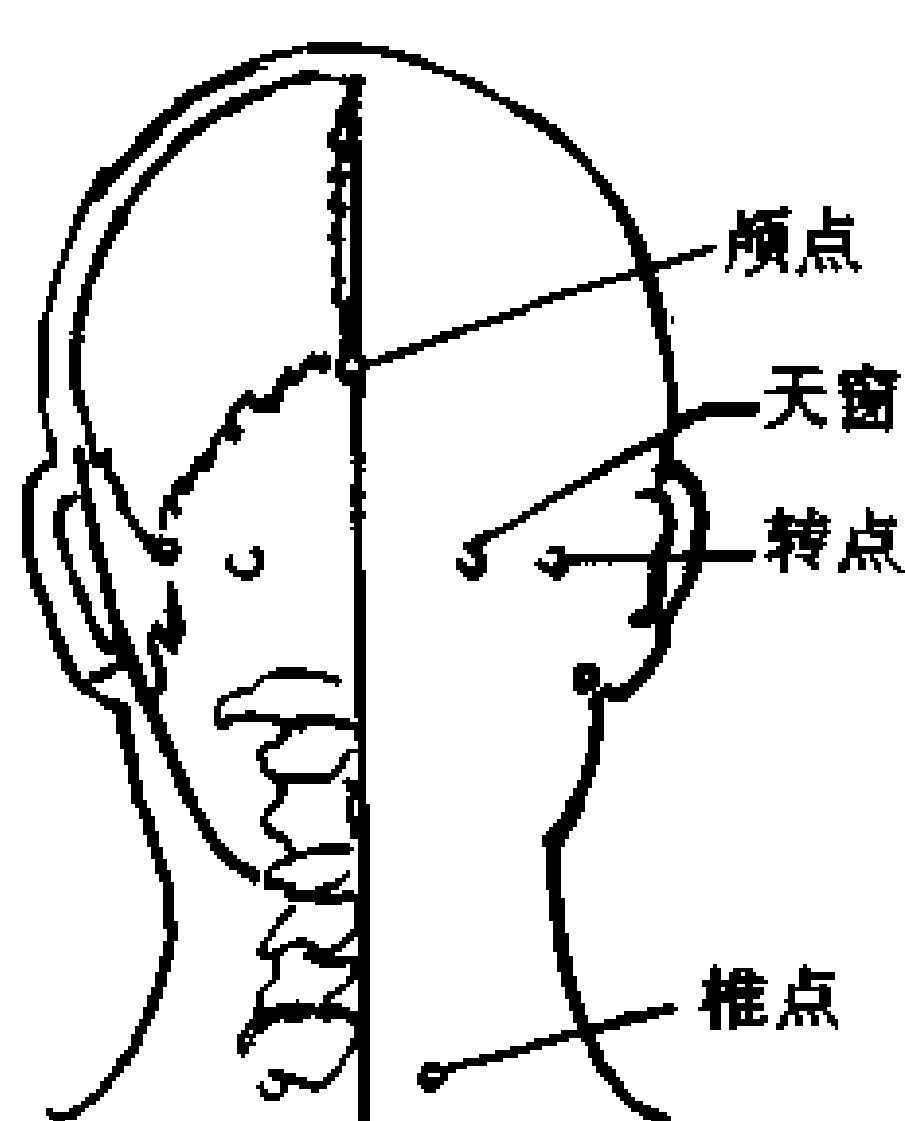


图 82-1

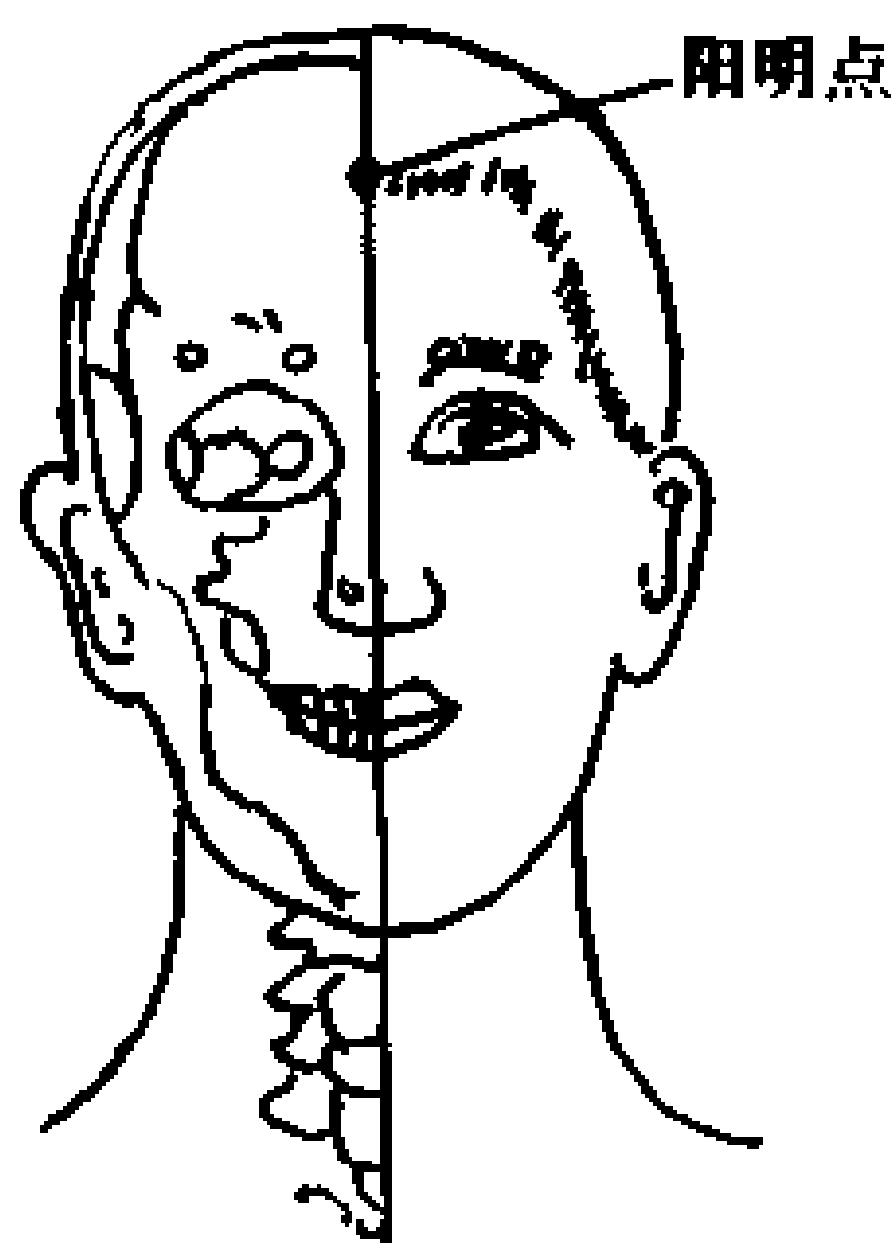


图 82-2

（2）配穴：颅点、阳明点、转点。

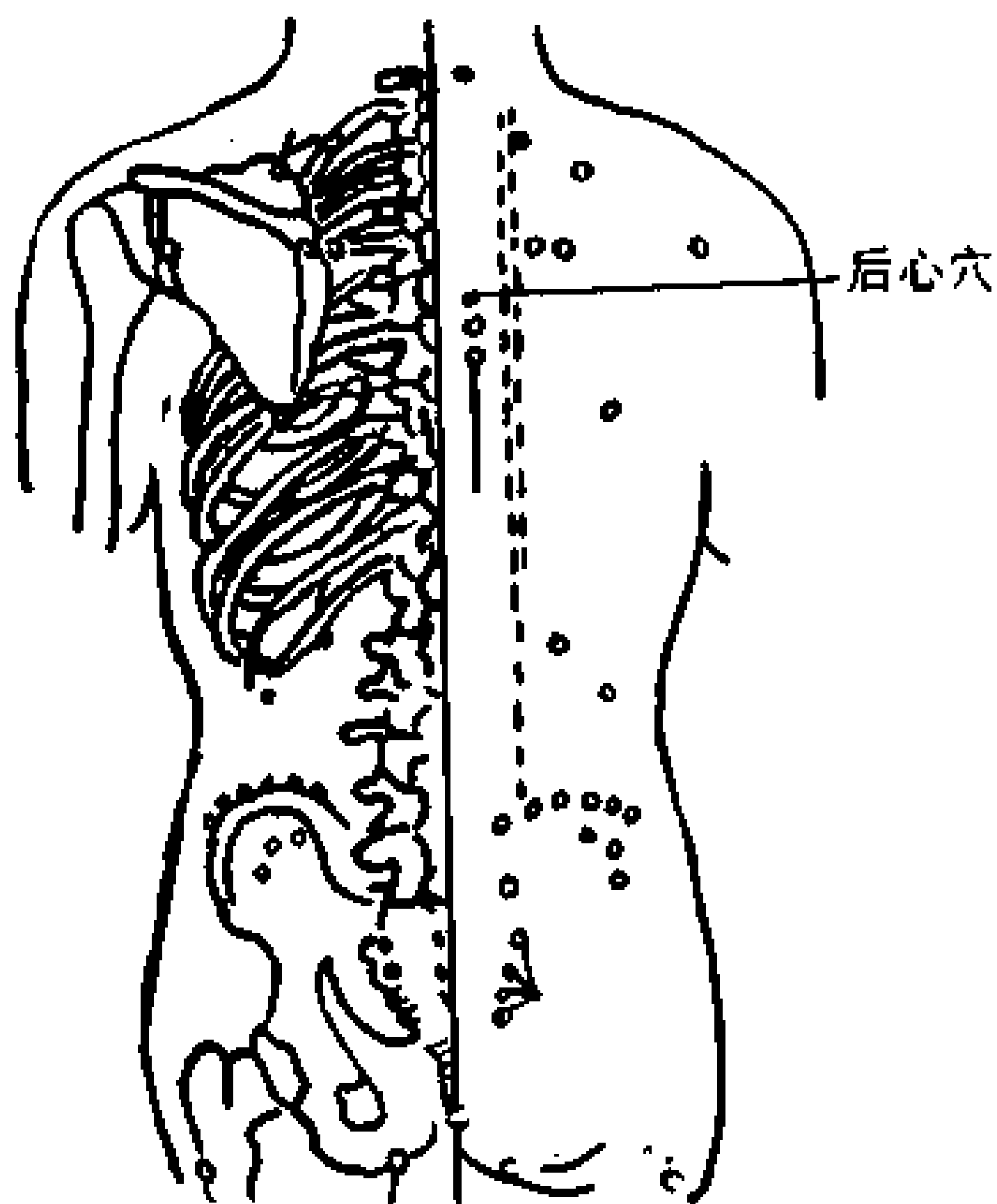


图 82-3

图 82 大脑损伤后遗症取穴图

【手法操作】

先点主穴。如效果不明显，可加点配穴。

七十二、小儿瘫后遗症

本症系指脊髓灰质炎后遗症，多见于儿童，成人发病者极少见。

脊髓灰质炎是由脊髓灰质炎病毒引起的一种急性传染

病。患者于急性期渡过之后，肢体遗留不同程度的麻痹，出现不规则、不对称的瘫痪，呈弛缓性，以下肢为多见。罹病的肢体表现为软、瘫、细、凉以及畸形等特点，无感觉障碍。腱反射早期可亢进，后期呈迟钝或消失。

【取穴】（图 83）

- （1）主穴：连排点、十八转。
- （2）配穴：上肢取椎点，臂水沟，水区点；下肢取血筋，上水沟，下水沟，膝点，内、外筋。

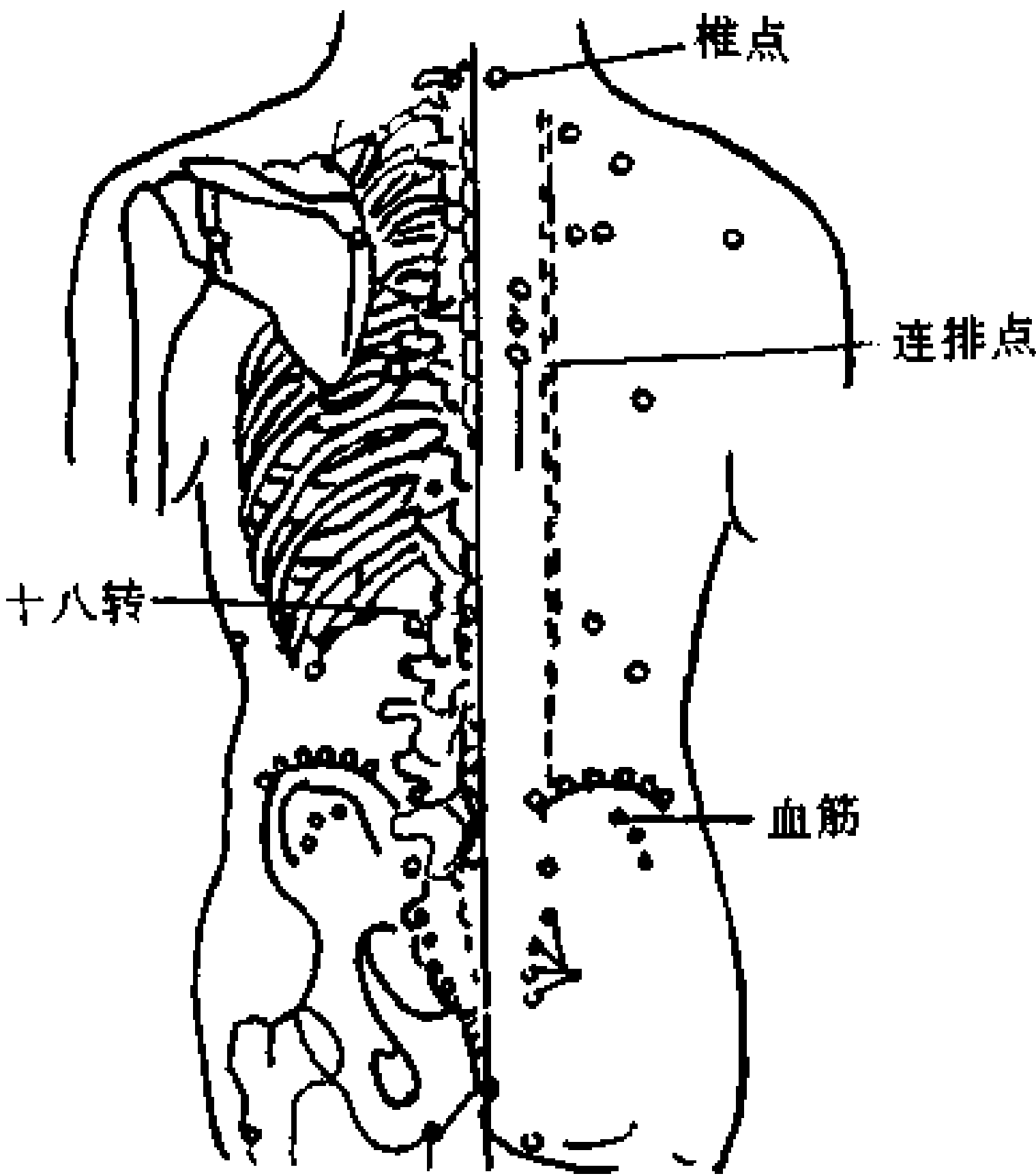


图 83-1

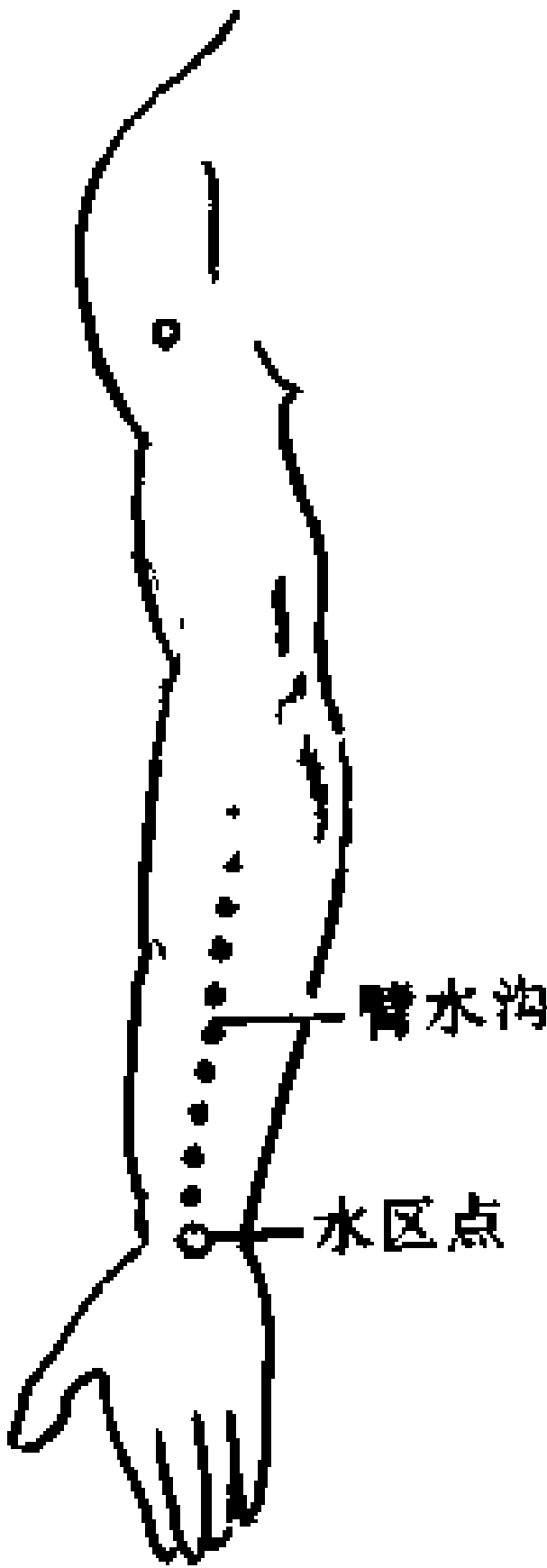


图 83-2

图 83 小儿瘫后遗症取穴图

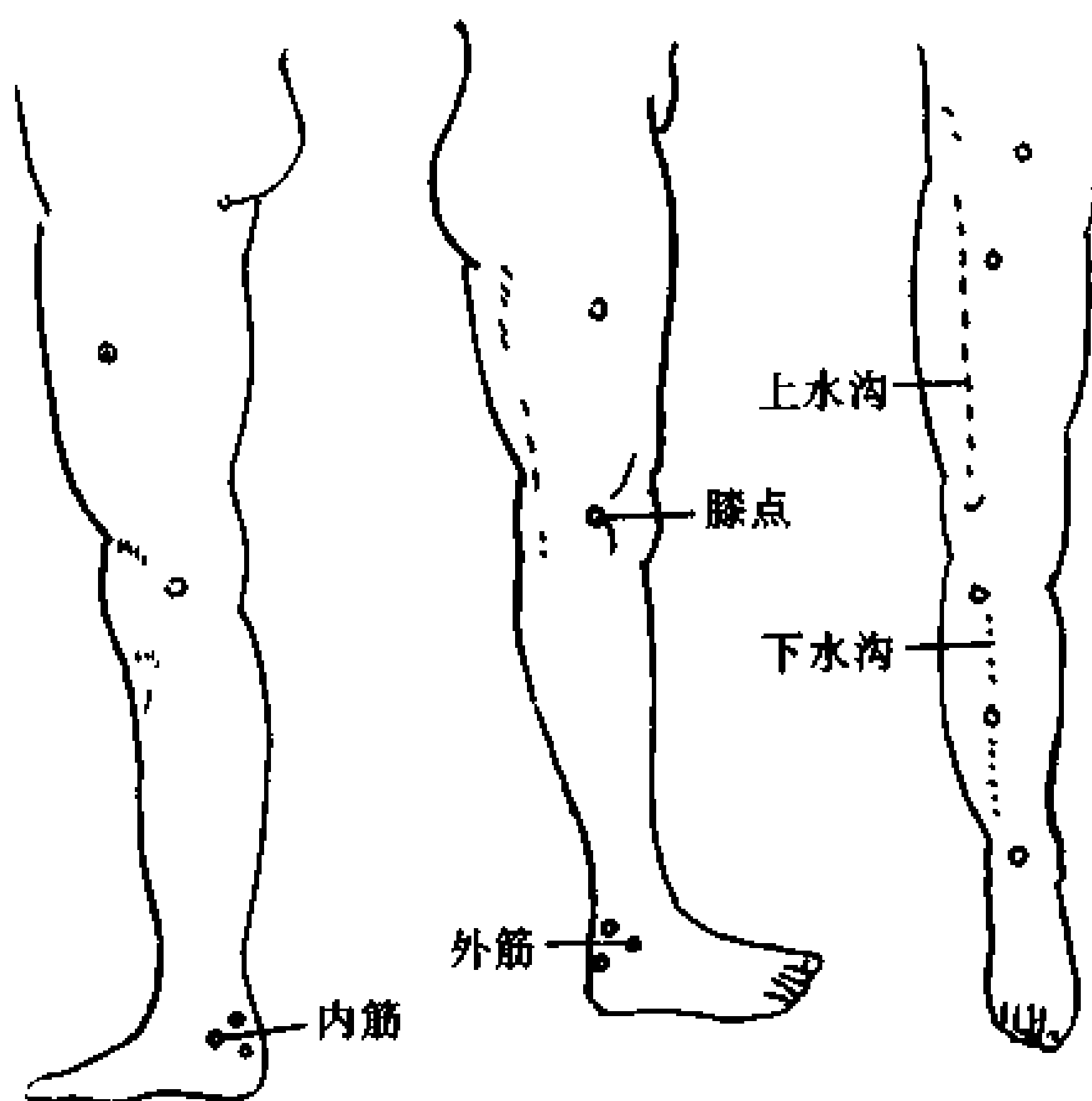


图 83-3

图 83-4

图 83-5

图 83 小儿瘫后遗症取穴图

【手法操作】

手法用力宜适中，并用捏脊法，每天行手法 1 次。

七十三、多发性神经炎

本病又称末梢神经炎，是一种两侧对称性的感觉障碍及弛缓性瘫痪的疾病。其发病原因以感染及中毒最为常见，亦可因代谢障碍、营养不良所致。

呈双侧对称性的感觉障碍，肢体远端症状比近端严重，逐

渐向上发展，起病缓慢，开始四肢发麻，刺痛或蚁行感，以后感觉减退或消失，呈手套形或袜套形。运动障碍可见四肢肌力减退，肌肉萎缩，以至出现弛缓性瘫痪，腕下垂，足下垂，皮肤发凉、光滑、变薄或干裂。严重者呼吸肌受累，表现不同程度的呼吸困难。腱反射早期可亢进，以后减退或消失。

【取穴】（图 84）

（1）主穴：椎点、后心穴、血筋、龙点。

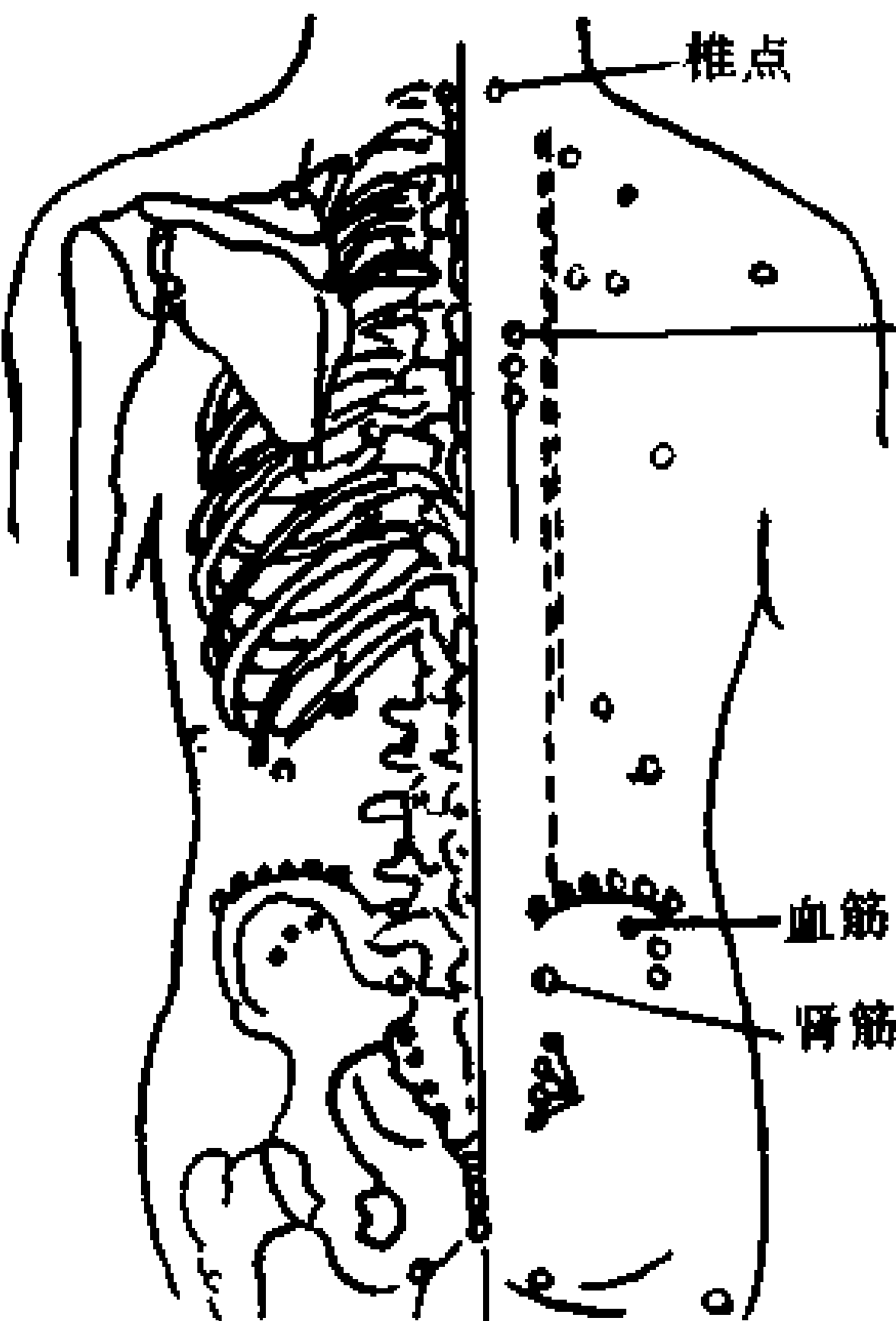


图 84-1

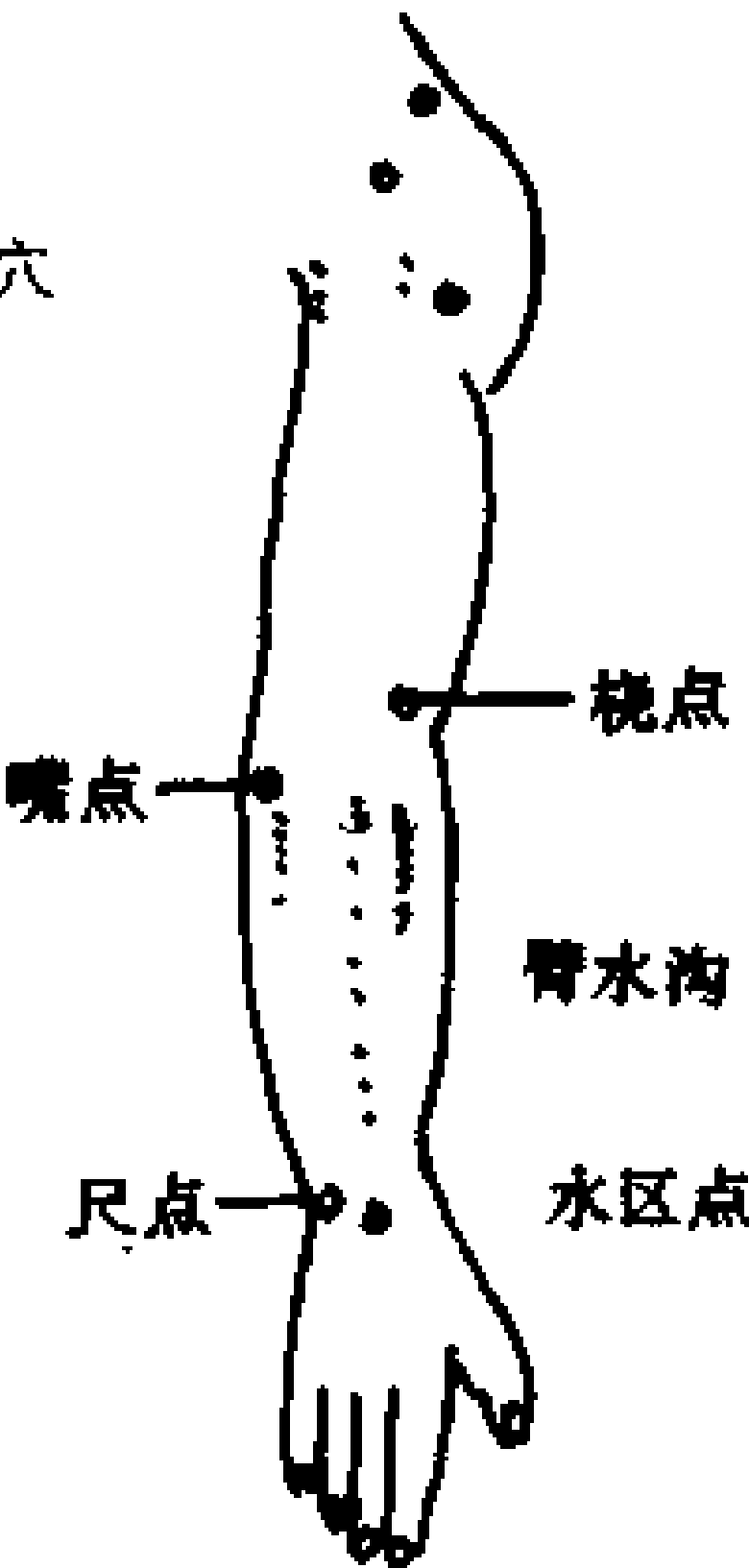


图 84-2

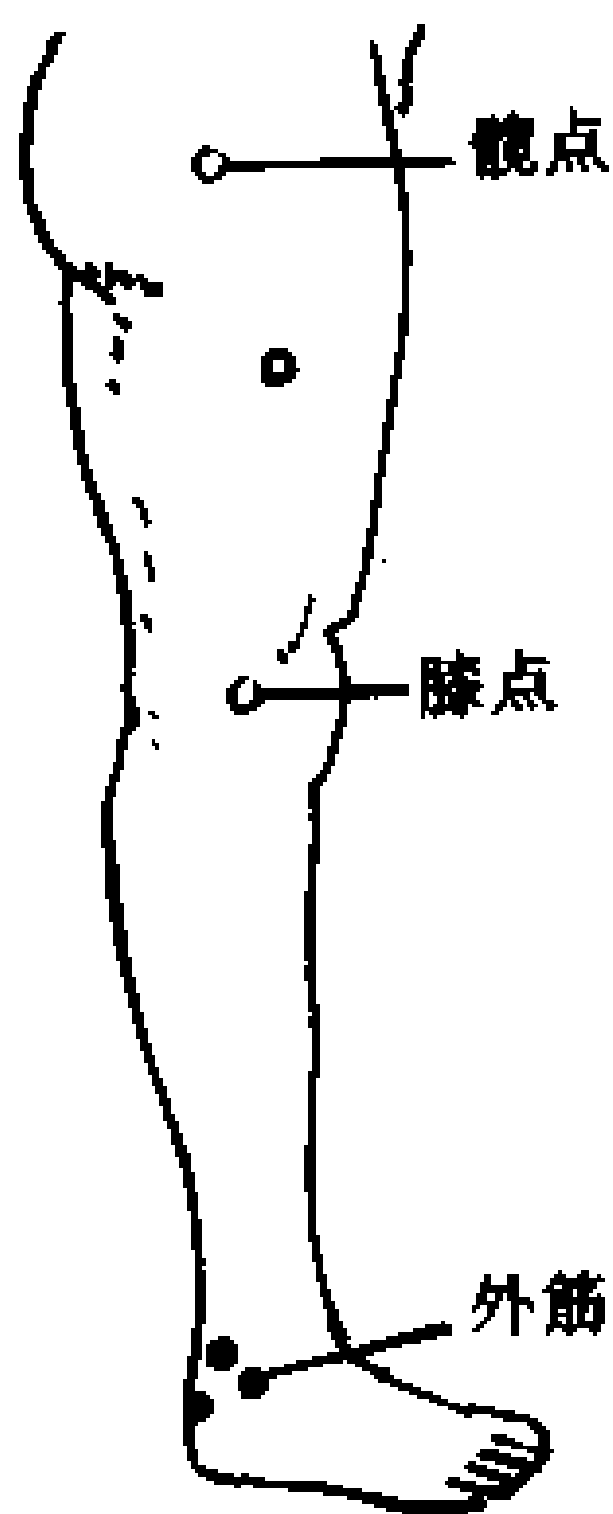


图 84-3

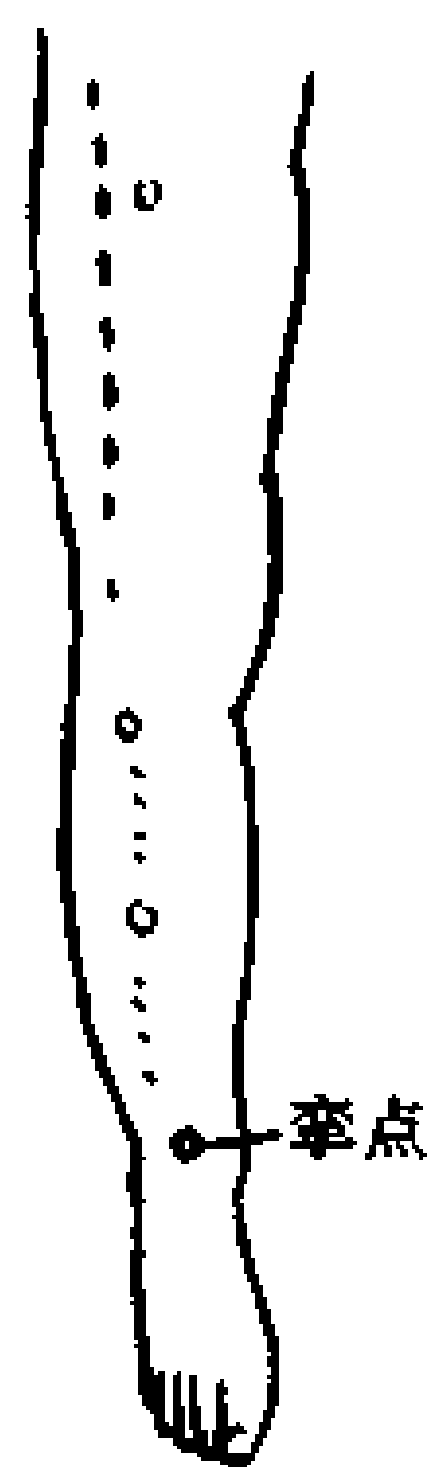


图 84-4

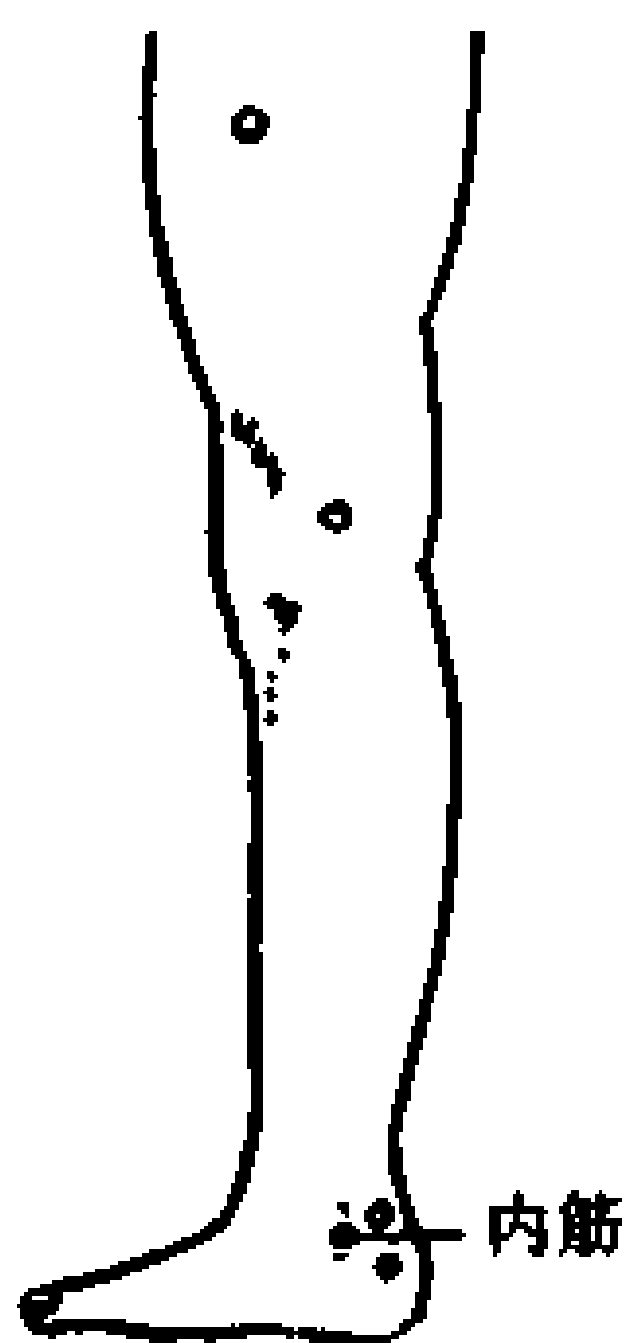


图 84-5

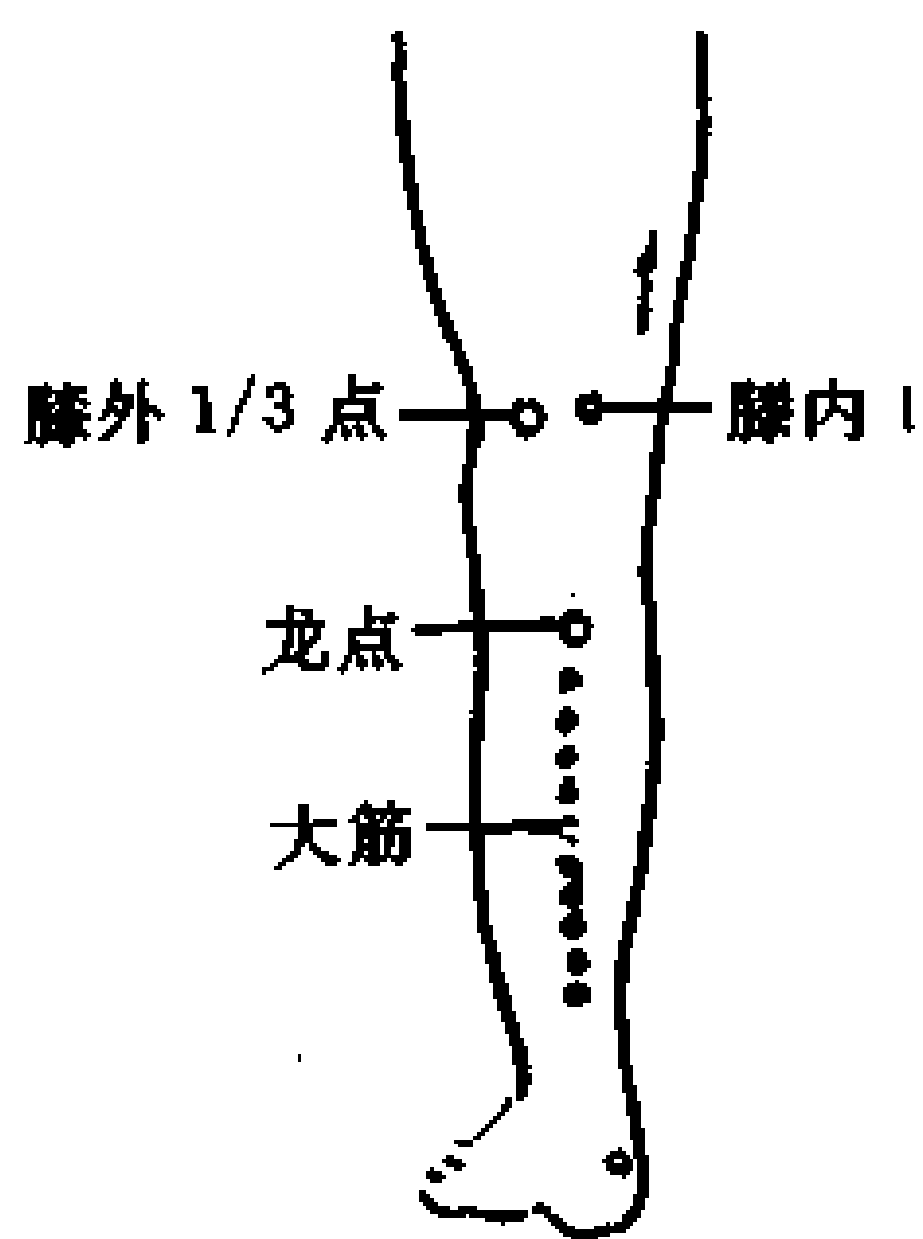


图 84-6

图 84 多发性神经炎取穴图

(2) 配穴：桡点，嘴点，臂水沟，水区点，尺点，肾筋，髌点，膝点，膝外 1/3 点，大筋，内、外筋，挛点。

【手法操作】

先点主穴，后酌情取点配穴，每个穴位点按约 1~2 分钟。

七十四、臂丛神经损伤

常因手臂被机器卷入后，上肢受到过度牵拉所致；其次是交通事故或枪弹伤造成。小儿则见于产伤。

臂丛上部 (C5、6) 损伤后其典型畸形是：上肢松弛，肩关节内收内旋，肘关节伸直，前臂旋前。肩关节周围的冈下肌、小圆肌、肩胛下肌、大圆肌、胸大肌部分以及背阔肌部分麻痹，肱二头肌、肱肌、肱桡肌亦麻痹。臂丛下部 (C8、T1) 损伤后，表现为手内在肌，屈指、屈腕肌麻痹。如果累及节后纤维，即出现霍纳氏综合征。束部损伤若为外侧束损伤时，肱二头肌、肱肌和喙肱肌、桡侧屈腕肌和旋前圆肌麻痹，若为后束损伤时，肩胛下肌、大圆肌麻痹，肌部麻痹，三角肌、小圆肌麻痹，肩关节不能内旋及外展，手腕、手指不能伸展。若属内侧束损伤，则表现为除桡侧屈腕肌及旋前圆肌外的正中神经及尺神经损伤。

【取穴】(图 85)

(1) 主穴：椎点、后心穴 (男取左穴，女取右穴)、连排点、十八经、嘴点、桡点。

(2) 配穴：抬肩点、魁点、魄点、腰点、内龙边、臂水沟、尺点。

【手法操作】

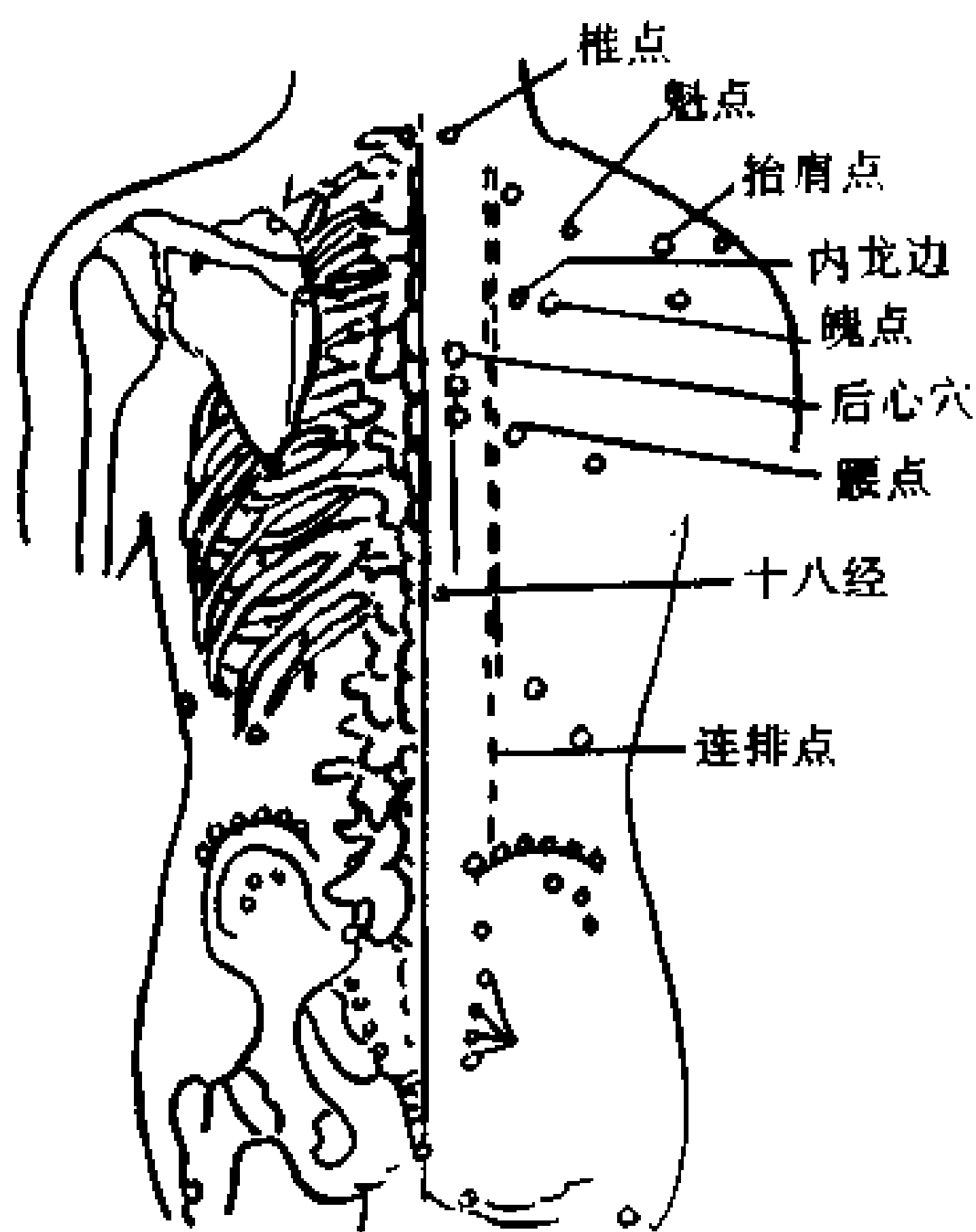


图 85-1

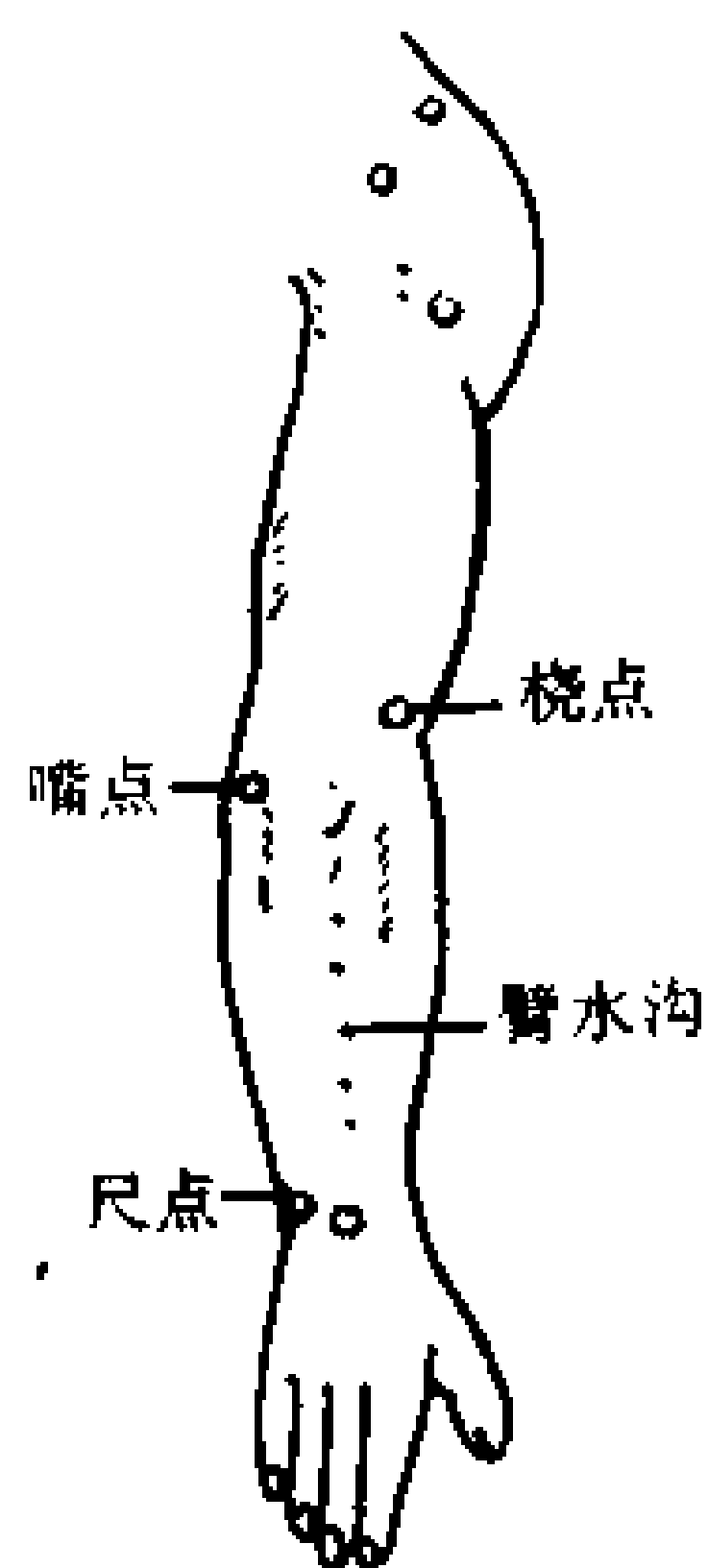


图 85-2

图 85 臂丛神经损伤取穴图

先点主穴，每穴点按 1~2 分钟，首次治疗时，手法宜重，然后酌情取配穴点按。

七十五、桡神经损伤

损伤常见于有移位的肘部骨折，特别多见于肱骨下部骨折，上臂受牵拉或腋窝受压也会造成桡神经损伤，少数为枪

弹伤、切割伤、手术误伤或注射药物损伤。

腕下垂，腕关节不能背伸；掌指关节不能伸直，拇指不能伸直，手背桡侧皮肤感觉障碍。桡神经高位损伤时，肘关节亦不能伸直。

【取穴】（图 86）

（1）主穴：椎点、桡点。

（2）配穴：臂水沟、水区点、掌点。

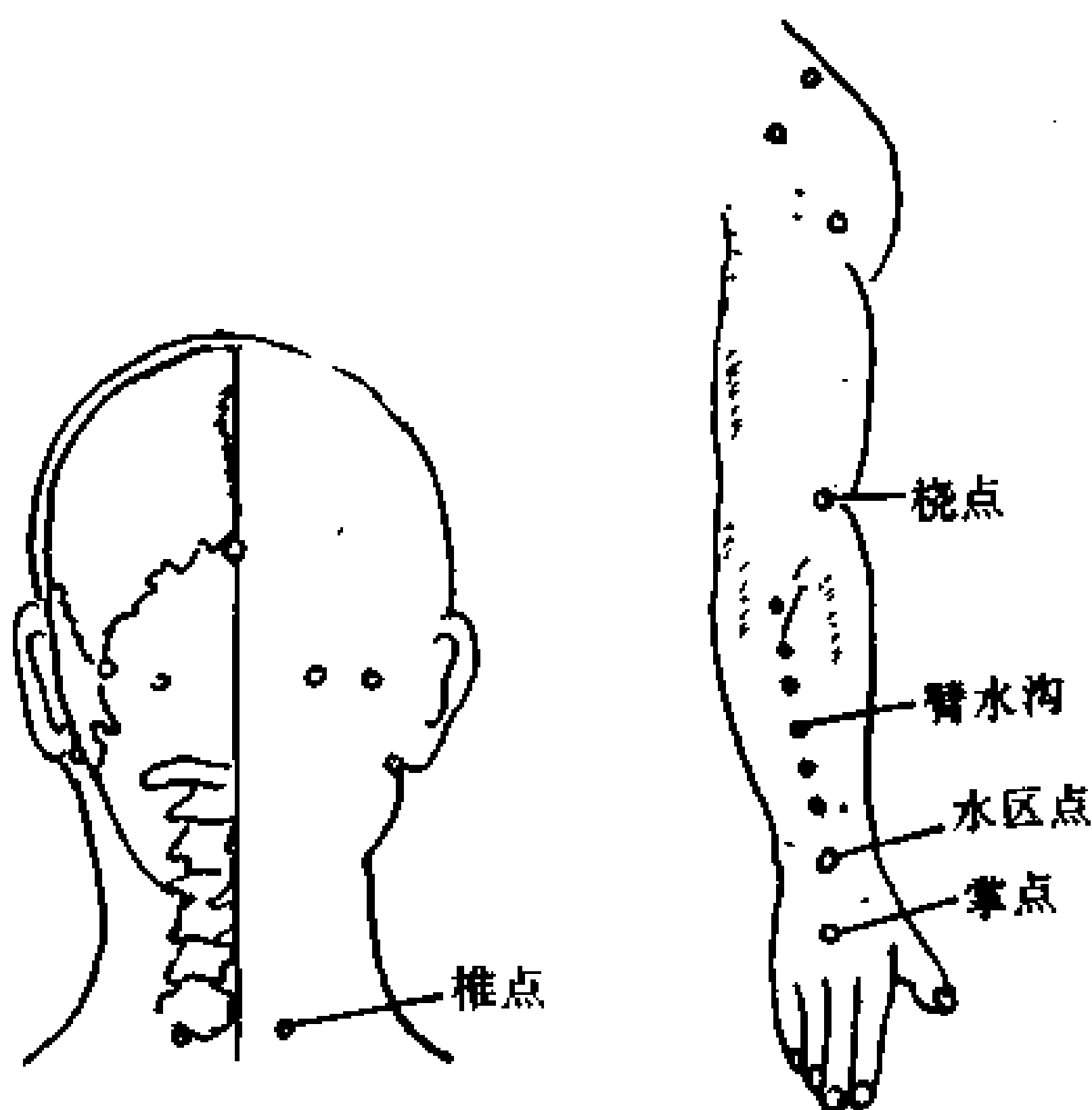


图 86-1

图 86-2

图 86 桡神经损伤取穴图

【手法操作】

反复先点按主穴 5 遍，每穴 1 分钟，然后取配穴，每天施术 1 次。

七十六、正中神经损伤

常见于切割伤、辗轧伤、枪弹伤和因骨折处理不当造成的前臂缺血性挛缩而累及。

正中神经在上臂受损伤时，发生完全性麻痹：前臂不能旋前，屈腕动作部分丧失，拇、食、中三指不能屈曲，但环、小指仍能屈曲，手掌鱼际肌萎缩，显见平坦，拇指内收且伸展，成为所谓的猿手畸形。桡侧三个半手指的掌面，背面远端二个半指节的浅感觉丧失。正中神经部分损伤时，常出现剧烈的灼性神经痛。

【取穴】（图 87）

（1）主穴：椎点、嘴点。

（2）配穴：前、后解胸，臂前、后点，桡点，臂水沟，尺点。

【手法操作】

先点主穴，每次施术选取配穴 3~4 穴，各配穴交替使用，每天施术 1 次，手法由重转轻。

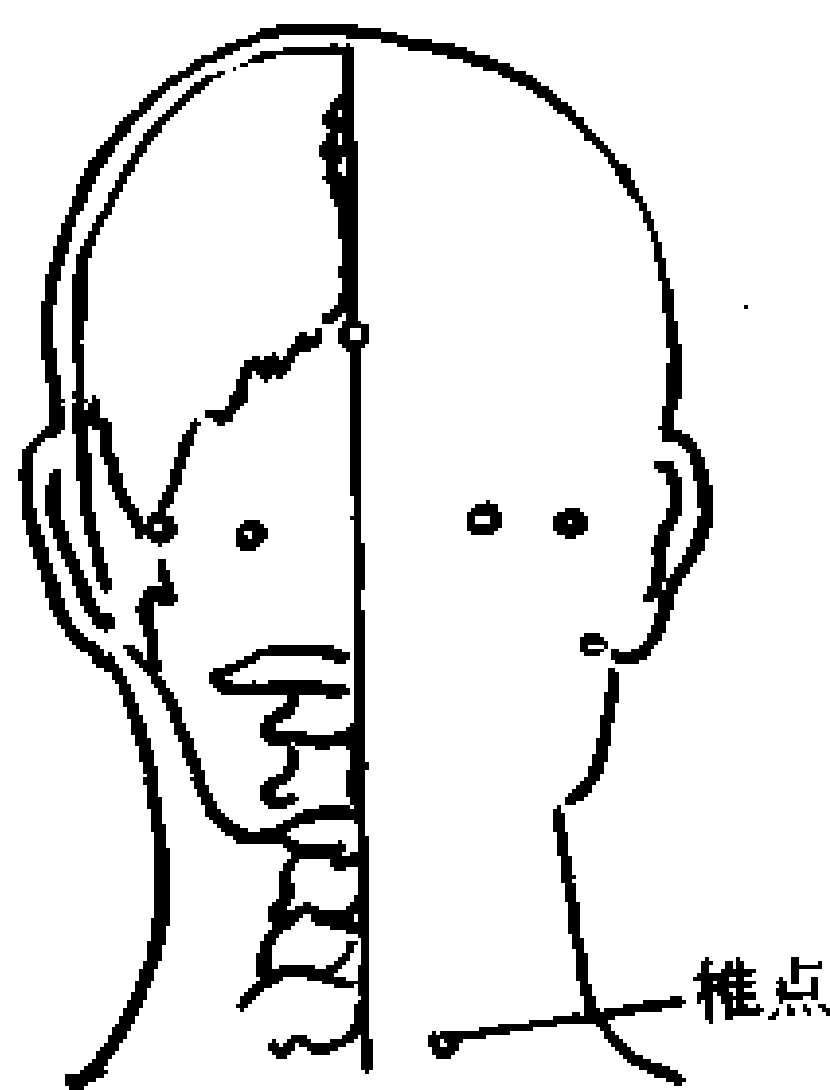


图 87-1

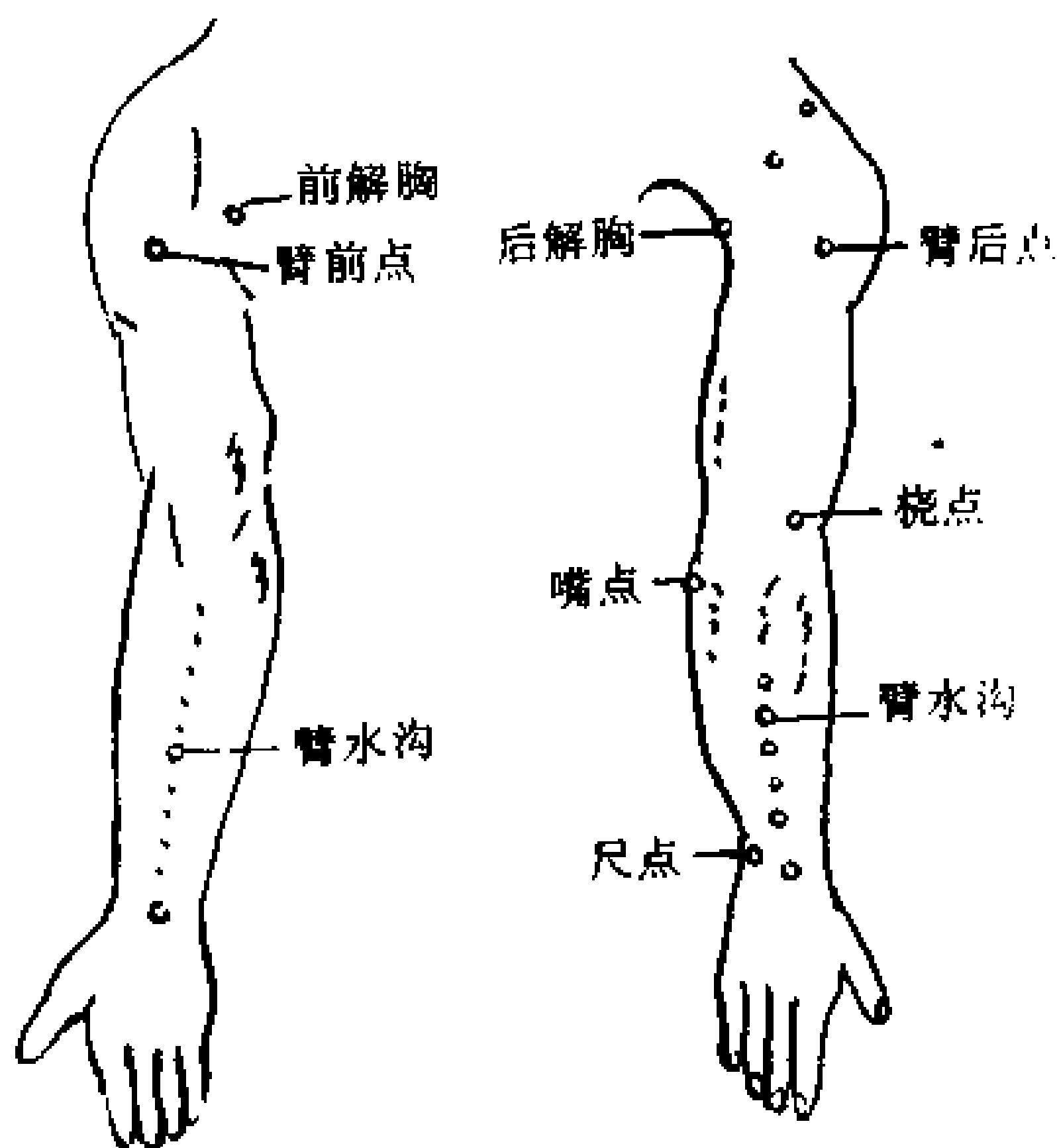


图 87-2

图 87-3

图 87 正中神经损伤取穴图

七十七、尺神经损伤

多数为腕部、前臂或上臂的切割伤，少数为枪弹伤或由肘部骨折及脱位造成。此外，肘外翻畸形屈伸时，屡受挫伤，麻风病常侵犯尺神经。

手呈典型的爪状畸形，环、小二指最为明显，手的尺半皮肤感觉缺失；手指内收，外展动作受限，夹纸力减弱或消失，以环、小二指最为明显，晚期骨间肌和小鱼际肌群明显

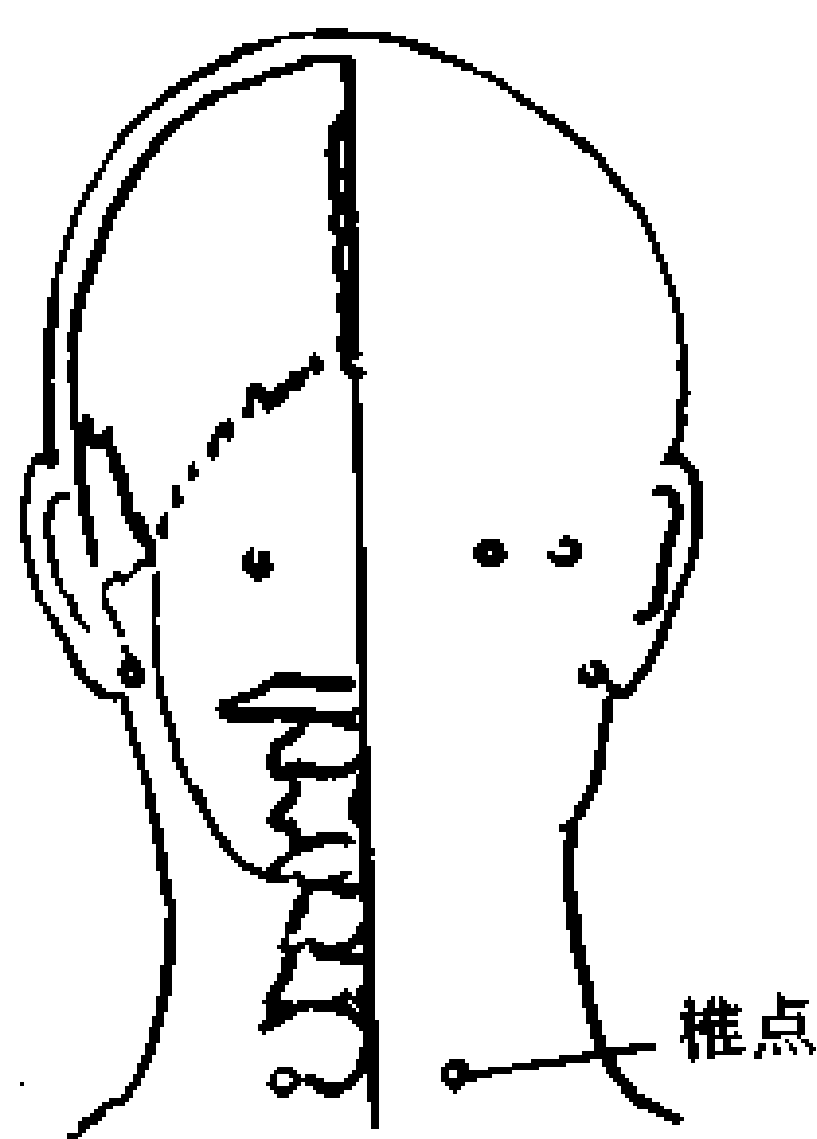


图 88-1

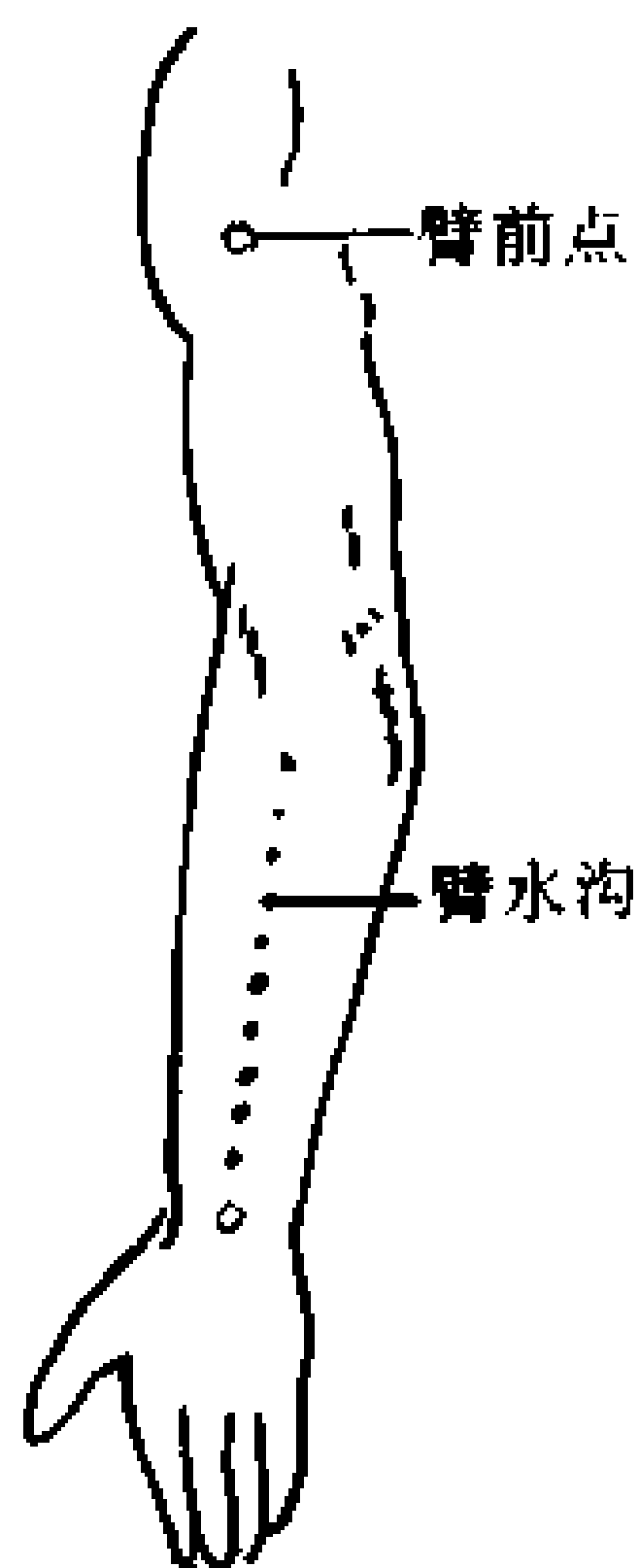


图 88-2

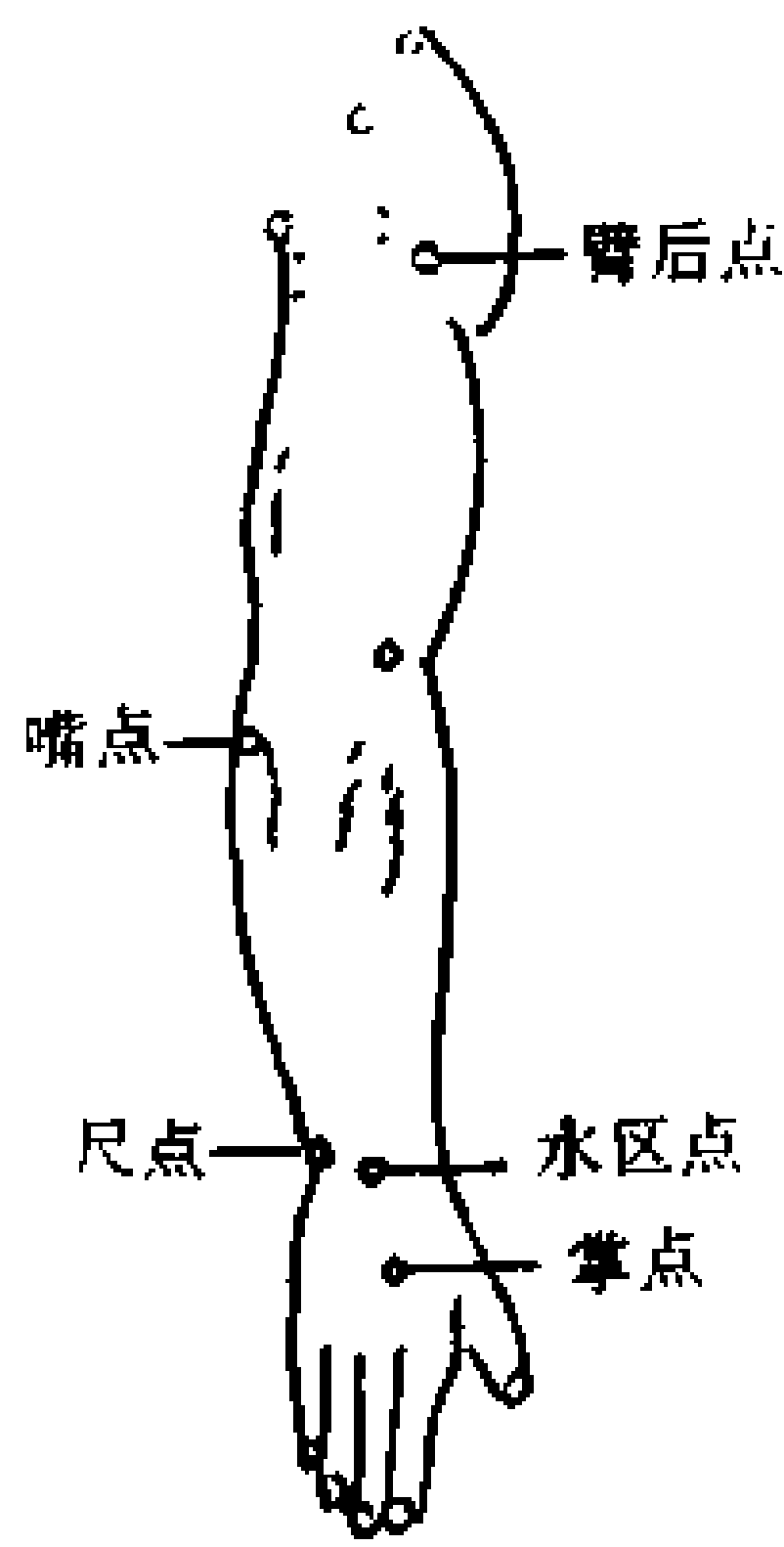


图 88-3

图 88 尺神经损伤取穴图

萎缩。

【取穴】(图 88)

(1) 主穴：椎点、嘴点、尺点。

(2) 配穴：臂前点、臂后点、臂水沟、水区点、掌点。

【手法操作】

先点主穴 1~2 分钟，点按嘴点时，如已“得气”，则手法应转轻。每次施术时，只选配穴 2~3 穴，不断交替使用。

七十八、坐骨神经损伤

可因刀刺伤或火器伤，髋部及臀部手术误伤，骨盆骨折、髋关节后脱位等所致损伤。此外，臀部肌肉注射某些药物不当，亦可造成损伤。

坐骨神经损伤若发生于大腿之行程中，则膝关节以下的肌肉均瘫痪，足下垂，屈膝动作部分障碍，膝以下皮肤感觉减退或丧失。坐骨神经的分支胫神经损伤时，踝关节和足趾不能跖屈，足呈背伸外展位，跟腱及趾反射消失，足跟及足底感觉消失。若坐骨神经的另一分支腓总神经损伤时，出现垂足畸形，呈跨越步态，足和趾不能背伸，也不能外展外翻，足背大部分及小腿前外侧皮肤感觉消失。

【取穴】（图 89）

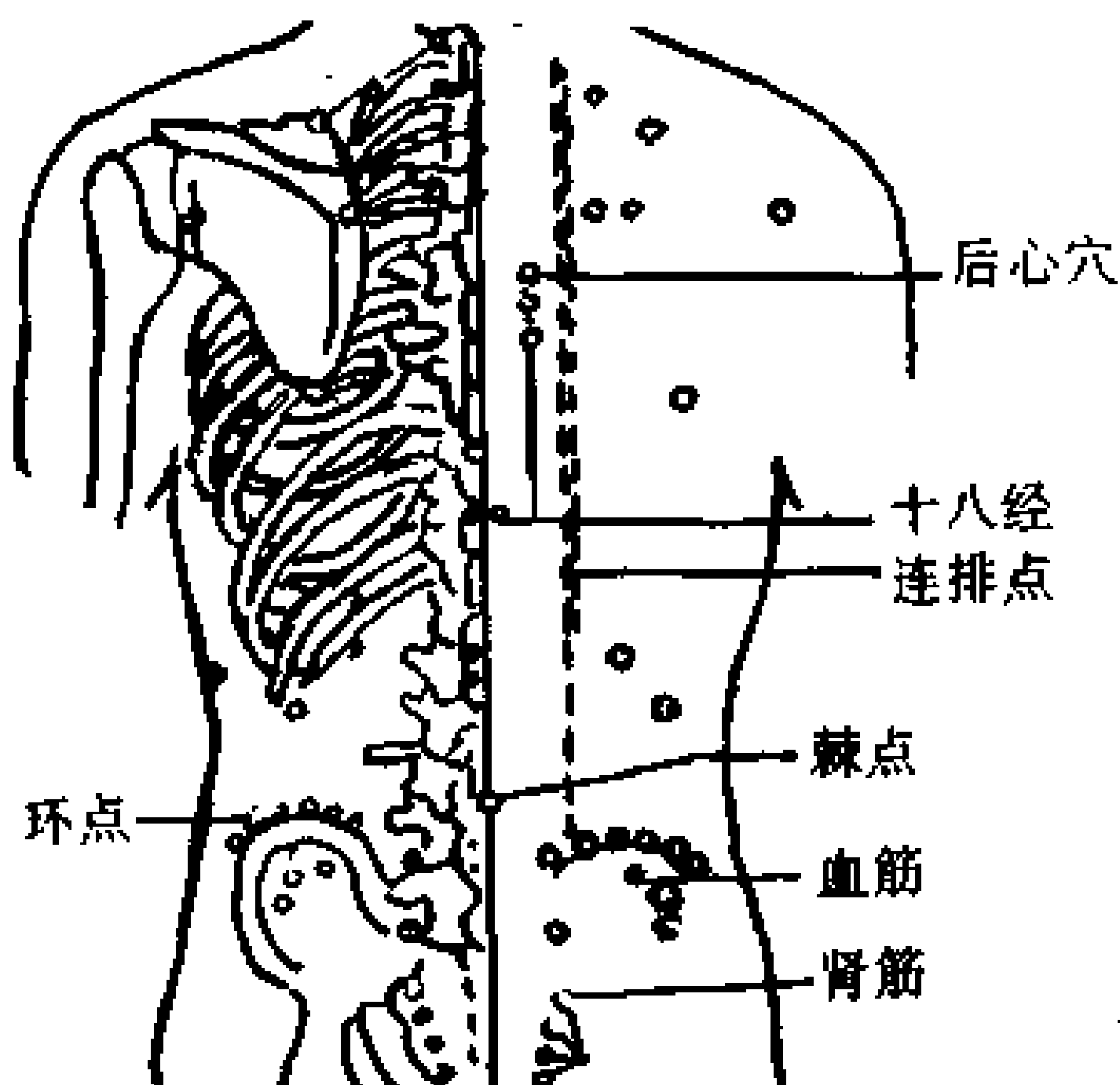


图 89-1

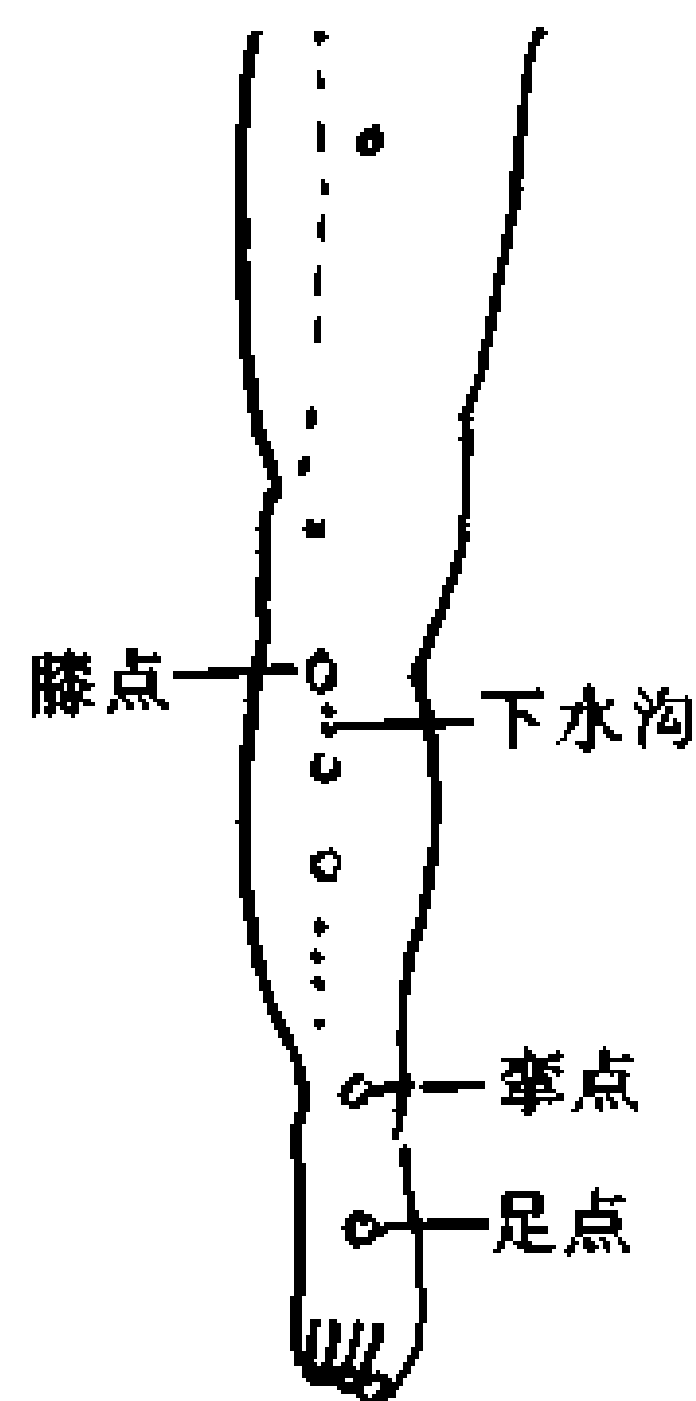


图 89-2

图 89 坐骨神经损伤取穴图

(1) 主穴：后心穴（男取左穴，女取右穴）、十八经、血筋。

(2) 配穴：连排点、棘点、肾筋、环点、膝点、下水沟、挛点、足点。

【手法操作】

先点主穴。血筋穴及配穴均取患侧穴位，手法宜重，每天行手法 1 次，每个穴位点按 1 分钟，反复 3~4 遍。

七十九、颜面神经麻痹

一般由于夜晚睡醒外出受凉，或熟睡后头面部受风，或耳炎、乳突炎症继发而引起的。小儿患者多因发高烧后而引起。

患者口向健侧歪斜，额纹及鼻唇沟变浅或消失，常流涎，鼓腮困难，说话漏风，不能吹气，眼睑闭不上，易流泪，遇风眼睛更难受。

【取穴】（图 90）

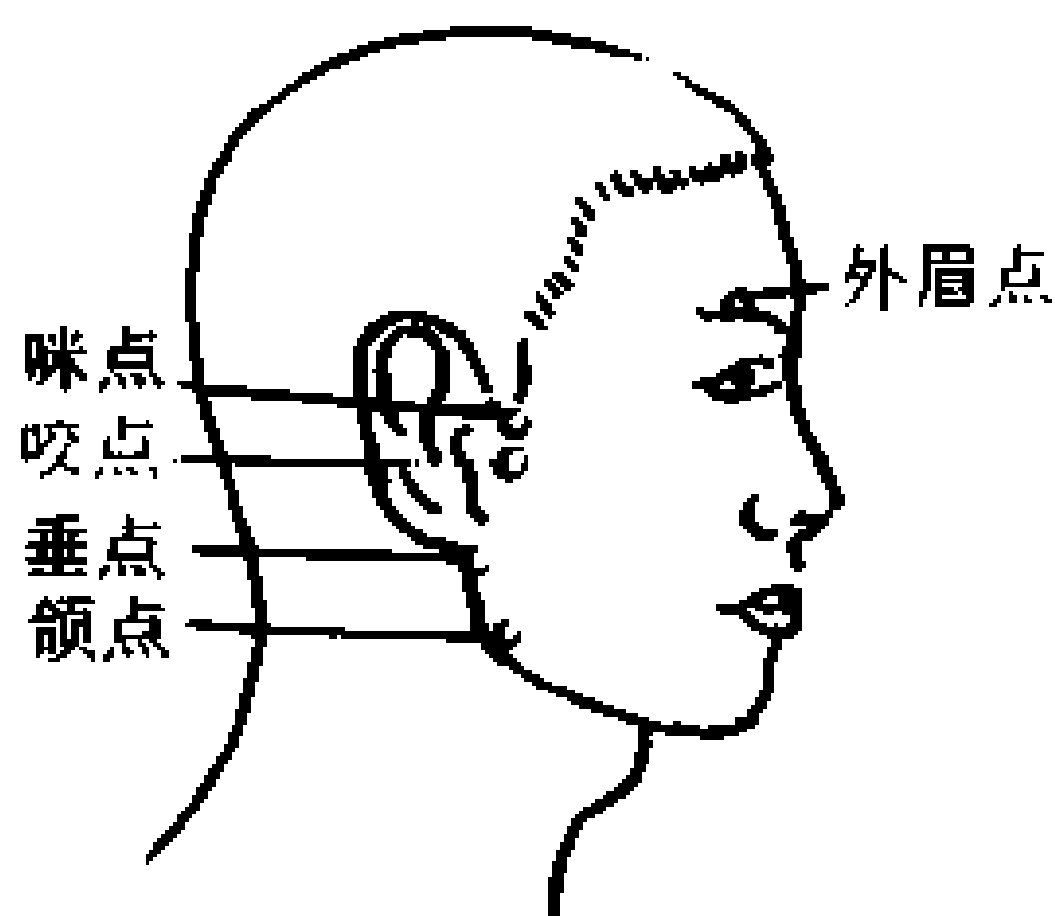


图 90-1

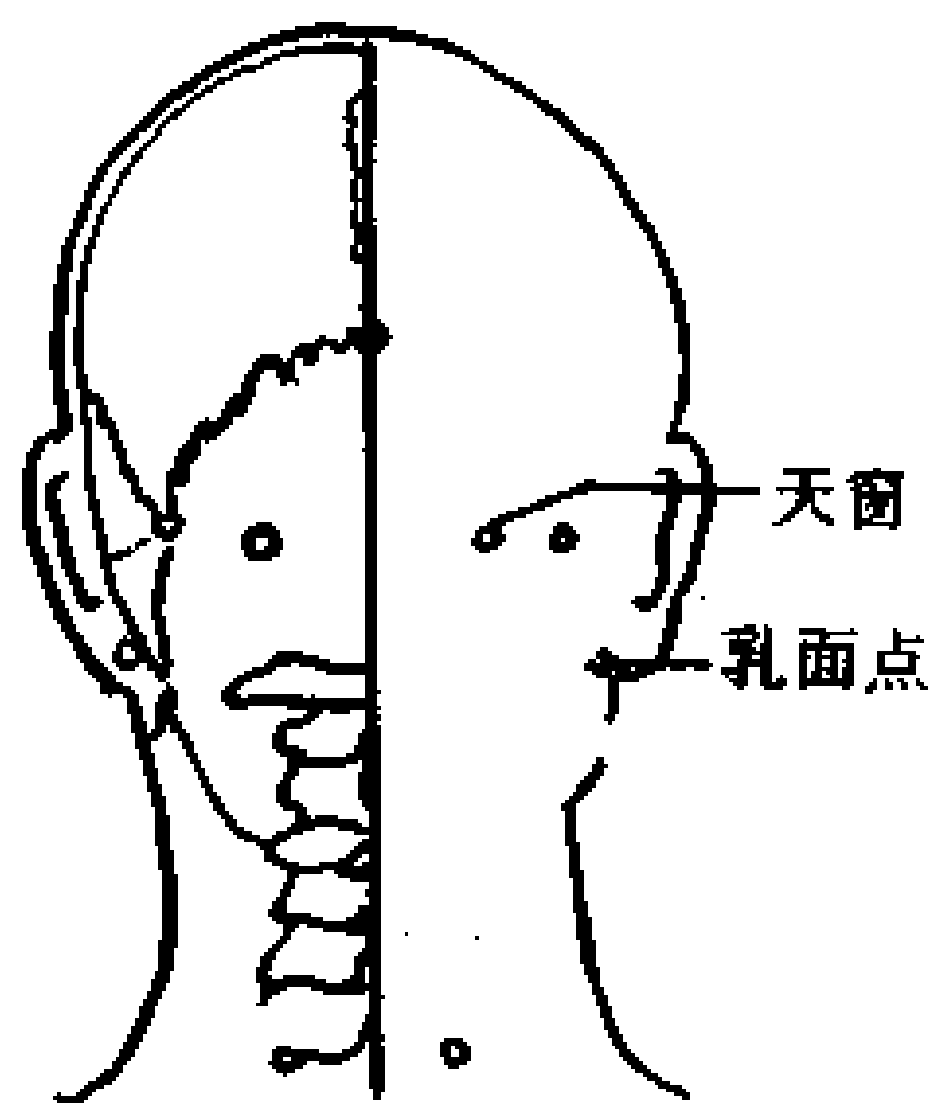


图 90-2

图 90 颜面神经麻痹取穴图

(1) 主穴：乳面点、垂点、颌点、外眉点。

(2) 配穴：天窗、咬点、咪点。

【手法操作】

手法不宜过重。穴位均取健侧。

八十、三叉神经痛

三叉神经分支范围内反复出现的阵发性短暂剧烈疼痛，无感觉缺失等神经传导功能障碍的表现，称为三叉神经痛。病因目前尚不明了，病理检查无异常发现。

疼痛分布严格局限于三叉神经感觉供应区内。通常涉及一侧三叉神经的第2枝或第3枝，少数表现为双侧三叉神经痛。发作时出现阵发性闪电样剧烈疼痛，阵痛持续时间仅数秒，一日数次或一分钟多次。突然出现的剧痛常反射性地引起同侧面部肌肉抽搐以及皮肤潮红、眼结膜充血、流泪或流涎等。疲劳或紧张时发作较频繁。

【取穴】（图 91）

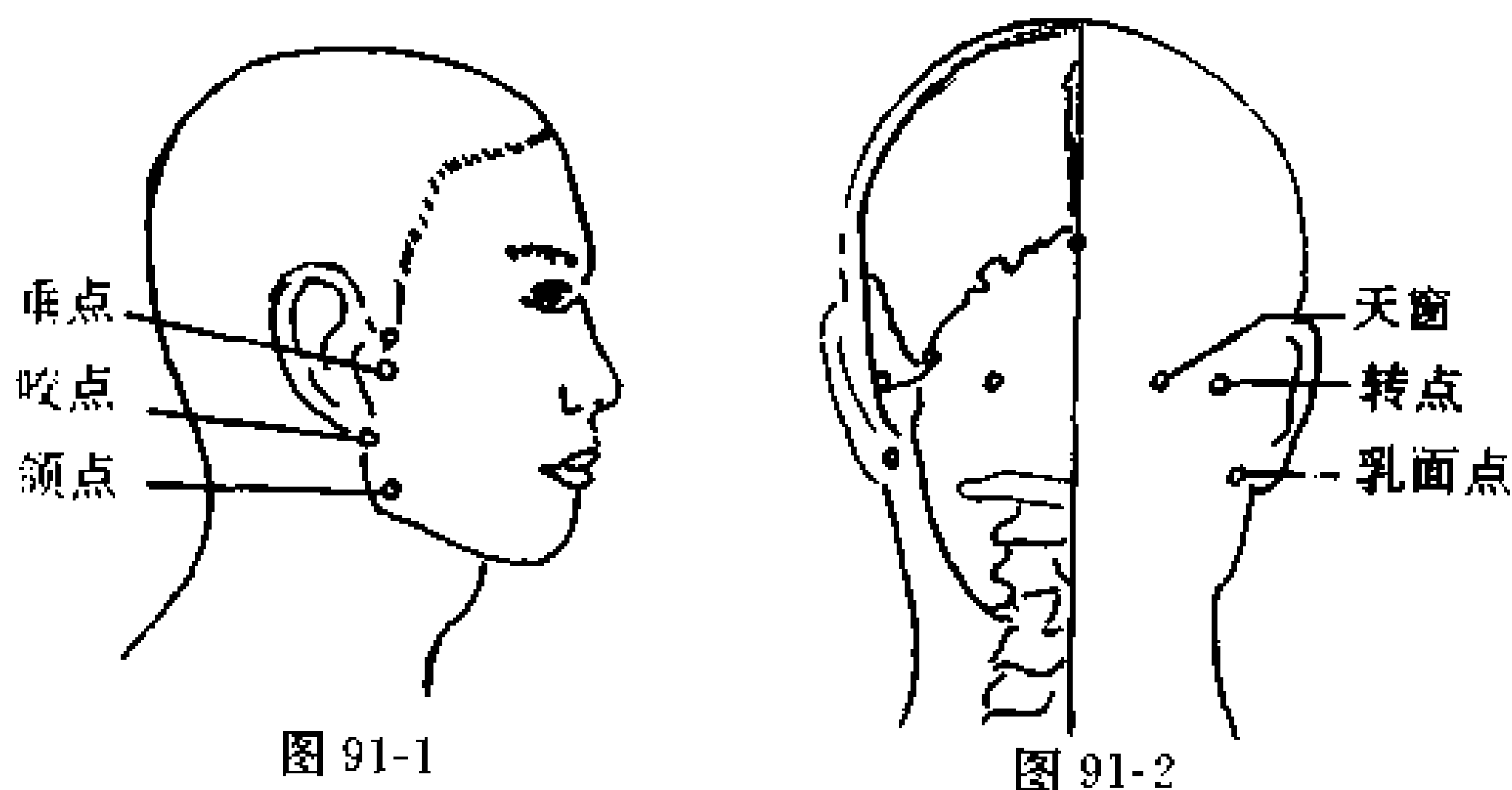


图 91-1

图 91-2

图 91 三叉神经痛取穴图

(1) 主穴：颌点、乳面点、咬点。

(2) 配穴：垂点、天窗、转点。

【手法操作】

手法由重转轻，均取患侧穴位。

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]
书名=图解民间传统独特疗法丛书 图解点穴疗法
作者=
页数= 1 9 3
S S 号= 0
出版日期=